

大芒山中医验案经验集 之癫痫和精神病篇

收集整理 罗维跃

大芒山中医验案经验集之癫痫和精神病篇

收集整理 罗维跃

更新日期：2025-1-26

目录

罗序 1

第一章 （《妇人良方》）妇人风邪颠狂方论 2

 1、 【因惊而癫】 2

 防风茯神散： 2

 牛黄清心丸： 3

第二章 《妇人良方集要》妇人怔忡惊悸方论 3

 排风汤：（《太平惠民和剂局方》） 3

 2、 【目愧成病言语失伦而死】 3

 3、 【补中益气汤加炮姜治崩血昏愤发热不寐】 3

 4、 【归脾汤八珍汤治心跳怔忡寒热往来】 3

 5、 【归脾汤八珍汤治惊悸怔忡日晡发热】 4

 6、 【归脾汤惊悸怔忡无寐】 4

 茯神散： 4

 7、 茯苓补心汤： 4

 8、 茯神汤： 4

 9、 酸枣仁丸： 4

 10、 定志丸： 4

 11、 养心汤： 4

 12、 朱砂安神丸： 5

 13、 治要茯苓散： 5

第三章 瓜蒌瞿麦丸方证(高齐民) 5

 瓜蒌瞿麦丸方： 5

 14、 【防己地黄汤艾怨而狂】高齐民： 6

 15、 【防己地黄汤失心风】高齐民： 6

第四章 针灸医案集 7

 16、 【柱隔姜灸鬼哭穴卒哑不能言医案】高齐民： 7

第五章 男子精神病 7

 17、 【四逆汤加肉桂治阴证误下救逆腹痛便秘误以桃仁承气汤下之医案】 7

 18、 【大承气汤治神志恍惚歌唱无序歌唱无序】曹颖甫门人： 8

 19、 【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医： 8

 20、 【桃核承气汤狂证】 8

 21、 【调胃承气汤治癫狂】 9

 22、 【小柴胡加龙骨牡蛎汤汤精神失常狂躁妄动医案】周连三： 9

 23、 【通脉四逆汤加人参身热面赤异常大躁】 9

 24、 【通脉四逆汤加人参烦躁闷乱欲绝时索冷水】 9

 25、 【桂枝甘草龙骨牡蛎汤治癫狂】 9

 26、 【桂枝甘草龙骨牡蛎汤悸甚而神不宁医案】刘渡舟： 9

 27、 【桂枝甘草龙骨牡蛎汤治被惊吓致病（瘧病）医案】： 9

 28、 【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫： 10

29、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治心悸易惊医案】罗卫东：	10
30、	【小柴胡加龙骨牡蛎汤治精神失常狂躁妄动医案】周连三：	10
31、	【柴胡龙骨牡蛎汤手足乱动行走不稳挤眉弄眼医案】朱进忠：	10
32、	【四逆汤腹痛便秘而发热（真寒假热）医案】吴佩衡：	10
33、	【大承气癫狂数日不得大便】	11
34、	【大承气汤癫狂】	11
35、	【旋复花汤加味崩血不止大便泄泻】王孟英：	11
36、	【大青龙汤眼球炎引起浮肿头痛、眼球痛】	11
37、	【柴胡姜桂汤紫圆治独语妄笑】	11
38、	【吴茱萸汤治卒然如狂头痛干呕】	11
39、	【柴胡姜桂汤合紫圆治独语妄笑】	12
40、	【柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散（癫痫）】	12
41、	【桂枝加龙骨牡蛎汤奔豚医案】张德超：	12
42、	【桂枝加龙骨牡蛎汤癫狂医案】张季云：	12
第六章	妇人精神病	13
43、	【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方：	13
44、	【妊娠四五个月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方：	13
45、	【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云：	13
46、	【抵当汤治月经不来下焦蓄血引起的精神病】胡希恕曰：	13
47、	【血在下则忘精神病医案】刘渡舟：	13
48、	【喜笑不休医案】张氏医通：	13
49、	【喜笑不休医案】张氏医通：	14
50、	【笑哭不常医案】张氏医通：	14
51、	【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫：	14
52、	【脏躁奔豚汤治精神恍惚医案】王峰：	14
53、	【甘草泻心汤治自言自语哭笑不休精神病】	14
54、	【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：	14
55、	【白虎加人参汤治腹满身重遗尿言语失常医案】许叔微：	15
56、	【白虎加人参汤治发狂病欲把刀自杀或投井终夜狂躁不眠医案】中神琴溪：	15
57、	【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：	15
58、	【大承气汤治惕而不安急黄发斑（肝昏迷前期）医案】夏发镛：	15
59、	【发狂见鬼多言骂詈不认亲疏】	16
60、	【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：	16
61、	【桃核承气汤治经前如狂医案】：	16
62、	【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：	17
63、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育：	17
64、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：	17
65、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：	18
66、	【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：	18
67、	【桂枝茯苓丸加味癫疾医案】龚士澄：	18
68、	【桂枝茯苓丸治“血在下则忘”精神病医案】刘渡舟：	18
69、	【四逆三生饮方证治形寒肢冷性欲下降轻生想法】阿骅表兄：	19
70、	【桂枝甘草汤寐多不醒或语无伦次医案】李白召：	19
71、	【桃仁承气汤合三黄泻心汤惊恐晕厥】	19

72、	【血府逐瘀汤治妇人发狂】：	19
73、	【血府逐瘀汤治熟睡中忽然胡言乱语】：	19
74、	【乌梅丸握拳狂躁高呼打人时而静卧】	19
75、	【乌梅丸时哭笑无常医案】蒲辅周：	20
76、	【小柴胡汤加百合知母汤瘵病治医案】曾荣修：	20
77、	【大陷胸汤治发狂】	20
78、	【茯苓四逆汤加龙骨、牡蛎癫狂】周连三：	20
79、	【用痿证方治疗子宫卵巢全部摘除后的下肢无力和焦虑神经症】矢数道明：	20
80、	【桃核承气加地鳖虫蛭螂两头尖热入血室神昏谵语手足抽掣治验】曹炳章：	21
81、	【大柴胡治谵语烦躁不安胸肋烦胀】	21
82、	【大柴胡加茯苓牡蛎汤遇人则必畏怖】	21
83、	【大柴胡汤治胸腹硬满大便不通恒怵惕怯】	21
84、	【柴胡姜桂汤治肝病兼肾病颜面及下肢浮肿不眠】朱木通：	21
85、	【大柴胡治谵语烦躁不安胸肋烦胀】	22
86、	【朴硝治疯疾癫狂甚剧医案】张锡纯：	22
87、	【朴硝治疯疾癫狂】张锡纯：	22
88、	【朴硝治结证】张锡纯：	22
89、	【朴硝治烦躁不眠证】张锡纯：	23
90、	【白虎加人参汤治腹满身重遗尿言语失常医案】许叔微：	23
91、	【黄连阿胶汤加味治脑动脉硬化无故大笑医案】张云：	23
92、	【柴胡姜桂汤治肝病兼肾病颜面及下肢浮肿不眠谵语】朱木通：	23
93、	【柴胡加龙骨牡蛎汤兼用伯州散精神受刺激失眠自闭案】矢数道明：	24
第七章 癫痫证		25
94、	【甘草小麦大枣汤治癫痫六年】：	25
95、	【柴胡桂枝干姜汤治素有痫证】	25
96、	【镇肝熄风汤治疗癫痫神经系统疾病举隅】彭墩	25
97、	【侯氏黑散治痫证医案】刘炯夫：	25
98、	【桂枝加葛根汤治抽风急性中毒性痢疾医案】蒲辅周：	25
99、	【桂枝加葛根汤痉症小儿急惊风】	26
100、	【桂枝加葛根汤口眼歪斜一年医案】金树武：	26
101、	【桂枝加葛根汤治小儿惊风发热抽风】	26
102、	【桂枝汤加葛根合桂枝茯苓丸外伤性癫痫医案】曾荣修：	26
103、	【吴茱萸汤治好了一个 20 年的癫痫病人】案例分享：	26
104、	【茯苓甘草汤兼紫丸治痫症】	27
第八章 其它情志和精神病医案		27
105、	【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】娄绍昆	27
106、	【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】	28
107、	【循衣摸床谵语不可治医案】许学士：	28
108、	【大承气汤、小陷胸汤治谵语发狂医案】：	28
109、	【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：	28
110、	【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：	28
111、	【承气汤治大便不通谵语心中懊憹】许学士：	29
112、	【一副药治愈失心风家传商陆汤方】	29
113、	【桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤治傻子医案】刘渡舟：	30

114、	【生铁铬方治精神病和不孕】（《素问·病能论篇》）	30
115、	【柴胡加龙骨牡蛎汤治舞蹈病】刘渡舟：	30
116、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：	31
117、	【葛根汤加熊胆治惊痫下利欲死医案】	31
118、	【栀子豉加大黄汤治胸中憋闷烦躁便秘腹胀不欲食】	31
119、	【小柴胡加生地黄昼则安静夜则谵语热入血室】：	31
120、	【加味逍遥散加生地黄】	31
121、	【香砂六君归脾月经不止肚腹作痛呕吐】	31
122、	【侯氏黑散治狂证医案】朱卓夫：	31
第九章	自闭证	32
123、	【阿骅表兄四逆三生饮方证桂枝加龙骨牡蛎汤自闭证治验医案】	32
124、	【柴胡桂枝干姜治不欲见人自闭证】	32
第十章	抑郁症	33
125、	【吴茱萸汤治抑郁症不时哭笑】案例分享：	33
第十一章	老年痴呆	33
126、	【柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤治疗痴呆老人】黄煌：	33
第十二章	狂犬病	33
127、	【血自下下者愈之下瘀血汤治狂犬病】医学衷中参西录：	33
	【逐风汤治狂犬病】张锡纯：	34
第十三章	癫痫疾病篇	34
128、	【桂枝去桂加茯苓白术汤治癫痫医案】李克绍：	34
129、	【五苓散治癫痫医案】刘渡舟：	34
130、	【五苓散治癫痫医案】刘景棋：	34
131、	【柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散（癫痫）】	34
132、	【甘草泻心汤治癫痫半年余病】	35
133、	【用催吐法治癫痫医案，止吐药和瓜蒂散致人死亡】郝万山：	35
134、	【当归四逆加吴茱萸生姜汤治舌外伸流涎四肢不温（运动性癫痫）医案】丁世名：	36
135、	【瓜蒂散治癫痫变证医案】陕西中医函授 1992 年 5 期报导：	36
136、	【风引汤癫痫医案】郭志生：	36
137、	【甘遂半夏汤治脑积液伴癫痫医案】钟枢才：	37
138、	【癫痫里也有五苓散证】胡希恕：	37
139、	【五苓散治癫痫医案】刘渡舟：	37
140、	【五苓散合真武汤加减治癫痫】娄绍昆：	37
141、	【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云：	38
142、	【瓜蒂散癫痫】	38
143、	【自拟牛黄天麻散治小儿特发性癫痫 19 例】杜玉玲	38
144、	【柴胡桂枝干姜汤治素有痫证】	38
145、	【大黄蟅虫丸治外伤性癫痫医案】郭汉林：	38
第十四章	精神病的药方	39
146、	【我治精神分裂症有一个方】刘渡舟：	39
	防己地黄汤方：	39
147、	【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民：	40
	干姜柴胡汤：（《妇人良方集要》）	40

海蛤散：（《妇人良方集要》）	40
第十五章 瓜蒂散方证	41
148、	41
瓜蒂散方：	41
149、	41
150、	41
151、	41
152、	41
153、	41
154、【瓜蒂散治癫痫医案】闫云科：	41
155、【瓜蒂散治发黄鼻内酸痛】：	42
156、【瓜蒂散治中风谵语狂躁】：	42
157、【瓜蒂散精神失常】	42
158、【瓜蒂散瓜蒂散头痛昏蒙目眩痞闷】	42
159、【瓜蒂散加郁金癫狂】	42
160、【瓜蒂散加郁金狂躁型精神病】	43
161、【瓜蒂散癫狂】	43
162、【瓜蒂散目赤大发】	43
163、【瓜蒂散胸膈痞满】	43
164、【瓜蒂散癫痫】	43
165、【瓜蒂散善笑不得息】	43
166、【瓜蒂散头肿如斗看人小如三寸】	43
167、【瓜蒂散治痫证若发则乱言】汤本求真：	44
168、【瓜蒂散治卒然腹痛入于阴囊医案】吉益东洞：	44
169、【陈南瓜蒂焙烧存性内服治左乳房外上方生一结节医案】李霜成：	44
170、【甜瓜蒂致死医案】	44
171、【瓜蒂细粉致危证】	44
172、【瓜蒂散黄疸家头身痛】	45
173、【瓜蒂散治两膝与背互痛食后偶作恶心】	45
174、【瓜蒂散心脐上结硬如斗】：	45
175、【瓜蒂散加郁金目赤多泪】	45
176、【瓜蒂散胸膈痞满心下石硬脉沉而数】	45
177、【瓜蒂散治呕吐不能食结成窠囊医案】张氏医通：	45
178、【瓜蒂散治气上冲痰塞喉中不能语言医案】易庆棠：	45
179、【瓜蒂散治哮喘】一道人：	45
180、【瓜蒂散治失语】唐祖宣：	45
181、【瓜蒂散吐法治癫狂医案】	46
第十六章 桃核承气汤方证	46
182、【桃核承气汤狂证】	46
183、【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：	46
184、【桃核承气汤证治妇人月经未来发狂医案】曹颖甫：	47
185、【桃核承气汤治产后如狂病案】：	47
186、【桃核承气汤治狂病案】：	47
第十七章 百合地黄汤方证	48

187、	【百合地黄汤结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎医案】贺德震：	49
188、	【经方百合地黄汤治皮疹痴呆双手舞动医案】网文：	50
189、	【经方百合地黄汤治嘴巴不自主抖动医案】网文：	50
190、	【百合地黄汤结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎医案】贺德震：	51
191、	【百合地黄汤滑石代赭汤加减彻夜不眠神志恍惚医案】夏学传：	51
192、	【百合地黄汤百合鸡子黄汤啼哭不宁】	51
193、	【百合地黄汤合酸枣仁汤视物不清头晕眼花神呆耳塞医案】王占玺：	51
194、	【百合地黄汤患鼻腔干燥吸气不畅双目干涩感医案】干千：	52
195、	【百合地黄汤治右肢活动受限语言欠清医案】李一立：	52
196、	【百合地黄汤治百合病得药剧吐剧泻神志恍惚案】彭履祥：	52
第十八章 百合知母汤方证		52
百合知母汤方：		53
197、	【百合知母汤百合病医案】吴方纶：	54
198、	【洪氏用百合知母汤合甘麦大枣汤治疗失眠 60 例】	54
199、	【百合知母汤合甘麦大枣汤治疗乳腺病双乳胀痛】高秀飞：	54
200、	【百合知母汤治疗乳腺病乳腺癌术后难以入睡】高秀飞：	54
201、	【小柴胡汤合百合知母汤治疗长期低热】王有章：	54
202、	【百合知母汤胆囊炎冠状动脉供血不足发热医案】王有章：	55
203、	【百合知母汤栝蒌牡蛎散治百合病精神疾病医案】吴才伦：	55
204、	【栝蒌牡蛎散合百合知母汤胸闷乳胀周身瘫软乏力神经官能症医案】秦书礼：	55
第十九章 大承气汤方证		55
大承气汤方：		55
205、	【大承气汤治神志恍惚歌唱无序歌唱无序】曹颖甫门人：	56
206、	【大承气汤汤汗出烦躁不宁谵语咳嗽吐黄痰腹胀不大便医案】胡希恕：	57
207、	【循衣摸床谵语不可治医案】许学士：	57
208、	【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：	57
209、	【大承气汤治低热不大便医案】樊文有：	57
210、	【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：	58
211、	【承气汤治大便不通谵语心中懊憹】许学士：	58
212、	【大承气汤证治大便八日不行脉实心痛彻背医案】曹颖甫：	58
213、	【大承气汤证坐则满头剧痛咳嗽引腹中痛不可忍治医案】曹颖甫：	58
214、	【大承气汤证治目中不了了睛不和壮热头汗出脉大便闭医案】曹颖甫：	59
215、	【大承气汤证治厥应下之医案】曹颖甫：	60
216、	【大承气汤合滨芍顺气汤加减急下宿食兼清湿热赤痢】	60
217、	【大承气汤产后燥热腹胀】	61
218、	【大承气汤瘟疫身黄发斑】	61
219、	【大承气汤下之伤寒便闭呃逆医案】	61
220、	【大承气汤产后阳明病】	61
221、	【大承气汤加桃仁丹皮发狂见鬼多言骂詈不认亲疏】	62
222、	【大承气汤加黄连阳明大实】	62
223、	【大承气汤恶寒发热，小便淋涩，大便不行】名医类案：	63
224、	【宜大承气汤十日不大便，恶气冲脑，则阙上痛，脑气昏，则夜中谵语】	63
225、	【大承气汤治哕而腹满】曹颖甫：	65

226、	【大承气汤治不大便呕吐渴而饮水】曹颖甫：	65
227、	【大承气汤治不大便呕吐】曹颖甫：	65
228、	【白虎加人参汤治阳明津竭】张锡纯：	65
229、	【大承气汤证治大便八日不行脉实心痛彻背医案】曹颖甫：	66
230、	【大承气汤证坐则满头剧痛咳嗽引腹中痛不可忍治医案】曹颖甫：	67
231、	【大承气汤证治目中不了了睛不和壮热头汗出脉大便闭医案】曹颖甫： ...	67
232、	【大承气汤证治自利清水色青医案】曹颖甫：	68
233、	【大承气汤产后燥热腹胀】	68
234、	【大承气汤证治厥应下之医案】曹颖甫：	69
235、	【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：	69
236、	【大承气汤治低热不大便医案】樊文有：	69
237、	【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：	70
238、	【大承气汤治惕而不安急黄发斑（肝昏迷前期）医案】夏发镛：	70
239、	【承气汤治大便不通谵语心中懊憹】许学士：	71
240、	【大承气汤加石膏瘟疫病阳明急下证】	71
241、	【大承气汤治不大便】姜春华	71
242、	【大承气汤治不寐不大便】姜春华	71
243、	【大承气汤伤寒身热便秘】：	71
244、	【大承气汤伤寒失下昏不知人】	72
245、	【大承气妊娠染疫厥阴绝舌卷乳缩】王寿芝：	72
246、	【承气汤治伤寒谵语便秘遗尿】	72
247、	【大承气汤治瘟疫谵语】	73
248、	【大承气汤癫狂】	73
249、	【大承气汤治关格】	73
250、	【大承气痉厥实证挛急抽搐】	73
251、	【大承气癫狂数日不得大便】	73
252、	【大承气伤寒厥证口不能言目不得正视身体不动手足清冷】	73
253、	【大承气大便干结五更咳嗽】李翰卿	73
254、	【大承气加槟榔腹痛二便闭】	73
255、	【大承气汤急性肠梗阻】	74
256、	【大承气汤合调胃燥咳夜不安寐】	74
257、	【大承气汤春温夹食头痛便秘烦躁谵语】	74
258、	【大承气汤加大黄不寐】	74
259、	【大承气汤、小陷胸汤治谵语发狂医案】：	74
260、	【大承气汤产后阳明病】	75
261、	【大承气汤加黄连阳明大实】	75
262、	【大承气汤恶寒发热，小便淋涩，大便不行】名医类案：	76
263、	【大柴胡合桂枝茯苓丸加生石膏哮喘医案】胡希恕：	76
264、	【大承气汤治不寐不大便】姜春华	77
265、	【大承气汤经年头痛】	77
266、	【大承气汤高热谵语，泻水恶臭】	77
267、	【大承气汤痢疾】	77
268、	【大承气汤伤食腹痛】	77
269、	【大承气汤伤寒误补发咳逆】	78

270、	【大承气汤治痢疾下利便浓血医案】	78
271、	【大承气汤腹部胀满拒按便秘】	78
272、	【大承气汤治宿食积滞】	78
273、	【大承气汤治少腹积块】	78
274、	【大承气汤治重感冒后目不了了】	78
275、	【大承气汤治暴发火眼】	78
276、	【大承气汤治产后身热口渴腹痛胸满便秘耳聋医案】	78
277、	【大承气汤加附子治腹痛医案】	79
278、	【大承气汤潮热谵语五日不大便医案】：	79
279、	【大承气汤目肿如桃头痛如劈医案】：	79
280、	【大承气汤目肿如桃头痛如劈医案】邢锡波：	79
281、	【大承气汤大便不通脉洪大而长医案】：	79
282、	【大承气汤四肢俱冷，六脉俱无医案】：	79
283、	【大承气汤阙上痛大便八日不行医案】：	79
284、	【大承气汤右髀牵掣膝外痛腹满不大便医案】：	79
285、	【大承气汤按脐则痛医案】：	80
286、	【大承气汤壮热头汗出大便闭医案】：	80
287、	【大承气汤脐周阵发性疼痛伴吐蛔医案】何语金：	80
288、	【跌阳大而有力乃知腹有燥矢大承气汤伤寒厥证】	80
289、	【大承气汤治发热口渴咳嗽不大便但见白睛黑睛全无医案】黎庇留：	80
290、	【大承气汤治多食多便舌苔中黄厚而燥医案】周凤梧：	80
291、	【大承气汤治腹部膨胀如鼓腹硬拒按肠梗阻医案】张仁宇：	81
292、	【大承气汤治睡中遗尿医案】秦亮：	81
293、	【大承气汤治下腹压痛医案】李素卿：	81
294、	【大承气汤治午后壮热大便秘结医案】熊寥笙：	81
295、	【大承气汤治牙龈红肿充血便秘医案】王国勤：	82
296、	【大承气汤治咽痛医案】秦亮：	82
297、	【大承气汤治口腔溃烂医案】秦亮：	82
298、	【大承气汤腹胀拒按口气臭秽医案】覃海能：	82
299、	【大承气汤治麻疹医案】陆安铝：	82
第二十章	大柴胡汤证	83
300、	【大柴胡汤治精神分裂症颜面痤疮医案】曾荣修：	83
301、	【大柴胡汤兼用当归芍药散治腹中痛大便难通】吉益南涯：	83
第二十一章	防己地黄汤证	83
	防己地黄汤方：	84
302、	【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民：	84
303、	【防己地黄汤治癲证医案】高齐民：	85
304、	【防己地黄汤不寐医案】高齐民：	85
305、	【防己地黄汤狂痹案】高齐民：	85
306、	【防己地黄汤治寒痹医案】高齐民：	85
307、	【防己地黄汤阴虚外感医案】高齐民：	85
308、	【防己地黄汤失心风案案】高齐民：	86
309、	【防己地黄汤四十年少寐医案】高齐民：	86
310、	【防己地黄汤治神经衰弱案医案】高齐民：	86

311、	【防己地黄汤恐惧性失心风治验案】高齐民：	87
312、	【防己地黄汤治案失心风案】高齐民：	87
313、	【防己地黄汤加味医案】赵守真：	87
314、	【防己地黄汤加味治失心风精神病医案】赵守真：	88
315、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正：	88
316、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正	89
317、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正医案：	89
318、	【防己地黄汤治患慢性风湿性关节炎医案】谭日强：	89
319、	【防己地黄汤治手足抽搐医案】何耀普：	89
320、	【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫：	89
321、	【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫：	90
第二十二章 甘草小麦大枣汤方证		90
甘草小麦大枣汤方：		93
322、	【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方：	93
323、	【妊娠四五个月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方：	93
324、	【甘草小麦大枣汤治精神病医案】岳美中：	93
	【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云	93
	【甘麦大枣汤喉暗医案】马玉起	93
	【甘麦大枣汤医案（虚损）】叶天士	93
325、	【甘麦大枣汤梅核气(慢性咽炎)医案】王振录：	93
326、	【甘麦大枣汤午后低热五心烦热医案】林君平：	94
327、	【甘麦大枣汤干咳无痰医案】刘铁蕃：	94
328、	【甘麦大枣汤盗汗医案】周意萍：	94
329、	【甘麦大枣汤尿道涩痛医案】邵金治：	94
330、	【甘麦大枣汤小便不禁医案】张正海：	94
331、	【甘麦大枣汤泄泻(癔病性泄泻)医案】刘一民：	95
332、	【甘麦大枣汤闭经医案】王国璜：	95
333、	【甘麦大枣汤产后自汗医案】吴德熙：	95
334、	【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：	95
335、	【甘麦大枣汤多动症医案】孙浩：	95
336、	【甘麦大枣汤小儿夜啼医案】周意萍：	96
337、	【甘麦大枣汤小儿厌食医案】周意萍：	96
338、	【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】娄绍昆	96
339、	【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】	97
340、	【用甘麦大枣汤治疗剧烈的头痛】矢数道明:	97
341、	【甘麦大枣桂枝加桂汤合方治面赤筋胀浑身大汗悲伤欲哭】陆渊雷：	98
342、	【甘麦大枣汤治无故悲泣不止】	98
343、	【甘麦大枣汤治遇昼则惨戚悲伤】	98
344、	【甘麦大枣汤硝石大圆治腹皮挛急小腹有块】	99
345、	【甘麦大枣汤治笑不止】	99
346、	【甘麦大枣汤治小儿昼夜啼哭不止】	99
347、	【甘麦大枣汤治发痴狂呼妄骂】	99
348、	【甘麦大枣汤治之子宫病】	99
349、	【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：	99

350、	【洪氏用百合知母汤合甘麦大枣汤治疗失眠 60 例】	99
351、	【百合滑石散合甘麦大枣汤加味治分手后失眠医案】	99
352、	【酸枣仁汤合甘麦大枣汤抑郁症】	100
353、	【酸枣仁汤治哭骂不休夜不睡觉神志失常医案】张孟林:	100
354、	【酸枣仁汤治经常夜间抽风医案】张孟林:	101
355、	【酸枣仁汤治惶恐不安且颤抖不已医案】于德正:	101
356、	【酸枣仁汤治肝豆状核变头部与右侧肢体皆震颤不眠医案】丁德正:	101
357、	【酸枣仁汤治经常夜间不眠不自主地运动自语不休医案】张孟林:	101
358、	【甘麦大枣汤治脏躁病案】:	101
359、	【酸枣仁汤治患焦虑性神经症医案】丁德正:	102
360、	【酸枣仁汤治患者精神沮丧患忧郁症医案】丁德正:	102
361、	【酸枣仁汤言语恍惚恶食不寐】	102
362、	【酸枣仁汤治疗癲狂】:	102
363、	【酸枣仁汤合黄连温胆汤治疗忧郁症】	102
第二十三章 柴胡加龙骨牡蛎汤方证		103
364、	【柴胡加龙骨牡蛎汤调瓜蒂散治幼患癲病长而益剧】	103
第二十四章 防己地黄汤方证		103
防己地黄汤方:		104
365、	【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民:	104
366、	【防己地黄汤治癲证医案】高齐民:	105
367、	【防己地黄汤不寐医案】高齐民:	105
368、	【防己地黄汤狂痹案】高齐民:	105
369、	【防己地黄汤治寒痹医案】高齐民:	106
370、	【防己地黄汤阴虚外感医案】高齐民:	106
371、	【防己地黄汤失心风案案】高齐民:	106
372、	【防己地黄汤四十年少寐医案】高齐民:	106
373、	【防己地黄汤治神经衰弱案医案】高齐民:	107
374、	【防己地黄汤恐惧性失心风治验案】高齐民:	107
375、	【防己地黄汤治案失心风案】高齐民:	107
376、	【防己地黄汤加味治失心风精神病医案】赵守真:	108
377、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正:	108
378、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正	108
379、	【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正医案:	109
380、	【防己地黄汤治患慢性风湿性关节炎医案】谭日强:	109
381、	【防己地黄汤治手足抽搐医案】何耀普:	109
382、	【防己地黄汤治心悸胸闷医案】魏雪舫:	109
383、	【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫:	109
384、	【防己地黄汤治精神病】高齐民:	110
第二十五章 抵当汤方证		110
抵当汤方:		112
385、	【抵当汤合桃核承气汤失笑散治头皮上头发紧精神分裂症医案】刘渡舟:	112
386、	【抵当汤治眼珠子痛棕褐色斑医案】刘渡舟:	112
387、	【抵当汤治脑血管瘤、头痛伴有偏盲医案】郝万山:	113
388、	【抵当汤合大柴胡汤治皮肤有紫癍医案】胡希恕:	114

389、	【太阳蓄血证抵当汤治发狂医案】许学士：	114
	【五苓散和桃核承气汤治太阳蓄血太阳蓄水证同时存在医案】郝万山：	114
390、	【桃仁承气治蓄血证全身发黄医案】日本《生生堂治验》：	115
391、	【抵当汤与瓜蒂散治腹脉坚实心下硬塞月经不来奇怪医案】漫游杂志：	116
392、	【抵当汤治壮热舌赤目赤发狂】《续名医类案·热病》	116
第二十六章 桂枝加龙骨牡蛎汤		116
393、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治心悸】：	117
394、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治心悸】：	118
395、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治女子梦交】：	118
396、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈反复噩梦 1 年】网文：	118
397、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈脱发 2 年案】网文：	119
398、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈脱发 6 年案】网文管志敏：	119
399、	【经方桂枝加龙骨牡蛎汤生发黑发】网文古朴中医：	119
400、	【经方桂枝加龙骨牡蛎汤治脱发案例】网文：	120
401、	【桂枝加龙骨牡蛎汤腰痛医案】网文：	120
402、	【桂枝加龙骨牡蛎汤证治精气不固两足乏力医案】曹颖甫：	120
403、	【桂枝加龙骨牡蛎汤证治夜寐喜盗汗医案】曹颖甫：	120
404、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治脱发医案】陈兆祥：	121
405、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治每伤风即吐血梦泄医案】张璐：	121
406、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治项部自汗竟日淋漓不止医案】岳美中：	121
407、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治间歇性盗汗医案】付美青：	121
408、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治上半身烘热汗出医案】张秀云：	122
409、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治夜不能寐寐则梦遗医案】赵守真：	122
410、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦：	122
411、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治小至今每夜尿床医案】叶益丰：	122
412、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：	122
413、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：	123
414、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治患心慌气短医案】罗卫东：	123
415、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治失眠年余寐则乱梦医案】叶益丰：	123
416、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治眩晕耳鸣心悸寐差汗多怕风医案】叶益丰：	123
417、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：	123
418、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育：	124
419、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治阴囊阴茎及小腹冰冷医案】：	124
420、	【桂枝汤加龙骨牡蛎黄芩汤治头晕耳鸣医案】叶益丰：	124
421、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治气从少腹上冲医案】张德超：	124
422、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗精 5 年屡治不愈视力逐渐下降医案】叶益丰：	124
423、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治咳嗽气喘医案】魏如恢：	124
424、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗泄无梦阳痿不举医案】：	125
425、	【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗精十余年医案】：	125
426、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治遗尿】宁飞：	125
427、	【桂枝龙骨牡蛎汤之夜必遗尿治验】陆自量：	126
428、	【桂枝加龙牡治遗尿】浅田宗伯：	126
429、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治小儿尿床 8 年】西湖虫二：	126
430、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治遗尿医案】叶益丰：	127

431、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治梦交医案】廖仲颐：	127
432、	【桂枝加龙骨牡蛎汤治梦交医案】李光琰：	127
433、	【桂枝加龙骨牡蛎汤合五苓散治失眠下肢肿】	128
434、	【桂枝加龙骨牡蛎汤癫狂医案】张季云：	128
435、	【桂枝加龙骨牡蛎汤昏厥(瘧病)医案】付美育：	128
436、	【桂枝加龙骨牡蛎汤发热医案】叶益丰：	128
437、	【桂枝加龙骨牡蛎汤奔豚医案】张德超：	129
438、	【桂枝加龙骨牡蛎汤遗精半载】	129
439、	【桂枝加龙骨牡蛎汤遗精十余年】	129
第二十七章 半夏厚朴汤方证		129
440、		129
半夏厚朴茯苓生姜汤方：		129
441、		129
442、		129
443、		129
444、		129
445、		129
446、	【半夏厚朴汤合梔豉汤治精神病案】：	132
447、	【半夏厚朴汤治咳嗽喉痒不利病案】：	133
448、	【半夏厚朴茯苓生姜汤治喉中梗梗有肉炙脔】孙文垣：	133
449、	【半夏厚朴茯苓生姜汤治滴水下咽则烦躁欲死】：	133
450、	【半夏厚朴汤食道癌术后食道糜烂(噎膈)】张磊昌：	133
451、	【半夏厚朴汤甲状腺腺瘤(瘰癧)】金国梁：	133
452、	【半夏厚朴汤颈淋巴结(核)肿(瘰癧)】金国梁：	134
453、	【半夏厚朴汤治瘧病】	134
454、	【半夏厚朴汤合金铃子散小儿郁滞腹痛】	134
455、	【半夏厚朴汤治浮肿了一年】娄绍昆：	134
456、	【梔子甘草豉汤合厚朴半夏汤治咽中贴贴】李振华：	136
457、	【半夏厚朴汤治脖子上先天性水瘤】费维光：	136
第一章 附方：李杲三圣散方证		137
三圣散：（《儒门事亲》）		137
458、	【瓜蒂散治水积医案】	138
459、	【三圣散白虎加人参汤治男子狂病大便燥】	138
460、	【瓜蒂散治妇人发狂】	139
461、	【三圣散治全身麻木目不能视口不能言】	139
462、	【瓜蒂散治卒然腹痛入于阴囊】	139
463、	【三圣散治缠喉风】	139
464、	【瓜蒂治妇人状如癲病】	139
465、	【吐剂治患喘多年】汤本求真：	139
466、	【瓜蒂赤小豆末以藿汁使服之治病证发则乱言】	139
467、	【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤面有疣赘】	139
468、	【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤少腹有物】	140
469、	【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤右半身不仁】	140
第一章 甘草泻心汤方证		140

甘草泻心汤方：	140
470、 【甘草泻心汤治疗常无故悲伤】	140
471、 【甘草泻心汤治疗梦游症】	140
472、 【甘草泻心汤治疗精神病】	141
473、 【甘草泻心汤治疗心下有痞满】	141
474、 【甘草泻心汤治疗心下有痞满疹不能出】	141
475、 【甘草泻心汤治疗心下有痞满下利不止】	141
476、 【甘草泻心汤治疗心下有痞满口中糜烂】	141
477、 【甘草泻心汤治夜间卒昏冒状如癫痫而吐沫】	141
478、 【甘草泻心汤治时健忘而骂詈】	141
479、 【甘草泻心汤治自言自语哭笑不休精神病】	141
480、 【甘草泻心汤治癫痫半年余病】	142
481、 【甘草泻心汤重症神经衰弱严重失眠】朱木通：	142

罗序

古有《名医类案》，造福后世也。现效古人之法，搜集网上网下治精神病经验之方，整理成册，让大家学习借鉴之用，名之《大芒山精神病经验集》。看看别人治病的思路和验方。

这些经验集，方药是能治好病的，真是验方，但是有些作者虽然说明的医理，未必对，因为是网上搜集而来的，本来医家的理论水平问题得不到验证，一般来说，他所述的情况就是，确实用对了药，治好了病。所以大家看的时候应当勤加思考，多从证状和药方进行分析研究。对于作者的病情辨析情况要存疑问。包括我说的说话也是如此，所以我在文中用“思考”二字，因为这是我的思考，对不对，还是一个疑问。

书中的方药用量，我能注明年代的，都注明年代，比如汉代的，你要转换成现代的重量，要不然，会吃坏人。

至于疮疡的疾病，笔者在另一本书《罗校外科正宗》中收集有相关医案。这是第一版稿，未完成，这个版本只是收集，作简单整理。因为整理的过程太复杂，要先观看思考，整理修改，提出思路，很耗时耗力。

这个书在持续更新中，本书的电子网络版本往往不是最新版本。想印刷最新版本的请联系下边的印刷。

这个书有什么错误的地方，希望加我 QQ: 284377157（微信同）告诉我。这本书是没有发行版的，喜欢这个书的朋友，可直接联系网友印刷，微信号: mimi20030926，或者微信号: LMJ2238245774，加他注明“印书”就是了。或者扫以下印刷商的二维码加好友，我把最新整理版本发给他。

Capybara
广东 佛山



印刷商的微信二维码

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

罗美坚
广东 云浮



印刷商的二维码

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

（印书请扫二维码加好友，备注印书）

罗维跃 2019 年于加益 大芒山脚下

第一章 （《妇人良方》）妇人风邪颠狂方论

【原文】：妇人颠狂，犹血气虚而风邪所乘，若邪并於阳则发狂，邪并於阴则发颠。

罗按：此言“妇人颠狂”而不言男子，故知妇人颠狂者多与经血相关也。古人限于当时的认识，以为“妇人颠狂”者，多因伤于风而发，故曰风邪。此条所言“妇人颠狂”是与血相关，因于风邪所引发。何也？人之血中，皆含代谢产物，而代谢产物又能产生氨类物质，而氨类物质容易受热分解，故病有病发于阳则狂，内在意义是因为阳胜则热，热则令氨分解，氨入于脑，脑受刺激，故令人狂。而“邪并于阴则发颠”者，因阴不发热，故氨的分解不如阳，但也能令人发颠，身体不受控制。

缘何经血令人颠狂？所谓经血，也是生殖系统的代谢产物。倪师所谓奶水也是经血。是乳房中奶水与胞宫内代谢产物的排出。若是不能排出，必还于血液，上注于脑。故令颠狂。故治颠狂，也是治血。

缘何颠狂发于风邪？病人先有经血疾病，隐而不发者，一是因身体尚具备抵抗能力；二是未达到颠狂这个临界点。若是受风邪所伤，结果有几：一是腠理失常，代谢产物不能从皮肤排出，令毒素堆积；二是风邪令人发热，热令氨生，故令人发狂。

故知治法，一是恢复皮肤的排泄功能，如是谓有风邪之证，须治风。二是恢复月经的排泄功能。若血蓄于下焦，则治蓄血。世人皆以为颠狂发于脑，此言差矣。病位在于脑，而病根在于血。

【原文】：夫颠者卒发而意不乐，直视仆地，吐涌涎沫，口 目急，手足撩戾，无所知觉良久而苏。

【原文】：狂者少卧不饥，自高贤，自辩智，自贵倨，妄笑歌乐，妄行不休。

素问云：“阳厥狂怒，饮以铁落。”狂怒出於肝，肝属木，铁落金也。以金制木之意一妇人眼见鬼物，言语失富，循衣直视，或作心病治之，无效投养正丹二服，前乳香，送三生饮立愈。

原按：前症刘宗厚先生云：“有在母腹中受惊者，或有闻大惊而得者。盖惊则神不守舍舍空则痰涎归之，或饮食失节，胃气有伤，痰停胸膈而作，当寻火寻痰固元气若顽痰胶固上膈，必先用吐法，若在肠胃，亦须下之。”

窃谓此症若因元气虚弱，或痰盛发 等，皆是虚象，如慢惊症无风可祛，无痰可遂但补脾胃，生气健旺，神智自清，痰涎自化，若误用辛散祇逐脑麝之剂，必为败症。

罗按：素问云：“阳厥狂怒，饮以铁落”，所谓“铁落”者，是打铁时产生的铁的氧化物，实际上人皆以铁锈之水代用。以其铁离子能生血故也，产生健康的血，故能治狂。

【附治验】：

1、【因惊而癫】

妇人素清苦，因惊而癫，或用风痰等药，愈甚，余用参、芪、归、术浓煎佐以姜汁、竹沥三斤馀，方愈。（参考谵语乍见鬼神力）

防风茯神散：

治风颠啼泣歌笑，或心神恐惧，或语言失常。

防风、茯神去木、独活、人参、远志去心、龙齿、菖蒲去毛、石膏、牡蛎煅各一两、秦艽、禹馀粮煅、桂各五钱、甘草炒三分、蛇蛻一条(炙)。

右每服五钱，水煎服。

牛黄清心丸：

治诸风缓纵不随，言语蹇涩，痰涎瓮盛，怔忡健忘，或发癫狂。

第二章 《妇人良方集要》妇人怔忡惊悸方论

罗注：此章出自《证治准绳-女科》卷。

【原文】夫心藏神，为诸脏之王，血气调和，则心神安静。若劳伤心血，外邪乘袭，则心神惊悸恍惚，忧 不安，用排风汤治之。

证治准绳云：妇人血风惊悸者，是风乘于心故也。心藏神为诸脏之主，若血气调和，则心神安定。若虚损则心神虚弱，致风邪乘虚袭之，故惊而悸动不定也。其惊悸不止，则变惚恍而忧惧也。（排风汤亦可用。）

排风汤：（《太平惠民和剂局方》）

男子、妇人风虚冷湿，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱。肝风发则面青心闷，吐逆呕沫，脉满头眩重，耳不闻人声，偏枯筋急，曲拳而卧。心风发则面赤翕然而热，悲伤嗔怒，目张呼唤。脾风发则面黄，身体不仁，不能行步，饮食失味，梦寐倒错，与亡人相随。肺风发则面白，咳逆唾脓血，上气奄然而极。肾风发则面黑，手足不随，腰痛难以俯仰，痹冷骨疼。若有此候，令人心惊，志意不定，恍惚多忘。服此汤安心定志，聪耳明目，通脏诸风疾。

白藓皮、当归（去芦，酒浸一宿）、肉桂（去粗皮）、芍药（白者）、杏仁（去皮、尖，麸炒），甘草（炒）、防风（去芦）、芎藭、白术各二两。独活（去芦）、麻黄（去根、节）、茯苓（去皮、白者），各三两。

上为粗末。每服三钱，水一盞半，入生姜四片，同煎至八分，去滓，温服，不计时候。

愚按：丹溪先生云：“惊悸者，血虚，用朱砂安神丸。痰迷心窍，用定志丸。怔忡者属火属痰，思虑便动者。属虚。时作时止者，火动也。假如病因惊而致惊则 出其舍，痰乘而人矣。”盖人之所王者心，心之所养者血，心血一虚，神气不守，此惊悸之所由作也治当调养心血，和平小气而已。

2、【目愧成病言语失伦而死】

金氏妇，壮年，暑月赴筵，归乃姑询其坐次失序，遂赧然自愧，因成此病。言语失伦，两脉弦数。予曰：此非邪，乃病也，当补脾导痰清热，数日当自安。不信，邀数巫者喷水咒之而死。或谓病既无邪，以邪治之，何至于死？予曰：暑月赴筵，外受蒸热，辛辣适口，内伤郁热，而况旧有积痰，加之愧闷，其痰愈盛。又惊以法尺，益惊其神而气血不宁，喷以法水，闭其肌肤而汗不得泄，内燔则阴既销而阳不能独立，不死何待？

故滑伯仁先生云：若胆气虚寒，用茯神汤。胆气实热，用酸枣仁丸。心气虚热，用定志膏、茯苓补心汤。心气实热，用朱砂安神丸、茯神散。

附治验：**3、【补中益气汤加炮姜治崩血昏愤发热不寐】**

文学归云桥内人，月事不及期，忽崩血昏愤，发热不寐，或谓血热妄行，投以寒剂益甚。或谓胎成受伤，投以止血，亦不效。余曰：此脾气虚弱无以统摄故耳，法当补脾而血自止，用补中益气汤（杂病伤劳倦）加炮姜，不数剂而验。惟终夜少寐惊悸，别服八物汤不效。余曰：杂矣，乃与归脾汤（杂病健忘）加炮姜以补心脾，遂如初。（《证治准绳》）

4、【归脾汤八珍汤治心跳怔忡寒热往来】

一妇人劳则心跳怔忡，寒热往来，用归脾汤为主，佐以八珍汤，诸证渐愈，又用加味道遥散、宁志丸而安。后复作，服归脾、定志二药即愈。

5、【归脾汤八珍汤治惊悸怔忡日晡发热】

一妇人患惊悸怔忡，日晡发热，月经过期，饮食少思，用八珍汤加远志、山药、酸枣仁，三十余剂渐愈，佐以归脾汤全愈。后因劳发热，食少体倦，用补中益气汤。又因怒，适月经，去血不止，前证复作，先以加味道遥散散热退经止，又用养心汤治之而痊。

6、【归脾汤惊悸怔忡无寐】

一妇人惊悸怔忡无寐，自汗盗汗，饮食不甘，怠惰嗜卧，用归脾汤而愈。至年余怀抱郁结，患前证兼衄血、便血，仍用前汤而愈。

茯神散：

治五脏血虚弱，惊悸怔神，宜用此安神定治，

茯神（去木），人参、龙齿（另研）、独活、酸枣仁（炒）各三钱、防风、远志（去心）、桂心、细辛、白微炒各三钱、干姜（炮）各三两。

上为末，每服四五钱，水煎服，或蜜为丸服。

7、茯苓补心汤：

治心气不足，善悲愁怒，衄血面黄，五心烦热，或咽喉痛舌本作强。

茯苓四两、桂心、甘草（炒）各三两、紫石英（虾）、人参各一两、大枣二十枚、麦门冬（去心）三两、赤小豆二十四粒

右水七升煎二升半，分三服。

8、茯神汤：

治胆气虚冷，头痛目眩，心神恐畏，不能独处，胸中烦闷。

茯神（去木）、酸枣仁（炒）、黄芪（炒）、柏子仁（炒）、白芍药（炒）、五味子（炒）各一两、桂心、熟地黄自制、人参、甘草（炒）各半两，

右每服五钱，姜水煎。

9、酸枣仁丸：

治胆气实热，不得睡卧，神思不安，惊悸怔忡，

茯神（去木）、酸枣仁（炒）、远志（去心）、柏子仁（炒）、防风各一两、枳壳麸炒、生地黄杵膏各半两、青竹茹二钱五分。

上为末，炼蜜丸，桐子大，每服七八十丸滚汤下。

10、定志丸：

治心神虚怯，所患同前，或语言鬼怪，喜笑惊悸。

人参、茯苓各一两五钱、菖蒲、远志去心各一两，

上为末，蜜丸，如前服。

11、养心汤：

治心血虚，惊悸怔忡不宁，或盗汗无寐，发热烦燥。

黄芪（炒）、白茯苓、茯神（去木）、半夏、当归（酒炒）、川芎各半两、辣桂去皮、柏子仁、酸枣仁（炒）、五味子（杵炒）、人参各三钱、甘草（炙）四钱。

右每服三五钱，姜枣水煎。

12、朱砂安神丸：

治心经血虚头晕，心神惊悸等症，

朱砂（飞过）五钱、黄连（酒洗）六钱、甘草（炙）五钱、生地黄、当归各一钱五分。

上为末，饭糊为丸，每服十五丸《如一二服不应，当服归脾汤补之。

13、治要茯苓散：

治心经实热，口乾烦渴，眠卧不安，或心神恍惚。

麦门冬、茯神各一两半、通草、升麻各一两二钱半、赤石脂一两七钱五分、知母一两、大枣十二枚、紫苑、桂心各七钱五分、淡竹茹五钱每服一两，

水煎。

第三章 瓜蒌瞿麦丸方证(高齐民)

【原文】小便不利者，有水气，其人若渴，瓜蒌瞿麦丸主之。

瓜蒌瞿麦丸方：

瓜蒌根二两（6g），茯苓三两（9g），山药三两（9g），附子一枚（炮）（3g），瞿麦一两（3g）。

上五味，末之，炼蜜为丸梧子大，饮服三丸，日三服。不知，增至七八丸，以小便利、腹中温为知。

方解：山药、天花粉生津止渴，茯苓、瞿麦渗泄水气，佐以附子的温化，可以使水气畅利，而小便自利。合方功用温中水气。

什么是水气病？师曰：“有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗。”瓜蒌瞿麦丸证“小便不利者，有水气”，是因湿热下注，膀胱气化失司，产生水气，故出现尿急、尿频、尿痛及小便不利。

本方是治疗泌尿系感染即湿热下注第一方。其特点，治疗后很少反复发作。有的病人吃完导赤散、小蓟饮子等很快痊愈，但一劳累，泌尿系感染又发作。服用瓜蒌瞿麦丸，病人很少反复。

60年前，我因未冲出瓜蒌瞿麦丸（汤）的误区，见到此病尿频、尿急、尿痛、小便淋漓、尿道烧灼疼，用导赤散的多，不敢用此汤。我请教恩师宋孝志先生，他说：“本方用附子，因膀胱气化失司，故少加附子温化水气，附子用量最多3g，多则两肾发热。仲景提出‘腹中温为知’。我在临床上瓜蒌瞿麦汤处方：天花粉9g，附子3g，山药9g，瞿麦3g，茯苓9g。”

查阅文献，瞿麦一味能杀血吸虫，我用瞿麦碾细，每服5~10g，每日2次，选择50个病人，15天为1个疗程。病人服药8~10天开始便秘，每人1天再发1两蜜润肠，结果一个病人也未治愈。

我用此方治湿热下注（泌尿系感染）数以百计，得心应手，疗效显著。最使我敬佩的是治愈后极少再次发作。我的夫人1966年夏该病治愈，至今40多年未再犯过。本方还可治疗前列腺炎、狼疮尿癰闭、糖尿病泌尿系感染，以及瘰疬、皮肤感染等。

不能因为湿热而忘掉“膀胱者，州都之官，气化则能出焉”，只会清利湿热，只是学会治标；加附子助膀胱气化，才是标本兼治，才是取法于上的高明治法。经恩师指点迷津，我才学会标本兼治之法。此病之所以反复不愈，就是没有治本之法。使我第一次知道仲景用药之神奇。

最近药房出了一个新规矩，因瓜蒌反附子，牵连了天花粉，要另签一字。我常把1个方，

开成 2 个，再去合煎，免了病人很多麻烦。天花粉反附子，医圣怎么会不知道呢！

临床报道：瓜蒌瞿麦丸治疗（1）水肿；（2）癰闭；（3）热淋（肾盂肾炎）；（4）石淋；（5）遗尿；（6）消渴；（7）产后阴户内收。

14、防己地黄汤

方证：见《金匱要略·中风历节病脉证并治》篇“治病如狂状，妄行独语不休，无寒热，其脉浮，防己地黄汤主之。”

防己一钱（3g），桂枝三钱（9g），防风三钱（9g），甘草一钱（3g），生地黄二斤（150g）。上五味，前四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁，生地黄二斤咬咀，蒸之如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

方解：本病又名“失心风”，起于肝气郁结，故用防风以舒肝，防己利水湿，以防痰迷心窍。因肝郁不解，心肾失调，心躁，心火燎原，扰动六神不安，故用桂引肾气上交于心，生地上熄滔天之心火，下滋肾水之枯，使心肾水火既济，心风自然消失。防己导水，又善搜经络风湿，防痰邪形成。合方功用安神治狂。

14、【防己地黄汤艾怨而狂】高齐民：

1960 年冬，我第一次用治 1 例七十多岁老者，因艾怨而狂，夜间外出，不管谁家的自留地的蔬菜全部拔光。村里无法，动用民兵把他用铁链拴起来，春节倒放他出来拜年，可他又把人家祭祖的馒头装到裤裆里。我应朋友之约来到黄花镇村，村干部把他带来看病。因提前知道他是“失心风”，诊完脉，病人要喝酒，我便开了防己地黄汤：桂枝 6g，防风 6g，防己 6g，甘草 6g，4 味用酒浸泡，另生地 100g 放笼里蒸一顿饭许，待温，同药酒放铜盆中混合，5 副，1 副只浸蒸 1 次。

我回北京请教恩师宋孝志先生，他说方子开得与方证相符，本方的关键是掌握君药生地的分量。“生地二斤”，我的经验最少 40g，最多 150g，超过 150g，病人则感躁烦不舒；若病重药轻则疗效就差。用此方后，病人反映：“服了防己地黄汤，我的脑子比以前更聪明了”。第三届中国当代名医集萃大会期间，住在太原迎泽宾馆。一天，吃完晚饭散步时，我和刘渡舟老师相遇，他谦逊地问我：“宋老用防己地黄汤，生地最重用多少克？”我告诉他：“最重用 150g”。

我常用此方治狂病，弃衣而走，登高而歌，裸体不避亲戚之“失心风”；愈后反复，再用仍效。

我用此方治抑郁症，日夜不寐，药后即能入睡。治不寐症，少则五六年，多则四十多年，用此方治更年期心烦、不寐，用此方治不明原因的不寐，效果都很好。

处方：生地 40~60g，防己 9g，防风 9g，桂枝 9g，甘草 6g。

药煎好，晚上服头一煎，煮好倒入碗内，温时加入白酒一小杯（八钱~一两）；不会用酒，可于服药后加服甜酒一杯以助药力；若对酒过敏，则可以不用酒。

15、【防己地黄汤失心风】高齐民：

“失心风”多因郁怒不解而病，也有因惊吓而狂者。今年秋治 1 例患者，4 岁时因做扁桃腺手术，4 个护士按住手脚，手术做完时，患者疯啦，治了 5 年无效。我用防己地黄汤，生地用到 110g，才让小孩安静下来。

我在洛杉矶时，用防己地黄汤治风热犯肌肤，出现皮肤溃烂，西医诊断为剥脱性皮炎。用此方治疗热痹都是以药推出，而不是辨证论治。

清末御医袁鹤侪先生说：“余潜心研讨者，《伤寒论》也……自习医以来，每于医籍中涉及《伤寒论》者，则必加以研究，及读《伤寒论》，更详尽各家论说，以期明晰。”

我开始学医，用六年时间将 1912 年以来各种中医杂志、各省中医杂志刊登的《伤寒杂病论》文章读了一遍，开阔了我运用经方的视野，学会一方治多种病的方法。方法多，方更灵活，常出奇制胜。尤其遇到《伤寒杂病论》疑难方证有老师解难分析的文章，我像孩童过年一样兴奋，并抄录下来反复研读。例如防己地黄汤，在恩师宋孝志先生指导下，我已学会应

用，但对其中一些病见识很浅。

一日读《河南中医》1984年5期，刊登了前辈丁浮艇先生用防己地黄汤治疗癫痫性精神病、癔症性精神病发作、反应性精神病、慢性精神分裂症一文。丁浮艇先生的体会，像一盘珍珠，光辉四射。他说：生地甘重于苦，干生地150g为妥，多则服后心烦，少则难收滋阴养血之效。改蒸为浓煎，法尚效同。“无寒热”，无寒热之象也；“其脉浮”，此为主证之病机，乃血虚而邪客于阳，故其脉当见浮象，但必浮而有力。

其他见症，可见之脉有脉虚数，或细数，或洪大无力，舌质红干少津无苔，烦躁难寐，渴不多饮，身肢拘强，头皮发紧，体表瘙痒等。

少量祛风药置于大量养血剂中，偏重于扶正而轻寓祛邪，堪称“血虚生热，邪并于阳”之佳方；然对于非风邪所伤，由真阴不足，营血郁热，逼及神明所致之症，即反应性精神病，施之收效亦著。

防己地黄汤神妙在“不安神而神自安，不治狂而狂自愈，不解郁而郁自解。”

临床报道：防己地黄汤治疗（1）失心风；（2）狂病（精神分裂症）；（3）癫痫（癫痫性精神障碍）；（4）脏躁（癔症）；（5）痹病（慢性风湿性关节炎）；（6）痉病；（7）心悸（风湿性心肌炎）；（8）剥脱性皮炎；（9）眩晕（高血压）；（10）肿满（肾病综合征）；（11）水肿（急性肾小球肾炎）

第四章 针灸医案集

16、【柱隔姜灸鬼哭穴卒哑不能言医案】高齐氏：

曾治一女孩，年十二，因黑夜外出受惊，卒哑不能言，静卧三日夜不醒。患者面白神呆，手冷握拳，脉息微弱，呼之不应，口噤不开。从病情分析此属“惊厥”，急用艾柱隔姜灸鬼哭穴（在两手大拇指去爪甲如韭菜叶许，两指并拢用线缚之，当两指甲缝中是穴）。灸两壮，患者皱眉缩手；灸至三壮，张目呼痛；至四壮，汗出起坐，口已开，神色和，给沈氏六神汤（二陈汤加胆星、鲜菖蒲叶、旋覆花）善后。

此属无热惊厥。但在临床上最常见的是高热惊厥。例如夏秋之交流行性乙型脑炎，此属中医的暑温范畴。若热重于湿，宜辛凉重剂，如白虎汤之属以清热解毒、熄风定惊治之；如湿重于热，必须轻宣温化，如三仁汤、甘露消毒丹之类。在治疗过程中，要注意“不关门”（畅通汗腺）三个字，退热采用卧地泥疗，此湖南益阳李星鹤老中医经验，是值得效法的。

第五章 男子精神病

17、【四逆汤加肉桂治阴证误下救逆腹痛便秘误以桃仁承气汤下之医案】

昔诊一男，约廿余岁，系一孀妇之独子，体质素弱。始因腹痛便秘而发热，医者诊为瘀热内滞，误以桃仁承气汤下之，便未通而病情反重，出现发狂奔走，言语错乱。延余诊视，脉沉迟无力，舌红津枯但不渴，微喜热饮而不多，气息喘促而短，有欲脱之势。据此断为阴证误下，逼阳暴脱之证，遂拟大剂回阳饮（即四逆汤加肉桂）与服。

附片130克干姜50克，上肉桂13克（研末，泡水兑入）甘草10克

服后，当天夜晚则鼻孔流血，大便亦下黑血。次日复诊则见脉微神衰，嗜卧懒言，神识已转清。其所以鼻衄及下黑血者，非服温热药所致，实由于桃仁承气汤误下后，致血脱成瘀，今得上方温运气血，既已离经败坏之血，不能再行归经，遂上行而下注。嘱照原方再服一剂。服后，衄血便血均未再出，口微燥，此系阳气已回，营阴尚虚，继以四逆汤加人参连进四剂

而愈。方中加入人参者，取其益气生津养阴以配阳也。

18、【大承气汤治神志恍惚歌唱无序歌唱无序】曹颖甫门人：

【按】友人施君。甲戌孟秋某晚，匆匆邀诊乃弟病。入其室，见病者仰卧塌上。叩其所苦，绝不语。余心异之。私谓施君曰：乃弟病久耳聋，无所闻乎，抑舌蹇不能言乎？则皆曰：否。余益惊异。按其脉，一手洪大，一手沈细，孰左孰右，今已莫能记忆。因询家人以致病之由。曰：渠前任某军电职，因事受惊，遂觉神志恍惚。每客来，恒默然相对，客去，则歌唱无序。饮食二便悉如常人，惟食时阙上时有热气蒸腾，轻则如出岫朝云，甚则如窑中烟，状颇怪特。前曾将渠送往本市某著名医院诊治，经二十余日，医者终不识其为何病，既无术以疗，故于昨日迁出，请先生一断。余细按其腹，绝不胀满，更不拒按。沈思良久，竟莫洞其症结。于是遂谢不敏，赧然告辞。

越日，施君告余曰：舍弟之病，昨已延曹颖甫先生诊治。服药后，大泄，阙上热气减。余闻而愕然，遂急访之，并视所服方。忆其案尾略曰：此张仲景所谓阳明病也，宜下之，主以大承气汤。方为：生大黄三钱，枳实三钱，芒硝三钱冲，厚朴一钱。

又越数日，余再晤施君，悉其弟服药后，已能起床，且不歌唱。惟两肋胀痛，经曹师诊治，顷又愈矣。审其方，乃小柴胡汤也。

柴胡三钱，黄芩三钱，党参三钱，半夏三钱，生姜三片，大枣十二枚，甘草二钱嗣是施君之弟似可告无恙矣，顾尚苦自汗，精神不振。又经曹师投以桂枝加龙牡汤，一剂而愈。

川桂枝三钱，大白芍三钱，生草二钱，生姜三片，大枣十二枚，花龙骨五钱，煅牡蛎五钱以上二味先煎。

自此以后，健康逾常人。一日与兄俱出，值余于途，各微笑颔首以过。翌日遇施君，问其弟昨日途间作何语。施曰：无他。固诘之，乃笑曰：彼说吾兄脉理欠精耳。余不禁重为赧然。于是深服吾师医术之神，遂执贽而列门墙焉。

【又按】本案病者所患似系所谓精神病，或神经病。顾西医用神经药治之，绝不见效。中医用经方治之，反奏肤功。其理深奥，莫可究诘，殆所谓治病必求其本欤？按初方系阳明方，次方系少阳方，末方系太阳方。以三方疏其三经之阻滞，诸恙乃痊，殆当日受惊之时，周身筋络器官，即因惊而有所滞乎？顾饮食二便如常，腹不痛，又不拒按，谁复有胆，敢用承气？乃吾师独以阙上热气之故，遂尔放胆用之，殆所谓但见一证便是，不必悉具之意乎？曹颖甫曰：此证予亦不能识，惟诊其脉，则右极洪大，左极微细，阴不足而阳有余，意其为少阴负趺阳之脉，而初非逆证。加以热气出于阙上，病情正属阳明，与右脉之洪大正合。故决为大承气汤的证，而不料其应乃如响也。

19、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝9克，大黄12克，枳实12克，厚朴12克，当归15克。

服1剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服3剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草6克，又服1剂，神识清楚，语言正常。（《陕西中医》1976；（1）：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

20、【桃核承气汤狂证】

房镜堂客游省垣，抱病归，神识不清，言语善恶，不避亲疏，登高而呼，弃衣而走，治经旬日不应。细审之，每当少腹硬满难耐时，其症更甚，乃知蓄血发狂也。外用熨法，内服桃核承气汤。是夜小便下血一瓶，狂少定，服近二十剂，小便渐次清白，病乃痊愈。《疫证治例》

21、【调胃承气汤治癫狂】

一狂人，阴不胜阳，则脉流薄厥，阳并乃狂。《难经》曰：阳极则狂，阴极则颠。阳为腑，阴为脏，非阳热而阴寒也。热并于阳则狂，狂则生寒，并于阴则颠，颠则死。《内经》曰足阳明有实则狂，故登高而歌，弃衣而走，无所不为，是热之极也。以调胃承气汤，下数十行，三五日复上涌一二升，三五日又复下之。凡五六十日，下百余行，吐亦七八度。如吐时，暖室置火，以助其热汗，数汗方平。《续名医类案》

22、【小柴胡加龙骨牡蛎汤汤精神失常狂躁妄动医案】周连三：

彭某某，男，32岁，1963年11月27日诊治。患者在1959年因精神受刺激，导致精神失常，狂躁妄动，打人骂人，久治不愈，住精神病院多方治疗无效，请周老师会诊。证见：面红目赤，狂躁妄动，打人骂人，毁坏器物，撕衣裸体，目光炯炯，少睡少食，哭笑无常，舌质红苔黄腻，脉洪数。症属肝郁化火，痰火上扰。治宜舒肝利胆，祛痰泻火。处方：

柴胡、黄芩各24克，半夏21克，生姜15克，茯苓、龙骨、牡蛎各30克，桂枝9克，铅丹6克，大枣12枚，大黄18克。

服上方后，涌吐痰涎二碗余，泻下风沫，夜能安睡，诸证减轻。后减铅丹为3克、大黄为9克，连续服用4剂，继以它药调治而愈。

23、【通脉四逆汤加人参身热面赤异常大躁】

徐某，伤寒六七日，身热面赤，异常大躁，将门牖洞启，身卧地上，更求入井，口渴索水，到前复置不饮，脉洪大无伦而重按无力。喻嘉言认为此证顷刻大汗，即不可救，乃急投通脉四逆汤加人参，煎成冷服后，寒战戛齿有声，阳微之状始著，再与前药一剂，微汗热退而安。（《寓意草》）

罗按：“洪大无伦”，实际上是脉中之血管比平时大了很多，脉为数脉，比平常快了很多。

24、【通脉四逆汤加人参烦躁闷乱欲绝时索冷水】

一人伤寒，面赤，烦躁闷乱欲绝，时索冷水，手扬足踢，五六人制之，始得就诊，脉洪大无伦而按之如丝。李士材急投通脉四逆汤加人参、白术，煎成用井水冰镇后冷饮，甫及一时，狂躁即定，再剂而神爽。凡服参至五斤而愈。（《续名医类案》）

25、【桂枝甘草龙骨牡蛎汤治癫狂】

纱帽街夏氏子，年甫二十五岁，疯癫，面戴阳，口裂，骨里青惨，扬手掷足，哭笑无时。问病几何时，曰：两月。问服何药，出方予视，不离攻痰败火诸峻剂。强诊，下指如窟，已虚极矣。先以洋参、桂圆，令煎浓汁与服，探其尚任药否。次日来告，得药可睡片刻，醒亦稍静。知可挽回，以桂枝甘草龙骨牡蛎汤投之。详告伊父：此药有旋乾转坤之力，服后狂甚往日，顷刻即定，一定即不复发，断不可令庸耳俗目见吾方，恐无知阻挠也。果一剂即应。往诊，已困卧无力，脉亦收敛，不似前空大无伦矣。原方再进二剂，睡卧安恬，语言有序。以炙甘草汤缓为调理，两月痊愈。桂枝甘草龙骨牡蛎汤：炙甘草五钱，桂枝二钱半，生龙骨五钱，生牡蛎五钱。照原方一两折二钱半为大剂。《寿芝医案》

26、【桂枝甘草龙骨牡蛎汤悸甚而神不宁医案】刘渡舟：

宋先生与余同住一院，时常交谈中医学术。一日，宋忽病心悸，悸甚而神不宁，坐立不安，乃邀余诊。其脉弦缓，按之无力。其舌淡而苔白。余曰：病因夜作耗神，心气虚而神不敛之所致。乃书：

桂枝9克，炙甘草9克，龙骨12克，牡蛎12克凡3剂而病愈。（《新编伤寒论类方》）

27、【桂枝甘草龙骨牡蛎汤治被惊吓致病（瘵病）医案】：

刘某，男，30岁。初诊1966年4月5日：东北泰来地区出现一条疯狗，到处咬人，人人恐惧。一天患者不料遇到疯狗，虽未被咬伤，但被惊吓致病，出现心慌、惊悸、恐惧、失眠等症，用中西药治疗久不见效。经病人介绍而来京找胡老诊治。患者外观泰然，神色无异常，只是感心慌、胸闷、时有恐惧不能自主，常失眠盗汗，舌苔白腻，脉弦数。脉证合参，知为阳虚水逆而致心阳不振，为桂枝甘草龙骨牡蛎汤的适应证：桂枝四钱，炙甘草二钱，茯

苓五钱，生龙骨一两，生牡蛎一两。

上药服六剂，诸症已，高兴回原籍，并来信告之一年多也未复发。

28、【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫：

此公系同乡高长佑先生之友。予因治其妻神经病，始识之。盖其妻饮食如故，但终日歌唱，或达旦不寐。诊其脉滑疾，因用丁甘仁先生法，用猪心一枚剖开，内藏辰砂二钱，甘遂二钱，扎住，向炭炉煨枯，将甘遂朱砂研成细末。一服而大下，下后安眠，不复歌唱矣。后以十全大补汤收膏调之，精神胜于未病时。附录之，以资谈助。

29、【桂枝汤加龙骨牡蛎治心悸易惊医案】罗卫东：

刘某，男，22岁，战士，1985年5月17日初诊。患心慌、气短半年余，查心电图示：预激症候群伴短暂性室上速。西药治疗月余疗效欠佳。刻诊：心悸易惊，四肢末端冷而不温，胸闷气短，动则汗出，头昏目眩，舌质淡嫩，苔薄白，脉细数。诊为惊悸，辨属心阳不足。治宜温补心阳，安神定悸。方药：桂枝12g，白芍12g，炙甘草10g，龙骨20g，牡蛎20g，生姜6g，大枣10g，党参10g，炒枣仁15g。5剂，日1剂，水煎服。

二诊：心悸好转，肢冷转温，仍觉气短，动则汗出。细察舌边尖有小紫色斑点，此乃阳虚夹瘀也，续用上方加丹参、桃仁，连服20余剂，以上诸症消失，复查心电图正常。（国医论坛1995；（6）：18）

30、【小柴胡加龙骨牡蛎汤治精神失常狂躁妄动医案】周连三：

彭某某，男，32岁，1963年11月27日诊治。患者在1959年因精神受刺激，导致精神失常，狂躁妄动，打人骂人，久治不愈，住精神病院多方治疗无效，请周老师会诊。证见：面红目赤，狂躁妄动，打人骂人，毁坏器物，撕衣裸体，目光炯炯，少睡少食，哭笑无常，舌质红苔黄腻，脉洪数。症属肝郁化火，痰火上扰。治宜舒肝利胆，祛痰泻火。处方：

柴胡、黄芩各24克，半夏21克，生姜15克，茯苓、龙骨、牡蛎各30克，桂枝9克，铅丹6克，大枣12枚，大黄18克。

服上方后，涌吐痰涎二碗余，泻下风沫，夜能安睡，诸证减轻。后减铅丹为3克、大黄为9克，连续服用4剂，继以它药调治而愈。

31、【柴胡龙骨牡蛎汤手足乱动行走不稳挤眉弄眼医案】朱进忠：

张某某，女，12岁。手足乱动，行走不稳，挤眉弄眼等五个多月。某院诊为“舞蹈病”。烦躁易怒，时时叹气，脉弦而细。综合脉证，诊为邪入少阳，痰湿内郁，风邪外客。故拟柴胡加龙骨牡蛎汤加减，解少阳，化痰湿，疏风定痉。

柴胡3克，桂枝6克，白芍6克，黄芩6克，半夏6克，党参6克，茯苓6克，生龙骨6克，生牡蛎6克，甘草6克，生姜2片，大枣2枚

服药3剂诸证好转，继服30剂而愈。

【补述】鄢建君在《四川中医》1987年12期中报导：柴胡加龙骨牡蛎汤出自《伤寒论》一书，有镇惊解郁，化痰安神之功。古人除用本方治疗伤寒下后烦惊谵语证外，还治癫、狂、痫、多梦少寐等症。今人则推而广之，用其治疗甲状腺机能亢进、高血压、眩晕等多种疾病。余曾试用本方治疗“甲亢”2例，均导致贫血现象，特报告如下，望能引起同道注意。两例患者均为20岁，皆系纺织厂女工，未婚。均于1980年初起病，同年5月经解放军171医院作基础代谢、扫描等检查，诊断为“甲亢”，回本地医院住院治疗。入院时，两例血常规检查均为正常值，以中药滋阴清热，软坚散结并配合西药他巴唑、维生素类治疗一月余，病情未见好转，此时，血常规检查，仍均属正常。改用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗（原方药味不变，其中铅丹用量9克），服药5~7剂后（西药未停），患者头昏、心悸等症加重，面色及口唇苍白无华。查血：Hb分别下降至8克、7克，RBC分别下降为286万和239万，但WBC仍均正常。遂停用本方，并将中药改为养血健脾法治疗半月，复查血常规才均恢复正常值。

32、【四逆汤腹痛便秘而发热（真寒假热）医案】吴佩衡：

昔诊一男，约20余岁，系一孀妇之独子，体质素弱。始因腹痛便秘而发热，医者诊为瘀

热内滞，误以桃仁承气汤下之。便未通而病情反重，出现发狂奔走，言语错乱。延余诊视，脉沉迟无力，舌红津枯但不渴，微喜热饮而不多，气息喘促而短，有欲脱之势。据此断为阴证误下，逼阳暴脱之证，遂拟大剂回阳饮（即四逆汤加肉桂）与服。

附片 130 克，干姜 50 克，上肉桂 13 克（研末，泡水兑入），甘草 10 克。

服后，当天夜晚则鼻孔流血，大便亦下黑血，次日复诊则见脉微神衰，嗜卧懒言，神识已转清。其所以鼻衄及下黑血者，非服温热药所致，实由于桃仁承气汤误下后，致血脱成瘀，今得上方温运气血，既已离经败坏之血，不能再行归经，遂上行而下注。嘱照原方再服一剂。服后，衄血便血均未再出，口微燥，此系阳气已回，营阴尚弱，继以四逆汤加人参连进四剂而愈。方中加入人参者，取其益气生津养阴以配阳也。

33、【大承气癲狂数日不得大便】

甲寅岁四月初，予随翰耳朵行至界河里住。丑斯兀闾病五七日，发狂乱，弃衣而走，呼叫不避亲疏，手执潼乳，与人饮之。时人皆言风魔了，巫师祷之不愈而反剧。上闻，命予治之。脉得六至，数日不得大便，渴饮潼乳。予思之，北地高寒，腠理致密，少有病伤寒者。然北地此时乍寒乍热，因此触冒寒邪，失于解利，因转属阳明证，胃实谵语，又食羊肉以助其热，两热相合，是谓重阳则狂。阳胜宜下，急以大承气汤一两半，加黄连二钱，水煎服之。是夜下利数行，燥屎二十余块，得汗而解。翌日再往视之，身凉脉静。《卫生宝鉴·泻热门》

34、【大承气汤癲狂】

彰德张相公子谊夫之妻许氏，乃状元许先之女，绍明之妹也。病阳厥怒狂，发时饮食四五倍，骂詈不避亲疏，服饰临丧，或哭或歌，或以刃伤人，不言如哑，言即如狂，素不知书识字，便读文选。人皆以为鬼魔，待其静诊之，六脉举按皆无，身表如冰石，其发也叫呼，声声愈高。余昔闻洁古老人云：本经言夺食则已，非不与之食而为夺食也，当以药大下之而使不能食，为之夺食也。予用大承气汤下之，得脏腑（指肠垢）数升，狂稍宁；待一二日复发，又下之，得便数升，其疾又宁；待一二日又发，三下之，宁如旧。但不能食，疾稍轻而不已，下之又五七次，计大便数斗，疾缓身温，脉生，至十四日其疾愈，脉如旧，困卧三四日后起苏，饮食微进，又至十日后得安。《阴证略例·海藏治验录》

35、【旋复花汤加味崩血不止大便泄泻】王孟英：

如“黄氏妇崩血不止，大便泄泻，半身痹痛。余脉之，右濡、左浮弦略数，知其脾有积湿，肝有郁热，因外风内陷，入肠胃则泄，入血室则崩，窜络则痛也。与旋复花汤加归须、桃仁、柏子仁润血和络，川芎、神曲以化湿，苓、防坚营散风，五服而三恙全愈。”几乎是叶天士本人亲治。

此外，王孟英对旋覆花的祛痰之功也曾谓：“二陈汤去甘草，加旋复花、石菖蒲、胆南星，亦名六神汤，治癲狂昏厥诸痰证，极效”。

36、【大青龙汤眼球炎引起浮肿头痛、眼球痛】

一男子患严重眼球炎引起浮肿，剧烈疼痛，精神若狂躁，痛苦难忍，濒于死亡之境。其脉浮数，头痛发热。先予搐鼻方（瓜蒂末或半夏、皂荚末等，吹入鼻孔。刺激鼻黏膜，使之打喷嚏），夜半再次引起疼痛，与搐鼻方同时用大青龙汤，至天明头痛痊愈。《临床应用汉方处方解说》

37、【柴胡姜桂汤紫圆治独语妄笑】

《建殊录》云：某生徒读书苦学，尝有所发愤，遂倚几废寝七昼夜，已而独语妄笑，指责前儒，骂不绝口，久之，人觉其狂疾。先生诊之，胸肋烦胀，脐上有动，仁气不降，为柴胡姜桂汤饮之，时以紫圆攻之，数日，全复常。

38、【吴茱萸汤治卒然如狂头痛干呕】

《成绩录》曰：一男子，卒然如狂，捧头踊跃，如头痛状，不能言语，干呕，目闭，手足微冷，面无血色，周旋堂中，不得少安。先生与吴茱萸汤，五六帖，痊愈。

罗按：伤寒曰：少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。

39、【柴胡姜桂汤合紫圆治独语妄笑】

《建殊录》云：某生徒读书苦学，尝有所发愤，遂倚几废寝七昼夜，已而独语妄笑，指责前儒，骂不绝口，久之，人觉其狂疾。先生诊之，胸肋烦胀，脐上有动，仁气不降，为柴胡姜桂汤饮之，时以紫圆攻之，数日，全复常。

40、【柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散（癫痫）】

胡某，14岁，初诊1965年10月18日：4年前患急性黄疸型肝炎经治疗黄疸退，但食纳不佳，肝功时有波动，时头晕目眩，近一年来大约每半月有一次癫痫发作，发作时先觉气上冲咽，旋即四肢抽搐，继则牙关紧闭，后则不省人事，口吐白沫，经常服西药镇静药，但仍每半月发作一次，常感乏力，每发作后尤为明显，因食欲不振而现身体瘦弱，舌净无苔，脉弦细稍数此证属血虚水盛，治以养血利水，嘱停服西药镇静药，与柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散：

柴胡四钱，黄芩三钱，桂枝三钱，白芍三钱，川芎二钱，苍术三钱，茯苓三钱，泽泻五钱，花粉六钱，生龙骨五钱，生牡蛎五钱，炙甘草二钱。

二诊10月25日：纳稍增，近几天咳嗽吐白痰，合用半夏厚朴汤：半夏四钱，厚朴三钱，苏子三钱，生姜三钱，茯苓三钱，柴胡四钱，黄芩三钱，花粉六钱，生龙骨五钱，生牡蛎五钱，桂枝三钱，当归三钱，白芍三钱，川芎二钱，泽泻四钱，苍术四钱，炙甘草二钱。

三诊10月29日：咳已，小便频，失眠，与猪苓汤合当归芍药散：猪苓三钱，茯苓三钱，泽泻四钱，滑石五钱，白芍三钱，川芎二钱，酸枣仁五钱，阿胶三钱。

四诊11月2日：尿频已，头晕、失眠好转，右胁痛，纳稍差继服10月18日方。

五诊12月17日：胁痛已，未发癫痫，查肝功正常。嘱停药观察。

41、【桂枝加龙骨牡蛎汤奔豚医案】张德超：

陈姓妇女，42岁。因受惊后，始感头昏，头痛，夜眠不宁，继则感气从少腹上冲，如奔豚之状，上至心胸则惊恐不安，甚则汗出，发则几乎欲死，移时冲气渐平，精神亦渐复。苔白而润，脉沉弦。如是者三年，时愈时发。证系心阳本虚，肾之阴气上逆。予本方重用桂枝加味。遂疏：桂枝15克，白芍10克，炙甘草5克，龙骨、牡蛎各30克（杵，先煎），紫石英15克，生姜4片，红枣7枚。服至20余剂，冲气渐平。后以甘麦大枣汤调理善后，竟收全功。（《北京中医》1984；（3）：34~35）

按语：《灵枢》云：“心，怵惕思虑则伤神”。《金匱》云：“奔豚……从惊发得之。”患者因惊恐而伤心阳，肾中寒水之气，随冲脉上逆，而为奔豚之证，故用桂枝加龙牡汤，独加重桂枝用量，取桂枝加桂之法，以复心阳，温肾寒，降冲逆，龙牡、石英以收镇心安肾、平冲降逆之效。

42、【桂枝加龙骨牡蛎汤癫狂医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，随访1年未再复发。（河南中医1995；（6）：343）

按语：对癫狂之证，叶天士主张应“察形证，诊脉候，以辨虚实”。但总由阴阳失调而发，故叶氏在治疗上指出：“医者惟调理其阴阳，不使有所偏胜，则郁逆自消，而神气得返其常焉矣。”本案即为调理阴阳治癫狂证的具体运用。

第六章 妇人精神病

43、【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方：

乡里打一妇人，数欠伸，无故悲泣不止。或谓之有祟，祈壤请祷备至，终不应。用麦甘大枣汤，尽剂而愈。

44、【妊娠四五月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方：

程虎卿内人妊娠四五月，遇昼则惨戚悲伤泪下，数欠如有所凭。医巫兼治，皆无益。与大枣汤一投而愈。（即本方）

45、【甘麦大枣汤癡痼医案】陈汉云：

患女，12岁。癡痼大发作六年，用苯妥英钠治疗无效，改用甘麦大枣汤，每日加明矾米粒大1枚冲服，连服半年而愈。随访6年未发作。（浙江中医杂志）

按语：本案标本兼治，值得借鉴。

46、【抵当汤治月经不来下焦蓄血引起的精神病】胡希恕曰：

“妇人经水不利下”，不是月经不调，是经闭，经闭不利下，就是用其它的药也不下。这个临床上也常有，我临床遇着一个精神病，她这个例假吃抵当汤才下，上次我给她用了抵当汤，她月经下了挺大一块的、很多很多的，现在她这个精神大致是好了，她以前拿斧子砍人，在精神病院治疗很长时间，现在这个人挺好。我用其它的祛瘀药都不行，她这个例假就是不见，用抵当汤这个是真有力量，我就用这个方子，不过我还加芒硝了，因为她这个大便也特别干，人也是癡狂。

罗按：这个其实应当归类下焦蓄血病，精神病不是主证，是兼证，下焦蓄血病才是主证，外证除精神病外，应当有脉沉结、少腹硬满而痛、大便黑，小便通利等证。

47、【血在下则忘精神病医案】刘渡舟：

女，30岁，姓魏，河南人，1969年患精神分裂症。住院用电疗、用胰岛素治疗，没完全好。出院以后遗留下一个问题，头皮发紧，就像打了一块铁箍。另外就是言听视众，随过随忘，一点儿记性都没有，就是喜忘。两目呆滞，神情淡漠；月经来的时候，小肚子疼痛。脉沉滑，舌苔有点儿发腻。我给她辨证为有瘀血，一个，因为脉见沉滑，沉主里，滑脉有的时候主瘀血。《濒湖脉学》：“滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎”。另外根据《内经》所说蓄血在下其人发狂，蓄血在上其人喜忘，善忘。同时，她月经来的时候小肚子疼痛，有瘀血的痛经。

根据这个，我第一个方子就是抵当汤加柴胡、半夏。抵当汤活血化瘀，加柴胡、半夏，一方面疏肝，一方面给祛痰，因为舌苔有点儿腻。吃了两付，效果不理想。第二次看，还是有瘀血，所以就按照桂枝茯苓丸的意思开，桂枝两钱，桃仁四钱，牡丹皮三钱，茯苓八钱，赤芍三钱，大黄三钱。这是桂枝茯苓丸的底子，还有大黄，又加上一个失笑散，蒲黄二钱、五灵脂二钱，也是活血化瘀的。吃下以后她就大便作泄，泄了好几次，泄完以后头上这个铁箍就去掉了，也就是说这个症状就解除了。问她记性怎么样？她感觉着有好转，还是忘但是轻了一点儿。感觉这个方子用对了，第三次就是大黄三钱、桃仁五钱、炙甘草二钱、芒硝二钱、牡丹皮三钱、赤芍三钱、郁金三钱、菖蒲三钱，在活血化瘀里加上一点儿芳香开窍、开心窍的药。这个药吃了两三付，大便还泄，这回泄的就不是一般的東西，像脓血之物甚多，似脓非脓，似血非血，黏黏糊糊。拉完以后，说是好了百分之八十。又开了个方子，她带回河南老家吃，约定如果还不好就来信，回去了以后根本就没来信，这病可能也就好了。

48、【喜笑不休医案】张氏医通：

昔治人笑不休口流涎，用黄连解毒汤加半夏、姜汁、竹沥，而笑止。

经云：“神有余则笑不休，精气并于心则喜”，心主手厥阴之脉，是动则病目黄，喜笑不休。河间云：喜笑者，皆心火之盛也。五行之中，惟火有笑。

黄连解毒汤方：（外台秘要）

黄连三两，黄芩、黄柏各二两，梔子十四枚（擘）

上四味切，以水六升，煮取二升，分二服。

49、【喜笑不休医案】张氏医通：

戴人治一妇，病喜笑不休，已半年矣。以盐块二两，烧令通赤，放冷研细，河水煎服，探吐出热痰五升，次服降火之剂，不数日而笑定。

《内经》曰：神有余则笑不休，此所谓神者，火是也。火得风而成焰，笑之象也。

50、【笑哭不常医案】张氏医通：

倪惟德治一妇，病气厥，笑哭不常，人以为鬼祟所凭，诊之，六脉俱沉，胃脘必有积，遂以二陈汤导之，吐痰升许而愈。此积痰类祟也。

51、【辰砂甘遂散治妇人神经病终日歌唱达旦不寐医案】曹颖甫：

此公系同乡高长佑先生之友。予因治其妻神经病，始识之。盖其妻饮食如故，但终日歌唱，或达旦不寐。诊其脉滑疾，因用丁甘仁先生法，用猪心一枚剖开，内藏辰砂二钱，甘遂二钱，扎住，向炭炉煨枯，将甘遂朱砂研成细末。一服而大下，下后安眠，不复歌唱矣。后以十全大补汤收膏调之，精神胜于未病时。附录之，以资谈助。

52、【脏躁奔豚汤治精神恍惚医案】王峰：

马某，女，16岁，学生，1988年10月14日初诊。患者自9月6日以来，每见欠伸之后即哭泣无常或叫嚷吵闹，或精神恍惚，不闻不见。询其因，乃上学恋爱，被家人打骂恐吓而发病。曾服谷维素、安定、氨络酸等西药治疗，疗效不佳，故于今日来诊。诊：患者无故自悲，善惊易恐，心烦不寐或多梦纷纭，大便干硬，小便短赤，头重昏蒙，面带愁容。舌红苔少，脉弦细。诊为脏躁，乃血虚气火逆乱所致。治宜养血平肝，泻火安神。投奔豚汤加味：葛根15g，白芍、当归、柴胡、黄芩各12g，半夏、李根白皮各10g，甘草、川芎、生姜各6g，潞参、生牡蛎、生龙骨各18g。日1剂，水煎服。服4剂后，证有转机，续服10余剂，诸症消失，安如常人。1990年10月随访，病无反复。（国医论坛）

注家按语：本例系血虚肝旺之体，故投奔豚汤养血、平肝、泻火，合小柴胡汤疏理气机，伍生龙牡凉血、镇潜、安神。诸药合用，血虚得养，邪热得泻，故是自安。

53、【甘草泻心汤治自言自语哭笑不休精神病】

贺XX，女，38岁。因孩子暴殁后，悲愤异常，不久即现精神失常。每日下午至晚上即自言自语，哭笑不休，夜间虽能勉强入睡，但一夜之间数次惊醒，心悸不宁，躁扰不安，精神恍惚，有时独自乱跑，早上至上午的时间则清醒如常人。如此二月之久，虽经断续治疗，时好时坏，不能巩固。

初诊时，患者正在清醒时候，故能将自觉症状反映清楚：心神或清醒如常，或模模糊糊，烦冤，懊恼，脚下憋胀不舒，口干舌燥，但不欲饮水。善太息，易感动。脉数大无力，苔白腻。证属心肝血虚，血燥肝急，兼痰热壅聚，时扰心神所致。遂投服甘草泻心汤，连服三剂，证情大有好转。后宗此方加减服十余剂，诸证痊愈。

炙甘草30克，半夏10克，党参15克，干姜6克，黄连5克，黄芩10克。

54、【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：

任某，女，26岁，干部。1982年4月5日初诊。2年前因情志不遂致精神失常。发病前先觉胸中烦乱异常，脘腹胀满，坐卧不安，时常悲伤啼哭不能自控，继而两目不睁，呼之不应，移时症消如常人，1周或半个月发作1次，遇精神刺激则发作更趋频繁。某医院诊为“癔症”，经暗示治疗稍好转。近月来诸症加重，精神恍惚，终日烦闷不安，哭笑无常，口渴纳差腹满，尿黄便干，经色黑量少，经期正常。舌质红、苔黄，脉弦数。诊为郁证。证属肝郁化火，上扰心神。方药：栀子15g，厚朴12g，炒枳实10g。每日1剂，水煎服。10剂后自感腹内舒适，情志舒畅，食欲增进，舌红、苔黄，脉数。继以上方合甘麦大枣汤，进20剂后症消病除，随访已结婚生子，至今未复发。（湖南中医学院学报）

现代临证：栀子厚朴汤现代应用于杂病食积化热、急性胃肠炎、消化不良、肝胆疾病等疾病，凡栀子豉汤下所列诸证，病位偏下，界于脘腹之间者，可用本方治之。

55、【白虎加人参汤治腹满身重遗尿言语失常医案】许叔微：

城南妇人，腹满身重，遗尿，言语失常。他医曰：不可治也。肾绝矣。其家惊忧无措，密召予至，是医尚在座。乃诊之曰：何谓肾绝？医家曰：仲景谓溲便遗失，狂言，反目直视，此谓肾绝也。予曰：今脉浮大而长，此三阳合病也，胡为肾绝？仲景云：腹满身重，难于转侧，口不仁，谵语、遗尿。发汗则谵语，下之则额上生汗，手足厥冷，白虎证也。今病人谵语者，以不当汗而汗之，非狂言反目直视，须是肾绝脉，方可言此证。乃投以白虎加人参汤，数服而病悉除。（伤寒九十论）

56、【白虎加人参汤治发狂痫欲把刀自杀或投井终夜狂躁不眠医案】中神琴溪：

一妇人发狂痫，发则欲把刀自杀，或投井，终夜狂躁不眠，间有脱然谨厚，女事无一误者，先生以瓜蒂散一钱五分，其痰上涌二三升许，使再服白虎加人参汤，不再发。（《皇汉医学》）

57、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝9克，大黄12克，枳实12克，厚朴12克，当归15克。

服1剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服3剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草6克，又服1剂，神识清楚，语言正常。（陕西中医药1976；（1）：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

58、【大承气汤治惕而不安急黄发斑（肝昏迷前期）医案】夏发镛：

曹某某，女，10岁。因身黄、目黄、尿黄，伴呕吐、乏力6天，诊为“急性黄疸型肝炎”，于1989年11月10日入院。B型超声：肝脏大小正常，肝实质炎性损害，重度胆囊炎。肝功能化验：黄疸指数110单位，麝浊17单位，锌浊15单位，麝絮（卅），凡登白直接立即，谷丙转氨酶181单位。中医以清热解毒，利湿退黄之法，用茵陈四苓散加减。西医以护肝、补能等处理，黄疸愈深，精神愈差，第三天出现神志模糊，循衣摸床，撮空理线，烦躁谵语，不饮不食，渐至神志不清，狂躁不安，拟诊为“急重肝”、“肝昏迷前期”。中医诊断为“急黄”，仍坚持中西医结合治疗。清洁洗肠，每日二次，均无大便。其舌苔黄燥，脉数有力，腹部虽无胀满，但隐隐约约有碍手之物，且患儿父母诉其已七日未大便，故辨证为阳明实热、燥屎内结。即投大承气汤一剂。5小时后间断解出如桃核大燥屎六枚，坚硬如石，次日神志清楚，言语正常，并欲饮食，黄疸亦渐渐消退。（新中医）

注家按语：腑热浊毒，壅滞肝胆，胆汁不循常道，而致急黄；上扰神明而致神昏发狂。《伤寒论》212条：“若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安……但发谵语者，大承气汤主之。”故与大承气汤原方，通其腑而黄自去，彻其热而神自清。

舒氏云：吾家有时宗者，三月病热，予与仲远同往视之，身壮热而谵语，胎刺满口，秽气逼人，少腹硬满，大便闭，小便短，脉实大而迟。仲远谓热结在里，其人发狂，小腹硬满，胃实而兼畜血也，法以救胃为急，但此人年已六旬，证兼畜血，下药中宜重加生地黄，一以保护元阴，一以破瘀行血。予然其言，主大承气汤，硝黄各用八钱，加生地一两，捣如泥，先煎数十沸，乃纳诸药同煎。连进五剂，得大下数次，人事贴然。少进米饮，一二口辄不食，呼之不应，欲言不言，但见舌苔干燥异常，口内喷热如火，则知里燥尚未衰减。复用犀角地黄汤加大黄，三剂，又下胶滞二次，色如败酱，臭恶无状，于是口臭乃除，里燥仍盛，三四日无小便，忽自取夜壶小便一回。予令其子取出视之，半壶鲜血，观者骇然，经言“血自下，下者愈”，亦生地之功也。复诊之，脉转浮矣，此溃邪有向表之机，合以柴胡汤迎其机而导之。但此时表里俱还热极，阴津所存无几，柴胡亦非所宜，惟宜白虎汤加生地、黄芩以救里，

倍用石膏之质重气轻，专达肌表而兼解外也。如是二剂，得微汗而脉静身凉，舌苔退而人事清矣。再用清燥养荣汤（知母、天花粉、当归、白芍、地黄、陈皮、甘草）二十剂而痊愈。

59、【发狂见鬼多言骂詈不认亲疏】

余友王百安君于月前治一郭姓妇人。该妇于双产后，发狂见鬼，多言骂詈，不认亲疏。其嫂曾被其掐颈，几至惊毙。家人因使强有力者罗守之。遂延王君往诊，车至中途，病家喘急汗流奔告曰，病者角弓反张，口吐涎沫，现已垂危，后事均已备妥，特询还可医否？如不可医，毋徒劳先生往返也。王君答以果系实症，不妨背城借一，或可挽回，然未敢必也。及至病所，见病人反张抽搐，痰涎如涌，诊其脉，数而疾，因病者躁动，未得细诊。询以恶露所见多寡，腹中曾否胀痛，二便若何，该家惊吓之余，视病者如虎狼，此等细事全无人知。王君以无确凿左证，力辞欲去。病家苦求立方，坚不放行。王君默念重阳则狂，经有明文，加以脉象疾数无伦，遍体灼热，神昏流涎，在在均露热征。其角弓反张当系热极成痉。综合以上各点，勉拟下方。生石膏四钱，知母三钱，寸冬三钱，川连三钱，条芩三钱，阿胶三钱，白薇三钱，生地三钱，半夏三钱，木通三钱，枳壳三钱，大黄三钱，粉草一钱，竹叶三钱。一剂，痊愈，躁动略安。复延往诊，病者固拒不令诊脉，询以大便情形，据云水泄挟有燥粪，遂为立大承气汤加桃仁丹皮，嘱其分三次灌之。如初次服后矢气，便为对证，可将余药服下。次日，病家来云，躁动若失，已能进食，惟仍狂言不寐。遂处下方：川连、炒栀子、条芩、杭芍、阿胶、云苓、茯神、远志、柏子仁、琥珀、丹皮、当归、生地、鸡子黄。据称服后熟睡竟夜，此后可以无虑。

其母因其灌药艰难，拟令静养，不复服药矣。似此病症，若仍以产后多虚，妄用十全八珍，或生化汤加减，岂不促其命期耶？”录《医界春秋》）按本证初起，似属桃核承气汤证，或竟抵当汤证。仲圣曰：“其人如狂，但少腹急结者，乃可攻之。”又曰：“其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞕满”是也。此二条，如狂与发狂异，急结与鞕满异，是其辨也，迨后角弓反张，当为大承气汤证。仲圣曰：“卧不着席，脚挛急，必齿介齿，可与大承气汤”是也。最后，狂言不寐，亦如仲圣所谓“心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之”之证。故用药近似，即可以起死回生。呜呼，此仲圣之所以为万世法也！此证甚剧，亦属产后，引之可与吾师原案互证。

曹颖甫曰：产后宜温之说，举世相传，牢不可破。而生化汤一方，几视为金科玉律，何怪遇大实大热之证，而束手无策也。大凡治一病，必有一病之主药，要当随时酌定，不可有先入之见。甚有同一病证，而壮实虚羸之体不当同治者，此尤不可不慎也。

60、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝9克，大黄12克，枳实12克，厚朴12克，当归15克。

服1剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服3剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草6克，又服1剂，神识清楚，语言正常。（陕西中医药1976；（1）：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

61、【桃核承气汤治经前如狂医案】：

妇女经来狂言谵语，据《竹林寺女科》载，多因月经来时多触烦怒，肝气逆乱，血随气逆，上攻于心所致。治宜舒肝宁心。因热与瘀血相搏而引起的经期发狂更为多见，由于感受实热之邪结于下焦，侵入血分，阻滞气血运行，产生瘀血，热与瘀血相搏，上扰心神，神明失聪，使人如狂、发狂。治宜清泻火热之邪，破血下瘀，瘀、热去而心神得安。用桃核承气汤治疗此病有良好的效果，如在经前服用效果更佳。

典型病例：向，教师，二十多岁，未婚。每到月经来潮时即成癫狂状态，妄见妄言，哭笑无常，夜寐不安，月经过后，不治自愈，数月以来皆是如此。经患者的母亲回忆，此人有痛经史，曾于数月前重感冒一次，那时正是月经期，以后即患此病。患者来就诊时，正是发病的时候，也就是正在月经期。虽然胡言乱语，嬉笑不常，但在问诊时还能够控制，准确的回答。经服桃核承气汤加减四剂而愈。随访数月，概未复发。

按：本例患者平素有痛经史，结合当时的证候，显然有瘀血阻滞，正值经期发生了感冒发热，外感热邪侵入下焦血分，以致瘀血不行，而引起发狂。其发病的机理和《伤寒论》中的蓄血证相同。即“瘀热”所致。如瘀血不与火热结合，仅能为癥积而已，不能发狂，只有热与瘀相挟，瘀浊才能上行清道而扰及神明。如徐灵胎《伤寒论类方》说：“热甚则血凝而上干心包，故神昏如狂。”故用桃核承气汤攻瘀兼清热，取得了速效。但是，这和《伤寒论》中所载的热入血室有根本上的区别，此有瘀血，彼无瘀血。所以在治疗方面，蓄血证是以逐瘀为主，而热入血室则是以疏解（小柴胡汤）针刺（期门）泄肝热为主。

《医方考》：桃仁，润物也，能泽肠而活血；大黄，行药也，能推陈而致新；芒消，咸物也，能软坚而润燥；甘草，平剂也，能调胃而和中；桂枝，辛物也，能利血而行滞。又曰：血寒则止，血热则行。桂枝之辛热，君以桃、消、黄，则入血而助下行之性矣，斯其治方之意乎！

《古方选注》：桃仁承气，治太阳热结解而血复结于少阳枢纽间者，必攻血通阴，乃得阴气上承，大黄、芒消、甘草本皆入血之品，必主之以桃仁，直达血所，攻其急结，仍佐桂枝泄太阳随经之余热，内外分解，庶血结无留恋之处矣。

62、【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：

一妇人，患疫，身热如灼，口舌糜烂，渴好热饮，一日妄语如狂，自胸至少腹，硬疼不可近手，十余日不大便，先生投以桃仁承气汤，黑便通快，诸证悉去。

《方舆貌》曰：此方证（即桃仁承气汤证）本论曰下血，曰少腹急结，若比抵当汤证，其血犹未沉痼也，兹举余所治屡验之一于下：经血欲来，腹疼不可忍，甚至到心妄者，以桃仁承气攻之，二三帖，疼失如神。此证经年不瘥，久患成宿疾者，皆由轻剂微汤无效故也。每月经期时，用桃仁承气二三帖或四五帖，得以定疼即停服，至下月经期之间，经服逐瘀丸散之类，至期时，复服桃仁承气汤，过期后，复服缓攻之剂，如前，如是回环四五月，则数稔之滞患，亦得痊愈。

63、【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育：

吴某某，女，36岁，营业员，1986年6月24日就诊。5年前因与人口角而突然晕倒，不省人事，四肢僵硬，约数分钟后苏醒，但仍觉头晕乏力，后反复发作，每月2~3次，每逢情志不畅则发作频繁，多种检查未发现器质性病变。西医诊断为癔病。5年来，服多种中西药罔效，遂求诊于余。刻诊：发作后2天，表情抑郁，少语寡言，时时惊恐，伴头晕，时自汗出，舌淡、苔薄白，脉弦略浮。予桂枝加龙骨牡蛎汤治疗。处方：桂枝10克，白芍、炙甘草各20克，生龙骨、生牡蛎各30克，生姜5克，大枣30枚。每日1剂，水煎分2次服。服药5剂，自觉诸症消失，效不更方，守原方续进30余剂，5年沉痾遂愈，随访至今，未再复发。（新中医1992；〈6〉：44）

64、【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，追访1年未再复发。（河南中医1995；

(6>: 343)

65、【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，随访1年未再复发。(河南中医1995；

(6>: 343)

66、【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：

任某，女，26岁，干部。1982年4月5日初诊。2年前因情志不遂致精神失常。发病前先觉胸中烦乱异常，脘腹胀满，坐卧不安，时常悲伤啼哭不能自控，继而两目不睁，呼之不应，移时症消如常人，1周或半个月发作1次，遇精神刺激则发作更趋频繁。某医院诊为“癔症”，经暗示治疗稍好转。近月来诸症加重，精神恍惚，终日烦闷不安，哭笑无常，口渴纳差腹满，尿黄便干，经色黑量少，经期正常。舌质红、苔黄，脉弦数。诊为郁证。证属肝郁化火，上扰心神。方药：栀子15g，厚朴12g，炒枳实10g。每日1剂，水煎服。10剂后自感腹内舒适，情志舒畅，食欲增进，舌红、苔黄，脉数。继以上方合甘麦大枣汤，进20剂后症消病除，随访已结婚生子，至今未复发。(湖南中医学院学报)

现代临证：栀子厚朴汤现代应用于杂病食积化热、急性胃肠炎、消化不良、肝胆疾病等疾病，凡栀子豉汤下所列诸证，病位偏下，界于脘腹之间者，可用本方治之。

罗按：此病证，有心烦而腹胀满

67、【桂枝茯苓丸加味癩疾医案】龚士澄：

孙某某，女，40岁，1981年7月29日诊。癩疾发作无常已四五年，每因志愿不遂而发，发则语言无序，多猜疑，昏倦又不能寐。以往除用安定、抗抑郁西药；中医多宗气郁生痰、神不守舍论治，与开郁清心、豁痰安神之剂，三两日即缓解如常人。7月20日月经前发病，以上述中西药治疗一周周效，且时时躁狂，妄责其夫有暧昧关系，喃喃自语或怒目相对，眠食俱废，诚如王清任先生所说“乃气血凝滞脑气”之证。以桂枝8克，黄连3克，茯苓12克，赤芍9克，桃仁20克，丹皮9克，香附9克，苏子9克，半夏10克，陈皮6克，甘草10克为剂。服3帖，患者如梦初醒，神态正常，从此发作即甚少甚轻。(《江苏中医杂志》1983；(3>: 18)

68、【桂枝茯苓丸治“血在下则忘”精神病医案】刘渡舟：

女，30岁，姓魏，河南人，1969年患精神分裂症。住院用电疗、用胰岛素治疗，没完全好。出院以后遗留一个问题，头皮发紧，就像打了一块铁箍。另外就是言听视众，随过随忘，一点儿记性都没有，就是喜忘。两目呆滞，神情淡漠；月经来的时候，小肚子疼痛。脉沉滑，舌苔有点儿发腻。我给她辨证为有瘀血，一个，因为脉见沉滑，沉主里，滑脉有的时候主瘀血。《濒湖脉学》：“滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎”。另外根据《内经》所说蓄血在下其人发狂，蓄血在上其人喜忘，善忘。同时，她月经来的时候小肚子疼痛，有瘀血的痛经。

根据这个，我第一个方子就是抵当汤加柴胡、半夏。抵当汤活血化瘀，加柴胡、半夏，一方面疏肝，一方面给祛痰，因为舌苔有点儿腻。吃了两付，效果不理想。第二次看，还是有瘀血，所以就按照桂枝茯苓丸的意思开，桂枝两钱，桃仁四钱，牡丹皮三钱，茯苓八钱，赤芍三钱，大黄三钱。这是桂枝茯苓丸的底子，还有大黄，又加上一个失笑散（五灵脂、蒲黄），蒲黄二钱、五灵脂二钱，也是活血化瘀的。吃下以后她就大便作泄，泄了好几次，泄完以后头上这个铁箍就去掉了，也就是说这个症状就解除了。问她记性怎么样？她感觉着有

好转，还是忘但是轻了一点儿。感觉这个方子用对了，第三次就是大黄三钱、桃仁五钱、炙甘草二钱、芒硝二钱、牡丹皮三钱、赤芍三钱、郁金三钱、菖蒲三钱，在活血化瘀里加上一二点儿芳香开窍、开心窍的药。这个药吃了两三付，大便还泄，这回泄的就不是一般的東西，像脓血之物甚多，似脓非脓，似血非血，黏黏糊糊。拉完以后，说是好了百分之八十。又开了个方子，她带回河南老家吃，约定如果还不好就来信，回去了以后根本就没来信，这病可能也就好了。

69、【四逆三生饮方证治形寒肢冷性欲下降轻生想法】阿骅表兄：

一个三十五岁的妇女，青年时代患过肺结核病，两年前停经以后，渐渐地陷入了疾病的漩涡之中而难以自拔，屡经中西医治疗没有明显疗效。现在的病况是：面色青白，形寒肢冷，生趣全无，容易疲乏，动作迟滞，话语减少，注意力分散，浅睡易醒，性欲下降，时有痰涎呕出，反复出现轻生的想法与行为。病人脉象沉滑，舌体淡红，舌苔白厚水滑，腹诊没有什么特殊征象。病症是少阴病四逆汤证，再考虑到“寒痰蒙蔽心窍为癫”的古训，就毅然投以四逆汤与《局方》三生饮合剂三帖。处方如下：制附片三钱，干姜二钱，甘草一钱，制南星二钱，木香二钱，制川乌一钱，生姜三片。药后诸症明显减轻，守方一周，病人神清气爽，恢复正常，停药观察没有复发，至今已经三个月了。阿骅表兄把这个病的以上脉症命名为“四逆三生饮方证”，要我在临床上注意观察与应用。

70、【桂枝甘草汤寐多不醒或语无伦次医案】李白召：

李某，女，21岁，1983年8月17日初诊。其母代诉：年前与母吵嘴而病，开始郁郁寡欢，不欲多言，后寐多不醒，呼之不应，或昏昏欲睡，或语无伦次，时轻时重。多次求医诊治，屡用理气泻下之品、病无起色，迁延至今。见患者发育正常，面容呆板，两手交叉护胸，问其故，但言心中害怕，耳中如物阻塞，脉浮大，舌淡苔白。病为癫疾，证属心阳虚损。处方：

桂枝45克，甘草20克，2剂，水煎。服1剂，精神好转。2剂而嗜睡除，言语增，病情稳定耳塞消失，自云如梦一场。效不更方，继服2剂，彻愈。（国医论坛U86；<3>；51）

71、【桃仁承气汤合三黄泻心汤惊恐晕厥】

杨美某，二十四岁，结婚未久与其夫游弥陀寺，有山禽由荆榛中飞出，因而惊恐晕厥，归家后初唯烦躁不眠，继则狂暴错乱，于是巫医并进，凡半年，症状愈剧。

初诊，1952年7月某夕。是为相当健硕的少妇，狂暴惊叫之状，使人不敢近，颜面潮红中呈瘀黑气味，眼睛充血赤脉纵横，脉洪数，舌干涸苔干而黄，腹膨满拒按。据云发病以来很少大便，唯时时喝冷水，且日夜不能睡眠。

以桃仁承气汤合三黄泻心汤投之，大泻下后渐有睡眠，狂暴稍轻。原方继续两星期，狂暴除、睡眠佳，但状如失神，时时诉腹痛——大约是大黄的关系——后以桂枝茯苓丸合黄解汤，月余全治。

72、【血府逐瘀汤治妇人发狂】：

此方曾治一妇人发狂一年余，加胆南星而愈。如火盛者，加黄连；大便燥结者，加酒军；狂甚，加石菖蒲。

73、【血府逐瘀汤治熟睡中忽然胡言乱语】：

一女十五岁，素有发烧病，入夜则剧。近来忽得一疾，人都谓奇。有时熟睡中忽然胡言乱语，有时突然倒地不省人事，有时詈骂不避亲疏，如此一二小时才能清醒。众皆想知其因，余曰：此证并不奇怪，因被抑郁，心情不畅，肝气拂逆，致气血郁甚，郁生热，热生痰，有时痰热壅滞，神识不清，病即发也，此癫狂之渐。方用血府逐瘀汤加苏子、半夏、青皮、木通，一剂愈，再无反复。

74、【乌梅丸握拳狂躁高呼打人时而静卧】

程子，病已旬余，腹痛，不思饮食，渐致时而握拳狂躁，高呼打人，时而静卧，脉洪大。吴太元投以乌梅丸，服后下蛔虫甚多而愈。（《函讯》）

75、【乌梅丸时哭笑无常医案】蒲辅周：

任某某，女，37岁。与爱人分居两地，老人、小儿多病，家事冗繁，以致情志抑郁。近两天来，头痛，恶心不食，昼夜不能眠，神呆，有时闭眼不动，呼之不应，有时哭笑无常，忧郁自语，四肢抽搐。某医院检查诊断为“癔病”，服镇静药等尚未见效。脉沉弦涩，舌略暗，苔薄黄。病由肝失条达，气血不和，厥气上冲，乱其神识。治宜泄肝宁神，调和气血，拟乌梅汤加减。处方：

乌梅9克，花椒4.5克，干姜4.5克，黄连6克，细辛3克，黄柏9克，制附片4.5克，肉桂3克，党参3克，当归6克。

共服4剂，神态恢复正常，隔4月后又犯病，发病较轻，再用乌梅汤治疗而愈。观察2年，一直未再犯病。

76、【小柴胡汤加百合知母汤癔病治医案】曾荣修：

孟某某，女，40，马边县银行（暂住南大街青平巷9号）。1975年3月10日，家属二人护送，指入诊室即伏案不语。代述：眩晕一月余，诊断：癔病。当地事区医住院一月余，加重18天，有时痴笑、喜呕，脉弦细右寸弦数，苔白。症属：少阳风热兼肺热阴虚。治宜：和解少阳兼养肺阴清虚热。方药：小柴胡汤加百合知母汤。[原文：百合病发汗后者，百合知母汤主之]二付。

1975年3月12日，基本全愈，但很疲乏，久病伤阴。原方二付巩固治疗。

1975年3月17日，纳差，健胃合剂兼养胃阴。

77、【大陷胸汤治发狂】

素某姓少妇病狂四载，延余至，病者卧床上，甫就诊，突被反手相掣，口出妄言。出谓其夫曰：脉虽未得，而劫夺之际，已领料其病情。讯其目珠之赤，盖已三年。每发不必有因，唯自禁食，登高歌哭，厉声叫喊，昼夜无眠，人莫能制，诸药罔效。其发一月，十日不已，已则如平人，惟食饮逾常，潮信衍期耳。为用大陷胸方，大黄一两、芒硝、甘遂各三钱、加甘草钱许，服剂须臾，吐泻交作，次日犹能起居。然静而可诊，两脉皆坚锐而数，按有胃气，因忆《内经》无过犯之旨，易以小剂，调胃承气继之。再泻十余行，口渴思饮，进稀粥碗余，熟睡一昼夜，起坐不支，然后以开窍利痰兼安抚药调养月余，最后以补心丸，归脾丸间用，两月寻愈。询其前事，如梦初觉。《名医经方验案》

78、【茯苓四逆汤加龙骨、牡蛎癔狂】周连三：

李某，女，41岁。因和爱人争吵而发病，初起喧扰不宁，躁狂打骂，动而多怒，骂詈日夜不休，经医用大剂大黄、芒硝泻下，转为沉默痴呆，舌白多津，语无伦次，心悸易惊，头痛失眠，时喜时悲，四肢厥冷，六脉沉微。处方：

茯苓30g，党参15g，炮附子15g，干姜15g，甘草12g，牡蛎30g，龙骨15g。服3剂后，神志清醒，头疼止，四肢温，改用苓桂术甘汤加龙骨、牡蛎，服10余剂而愈。

点评：癔狂之病，多属实热之证，病机多为气郁痰火，治疗多以镇心安神、涤痰清热、解郁散结等法。但周氏认为：“癔狂之疾，属热证者有之，属寒者亦为常见。”缘于脾气不伸，运化失调，痰浊内生，痰气上逆，蒙蔽清窍，正阳不足，运化无权，以致浊阴填塞于上，亦能发病，故每见沉默痴呆，语无伦次，时悲时喜，四肢厥冷，六脉沉微，汗出遗尿等阳虚证，治疗即以温肾补土，助阳扶正；水邪痰饮伏留，故以茯苓渗湿利水，水邪去尽，神志自清。本案即为例证。周氏常用茯苓四逆汤为基本方，若痰盛者瓜蒂散先吐之，再以上方加陈皮、半夏治之。语无伦次，时悲时喜者加代赭石、磁石潜阳安神；气短声微加黄芪，汗出不止加白芍，并用金匱肾气丸以善后。《中医火神派医案全解》曾收周氏另一癔狂案，亦用茯苓四逆汤加龙牡、术桂而愈，可互参。

79、【用痿证方治疗子宫卵巢全部摘除后的下肢无力和焦虑神经症】失数道明：

患者33岁，家庭妇女，初诊于1972年7月。病历：已经过6年治疗的难病。1974年第二次妊娠4个月时经埼玉的妇产科医院诊断子宫肌瘤和卵巢腐烂而将子宫、卵巢全部摘除。

从那以后腰痛严重，不能弯曲，不能鞠躬行礼。还有膝痛，不能端坐，沿着坐骨神经部位有疲倦感，双脚冷，麻木感，无力感严重，无法站立5分钟以上。还有肩、颈酸高，耳鸣，心情忧郁，焦虑感严重，失眠，不能单独一人出外。常有不愿意生活下去的想法。经各种治疗无效。膝盖腱反射兴奋，两脚无力，不能跨过门坎，步行困难。消瘦，色气不好，初诊时血压为110/70。脉、腹部均虚，脐上动悸，下腹部有较大片的手术痕迹。

治疗：我让她服用过多种处方，但都无效。针对虚弱体质与腹证用过当归芍药散、真武汤合人参汤，针对焦虑神经症而用过半夏厚朴汤或抑肝散加芍药、甘草、加味逍遥散等，但都无效。患者却很相信我的治疗并继续服药。1980年11月起针对下肢无力而让服痿证方加附子，服7个月，即到1981年夏天，脚无力好转，心情好，能单独1人外出，几年来头一次去参加家长会。以后乌杉好转，没有来诊察但继续服药。1983年5月单独1人来院，以前忧郁的表情，主诉繁多的患者变得表情明朗，患者说身体已经恢复健康。近来脚力增强，能单独一人外出，心情舒畅，腰痛消失，能鞠躬敬礼。患者以前的痛苦全部忘掉，因而表示非常感谢。患者说当时担心会一辈子过着椅子上的生活。《汉方的临床》。

【痿证方】出自日本汉方学家【福井枫亭】之《秘方集验》。对腰以下瘫痪的初期。对重病后的下肢无力，产后的脚膝痿弱，脚下肢麻痹。【组成】当归5克，地黄4克，芍药、苍术、牛膝各3克，知母各、黄芪各2克，杜仲、黄柏各1克。

80、【桃核承气加地鳖虫蛻螂两头尖热入血室神昏谵语手足抽掣治验】曹炳章：

姚幼搓媳陈氏，病热，神昏谵语，手足抽掣，群医作热入血室治，无效。曹先生细询病情，细察脉状，认为热入血室本无误，由于不识血瘀脑门之故。乃以桃核承气加地鳖虫、蛻螂、两头尖及清热息风之品，一服而下瘀血如拳，宿垢如酱者三四次，抽搐即停，热减神清，继予退热养阴获痊。

【黄土汤治妇人精神病脐下悸】

《续建殊录》云：一妇人，两脚酸痛，自脘至膝腠见紫色卷五筋。其妇曰：脐下悸。有时上突胸间，剧则精神变乱，方其时，彼紫色者忽焉而去，已则候焉复来。先生即令服黄土汤，得之下血，疾全解。

81、【大柴胡治谵语烦躁不安胸肋烦胀】

《古方便览》又云：一妇人，年三十四五，患热病十八九日，谵语烦躁不安，热不减，不欲饮食，诸医以谓必死。余诊之，胸肋烦胀，腹满拘挛，乃与大柴胡汤，六七日而腹满去，思食，出入二十日许而收全效。

82、【大柴胡加茯苓牡蛎汤遇人则必畏怖】

《成绩录》又云：某所患粗同前证，但见诸物，以为人首，始遇人，则必畏怖，稍相识则不然，其人去，则反悲哀，以是虽家人，不得出去，如外出移时，则眷慕不堪，遂乃晕绝。先生诊之，胸腹动高，所未曾见，胸骨随动有声，乃与大柴胡加茯苓牡蛎汤，大下秽物而愈。

83、【大柴胡汤治胸腹硬满大便不通恒怵惕悸怯】

《成绩录》又云：滩横田某者，恒怵惕悸怯，凡目之所触，虽书画器物，悉如梟首，或如鬼怪，以故不欲见物。然有客访之，则一见如亲故，其人归去，则恋恋悲哀，瞻望弗止，如此数月，百事废度，于是求治于先生。先生诊之，胸腹有动，心下硬满，大便不通，剧则胸间如怒涛，其势延及胸肋，筑筑然现于皮外，乃与大柴胡加茯苓牡蛎汤。服数剂之后，屢下秽物，病减十之七八，既而头眩频起，更与苓桂术甘汤，不日而旧癖如洗。

84、【柴胡姜桂汤治肝病兼肾病颜面及下肢浮肿不眠】朱木通：

有胃下垂之老妇人黄某某，年六十五岁，半月前忽然发热，同时腹满、疝痛、浮肿，乃请省立病院高医师往诊。盖患者之女儿曾经服务于该院为护士，同事间交情不错，所以随请随到。

据云当时高医生未曾诊出病名，仅以葡萄糖一针敷衍了事，而病状依然。于是转某医院，经某博士诊为肝炎，并发肾脏炎。几经应急治疗，腹膨满旋消旋胀。乃于昨夜用泻便剂，排出

少许粘液便，热退。可是泻便后，一切症状转为复杂而危殆，遂由其妣转嘱我往诊。

初诊 1973 年 7 月 19 日，此时患者坐卧转侧必需家人扶持，状颇憔悴疲倦苦楚，呻吟。体质瘦小，贫血，熏黄，皮肤干燥，外观上颇似捞瘵。颜面及下肢浮肿。腹膨满压痛，如覆釜状，但弛缓绵软、空虚、鸣动，按之瓦斯充满。舌干燥而赤无苔，手足温，身微热，脉弦迟。主诉：全身疲惫，沉重，体疼，头痛，口苦，口干，嗜热饮，胸胁苦满，心悸，呕不止，季肋下（右）压痛，头汗，便秘，小便短赤，不食，不眠。其中以不眠及精神恐怖为重要：每因眼合，则见妖魔鬼怪。惊惶失措，精神不安。屡屡檐语。

在这一复杂重危病之中，初诊时，我“问而不厌其详”，将各种症状分别加以整理，而发现“主证”在于“柴胡汤证具”（《伤寒论》），虽然经过误治，但临床所见“柴胡证仍在”（《伤寒论》）于是，我决定从柴胡汤中找出答案。但柴胡汤中，有实证、虚证之别。实证者大柴胡汤，患者虽“便秘”、“腹满”、“呕逆”，但体质老衰、虚秘、虚满，是不适合的。柴胡加龙骨牡蛎汤，也是实证之剂，也不适合。至于小柴胡汤，属于“和解之剂”，在此危急之际，有“缓不济急”之嫌。最后乃于虚证柴胡桂枝干姜汤着眼：脉弦迟、大便虚秘、腹虚满、头汗等等。所以用此方者，重用在于辛温之桂枝、辛热之干姜。古人所谓“棘手著文章”，此之义也。于是投以单方柴胡桂枝干姜汤。服药后，呕吐止，口干除，头眩、心悸差，腹满痛减，头汗亦止，睡眠佳。最显效者为浮肿尽消、大便通，其他亦差。翌日来诊，可以乘三轮车，由其儿媳扶持。自云所苦去大半。唯腹满未甚消。第二、三日，不乘三轮车而由其儿媳以机车载其来诊。原方。

第四日自云已无所苦楚，要求置全力于胃症状。第五、六日，为应其要求而转用厚朴温中汤，再转安中散料加茯苓。胃症状亦稍愈，食欲稍退，而全身血色亦佳，唯大便仍不太畅通。

第七日忽以电话要求急诊：突然恶寒战栗，高热，呕逆，大渴，腹满痛，肢节痛，檐语妄言，脉浮弦。知为“太阳与少阳并病”（太阳下），依伤寒法，转用柴胡桂枝汤。一剂“太阳与少阳并病”解，而各症状俱除，此方共服三剂。

第十一日，回复柴胡桂枝干姜汤，各种症状可以说大部痊愈。自初诊至停药共计十四剂。

【原按】：当时我对此严重危殆之例，颇感复杂纷纭，但经过考虑，则本患者之中心“证”，始终不离“柴胡汤证具”。以此一开始便投以柴胡桂枝干姜汤，一剂见效如桴鼓。其间如忽然恶寒战栗、高热，也不过是伤寒论中之“并证”而已。因此，据《伤寒论》条文“太阳与少阳并病”，转用临时性之柴胡桂枝汤，一剂病除，三剂全治。对此种大病、危病，盖在治疗过程中，皆依据《伤寒论》原则“证”，按部就班，故能轻而易举，于短短十四五日间收到显效。

85、【大柴胡治檐语烦躁不安胸肋烦胀】

《古方便览》又云：一妇人，年三十四五，患热病十八九日，檐语烦躁不安，热不减，不欲饮食，诸医以谓必死。余诊之，胸肋烦胀，腹满拘挛，乃与大柴胡汤，六七日而腹满去，思食，出入二十日许而收全效。

86、【朴硝治痲疾癲狂甚剧医案】张锡纯：

一少年女子，得痲疾癲狂甚剧，屡次用药皆未能灌下。后为设方，单用朴硝当盐，加于菜蔬中服之，病患不知，月余全愈。

87、【朴硝治痲疾癲狂】张锡纯：

法库门生万生治一少女痲狂，强灌以药，竟将药碗咬破，仍未灌下。万生素阅《衷中参西录》，知此方，遂用朴硝和鲜莱菔作汤，令病患食之，数日全愈。

88、【朴硝治结证】张锡纯：

奉天刘生，年四十余，得结证，饮食行至下脘复转而吐出，无论服何药亦如兹，且其处时时切疼，上下不通者已旬日矣。俾用朴硝六两，与鲜莱菔片同煮，至莱菔烂熟捞出，又添生片再煮，换至六七次，约用莱菔七八斤，将朴硝咸味借莱菔提之将尽，余浓汁四茶杯，每

次温饮一杯，两点钟一次，饮至三次其结已开，大便通下。其女时息痢疾，俾饮其余，痢疾亦愈。

89、【朴硝治烦躁不眠证】张锡纯：

奉天于姓妇，年近五旬，因心热生痰，痰火瘀滞，烦躁不眠，五心潮热，其脉象洪实。遂用朴硝和炒熟麦面炼蜜为丸，三钱重，每丸中约有朴硝一钱，早晚各服一丸，半月全愈。盖人多思虑则心热气结，其津液亦恒随气结于心下，经心火灼炼而为热痰。朴硝咸且寒，原为心经对宫之药，其咸也属水，力能胜火，而又寒能胜热，且其性善消，又能开结，故以治心热有痰者最宜。至于必同麦面为丸者，以麦为心谷，心脏有病以朴硝泻之，即以麦面补之，补破相济为用，则药性归于和平，而后可久服也。

硝石即焰硝，俗名火硝。味辛微咸，性与朴硝相近，其寒凉之力逊于朴硝，而消化之力胜于朴硝，若与皂矾同用，善治内伤黄胆，消胆中结石、膀胱中结石（即石淋）及钩虫病（钩虫及胆石病，皆能令人成黄胆医论篇中有“论黄胆有内伤外感及内伤外感之兼证并详治法”，载有审定《金匱》硝石矾石散方，可参观）。

90、【白虎加人参汤治腹满身重遗尿言语失常医案】许叔微：

城南妇人，腹满身重，遗尿，言语失常。他医曰：不可治也。肾绝矣。其家惊忧无措，密召予至，是医尚在座。乃诊之曰：何谓肾绝？医家曰：仲景谓溲便遗失，狂言，反目直视，此谓肾绝也。予曰：今脉浮大而长，此三阳合病也，胡为肾绝？仲景云：腹满身重，难于转侧，口不仁，谵语、遗尿。发汗则谵语，下之则额上生汗，手足厥冷，白虎证也。今病人谵语者，以不当汗而汗之，非狂言反目直视，须是肾绝脉，方可言此证。乃投以白虎加人参汤，数服而病悉除。（《伤寒九十论》）

91、【黄连阿胶汤加味治脑动脉硬化无故大笑医案】张云：

于某，女，73岁。无故大笑不止7天，非但开口即笑，独处亦笑，影响饮食及睡眠。西医诊断为脑动脉硬化，服药不效。症状如前，面部潮红，舌红无苔，脉细数。心主神明，火盛伤心阴，责肾水之亏。滋水清热，交通心肾，乃为本病治疗之肯綮。

拟黄连阿胶汤加味治之：黄连10g，黄芩12g，阿胶15g，白芍30g，鸡子黄2枚，夜交藤50g，生龙牡各60g。2剂笑止。随访年余，未见复发。（张云医案）

按语：《灵枢·本神》云：“心气虚则悲，实则笑不休。”本案大笑不止见面红、舌红少苔、脉细数，乃肾水不足，心火亢盛，上扰神明所致，属“肾虚”而“心实”。故用黄连阿胶汤滋肾水之“虚”，清心火“实”，心肾相交，坎离既济，神无火煎，则狂笑自己。

92、【柴胡姜桂汤治肝病兼肾病颜面及下肢浮肿不眠谵语】朱木通：

有胃下垂之老妇人黄某某，年六十五岁，半月前忽然发热，同时腹满、疝痛、浮肿，乃请省立病院高医师往诊。盖患者之女儿曾经服务于该院为护士，同事间交情不错，所以随请随到。

据云当时高医生未曾诊出病名，仅以葡萄糖一针敷衍了事，而病状依然。于是转某医院，经某博士诊为肝炎，并发肾脏炎。几经应急治疗，腹膨满旋消旋胀。乃于昨夜用泻便剂，排出少许粘液便，热退。可是泻便后，一切症状转为复杂而危殆，遂由其妣转嘱我往诊。

初诊1973年7月19日，此时患者坐卧转侧必需家人扶持，状颇憔悴疲倦苦楚，呻吟。体质瘦小，贫血，熏黄，皮肤干燥，外观上颇似捞擦。颜面及下肢浮肿。腹膨满压痛，如覆釜状，但弛缓绵软、空虚、鸣动，按之瓦斯充满。舌干燥而赤无苔，手足温，身微热，脉弦迟。主诉：全身疲惫，沉重，体疼，头痛，口苦，口干，嗜热饮，胸胁苦满，心悸，呕不止，季肋下（右）压痛，头汗，便秘，小便短赤，不食，不眠。其中以不眠及精神恐怖为重要：每因眼合，则见妖魔鬼怪。惊惶失措，精神不安。屡屡谵语。

在这一复杂重危病之中，初诊时，我“问而不厌其详”，将各种症状分别加以整理，而发现“主证”在于“柴胡汤证具”（《伤寒论》），虽然经过误治，但临床所见“柴胡证仍在”（《伤寒论》）于是，我决定从柴胡汤中找出答案。但柴胡汤中，有实证、虚证之别。

实证者大柴胡汤，患者虽“便秘”、“腹满”、“呕逆”，但体质老衰、虚秘、虚满，是不适合的。柴胡加龙骨牡蛎汤，也是实证之剂，也不适合。至于小柴胡汤，属于“和解之剂”，在此危急之际，有“缓不济急”之嫌。最后乃于虚证柴胡桂枝干姜汤着眼：脉弦迟、大便秘、腹虚满、头汗等等。所以用此方者，重用在于辛温之桂枝、辛热之干姜。古人所谓“棘手著文章”，此之义也。于是投以单方柴胡桂枝干姜汤。服药后，呕吐止，口干除，头眩、心悸差，腹满痛减，头汗亦止，睡眠佳。最显效者为浮肿尽消、大便通，其他亦差。翌日来诊，可以乘三轮车，由其儿媳扶持。自云所苦去大半。唯腹满未甚消。第二、三日，不乘三轮车而由其儿媳以机车载其来诊。原方。

第四日自云已无所苦楚，要求置全力于胃症状。第五、六日，为应其要求而转用厚朴温中汤，再转安中散料加茯苓。胃症状亦稍愈，食欲稍退，而全身血色亦佳，唯大便仍不太畅通。

第七日忽以电话要求急诊：突然恶寒战栗，高热，呕逆，大渴，腹满痛，肢节痛，檐语妄言，脉浮弦。知为“太阳与少阳并病”（太阳下），依伤寒法，转用柴胡桂枝汤。一剂“太阳与少阳并病”解，而各症状俱除，此方共服三剂。

第十一日，回复柴胡桂枝干姜汤，各种症状可以说大部痊愈。自初诊至停药共计十四剂。

【原按】：当时我对此严重危殆之例，颇感复杂纷纭，但经过考虑，则本患者之中心“证”，始终不离“柴胡汤证具”。以此一开始便投以柴胡桂枝干姜汤，一剂见效如桴鼓。其间如忽然恶寒战栗、高热，也不过是伤寒论中之“并证”而已。因此，据《伤寒论》条文“太阳与少阳并病”，转用临时性之柴胡桂枝汤，一剂病除，三剂全治。对此种大病、危病，盖在治疗过程中，皆依据《伤寒论》原则“证”，按部就班，故能轻而易举，于短短十四五日间收到显效。

【柴胡加龙骨牡蛎汤证少女抑郁症案】黄煌

Y女，19岁。2019年12月9日初诊。抑郁倾向1年余。学习能力下降，不愿与外界交流，不愿上学，感觉没有希望、想哭，人多的环境易烦躁。上课嗜睡，晚上失眠，常被恶梦吓醒。易腹胀欲吐。就诊前情绪问卷得分：焦虑分、抑郁分分别高达17、15。

体型中等，营养状况良好，表情淡漠，舌面红点满布，苔厚腻，唇红脉滑。腹诊见腹肌紧张，腹部叩诊则气声明显。病是抑郁症，其人体质属实热，并有痰热郁火。柴胡加龙骨牡蛎汤证在。

处方：柴胡15g，黄芩10g，姜半夏15g，党参10g，桂枝15g，茯苓20g，制大黄5g，生龙骨15g，煅牡蛎15g，栀子15g，枳壳15g，厚朴15g，干姜5g，红枣20g。15剂。

2019年2月26日复诊：其母诉精气神好转，意欲大增，已不愿缺课。

按：“一身尽重不可转侧”是《伤寒论》对柴胡加龙骨牡蛎汤方证的形象描述，这种状态与抑郁症导致的意欲低下非常相似。不愿意与人交流、兴趣缺失、悲观失望等是常见症状。柴胡加龙骨牡蛎汤是抑郁症的常用方之一。其人多有睡眠障碍，其体征多见腹肌紧张或腹主动脉搏动感明显、舌苔厚腻等。除柴胡加龙骨牡蛎汤外，本案用方还有栀子厚朴汤。这是一首用于抑郁症的小方，经典方证为“心烦腹满，卧起不安”，可以认为这是对严重抑郁状态的一种描述。其人多有胸闷烦躁、腹胀便秘等症状，舌尖红，或有黄腻苔，或有鼻衄，眼睑咽喉大多充血。

93、【柴胡加龙骨牡蛎汤兼用伯州散精神受刺激失眠自闭案】矢数道明：

某，男性，22岁。此为战前之事，患者中学毕业升入某高等学校，在校寄宿。当时是以横蛮为自豪的时代，宿舍的老生为显示对新生的威严，有时竟把入睡的新生连被包着从2层楼的窗口抛出，患者不幸受害。此后由于受惊吓而发生失眠，并成严重神经衰弱。退学回家，整日闭门不出，除父母外不愿与任何人说话。2年中未曾理发洗澡，竟成废人之惨状。患者猜疑心强，不相信医生，拒绝诊治。因此，不能获得主诉且不能诊脉。余初诊时仅用纸笔问答，后患者同意诊察。

其面如白蜡，脉无力，腹诊见心下至耻骨全腹硬而紧张如板状。大小便正常。给予柴胡加龙骨牡蛎汤。服药后似有起色，更兼用伯州散（反鼻、鹿角、津蟹烧黑为末），后显著好转，已出门与家人共语。服药1年余，其症痊愈。后承继家业，娶妻得2子。（《汉方辨证治疗学》）

第七章 癫痫证

94、【甘草小麦大枣汤治癫痫六年】：

癫痫六年，苯妥英钠无效，服本方半年而愈。（《浙江中医杂志》1980；10：455）

95、【柴胡桂枝干姜汤治素有痫证】

《成绩录》云：：一女子，素有痫证，一时患疫，诸医疗之，不建。迎先生乞诊治，其腹有动，头汗出，往先寒热，大便燥结，时时上冲，昏不识人，日夜如此两三次，乃与柴胡姜桂汤，及紫圆攻之，不一月，诸证尽除。

96、【镇肝熄风汤治疗癫痫神经系统疾病举隅】彭瞰

胡某，女，7岁，1986年9月6日诊。5个月前于玩耍时突发精神恍惚，喊叫不应，并见眼睑及上肢出现轻微颤动，约半分钟后恢复正常，对所发之事不知，惟述头晕。至今如是发作已20余次，经某精神病院诊断为“癫痫小发作”。刻诊见烦躁不安，睡眠不宁，记忆力减退，口渴不饮，大便干结，舌红少苔，脉弦细。脑电图检查有痫样放电。此因肝肾阴虚，水不涵木，木旺化火生风，风阳上扰心神所致。拟柔肝滋肾，熄风安神为治。投镇肝熄风汤加减：龙骨、牡蛎、淮牛膝、白芍、茵陈、磁石各15g，熟地、玄参、天冬、龟板、柏子仁各12g，钩藤、夜交藤、代赭石各20g。水煎服，服7剂后，癫痫未见发作，神清活跃，大便微溏，夜卧时见躁动不安，盗汗。原方去柏子仁、玄参，加酸枣仁12g、五味子10g。嘱其注意生活调理，切勿打骂。继服20剂，诸症悉除。续服前方20剂以资巩固。1年后随访，未见复发。脑电图复查未见痫样放电。（《四川中医》，1993，（12）：37）

97、【侯氏黑散治痫证医案】刘炯夫：

陈某，男14岁，患痫年余，每月发作3-5次，每次约3-10分钟，1982年1月26日来诊。据诉：发作时两目上窜，牙关紧闭，手足抽搐，口吐涎沫，时有啼声。初认为风火交炽，肝风挟痰，上蒙清窍，予风引汤一付，无效。后认为四肢沉重，胃纳欠佳，内心层冷，痫以夜发为甚，观面色黯淡，神态迟滞，反应迟钝，舌苔白滑，脉弦滑而缓。脾阳不足，酿湿生痰，肝风挟痰，蒙蔽清窍。清痰祛风，养血益气，侯氏黑散加减。

处方：菊花40克，白术，防风，党参，牡蛎各10克，细辛，桔梗各3克，茯苓，半夏各6克，黄芩，川芎，胆星，干姜各5克，当归，礞石各9克，共研细末，每服6克，一日2次，开水调下。服药一月，其痫停发。

按：牙关紧闭，手足抽搐，口吐涎沫，时有啼声，肝风上扰之象。神态迟滞，反应迟钝，舌苔白滑，脉弦滑而缓。脾虚生痰之征。总为肝风挟痰，上扰清窍，又见四肢烦重特征，正合侯氏黑散之病机，症状特点。本方对肝风挟痰之癫痫，有良效。

98、【桂枝加葛根汤治抽风急性中毒性痢疾医案】蒲辅周：

陈某某，男，4岁半。1963年8月15日突然发热，恶心呕吐，4小时内抽风2次，因昏迷而急诊入院。患儿大便呈脓血样，有里急后重现象，当时诊为急性中毒性痢疾，用冬眠药物及温湿布裹身。翌日，面色转灰暗，寒战高热，呼吸微弱，经人工降温16小时，方得呼吸均匀。复温后第二天开始，每日上午发生寒战，且有紫绀，肢凉，午后高热（42—43℃）无汗，时有语妄躁动，每日下利脓血便20余次，胀，里急后重，无呕吐，食欲尚可。血检：白血球逐渐减少，出现粒细胞减少征（白血球总数600/立方毫米，中性0%）。大便培养：福氏痢疾杆菌阳性。耐药试验：对多种抗菌素等药物不敏感，于26日请我院中医会诊。诊时息

儿呼吸促迫，唇色淡红，腹满不硬，午前寒战，午后高热，右脉沉滞，左脉弦大而急，舌质色淡，苔薄白而腻。证由暑湿内伏，新凉外加，表郁里结，以致升降阻滞，营卫不通。若单治其里则伏邪不得外越，内结必然更甚，病为正虚邪实。幸胃气尚存，津液未竭，急宜升阳明，和营卫，开玄府之闭，达邪外出而解里急。方用桂枝加葛根汤：

粉葛根 6 克，桂枝 3 克，白芍 3 克，炙甘草 3 克，生姜 2 片，大枣 2 枚。

上药用文火煎取 180 毫升，每 4 小时服 30 毫升。药后另服荷叶、炒粳米煎汤。仿桂枝汤服法以助汗。药后当夜染梨汗出，但小腿至足无汗，体温渐降，四肢转温，今晨无寒，但仍有脓血便及里急后重，前方去桂枝、白芍，加健脾化湿之品调理一周而愈。（《上海中医药杂志》1964；〈8〉：13）

99、【桂枝加葛根汤痊愈小儿急惊风】

小儿急惊一症，古无其名，不知创自何时。余著有《急惊治验》一书，经李大守听斋刊送流传。兹有曾姓之子，生甫一周，染患此症。医用清热祛风化痰之剂，愈见口渴便闭，角弓反张，四肢抽掣。已无生理，医辞不治。伊戚王姓知余能医此病，时已三更，令其叩门求治。余视经纹告曰：此名痉症，俗号惊风。问曾服凉药否，曰数剂矣。余曰：此寒也，非火也。服凉药大谬。幸而今晚求治，明日殆矣。余即与以葛根汤，令其服药后覆取微汗，其搐搦自止。次晨抱来复诊，诸症悉退。再用桂枝加葛根汤而愈。（《温病浅说温氏医案·急惊风》）

100、【桂枝加葛根汤口眼歪斜一年医案】金树武：

魏某，女，45 岁，1987 年 4 月 25 日初诊。自述右动侧面部肌肉颤动，且有麻木感，口眼歪斜一年。一年前由于汗出伤风而后突感右侧面部肌肉颤动，项背强几几，右侧面部麻木，逐渐出现口眼歪斜，时有自汗、恶风、手足麻木等症。曾去某某等医院均诊断为周围型面神经麻痹。服西药（不详）及中药镇肝熄风汤、牵正散等不效。乃来我院诊治。检查：神志清楚，面色微黄，两目有神，右侧面部肌肉颤动，无明显口眼歪斜，舌淡红，苔薄白，脉弦。风邪侵袭，营卫不和，分肉不利，筋脉失养。仍以法风调和营卫，解痉舒筋为法。处方：

桂枝 15 克 白芍 15 克，甘草 10 克，生姜 3 片，大枣 4 枚，葛根 50 克。

服后吸热粥 200 毫升，取微汗避风。6 剂后症状大减。又因劳累汗出当风而复发加重，仍守前法治之，复投本方 21 剂，诸症痊愈。（《中医杂志》1989；〈1〉：27）

101、【桂枝加葛根汤治小儿惊风发热抽风】

尹某，男，1 岁。因感冒在某医院诊治，在注射了一针（不知为何药）后，即发生抽搐。转诊至某大医院后，经脊髓穿刺检查，未发现脑炎病菌，但小儿抽风不止，准备第 2 次抽脊髓。因小儿的母亲不愿而止，暗中请我去诊治，时间是 1978 年 12 月 11 日。症状是发热抽风，体温不高，只在 38℃ 多一点，四肢抽搐，角弓反张，无汗。处方：用桂枝汤加葛根：桂枝 5g，白芍 5g，甘草 5g，葛根 10g，生姜 3 片。药煮好后，只给病儿灌了 1/2 的量，不到 2 个小时，小孩不抽风了，慢慢地热也退了，当日即出院回家。这是痉病，亦名惊风，因为体温不高，不是热证，是寒证，故用桂枝加葛根汤半剂即愈。（《台北临床三十年》）

102、【桂枝汤加葛根合桂枝茯苓丸外伤性癫痫医案】曾荣修：

李某某，女，12 中江县北街 12 号。1976 年 6 月 3 日孩子八岁时在架架车上玩耍，被另一孩子推下车跌伤头部，六天后开始发癫痫，先头痛后发癫痫，服中西药无效，经刘某某医生介绍来诊。

辨证：由于外伤，瘀血阻滞致营卫不调，神经受损所致癫痫。治宜：调和营卫，兼和血化瘀，并引药上行。

方药：桂枝汤加葛根合桂枝茯苓丸三付。

半月后来信说：服药后半月时间只发病二次，而且都是晚上发病，嘱服至病愈为止。

103、【吴茱萸汤治好了一个 20 年的癫痫病人】案例分享：

我最近用吴茱萸汤治好了一个 20 年的癫痫病人，癫痫已经半个多月没有发作了，现在还在服药，我感到非常高兴，我挽救了一个家庭的幸福！

104、【茯苓甘草汤兼紫丸治治痢症】

东洞《家配剂钞》云：凡右卫门，年五十，自七年前，患世所谓痢症，月四五发，发则颠倒不知人事，与茯苓甘草汤、应钟及紫圆。

第八章 其它情志和精神病医案

105、【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】姜绍昆

夏成锡一脸兴奋地问：“姜老师，梦游症与《金匱》中的脏躁证有没有共同的病理基础？”我从来没有思考过这个问题，我也无法回答这个问题。

“梦游症是指睡眠中突然爬起来进行活动，一会儿又睡下，醒后对睡眠期间的活动一无所知的一种病症。它大多发生在小儿六岁到十二岁之间。脏躁证属于现代医学神经官能症的一种类型，更年期妇女发病较多，主要表现为表情忧郁，神志恍惚，悲伤欲哭，喜怒无常等。甘麦大枣汤证在脏躁证中比较多见。你用甘麦大枣汤加太子参治愈梦游症多例，也就可以说它们两者共同拥有一个方证。”我根据教材的内容泛泛而谈。

“姜老师，你有用甘麦大枣汤治疗过梦游症吗？”“我临床，上治疗过几例梦游症，用得较多的是甘草泻心汤，但没有用甘麦大枣汤治疗梦游症的经验。”

“我治愈了一个七岁男孩的梦游症。”原来夏成锡问我是有的放矢，并非蹈空之言。他眼睛发亮对着我说，“患儿是我外甥的儿子，三个月前发病，每天晚上一睡，下来不久就从床上爬起来，也不穿衣服，也不穿鞋子就在房间里乱走。第二天问他夜晚的情况，他一点也不知道。看过几个医院的医师，都说是梦游症，要家人在他发作时叫醒他就可以治愈。但是这个办法没有效果，依然每天晚上如此发作。这个患儿很消瘦，半年前因为夜里盗汗不止而被我用一个民间单方治愈。所以我外甥就来询问我是否有什么办法。”

“噢，就是那个你用浮小麦一两加大枣十个而治愈的那个小孩吗？”“是的，那次吃了三天就好了。当外甥询问我有什么办法的时候，我就想这次的梦游症与上次的盗汗是不是有联系，就问外甥有关他孩子盗汗的情况。我外甥说，开始不注意，最近发现半夜盗汗还是很多。我突然想到《金匱》治疗脏躁的甘麦大枣汤。因为患儿消瘦所以加 20g 太子参，当时给他开了三帖。过了一天，外甥就打电话来，说是吃药以后当晚就一夜睡到天亮，没有出现梦游症，也没有盗汗。三帖以后就好了。为了巩固疗效，我叫外甥给他儿子连续服用了十帖。现在三年过去了，梦游症没有复发，大概是治愈了吧。”

他有这样的治疗成绩，我十分高兴。这也证明了经方医学力证相对的方法简易可行，只要捕捉到用方的主症就能取效。夏成锡有常人罕见的敏感性，所以一点就懂，并在实际中有了成果。我还有一事不明白，就问：“阿锡，你为什么想到用甘麦大枣汤治疗梦游症？”夏成锡不假思索地说：“我认为《金匱》脏躁症与梦游症都是神经系统的病变，它们虽然临床表现不一样，但是可以看成是相似的主症，所以治疗脏躁症的药方也可以治疗梦游症。这是第一个理由。”

同一个神经系统的病变，就把它看作是一个相似的主症，这种跳跃式的思维方法在受过正规教育的人会认为是一种逻辑的错误。我也还从来没有做过这样的联想，不过仔细想想也不是完全没有道理。夏成锡伸出右手的两个指头说：“第二，我认为‘脏躁’就是内脏的津液干燥，当然引起‘脏躁’的原因很多，这个患儿的原因就是长期的盗汗。“脏躁，就是内脏的津液干燥”。中医学方面还从来没有听说过如此注释，但是从说文解字的角度来看也顺理成章，有所依据。夏成锡继续说：“第三，我已经用浮小麦与大枣治愈了患儿的盗汗，现在仍旧有盗汗的症状，上方依然可以使用，加一味炙甘草就是甘麦大枣汤治疗‘脏躁’，再加太子参益气生津，所以能迅速取效。”

106、【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】

去年秋天的一天傍晚，有人在我家的门口点香、烧纸钱。我就问他干什么？他说自己是一个安徽人，全家住在我的隔壁已经有好几个月了，由于他们起早摸黑外出打上，所以进进出出我们都不认识。他家的胖儿子今年十岁，发现夜间梦游症一年了，每天夜间起床到处乱跑，第二天问他什么也不知道，其他方面都正常，中西医屡治无效，所以在这里点香求求菩萨。我看他在我家打工不容易，就毛遂自荐说：‘这个毛病我能治疗，你带我去瞧瞧。’他很高兴，就带我去他的房子，我看见患儿在睡觉，满头大汗，就给他开了三帖甘麦大枣汤加黄芪 30g。第三天晚上，他登门道谢，说这帖药比仙丹还要灵验，才吃一帖就一夜平安无事。总共也就吃了三帖药，至今还没有复发。”

我对他的诊治思路与疗效都很感兴趣，就问：“加黄芪 30g 有什么根据？”“我对胖人的盗汗多重用黄芪。”

夏成锡从一个病患者渐渐地成为一个经方医学的爱好者，正因为没有正式行医，也就不存在职业中医师的许多矜持与拘谨，所以说话直来直去，不加掩饰。他对《伤寒论》与《金匱》的理解不一定都合理，但是也不乏精到之处。听了他的谈话以后，我改变了自己过去一些固化了的看法。譬如，过去我一直认为“一人一仲景，一家一伤寒”的涵义就是对许多注家各说一套的批评，批评有的《伤寒论》注家脱离临床，故弄玄虚。认为这样的“公说公有理，婆说婆有理”的现象，会把初学者置于迷惑阵之中不得自拔。然而听了他一席话才发觉自己只是想对了一半，实际上“一人一仲景，一家一伤寒”的状态也无限丰富了经方医学的内容与不断开阔了经方医师的视野。尽管近两千年来，诸多的解释与理解人多是对仲景医学思想的误读，但是只要经过临床实践的检验并得到了证实，那么这种误读就是有价值的。

107、【循衣摸床谵语不可治医案】许学士：

仪真一妇，病伤寒，八九日，发热，昏闷不识人，手循衣缝，摸床，谵语，不识人事，他医不识，或汗或利，旬日增甚，予诊之曰：此脉涩而小便不利，不可治也。翌日死，论曰：华佗云：病患循衣摸床谵语，不可治，仲景云：伤寒，吐下后不解，不大便，五六日，发潮热，不识人，循衣，撮空，微喘，直视，脉弦者生，脉涩者死，又云小便利者可治，今脉涩，小便不利，见其两死，不见一生，吾莫能为也。

108、【大承气汤、小陷胸汤治谵语发狂医案】：

一妇人，伤寒十余日，手足躁扰，口目动，面白身冷，谵语发狂。张令韶诊其脉全无，问其症不知，坐视良久，聆其声重而长，即作大承气汤灌服，至黄昏即下黑粪半床，次晨脉出身热，人事已知，舌能伸出而黑。再进小陷胸汤二剂而愈。（《续名医类案》）

109、【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：

一人病伤寒，大便不利，日晡发潮热，手循衣缝，两手撮空，直视喘急。更数医矣，见之皆走，此诚恶候，得此者，十中九死。仲景虽有症而无治法，但云：“脉弦者生，涩者死”。已经吐下，难于用药，谩且救之，若大便得通而脉弦者，庶可治也。与小承气汤一服，而大便利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。或问曰：下之而脉弦者生，此何谓也。许曰：《金匱玉函》云：循衣妄撮，怵惕不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者但发热，谵语，承气汤主之。予尝观钱仲阳《小儿直诀》云：手循衣领及捻物者，肝热也。此症在《玉函》列于阳明部，盖阳明者胃也，肝有热邪，淫于胃经，故以承气泻之，且得弦脉，则肝平而胃不受克，所以有生之理。读仲景论，不能博通诸医书，以发明其隐奥，专守一节，吾未见其能也。尝治循衣撮空得愈者数人，皆用大补气血之剂也。惟一人瞶兼振，脉代，遂于补剂中略加桂二分，亦振止脉和而愈。

110、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降

气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝 9 克，大黄 12 克，枳实 12 克，厚朴 12 克，当归 15 克。

服 1 剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服 3 剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草 6 克，又服 1 剂，神识清楚，语言正常。（陕西中医药 1976；(1)：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

111、【承气汤治大便不通谵语心中懊恼】许学士：

一人病伤寒，八九日，身热无汗，时时谵语，时因下后，大便不通三日矣，非躁非烦，非寒非痛，昼夜不得卧，但心中无晓会处，或时发一声，如叹息之状，医者不省是何症。许诊之曰：此懊恼、怫郁二症俱作也。胃中有燥屎者，承气汤下燥屎二十余枚，得利而解。

（琇按：身热无汗，似大柴胡较胜。）仲景云：阳明病下之，心下懊恼，微烦，胃中有燥屎者，可攻。又云：病者小便不利，大便乍难乍易，时有微热，怫郁不得卧者，有燥屎也，承气汤主之。《素问》云：胃不和，则卧不安，此夜所以不得眠也。仲景云：胃中燥，大便坚者，必谵语，此所以有时发谵语也，非躁、非烦、非寒、非痛，所以心中懊恼也。声如叹息时发一声，所谓外气怫郁也，燥屎得除，大便通利，胃中安和，故其病悉去也。

112、【一副药治愈失心风家传商陆汤方】

1959 年暑假，我回到故乡一山西垣曲县南羊村，只清静了一天，带的《伤寒论》还没从书包中拿出来，第二天大清早，东院南屋北平叔找上门来说，“我有个好朋友，叫孟照圣，住在北木坪村，他的女儿病了一年多，至今卧床不起，想请你去看看。”我说，“叔叔，我可是中医学院一年级学生，还没学会看病呢。”叔叔马上说，“我是看着你在药铺一天天长大的，每天放学后，你还跟着舅舅赵仲凤走村串户给人家看病，天天耳濡目染，多少也学会一点。你去看看，看得了，给他开个方子；看不了，只当去山沟玩了一趟。”吃完早饭，我叔把他的朋友带来，我只答应去看看，路上互相客套了一会儿，五里路很快就到啦。

到病人家一看，病人原是一个少女，蓬头散发，面黄肌瘦，走路东倒西歪，两眼痴呆无神，不愿睁眼，还不想起床，诊其六脉，浮而滑。浮为风，滑为痰，好像是痰迷心窍。我问少女，你怎么不好？哪里不舒服？少女望着我，只见嘴唇动，却听不到一点声音。我顺手把笔和纸给她，让她用文字表达，她拿笔写了三个字：“不怪我”。我一下明白了，这是一起包办婚姻未遂，少女怒气郁闷所激发的“失心风”症。又不便当着病人问其父母，我只好出院外树下乘凉，问少女的奶奶和爷爷。少女 18 岁，叫孟秀娥，上了高中，一年前和青梅竹马的同学暗自定了婚。她妈妈不喜欢这个男的，嫌他们家出不起嫁妆，连订婚钱都凑不齐，未经女儿同意，就找了娘家侄，私自决定给女儿订婚。少女一气之下到学校去了，不安心听课，下课不做作业，整天不吃饭，整夜不睡觉，明显精神失常，老师就把她送回家。她拒绝看病，父母也没法。由于肝郁至极，无法理通，病情加重，自言自语，也听不懂她说什么，一会儿哭，一会儿笑，不打人也不骂人，有时弃衣而走，登高而歌，裸体钻进玉米地里不出来，害得全家人放不下心。后来由狂变癫，吃饭不知饥饱，睡觉不分昼夜，几个月不说一句话。靠近细听，喉中有痰鸣声。我初步诊断为失心风，是家传秘方的适应症，就答应开方救治。

家传商陆汤方：组成：商陆、绿豆芽、大鸭梨、红糖、生姜各四两。

制法如下：先将商陆全部用开水浸泡在一个大碗中，泡 4~6 小时。泡的时间到了，再将绿豆芽挤汁、大鸭梨挤汁，和商陆汁混合，加入红糖四两，再将生姜取汁另放。药后若病人呕吐不止、下利不止，将姜汁服下即止。

一切准备就绪，让病人将药汁全部喝下。约半时许，病人开始肠鸣，急于登厕，就由姑姑、婶婶扶她去啦。正好饭也熟啦，我说等病人一块吃，主人让我先吃。我刚吃下六个饺子，就听屋外乱成一团：“快来呀，病人晕过去啦！”我顺手从书包中拿出银针捏在手中，准备急救。病人由几个壮小伙子抬进屋，放在大炕边上。我一看，吓我一跳，

病人面色苍白，无血色，四肢厥冷，六脉全无，呼吸微弱。我立即在人中扎了一针，马

上将备好的姜汁灌下。不到一分钟，病人面色红润，六脉恢复，呼吸均匀，再无痰鸣之声。屋门口挤满了四邻八舍的乡亲，急切地等待病人苏醒。把我吓坏了！这个小村无医生，无药铺，什么抢救的东西也没有。虽然心中有点怕，但我神情镇定，不慌不忙。少女的奶奶夸赞我说：“高大夫，在危重病人面前，你很老练啊！”我微微笑了笑，心想，奶奶你哪里知道，我这是在演“空城计”：“诸葛亮上敌楼，自作镇定。”

由于少女近一个月来总想轻生，几次想跳沟里自杀，老人日夜守护，加上女儿突然脱水性休克，老人已支持不住了，就说，“高大夫，今天你来值班吧。我女儿睡炕里面，你靠在炕边看书。我们俩打地铺，睡在地下，有事马上叫我。”

夜深人静，我在灯下看《伤寒论》，在想病人休克的原因是我用药不分虚实引起的。我的继母赵氏，1943年患失心风，她身体强壮，能把几十斤的东西扔来扔去，属失心风之实证；今天我看的这个少女，弱不禁风，走路东倒西歪，应属失心风之虚证，不能都用四两商陆！一般临床用一钱至三钱即能逐水消肿，我一下用到四两，自然会决流溃堤。看来今后应用时，应先辨别虚实再用。

不觉已到凌晨六点，少女翻过身，面向着我，疑惑地问道：“你是谁，怎么靠在我床上？”我告诉她，“我是大夫，我来给你看病，你妈让我值班看着你。”她羞得脸都红啦。我明白了，她不仅睡醒了，而且病也好啦。我马上把她爸妈叫醒：“快起来，你女儿肚子饿了。”其实我早饿了。

早上洗漱完，我和姑娘全家一起吃早饭。全村听说姑娘病好啦，都带着奇怪的表情，不时挤进门伸头看看。我临走时，姑娘把我送到村外，举手告别。

人常说：无巧不成书。40多年后，我在墨西哥城收到一封信，原来是孟秀娥寄来的。她说：“妈妈临终前把我叫到身边说，‘你不是我生的，是抱养南羊村井上院高家的，你妈生下你就故去啦，1959年来给你看病的高大夫，是你同父异母的亲哥哥……’”。

原来她是我继母赵玉凤的女儿，她母女俩都是吃同一方“商陆汤”治好的。生姜汁也能回阳救逆。再去理解，生姜泻心汤治肠鸣下利、“日数十行”之险证，已解利下休克之危，故仲景重用生姜加干姜，旨在回阳救逆。

113、【桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤治傻子医案】刘渡舟：

这个讲的是心的生理，肾的生理。我在大连看过一个病人，五十多岁了，挺胖，有一天他去厕所大便，大便解完一站起来头就晕了，晕了就跌倒了，后来家里人知道了就把他扶到家里去了。到家里，儿子、老伴、家里人他都不认识了。这个人就等于是个傻子了。这是个什么病，是心肾的精血大亏。后来就用了一些补心、补肾的药，补心就是补神，补肾就是补精，火以助物，水以见物。后来他就好了，也能认识人了。

114、【生铁烙方治精神病和不孕】（《素问·病能论篇》）

帝曰：“病怒狂者，此病安生？”岐伯曰：“生于阳也。”帝曰：“阳何以使人狂？”岐伯曰：“阳气者，因暴折而难决，故善怒也，病名曰阳厥。”帝曰：“何以知之？”岐伯曰：“阳明者常动，巨阳少阳不动，不动而动，大疾，此其候也。”曰：“治之奈何？”岐伯曰：“夺其食即已。夫食入于阴，长气于阳，故夺其食即已。使之服以生铁烙为饮，夫生铁烙者，下气疾也。”

注家曰：古人治怒狂，用饥饿下气夺食综合治疗，难能可贵。生铁烙，又名生铁落，是打铁飞出的铁花，其性重坠，故有下气的作用。

我很少治怒狂病人，常用桃核承气汤加生铁落，泻阳明之动，大黄推荡阳明之气，使随铁落下降。我最爱用的是防己地黄汤和镇肝熄风汤。盐山张锡纯先生，在建瓯汤中加生铁锈一两，以助怀牛膝30g降血下气。

一农村老夫人，用醋煎生铁落20~50g（已锈的）逐瘀调经，治不孕。

115、【柴胡加龙骨牡蛎汤治舞蹈病】刘渡舟：

甘肃张掖党校有个同志的小孩，大概十一二岁，就是舞蹈病，直蹦直跳的，手舞足蹈、

蹦蹦跳跳。这是个老大难的病，听说北京来了医疗队了，北京中医学院的，人家专门让我们过去看，组织上说就给看看吧，我们有三个人，一起会诊就看这个病，就是开的柴胡加龙骨牡蛎汤这个方。后来有个老师说加上点儿祛痰的药吧，病人确实还有点儿痰，就加上点儿什么胆星啊一些化痰的药。过了两三天，我们就走了，等回北京时又过张掖，这个同志就来向我们感谢，说那孩子已经好多了。

116、【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头胀痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，随访1年未再复发。（《河南中医》1995；（6）：343）

罗按：桂枝汤加龙骨牡蛎汤它不是治精神病，是治虚劳引起的精神病。

117、【葛根汤加熊胆治惊痫下利欲死医案】

《漫游杂记》云：一儿年五六岁，病天行痢二日，发惊痫、直视挛急，身冷脉绝，医将用三黄汤。余止之曰，痢发于初病时，腹气坚实，虽危不死。今外证未散，而用三黄汤，则痢毒郁积（案当云表热内陷），将迁延数十日而不愈，彼时腹气虚竭，再发痢，则不可救矣。今日之政，唯须发散耳，乃以葛根汤发之，稍加熊胆，经五日而痢愈，痢不再发。陆渊雷按：观于此案，有当注意者二事焉。其一，小儿得急性热病，热高者，往往发痉挛，时医谓之急惊风，其实非真正脑病，急解其表热，则痉挛自止。其二，病有表里证者，当先解其表，表解而里未和，然后乃攻其里。此皆治病之大法，学者宜拳拳勿失者也。

118、【栀子豉加大黄汤治胸中憋闷烦躁便秘腹胀不欲食】

刘某，女，46岁，职工。2001年6月12日初诊。患者终日心烦急躁，不能自控，总想和丈夫吵架，或者想跑到空旷无人的地方大喊大叫大哭。胸中憋闷，胃中满，腹胀，无食欲，不知饥饿，也不欲进食。大便干燥，数日未解，口渴欲饮。舌红绛，苔薄黄，脉滑数，体瘦。此属典型的枳实栀子豉加大黄汤或栀子大黄汤证。处方：栀子10g，豆豉10g，枳实14g，生大黄6g。2剂。当晚服药，次晨服完1剂，至中午解下干结大便许多，腹胀顿时减轻。午饭后感到胃腹空空，胃口大开，竟一次吃两包方便面和许多红烧肉。据述一个多月以来，因无食欲，从来没有这样吃过饭菜，也从未像今天这样感到饭菜的香味。继续服完第2剂药，烦躁、胸憋闷、胃满、腹胀诸症全消而愈。（《温病方证与杂病辨治》）

119、【小柴胡加生地黄昼则安静夜则谵语热入血室】：

妇人经行，感冒风邪，昼则安静，夜则谵语，此热入血室也用小柴胡加生地黄治之顿安，但内热头晕，用补中益气，加蔓荆子而愈。后因怒恼寒热谵语，胸腹胀痛，小便频数，月经先期，此肝火血热妄行，用加味道遥散加生地黄而愈。（《妇人良方集要》）

120、【加味道遥散加生地黄】

妇人因怒，寒热头痛，谵言妄语，至夜益甚，月经暴至，此怒动肝火用加味道遥散加生地黄治之，神思顿清，又用补中益气汤而痊。（《妇人良方集要》）

121、【香砂六君归脾月经不止肚腹作痛呕吐】

妇人经行，感冒谵语，或用发散寒凉之剂，前症益甚，月经不止，肚腹作痛呕吐不食，痰涎自出，此热入血室，而寒复伤胃也，用香砂六君，及归脾而痊。

122、【侯氏黑散治狂证医案】朱卓夫：

邓某，男，40岁。其弟代诉：初患感冒，迁延数日，变症叠出，延余诊治。证见语无论次，詈骂不休，不避亲疏，口唾白沫，时刻不断，脉象浮缓，舌苔清润。余进以侯氏黑散。

处方：菊花24克，防风9克，桔梗9克，茯苓9克，当归9克，牡蛎9克，人参6克，

干姜 6 克，桂枝 6 克，矾石 6 克，黄芩 6 克，川芎 5 克，细辛 3 克，上药共研细末，酒服 9 克，日一次。

嘱初服二十日，温酒调服，禁一切鱼肉大蒜。后四十日改冷服，共服六十日止。时亲朋满座，谓斯病热剧，不堪服此热药，要求易方。余加释疑，强与服之，服一次后，白沫稍减。次日更进一次，詈骂亦渐止。继以六神汤：茯苓 15 克，半夏 12 克，旋覆花 12 克，胆南星 12 克，陈皮 6 克，石菖蒲 6 克，4 剂而安，可见认症既确，立志须坚，斯时倘轻信旁言，改而不用，则病必不愈矣。

按：本案脉证所现，属风痰上扰之候，故以侯氏黑熄风祛痰，潜镇心神。继以六神汤，在于理脾调中，以绝生痰之源。本案服药方法亦较有章法，初用温酒调服，在于活血以祛风。继而冷服，乃取药积腹中，排泄迟缓，以达潜肝镇心安神之效。

第九章 自闭证

123、【阿骅表兄四逆三生饮方证桂枝加龙骨牡蛎汤自闭证治验医案】

阿骅表兄给讲的故事与教我诊治忧郁症的“四逆三生饮方证”，在临床上我也时有应用的机会。如果方证相对应，就能取得覆杯而愈的疗效。

1994 年秋天的一天晚上，我的一个高中同学带他的妹夫来我家看病。他的妹夫在上海的工厂工作，40 岁，中等身材，偏于消瘦，脸色白净，五年来渐渐地出现自闭现象，除上班以外，不愿参加任何社交活动。近年来讲话的次数也越来越少，厌世情绪日益增加，有气无力的样子，喜欢独自一人紧团门户，可以连续几个小时盯着看一张图片，多梦易醒，性欲下降，恶风自汗，清晨空腹时经常呕出水样的痰涎，反复出现服药自杀的举动，这些都被家人及时发现。他对自己的想法与行为非常冷静，拒绝到医院就医。

患者脉象滑大，舌体大而暗淡红色，舌苔白腻而厚，腹诊腹肌菲薄拘紧，心下与肚脐上下有悸动。我认为患者是腺病质的桂枝加龙骨牡蛎汤证，依据阿骅表兄“四逆三生饮方证”诊治忧郁症的经验，取其三生饮与桂枝加龙骨牡蛎汤合方，先投五帖。服药后疗效极为明显，精神状态大为恢复。二诊时相当配合，原方再投五帖，就轻轻松松地回上海去了。回去后为改善体质，继续服用桂枝加龙骨牡蛎汤，半个月后患者的妻子来电话说，一切都很正常，渐渐地也参与到社交活动中去了，和生病的时候相比恍如换了一个人。一晃十五年过去了，在这期间都没有复发的迹象，只是每逢春节的时候，时时来电话问候，我心中也非常欣慰。

2009 年 10 月，我的同学又带他的妹夫来求诊，说是近几个月因为家中事情烦心，又出现十五年前的类似症状，只是程度较轻而已。我诊察时发现有一部分症状已经有所改变，如面色暗黄、口苦口臭、口干欲饮水，腹诊时发现胸胁部满闷不适，难以名状，肚脐上下腹主动脉悸动应手。考虑再三投柴胡加龙骨牡蛎汤和三生饮合方五帖，真的如愿以偿，服药后依然是覆杯有大效。再诊时，守方不变，他们就带了几包未服的中药回上海去了。一个月后其妻子来电话，高兴地告诉我，一切平安无事。我在电话中给她的丈夫开方，开的方子是调节体质的柴胡加龙骨牡蛎汤，要求患者每周服五帖，连服三周后停药观察，停药至今一切无恙。

这个病案，前后相隔十多年，病还是这个病，然而人的体质状态却发生了变化，所以方证也发生了改变。医者只要知常达变，随证治之，就能取效。

124、【柴胡桂枝干姜治不欲见人自闭证】

又云：一男下，平居郁郁不娱，喜端坐密室，不欲见人，动辄也视，胸腹有动，不治六年。所先生诊之，与柴胡姜桂汤而愈。

第十章 抑郁症

125、【吴茱萸汤治抑郁症不时哭笑】案例分享：

某女，多疑，幻觉，不时哭笑三周，伴胸闷，手足冷，梦多，想自杀，诊为抑郁症。来诊所时，舌淡，苔白，脉细，用吴茱萸汤3剂，已不再哭，也不想自杀了，今天第五天，已开始说话正常，眼神正常，自己说要去复课了。经方就是这么神，我又给她开了7剂。

第十一章 老年痴呆

126、【柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤治疗痴呆老人】黄煌：

一位女士是我的老病人了，她患有严重的便秘，检查发现结肠冗长，结肠袋消失，外科医生建议手术。我给她服用的是柴胡加龙骨牡蛎汤合栀子厚朴汤，后来居然有了便意，开塞露也可以停用。所以，她介绍了不少消化系统的病人来，而且效果都不错。

这次她来的目的，除了自己看以外，还为她的奶奶转方。老人已经87岁，消瘦，去年冬天房颤发作，后又出现脑梗，至今年春天大都卧床不起，经常胡言乱语。我当时用的方是柴胡加龙骨牡蛎汤合桂枝茯苓丸与栀子厚朴汤。这位女士告诉我这张方很灵，服用以后，头脑就会清醒，失眠、夜尿频繁、烦躁，说话颠三倒四的现象就减少。但停药个把月后，症状又会加重，再服此方，又会好转。所以，这张配方也就间断服用的。我没有更方，慢性病还是要守方。这位女士小心收下处方签，笑容满面地走了。

这个反馈信息对我很重要。老年性痴呆是难病，柴胡加龙骨牡蛎汤与桂枝茯苓丸栀子厚朴汤合方对老年性痴呆有效，虽然是近期疗效，而且也只是改善部分症状，但已经是不简单了。这个信息提示我以后可以进一步观察。我的许多经验就是从个案开始摸索的。

柴胡加龙骨牡蛎汤是《伤寒论》方，方证的经典表述为：“胸满，烦、惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者”。这都是精神神经系统疾病的部分常见症状，所以，我将此方经常用于抑郁症、恐惧症、神经症以及脑萎缩、痴呆等。桂枝茯苓丸是活血化瘀的名方，老年人瘀血多，尤其是脑血管梗塞患者，多用此方。栀子厚朴汤只有三味药，栀子、厚朴、枳实，经典方证是“心烦腹满，卧起不安”，这正是焦虑症、抑郁症患者常见的表现，栀子厚朴汤除胀满，抗焦虑，效果好。三方相合，作用面更宽，改善睡眠的效果尤其明显。对于许多老年性痴呆等老年脑病患者来说，睡眠的改善就是其生活质量的提高，不可小视啊。

第十二章 狂犬病

127、【血自下下者愈之下瘀血汤治狂犬病】医学衷中参西录：

无锡友人周小农，曾登《山西医学杂志》，论治疯犬咬伤之方。谓岁己丑，象邑多疯犬，遭其害者治多无效。适有耕牛亦遭此患而毙。剖其腹，有血块大如斗，黯紫，搅之蠕蠕然动，一方惊传异事。有张君者，晓医理，闻之悟曰：“仲景云‘瘀热在里，其人发狂。’又云‘其人如狂者，血证谛也，下血狂乃愈。’今犯此证者，大抵如狂如癫，得非瘀血为之乎？不然，牛腹中何以有此怪物耶？吾今得其要矣。”于斯用仲景下瘀血汤治之。不论证之轻重，毒之发与未发，莫不应手而愈。转以告人，百不失一。其所用之方，将古时分量折为今时分量，而略有变通。方用大黄三钱，桃仁七粒，地鳖虫去足炒七个，共为细末，加蜂蜜三钱，用酒一茶碗煎至七分，连渣服之。如不能饮酒者，水、酒各半煎服亦可。服后二盒饭下恶浊之物。日进一剂，迨二便如常，又宜再服两剂，总要大、小便无纤毫恶浊为度。服此药者，但忌房

事数日，其余则一概不忌。若治小儿，药剂减半。妊妇亦可放胆服之，切莫忌较。按：服此方果如上所云云，诚为佳方。

【逐风汤治狂犬病】张锡纯：

曾治一媪，年六旬。其腿为狗咬破受风，周身抽掣。延一老医调治，服药十余日，抽掣愈甚。所用之药，每剂中皆有全蝎数钱，佐以祛风、活血、助气之药，仿佛此汤而独未用蜈蚣。遂为拟此汤，服一剂而抽掣即止。又服一剂，永不反复。（逐风汤方：治中风抽掣及破伤后受风抽掣者。生箭芪六钱，当归四钱，羌活二钱，独活二钱，全蝎二钱，全蜈蚣（大者两条））

第十三章 癫痫疾病篇

128、【桂枝去桂加茯苓白术汤治癫痫医案】李克绍：

王某某，女，约50岁。患者经常跌倒抽搐，昏不知人，重时每月发作数次，经西医诊断为“癫痫”，多方治疗无效，后来学院找我诊治。望其舌上，一层白砂苔，干而且厚。触诊胃部，痞硬微痛，并问知其食欲不佳，口干欲饮，此系水饮结于中脘，但病人迫切要求治疗癫痫，并不以胃病为重。我想，癫痫虽然是脑病，但是脑部的这一兴奋灶，必须通过刺激才能引起发作，而引起刺激的因素，在中医看来是多种多样的，譬如用中药治癫痫，可以选用祛痰、和血、解郁、理气、镇痉等各种不同的方法，有时都能减轻发作，甚至可能基本痊愈，就是证明。本患者心下有宿痰水饮，可能就是癫痫发作的触媒。根据以上设想，即仿桂枝去桂加茯苓白术汤意。处方：茯苓，白术，白芍，炙甘草，枳实，僵蚕，蜈蚣，全蝎。

患者于一年后又来学院找我看病，她说，上方连服数剂后，癫痫一次也未发作，当时胃病也好了。现今胃病又发，只要求治疗胃病云云。因又与健脾理气化痰方而去。（《伤寒解惑论》1978）按语：于本案足见辨证求因，审因论治之重要。

129、【五苓散治癫痫医案】刘渡舟：

曾治河北晋县一王姓男青年，患癫痫，虽屡用苯妥英钠等抗癫痫药物，不能控制发作。自述发病前感觉有气从下往上冲逆，至胃则呕，至心胸则烦乱不堪，至头则晕厥，人事不知，少顷则苏醒。小便频数，但排尿不畅，尿量甚少。脉沉滑，舌质淡嫩，苔白。我辨为太阳膀胱蓄水，水气上逆，冒蔽清阳之证，以利水通阳，温养心肾之法治疗。方用泽泻18g、茯苓12g、猪苓10g、白术10g、肉桂3g、桂枝10g。连服九剂，癫痫发作竟得以控制。临床实践证明，对于阳虚水泛型的癫痫病，还可用真武汤治疗，或以五苓散与真武汤合方使用，皆有良好的疗效。

130、【五苓散治癫痫医案】刘景祺：

陈某某，男，45岁，1979年7月20日初诊。患癫痫已三年，为受惊后而起，最初每月数发，近半年来每天发作，发则不省人事，惊叫抽搐，项背强直，口吐涎沫，每次发作约持续八至十二分钟，屡用西药，未能控制。口渴自汗。苔薄白，脉浮滑。辨证：气化不行，水饮上冲。治则：化气行水，祛风止痉。处方：茯苓18克，猪苓18克，桂枝18克，白术18克，泽泻30克，钻地风30克，千年健30克，钩藤30克，防风21克。

服6剂已控制发作。服24剂，临床治愈。疗后3年无复发。（经方验肥）

注家按语：五苓散治癫痫，国内外均有报导，本方对水饮型癫痫，疗效甚佳。

131、【柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散（癫痫）】

胡某，14岁，初诊1965年10月18日：4年前患急性黄疸性肝炎经治疗黄疸退，但食纳不佳，肝功时有波动，时头晕目眩，近一年来大约每半月有一次癫痫发作，发作时先觉气上冲咽，旋即四肢抽搐，继则牙关紧闭，后则不省人事，口吐白沫，经常服西药镇静药，但仍每半月发作一次，常感乏力，每发作后尤为明显，因食欲不振而现身体瘦弱，舌净无苔，脉

弦细稍数此证属血虚水盛，治以养血利水，嘱停服西药镇静药，与柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散：

柴胡四钱，黄芩三钱，桂枝三钱，白芍三钱，川芎二钱，苍术三钱，茯苓三钱，泽泻五钱，花粉六钱，生龙骨五钱，生牡蛎五钱，炙甘草二钱。

二诊 10 月 25 日：纳稍增，近几天咳嗽吐白痰，合用半夏厚朴汤：半夏四钱，厚朴三钱，苏子三钱，生姜三钱，茯苓三钱，柴胡四钱，黄芩三钱，花粉六钱，生龙骨五钱，生牡蛎五钱，桂枝三钱，当归三钱，白芍三钱，川芎二钱，泽泻四钱，苍术四钱，炙甘草二钱。

三诊 10 月 29 日：咳已，小便频，失眠，与猪苓汤合当归芍药散：猪苓三钱，茯苓三钱，泽泻四钱，滑石五钱，白芍三钱，川芎二钱，酸枣仁五钱，阿胶三钱。

四诊 11 月 2 日：尿频已，头晕、失眠好转，右胁痛，纳稍差继服 10 月 18 日方。

五诊 12 月 17 日：胁痛已，未发癫痫，查肝功正常。嘱停药观察。

【癫痫】

癫痫，见《内经》大奇论等篇，是一种发作性神志异常的疾病，又名胎病，说明《内经》早已指出病因中的遗传因素，或因惊恐，情志失调，饮食不节，劳累过度，伤及肝、脾、肾三经，使风痰随气上逆所致。证见短暂的失神、面色苍白、双目凝视，但迅速恢复常态；或见突然昏倒，口吐涎沫，两目上视，牙关紧急，四肢抽搐或口中发出类似猪羊的叫声，醒后除感觉疲劳外，一切如常人，时有复作。在发作阶段，治宜豁痰开窍，熄风定痛。

癫痫发作的病理因素以痰为主。由于痰聚而气逆不顺，于是导致气郁化火，火升风动，挟痰上蒙清窍，横窜经络，内扰神明，以致痫证发作。若痰降气顺，则发作渐止，神志渐苏，醒后外观如常人。甘草泻心汤治疗此病，可以健运中焦，清化痰热，降痰顺气，可减少或消除痰浊气郁的病理因素。

以本方制成丸剂久服可治疗发作较轻，间歇时间较长的轻型癫痫，间或有治愈者。对病程长、病情严重的虽未必能根治，但对改善症状方面，有一定的意义。

132、【甘草泻心汤治癫痫半年余病】

李 xx，女，68 岁。患者平素精神抑郁，性格不开朗，患癫痫半年余，约 20 余日或一月发作一次。发作时突然昏倒，不省人事，口吐白沫，两目上视，四肢抽搐，约持续五分钟后，即进入昏睡，半小时左右清醒。醒后除感头痛、心悸、疲乏外，余无不适。曾服西药苯妥因钠及利眠宁等药治疗，症状未见多大改善。后改服甘草泻心汤，制成丸剂，连服半年，在服药期间又发作两次，以后一直未复发。

133、【用催吐法治癫痫医案，止吐药和瓜蒂散致人死亡】郝万山：

病人 12 岁，男，他有癫痫。当地邻村有一个老中医，他专治癫痫，就到这个邻村找这个老中医去买药，这个老中医药也卖得很贵，就一小包，研末的药。回来之后就给她儿子吃上，吃了之后这个孩子就剧烈的呕吐，吐了大量的粘液，包括胃的内分泌物，好，三个月癫痫不发作，三个月以后，癫痫又发作了，大发作。他妈妈想，既然吃这个药有效的的话，我再找他去买个这药。第二天就去买药，买回来之后也是同样的方法，吃完了就吐。

吃完了又是有三个月没有发作，第三次还是得买药。她妈妈就给她大儿子说，她大儿子是农村医生，说你看看你的弟弟吃了这老头儿的药，每吃完之后马上就吐出来，吐出来之后呢能管三个月，你说他吃完了就吐出来，它的药效吸收得太少了，只管三个月，如果让这个药能在胃里头多呆一会儿，多吸收一点，能不能管得更长一点时间啊，药又这么贵。

她大儿子说要是这样的话，我可以想个办法，我可以先给他打一针爱茂尔，大家知道爱茂尔有镇吐的作用，他妈妈说，你打这爱茂尔，多长时间发挥作用啊，等它快发挥作用提时候，我们再给你弟弟吃这个药。好，第三次买回来药之后，他哥哥提前半个小时给他弟弟打了一针止吐的药，然后他弟弟吃完这个药之后，欲吐不得吐，辗转反侧，坐卧不宁，过了一会儿就出现了冷汗直出，呼吸急促，面色苍白。他妈妈和他哥哥一看，唉哟，大事不好。非常偏僻的农村，根本没有汽车，拉着个小平车，就往城里拉，走到半路，这孩子就死了。

瓜蒂的毒素中毒，呼吸麻痹，呼吸停止了。我想他用了催吐的药，除了瓜蒂散没有别的，他怀疑这老大夫用了什么毒药。催吐的药除了瓜蒂散没有别的，用催吐的方法就是因势利导，就是让他吐，这个药不能吸收，吸收了之后就会导致中毒的，就是让它刺激胃粘膜，通过胃粘膜分泌大量的粘液，把体内的毒素、病理产物排泄出体外。

中医是个很仁慈的医学，它都是给邪气出路的。病在体表的话，用发汗的方法，把在体表的这些毒素、这些代谢产物通过汗排出体外。你看，使邪气排出体外的时候，人们要付出些津液。汗不是津液所化吗，毒热、毒素在体内的时候，通过通大便的方式来排出体外，这都是给邪气出路的方法，湿热在体内的时候通过利尿的方式，通过泌尿系统把毒邪排出体外。而有形的邪气或者毒邪在上焦的时候，我们就通过胃粘膜的分泌，通过刺激胃粘膜让它分泌大量的粘液，然后把体内的毒素排出体外。这都叫给出路的政策，所以中医特别忌闭门留寇的方法。我说这个农村医生，你呀，本来是催吐，是给邪气以出路，你先打了针爱茂尔来镇吐，所以闭门留寇，导致了瓜蒂毒素的吸收中毒，导致了呼吸的麻痹。

134、【当归四逆加吴茱萸生姜汤治舌外伸流涎四肢不温（运动性癫痫）医案】丁世名：

史某某，男，8岁，1982年2月15日诊。1981年7月始，自觉疲困嗜睡，逐渐加重，昼夜昏睡，呼之则醒，但旋即复睡。经脑电图检查，诊断为“运动性癫痫”。诊时舌外伸、流涎，四肢不温，舌嫩、苔薄白，脉微细。证属阴盛阳微，阳被阴遏。治当温通经脉，散寒助阳：当归、白芍、党参、吴茱萸各10克，桂枝15克，细辛5克，通草3克，生姜3片，大枣3枚。

6剂后，嗜睡瘥，流涎止，手足温，饮食精神好转，但性情烦躁，舌红，脉沉，继用仲景桂枝甘草龙骨牡蛎汤3剂，诸证消失。3月后随访，未见复发。

135、【瓜蒂散治癫痫变证医案】陕西中医函授1992年5期报导：

马某，男，16岁，住院号：15186。患者于1988年2月10日18时急诊入院。其父代诉：患儿因癫痫病多年，久治无效，遂找某医用催吐法治之。于当日下午16时服瓜蒂细粉1克，以温水送服。药后半小时未见呕吐反应，遂再服0.5克，服后约10分钟，即出现严重的脘腹疼痛和剧烈的恶心呕吐，呕吐物为咖啡色液体，内含食物残渣约500毫升，继之呕出鲜血数次，每次约100毫升，半小时后脐腹绞痛，大便呈稀水样，数次，随即也转为鲜血样，先后便出四次，均为少量血液，于18时急来本院就诊。

查体：急性重病容，神清，精神萎靡，呈脱水貌，血压5.32/2.66KPa（40/20毫米汞柱），心肺（一），腹软，全腹广泛性压痛，肝脾未触及。急行常规洗胃，插管过程中又因恶心呕出鲜血少量，故改为口服清水洗胃，同时急给补液、升压、输血、止血、抗感染等对症处理，经综合治疗，吐泻停止，再未出血，经10多小时的抢救，血压回升到正常，腹痛等症状消失，精神好转，三日后大便一次，隐血试验转阴，能进少量饮食，于2月14日出院调治。

136、【风引汤癫痫医案】郭志生：

癫痫患者，女，45岁，2003年5月17日初诊。1年前因生气而发病，当时突然昏倒，不省人事，四肢抽搐，口吐白沫，约3分钟后自行缓解。半个月后无明显诱因再次发作，遂到当地医院就诊，诊断为癫痫。予以鲁米那口服，服药后半年未发作。后因生气再次发作，每周发作1次，呈癫痫大发作样，故来我院求治。现症：头晕乏力，胸闷痰多，烦躁易怒，舌红，苔黄厚腻，脉弦滑有力。中医诊为痫证，证属肝阳上亢、痰热阻窍。治宜潜阳熄风、清泻肝火。予以风引汤加减，处方：大黄15g，桂枝10g，干姜10g，生、龙牡蛎各30g，生石膏30g，寒水石30g，滑石30g，赤石脂15g，紫石英30g，胆南星15g，全蝎6g，蜈蚣1条。水煎服，1天1剂。服药30剂，癫痫未发作。后将上方改为散剂，1次6g，1天2次，水冲服。服药3个月，病情稳定。遂改为1次6g，1天1次，睡前服。服药至今已4年，癫痫未再发作。（《中医研究》）

137、【甘遂半夏汤治脑积液伴癫痫医案】钟枢才：

曹某，男，59岁。某航空工业学校职工，1993年3月15日初诊。主诉：头痛半年，伴癫痫发作3月。病员半年前始现头晕痛，持续不止，因病情不重，故未予治疗。3月前突然发生昏倒，不省人事，四肢时有抽搐，口中冒出白沫，约有5分钟之久。病员苏醒后感精神疲惫，四肢倦怠，头晕头痛加重，遂送本市某医科大学附属医院诊治。经CT检查，诊断为右颞叶硬膜下积液（约6mm×6mm），第3~5颈椎骨质增生。治疗用大仑丁0.1g，每日早晚各服1次，以控制其癫痫发作。但服药后，仍然每周有2~3次癫痫发作，每次3~5分钟左右，并伴有头晕头痛，恶心呕吐，失眠烦躁，记忆减退。遂前来我院求治于李老。患者现症状如前，饮食尚可，二便调，舌质红，苔白，脉沉。诊断为癫痫，由痰饮上逆所致。李老认为，该病员体质比较壮实，病程较短，病情较重。病属实证，可先攻逐痰饮，用《金匱要略》之甘遂半夏汤。

处方：甘遂3g（另包单煎兑服），法半夏20g，白芍10g，炙甘草6g，水煎，蜂蜜兑入药汁口服，每2日1剂。

3月22日复诊：服上方后，病员稍感脘腹不适，时有腹痛，每日泻下稀水2~5次，未见呕吐。现服完3剂，病员自觉头晕头痛减轻，服药期间未有癫痫发作，但仍有时呕恶，失眠心烦。舌质红，苔薄白，脉沉。《素问·五常政大论》云：“大毒治病，十去其六。”今用甘遂半夏汤既已中病，恐大毒之性烈，反伤正气而致他疾，故暂缓攻逐，改用化痰利湿之品，以图缓治，用二陈汤加减。处方：菖蒲子15g，车前子15g，白芥子10g，薏苡仁30g，茯苓15g，草薢20g，茵陈20g，法半夏20g，枳实15g，甘草10g，水煎服。3月29日复诊：患者2周末发癫痫，自觉时有头晕头痛，现睡眠较好，二便调，饮食好，舌红苔白，脉沉。李老曰：病人自觉症状虽减，但脑部积液尚未能尽除。病员体质壮实，仍可再度攻逐。故再用甘遂半夏汤。此后复诊，李老嘱以上述攻逐，化痰利湿二法交替使用，连续治疗2月，患者癫痫一直未发作，精神好，余正常。建议病员复查CT，但病员自认为其病已愈，未做检查。（成都中医药大学学报）。

【临证提要】本方乃治疗留饮的主方，方中的甘遂与甘草属于后世“十八反”用药禁忌之一，故临床应用本方应严格把握病机与主证。本方适于饮邪久留，邪盛体实的急顽重症，现代临床多用于结核性胸膜炎，湿性肋膜炎，胸腔积液，心包积液等病，服本方后大便当泻下黏腻如鱼冻样物。

138、【癫痫里也有五苓散证】胡希恕：

癫痫里也有五苓散证，这我也治过，其中一个小孩还是我亲戚，我就用这个整个治好了，他从小隔些日子就上抽，还吐涎沫。有些他们旁的书给改了，把癫改颠，说上面晕，这晕不在上面，还能脚底晕吗？像金鉴就改错了，表示他就没遇过这种病，我遇过这种病，拿这个药治真有效。不过这个癫痫不一定是水，也有瘀血其它问题的，但如果是水引起的，这水从哪来看的？一个眩，一个悸、脐下悸，这些都是水饮所作。

139、【五苓散治癫痫医案】刘渡舟：

我曾治河北晋县一王姓男青年，患癫痫，虽屡用苯妥英钠等抗癫痫药物，不能控制发作。自述发病前感觉有气从下往上冲逆，至胃则呕，至心胸则烦乱不堪，至头则晕厥，人事不知，少顷则苏醒。小便频数，但排尿不畅，尿量甚少。脉沉滑，舌质淡嫩，苔白。我辨为太阳膀胱蓄水，水气上逆，冒蔽清阳之证，以利水通阳，温养心肾之法治疗。方用泽泻18g、茯苓12g、猪苓10g、白术10g、肉桂3g、桂枝10g。连服九剂，癫痫发作竟得以控制。临床实践证明，对于阳虚水泛型的癫痫病，还可用真武汤治疗，或以五苓散与真武汤合方使用，皆有良好的疗效。

140、【五苓散合真武汤加减治癫痫】姜绍昆：

王某，男，33岁，干部，1995年3月15日初诊。5年来患者经常昏倒、抽搐，无明显诱因，常一月数发。经神经内科检查，确诊为癫痫。刻诊：体型消瘦，面色苍白，时有腹痛，

便溏夹有黏液，下肢浮肿，小便不利，色黄而短。发作时先觉背后发冷，旋即昏仆不知人，继而四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，历时5~10 min，醒后乏力，畏寒形冷，头眩心悸，时有颤抖。舌淡暗，形大质嫩，苔薄白腻，脉沉弦。腹诊：腹肌菲薄，扁平，两腹直肌拘急，心下悸动，脐上按之跳动明显。此为太阴少阴合病，阳气不足，水饮上泛，蒙蔽心窍。治宜温阳利水，通阳化饮，用五苓散合真武汤加减：附子、白芍桂枝、猪苓、泽泻各10g，白术15g，茯苓30g，生姜3片，5剂。第3剂服后，顿觉手足与前胸后背汗出，小便爽利，头眩稍减。5剂尽服后，诸症悉减，守方再服10剂。服药期间仅小发作1次，尚觉神疲，转方为春泽汤合小剂真武汤，连服3个月而痊愈，随访6年，未规复发。

按：患者消瘦，面色苍白，自汗，腹肌菲薄，按之拘紧，符合桂枝汤证；背冷，心下悸动，下肢浮肿，小便不利，为典型的五苓散证；形寒肢冷，腹痛，头眩，心悸，筋惕肉明，为真武汤证。脉症、舌象均符合痰证，故投五苓散、真武汤合剂而愈。后因邪去正虚，故加党参并小其剂而全功。此病治疗，如仅从病因出发，不作方证、药证的具体分析，恐怕不能中鹄。之前对于五苓散的方证，看到比较多的是有表证之蓄水证和水泻证，亦或无表证之水饮内停证等等，多以“水肿、小便不利、发热而渴、渴欲饮水，水入则吐、淡嫩舌、水滑苔”为目标，基本上都是《伤寒论》中的五苓散的那些条文的症候，但是，对于金匱中的另外一条“假令瘦人有悸，吐涎沫而癫眩，此水也，五苓散之”的症候，确实忽视了。这个医案做了一个很好的注脚。

五苓散脉象：可浮（病在表兼水饮不利）。可弦（弦也主水饮）。可沉（沉也主水饮）。

141、【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云：

患女，12岁。癫痫大发作六年，用苯妥英钠治疗无效，改用甘麦大枣汤，每日加明矾米粒大1枚冲服，连服半年而愈。随访6年未发作。（浙江中医杂志）

按语：本案标本兼治，值得借鉴。

142、【瓜蒂散癫痫】

城州梅瑞真休寺住持，有痫症，发则乱言，或欲自缢，且足挛急，难以行步，来请治。予晓以非吐剂莫治。而僧侣沮之，不肯服，乃请治于他医。医与四逆散加吴茱萸牡蛎，半年无寸效，于是再来请治。予则用瓜蒂、赤小豆末，以汁服之。吐黏痰许多，不复发，足挛急顿治。住持甚悦，行歌相赠。《生生堂医谈》。

143、【自拟牛黄天麻散治小儿特发性癫痫19例】杜玉玲

近年来，笔者采用自拟方“牛黄天麻散”治疗小儿特发性癫痫19例，均取得较好疗效，现介绍如下：一，一般资料19例患儿年龄在3~10岁之间，男女之比为10:9，均经西医诊断为“特发性癫痫”之后前来要求服中药治疗。二，治疗方法及结果方药组成：牛黄1克明天麻15克白附子15克僵蚕15克炮姜15克元寸1克荆芥炭15克白术20克云苓30克吴茱萸15克肉桂14克小茴12克。用法：将上药共研细面，装瓶备用。每日服一次，每次6克，清晨空腹时服用。先将药面倒入茶缸内，加水200毫升，煎熬5~6分钟后，加入红糖少许，带药渣一并温服。

144、【柴胡桂枝干姜汤治素有痫证】

《成绩录》云：一女子，素有痫证，一时患疫，诸医疗之，不建。迎先生乞诊治，其腹有动，头汗出，往先寒热，大便燥结，时时上冲，昏不识人，日夜如此两三次，乃与柴胡姜桂汤，及紫圆攻之，不一月，诸证尽除。

145、【大黄蟅虫丸治外伤性癫痫医案】郭汉林：

张某某，男，38岁。1986年7月诊。三年前因车祸被撞伤头部，昏迷两天，抢救脱险后头昏，头痛，记忆力减退，多梦失眠。半月后行走时突然大叫一声昏倒在地，四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，气壅息粗，喉有痰鸣，大便失禁，约半小时后自行苏醒，全身困倦，反应迟钝。在西安某院查脑电图诊断为外伤性癫痫，给服大仑丁、丙戊酸钠不能控制。近日来发作频繁，每日一至三次不等，饱食及情绪激动容易诱发。查体质消瘦，神情呆滞，反应迟

钝，面色晦黯无华，舌紫暗，苔白腻，脉沉涩，余(一)。其脉症皆一派血瘀征象，故给血府逐瘀汤10剂，意图开闭通瘀，散结消肿。药毕证如前，发作依旧。窃思血府逐瘀汤乃活血祛瘀平剂，不能胜病，此非峻剂而不能破其瘀积于头部离经之血，故改予大黄蟅虫丸每日两次，一次两丸，早晚温开水送服。半月后始感腹部隐疼，大便稀溏、黑褐色，头昏头痛减轻，癫痫发作次数显著减少，3~5日一次。夜寝安静，精神振作，面有悦色。连服一月，体质恢复，面色红润，精神如常，舌淡红，苔薄白，脉弦数。服法改成一日两次，每次一丸，早晚服。又治一月，体质康复如常。癫痫半月未犯，遂停药。随访一年未犯病。(《四川中医》1989;(8): 28)

第十四章 精神病的药方

146、【我治精神分裂症有一个方】刘渡舟：

里面有蜀漆水焯，一钱到一钱半，然后有大黄、黄连、远志、菖蒲。这个药治疗精神分裂症带有热性的，带有热痰的，效果很好。吃了这个药以后有两个方面的问题要注意，有的就吐，有的就泻，有的是上吐下泻，服了它得活动，吐一些痰，泻也泻一些黏黏糊糊的东西，一下子就好了。这个方子还挺管用的。

蜀漆在水里焯一焯，根据身体情况用一钱到一钱半，还是有效果的。吃了以后这人精神就清亮了，有的时候晚上睡不好觉，失眠，有的打人骂人摔东西，吃了它以后就稳当了。所以蜀漆不能光理解为去火邪的，它还是祛痰的药，治疗痰迷心窍，由痰而影响心神的惊狂的，这个药是个好药。

【原文】：病中风，如狂状，妄行，独语不休，无寒热，其脉浮者，宜防己地黄汤。(依培古本补)

赵以德曰：狂走谵语身热，脉大者，则阳明。若此无寒热其脉浮者，血虚从邪并于阳而然也。《内经》曰：“邪入于阳则狂”，此狂者谓五脏阴血虚乏，魂魄不清，昏动而然也。桂枝、防风、防己酒浸其汁用，是轻清归之于阳，以散其邪。用生地黄之凉血补阴，熟蒸以归五脏益稍养神也。盖药生则散表，熟则补衰，此煎煮法也，又降阴法也。阴之不降者，须少升以捉其阳，然后降之方可下。不然则气之相并，不得分解矣。

徐忠可曰：此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滞涎，涎滞则留湿，湿留雍火邪聚于心。故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火，凉血热。谓如狂妄行独语不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚不疑耳。后人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。

防己地黄汤方：

防己、甘草各一分，桂枝、防风各三分

上四味，以酒一杯渍之一宿，绞取汁。生地二斤，咬咀，蒸之，如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

《千金方》：风眩门防己地黄汤，治言语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。防己、甘草各二两，桂心、防风各三两，生地黄五斤别切，勿合药渍。疾小轻用二斤。

上五味，咬咀，以水一升渍一宿绞汁，著一面取滓著竹箬上，以地黄著药滓上，于五斗米下蒸之，以铜器承取汁，饭熟以向前药汁合绞取之，分再服。

徐灵胎曰：此方他药轻而生地独重，乃治血中之风。生渍取清汁归之于阳以散邪热，蒸取浓汁归之于阴以养血，此皆治风邪归附于心，而为癫痫惊狂之病。与中风、风痹，自当另

看。又曰：凡风胜则燥，又风能发火，故治风药中，无纯用燥热之理。此方他药轻而生地独重，治血中之风也。

147、【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民：

防己地黄汤，几味治风寒湿的药怎么会治癫狂症呢？殊不知此方之妙，妙就妙在“不安神而神安，不治狂而狂自愈。”1960年，宋老向我传授《金匱要略》经方的用法时，告诉我，他在广州行医时不止一次用此方治疗“失心风”，奇怪的是，病人痊愈后告诉他：“你这个药能‘开悟’，我比吃药前聪明了好多。”

1962年春节，我应邀到怀柔黄花镇村做客。当天晚上，村支部委员来找我，请我给看一个狂躁型精神病病人。我问他，什么原因疯的，他说，秋天收板栗的时候，此人从地里回来，衣服鼓鼓的，村外站岗的民兵告诉我，他偷了板栗，因此人是个老前辈，不好问他，可在全村流传开来，说他偷了板栗。老前辈听说，向村委会说明，是他从板栗沟回来时，又拐到自留地拔了几个萝卜，还摘了一个小南瓜，根本一个板栗也没偷。不管老人怎么解释，满村人怀疑他偷板栗之言风愈传愈烈。老人一生耿直，一气之下疯啦。晚秋每天晚上出去，谁家自留地菜都给拔掉。为了防止他再祸害村里人，派民兵用铁链把他锁起来，直到大年三十才把他放出来。初一，他到别人家拜年，把祭祖的馒头装在裤裆拿走，害得全村人都怕他。我说，我现在是一个未毕业的学生，但父亲善治精神病，我学得不好，你带来我看看，能治我就给开药治疗。

不一会，两个民兵把病人押来，我让病人坐下，诊完脉，我说：“我给你开个方试试”，病人马上说：“我没病，不吃药，只想喝酒”，我笑着回答：“我给你买酒喝”。病人走后，我开了防己地黄汤：防己9g，防风9g，桂枝9g，生地黄100g（另煎），甘草9g，5副。告诉病人家属，把防己、防风、桂枝、甘草泡在酒里一宿，把生地放入大碗里，蒸一顿饭功夫，然后找个铜盆洗净，将两种药汁倒在盆内混合，温服，1天1副药，还只吃1次。病人家属后来告诉我，吃完5副药，疯病就好啦。我先后用防己地黄汤治“失心风病”好几例，都很快能好。

防己地黄汤原为酒浸水煮法，我改用水煮法，温服时加酒1杯，疗效不变。

防己地黄的方解：失心风，多发生于肝郁难以疏解，卒然暴发，失去理智。防风疏肝解郁，疏所郁之肝气。防己利湿，湿去则痰不生，先防痰迷心窍。桂枝通心阳、伐肝气；肝木最怕桂枝，所以有“木得桂而枯”之说。生地甘寒养心阴，安心神，心安，神才能藏住；生地大剂量能清肝郁所化之热，热泄，神欣然而安。甘草调和诸药。所以，防己地黄药能“不安神而神自安”。

我常用它治疗肝郁不疏引起的失眠，配百合地黄汤治疗更年期抑郁症，合酸枣仁汤治难以入眠症。若在防己地黄汤中加半夏秫米汤，都是安神定志、促进睡眠的好方药。

从药论该方之功用，确能治痹，治类风湿性关节炎，但非防己地黄汤之主治。直到1984年《河南中医》刊登丁先生用防己地黄汤治疗4种精神病的报道，读后让我敬佩不已。

干姜柴胡汤：（《妇人良方集要》）

治妇人伤寒，经脉方来，热入血室，寒热如疟，或狂言见鬼。

柴胡一钱、桂枝三分、姜根五分、牡蛎、干姜炮、甘草炒各三分。

上水煎，汗出而愈。

海蛤散：（《妇人良方集要》）

治妇人伤寒，血结胸膈，宜服此药，及真期门穴。

海蛤、滑石、水飞、甘草各二分、芒硝一两，

上为末，每服二钱用鸡子清调下，小肠通利，其结血自散，更用桂枝红花汤，

发其汗则愈。

第十五章 瓜蒂散方证

【原文】病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。（166）

【原文】：病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。（355）

【原文】：宿食在上脘，当吐之，宜瓜蒂散。（《金匱要略》第十篇）

【原文】：湿家病，身上尽疼痛，发热，面黄而喘，头痛，鼻塞而烦。其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，纳药鼻中则愈。（金匱）

瓜蒂散方：

瓜蒂一分（熬），赤小豆一分

上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕。以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁，和散温顿服之，不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与。

【组成】瓜蒂（炒黄）、赤小豆各等份，豆豉 10g。

【煎服】将二药研细末，取 3 克，豆豉煎汤乘热送下。

【主治】癫、狂、痫属痰饮所致者，或痰涎、宿食滞于上脘。

【注意事项及转归处理】

1. 张子和云：“涌吐之药，或丸或散，中病即止，不必尽剂，过则伤人。”
2. 服药须缓缓饮之，端坐勿动，待药性发作时起动。服后 30 分钟不吐者，可饮热水半碗；或含沙糖一块；或助以探吐。
3. 痰涎已尽，仍干呕不止者，可饮冷开水；或葱白煎汤冷饮；或服麝香 0.2g，止吐。
4. 吐后一二时再进糜粥，禁食生冷、油腻及不易消化食物。
5. 吐后症状减轻，需再涌吐者，可一周后进行。
6. 体质虚弱者，可用小剂缓吐，或补吐同施，或先补后吐。
7. 药后昏眩，慎勿惊慌，饮冷水即解。
8. 药后痰水并涌，或泄泻无度，或头额汗出淋漓，皆为中病。
9. 吐后气逆不舒，据症选用旋复代赭汤，半夏泻心汤，竹叶石膏汤。
10. 吐后心中懊憹，头目昏眩不得眠者，酌用梔豉汤。
11. 吐后脐腹疼痛，轻者不必治疗，次日仍不止者，可炒盐熨敷痛处。属胃家实者，调胃承气汤治之。

12. 仲圣云：“大法春宜吐”，春天阳气在上，有助鼓邪外出，然需急吐者，勿须待春。

154、【瓜蒂散治癫痫医案】闫云科：

忆 1973 年冬某日，武医生亲戚张某，25 岁，腰粗背宽，躯壮体实。患癫痫而外人不知，以其病发于夜，昼则如常人也。据云病时，口吐涎沫，作羊叫声，手足抽搐，小便自遗。因婚娶期临，惧女婚后知隐，始来求诊。察其脉症，视为痰迷心窍，拟瓜蒂散 3 克，豆豉煎汤送服。余虽千叮咛，万嘱咐，详告煎法服法，宜忌事项及止吐之法，然彼不之听。止吐之治，其法简单，其效快捷，奈彼以为新汲井水寒冷，饮之得病，而饮以温。再者，吐因药而起，不找系铃人解铃，反戏他人，岂不糊涂！一误再误，几致铸成大错。

是日张某如法服下：一时许呕吐发作，涌出痰涎甚多，吐净犹仍干呕。翌日仍呕，饮食少许，须臾吐出。三日依然。第四日仍呕恶不食，遂去某地段医院就诊，彼讳莫如深，不言

呕吐之因，仅述呕吐之状，某医注射爱茂尔、氯丙嗪，呕吐仍不止。延至第五日晨，方卧驴车至，唬得余三魂六魄不知所剩几多。但见昔日彪形大汉容颜全非，面色苍白，沉睡不醒，强呼之，声如蝇，四末厥冷，肌肤不温，六脉微细，血压 9.3/5.3kPa，急令住院抢救。

余拟四逆加人参汤，频频喂饮，内科翟医生补充液体，纠正电解质紊乱，并加用肾上腺素提升血压。至午方神志清醒，四末转温，血压恢复至 14.6/8.5kPa。住院三日，诸症消失；出院调养。虽遭此惊险，所幸癫痫不再，亦算得大于失，《金匱要略》一物瓜蒂汤，仅瓜蒂一味，本治中暑身热疼重。而刘吉红先生研末吹鼻，治疗黄疸，鼻息肉。据云，吸入片刻，鼻涕如注，皆黄水也。

155、【瓜蒂散治发黄鼻内酸痛】：

一舟子病伤寒，发黄，鼻内酸痛，身与目如金色，小便赤而数，大便如经，（《医学纲目》作如常）或欲用茵陈五苓，许曰：非其治也，小便利，大便如常，则知病不在脏腑。（《纲目》无腑字。）今眼睛疼，鼻酸痛，（《纲目》作眼睛鼻额痛。）是病在清道中。清道者，华盖肺之经也。若下大黄，则必腹胀为逆，用瓜蒂散，先含（原刻食）水，次搐之，鼻中黄水尽，乃愈。（名医类案）

156、【瓜蒂散治中风谵语狂躁】：

刘某，女，44岁，农民，1982年7月17日初诊。左侧半身不遂10天。发病前曾生气，又为雨淋，当天夜间至户外滑倒，之后即出现左上下肢发软，左手不能抬至平肩，握力减，持物不灵。左腿发软，走路不稳，行动须人搀扶。心烦易怒，失眠，舌强言语不清，口角歪斜，舌不能伸出口外，流涎，吞咽不利，谵语狂笑，烦躁不安。检查：左上下肢肌张力减退，二头肌及膝腱反射稍亢进，巴宾斯基征（-）。舌绛，苔黄白，脉寸浮，上关上滑。暴怒伤肝，痰热阻络，又加冷雨外袭，入中经络，气血痹阻，半身不遂，脾失健运，聚湿生痰，痰郁化热，蒙蔽清窍，故谵语狂躁。辨证：痰郁化热，蒙蔽清窍，阻遏经络。治法：除痰开窍。第一次予瓜蒂散 1/4~1/5，即拒不再服，服后吐痰涎两口，症状稍有好转。次日又服少量，又吐出少量痰涎，偏瘫稍减，说话较前清楚。第3日，按量服药，服后吐出黏液约一大碗，神态清楚，言语清楚，左上下肢较有力，左手已能摸到头顶，握力恢复正常。舌红，脉左右上关上滑。失眠，有时仍烦躁。

处方：枳实 9g，苦参 6g，黄芩 9g，半夏 9g，党参 15g，干姜 6g，甘草 9g，大枣 3个，夜交藤 30g，炒枣仁 30g。服 6 剂。以上方辛开苦降之力，调和中焦，以竟全功。随访半年无复发。出处：《经方验》。

157、【瓜蒂散精神失常】

赵某，女，47岁，1982年7月2日初诊。患者精神失常已2年余，语无伦次，有时外出不归。近3个月来加剧，曾去某精神病院治疗，稍有好转，但平时右手抖动不止，入睡则不抖，端碗时亦不抖。舌强，不能伸出口外，经常口吐黏液，胃脘憋闷。苔薄白，脉左右寸浮，上关上滑。辨证：痰涎停滞，蒙蔽心神。治法：涌吐痰涎。服瓜蒂散 3 剂，隔日 1 剂。服后吐大量黏痰，每次约一碗多，服完 3 剂后，胸部憋闷消失，意识清楚，能正常谈话，右手抖动基本消失，只在精神紧张时稍有抖动，有时心悸。舌质正红，脉滑数。以茯苓 12g，桂枝 12g，五味子 24g，炙甘草 9g，服 6 剂，临床治愈。随访半年无复发。出处：《经方验》。

158、【瓜蒂散瓜蒂散头痛昏蒙目眩痞闷】

一齐姓男子，28岁。近月余自觉头痛昏蒙，两目眩眩，胸膈痞闷，体乏纳呆，诊其脉弦滑，舌苔白腻。与服瓜蒂散加郁金（甜瓜蒂 3g，赤小豆 2g，郁金 3g），捣为细末冲服。1 剂则得吐，吐后诸症若失，唯身体疲惫，静息两日而解。出处：《名方广用》。

159、【瓜蒂散加郁金癫狂】

贾某，男，40岁。初患病时，思想涣散，神志痴呆，言不由衷，继而出现狂躁，失眠，两目怒视，骂詈号叫，逾垣上房，甚至毁物伤人。诊其脉数而有力，唯寸独滑，舌红而苔黄。此乃痰火上扰清窍，急当“引而越之”，予瓜蒂散加郁金 6g。一服后吐出涎半盂，发狂止，

诸症见轻，后又用越鞠丸汤、安神定志丸汤、血府逐瘀汤调治而愈，一直工作至今。出处：《名方广用》。

160、【瓜蒂散加郁金狂躁型精神病】

薛某，男，34岁。患精神病，半年后发展成为“狂躁型”。患者时而狂躁妄言，登高弃衣，不避亲疏，时而吼叫怒骂，狂奔乱跑，哭笑无常。脉象：滑数而无力，舌尖红，苔黄腻。此为痰火上扰，蒙蔽心神。随疏以瓜蒂散加减。甜瓜蒂3g，赤小豆2g，郁金6g。捣为细末过箩，令其次日晨，温开水冲服。约服后2小时，患者烦满不适，涌出大量黏性很强的顽痰。吐后精神疲惫，狂躁顿减，安睡2日。余又以自拟活化汤、温胆汤加胆南星调治月余而告愈，至今已15年未复发。出处：《名方广用》。

161、【瓜蒂散癫狂】

张某，男，59岁，干部。病史：因平素性情暴躁，更加思虑过度，经常失眠，后遂自言自语，出现精神失常状态，有时咆哮狂叫，有时摔砸杂物，喜笑怒骂变幻无常，月余后渐至见人殴打，因此将其锁闭室中，不敢令其出屋。百般医疗，均无效果，邀余治疗。古人对精神错乱的认识，谓系痰涎蒙蔽清窍，须用涌痰之剂，使痰涎涌出，方能有效，余遂疏瓜蒂散予之。

证属：寒痰壅塞胸膈。治宜：涌吐寒饮结满。处方：赤小豆30g，瓜蒂10g，豆豉10g，煎汤顿服。连服2剂，共呕吐痰涎3次，毫不见效。后因锁开乘机蹿出，竟将邻人殴伤并将所有杂物尽行砸碎，因此家人苦闷无法维持，故一再强余设法治疗。遂又以大剂瓜蒂散予之。处方：赤小豆30g，瓜蒂20g，豆豉20g，煎汤顿服。服后隔半小时即开始作呕，连续两昼夜共呕吐20余次，尽属黏液。自呕吐开始便不思饮食，1日后现周身困顿不欲活动，困睡至第3日忽然清醒。后以豁痰通窍安神之剂，调理而愈。出处：《邢锡波医案集》。

162、【瓜蒂散目赤大发】

李氏范日常赤，至戊子年火运，君火司天，其年病目者，往往暴盲，火运灾烈故也。李是年目大发，张以瓜蒂散涌之，赤立消。不数日又大发，其病之来也，先以左目内眦赤发牵睛，状如铺麻，左之右次锐眦发赤，左之右赤贯瞳子，再涌之，又退。凡五次，亦五次皆涌之，又刺其手中出血，及头上鼻中皆出血，上下中外皆夺，方能战退，然不敢观书及见日。张云：当候秋凉再攻则愈。火方旺而在皮肤，虽攻其里无益也。秋凉则热渐入里，方可擒也。惟宜暗处闭目，以养其神水。暗与静属水，明与动属火，所以不宜见日也。盖李因初愈后，曾冒暑出门，故痛连发不愈如此。涌泄之后，不可常攻，使服鼠粘子以退翳。出处：《续名医类案·目》卷十七。

163、【瓜蒂散胸膈痞满】

《生生堂治验》。一男子，胸膈痞满，恶闻食气，动作甚懒，好坐卧暗所。百方不验者半岁。先生诊之，心下石硬，脉沉而数。即以瓜蒂散吐二升余，乃痊。

164、【瓜蒂散癰痛】

城州梅端真休寺住持，有痼症，发则乱言，或欲自缢，且足挛急，难以行步，来请治。予晓以非吐剂莫治。而僧侣沮之，不肯服，乃请治于他医。医与四逆散加吴茱萸牡蛎，半年无寸效，于是再来请治。予则用瓜蒂、赤小豆末，以汁服之。吐黏痰许多，不复发，足挛急顿治。住持甚悦，行歌相赠。《生生堂医谈》。

165、【瓜蒂散善笑不得息】

绵屋弥三郎之妻，善笑，凡视听所及，悉成笑料。笑必捧腹绝倒，甚则胁腹吊痛，为之不得息。常自以为患，请师治之。即与瓜蒂散，吐二升余，遂不再发。《生生堂治验》。

166、【瓜蒂散头肿如斗看人小如三寸】

人忽头面肿如斗大，看人小如三寸，饮食不思，呻吟如睡。此痰也。用瓜蒂散吐之而头目之肿消，又吐之见人如故。后用六君子汤煎服三剂痊愈。出处：《外科真论·头肿如斗》卷

167、【瓜蒂散治痫证若发则乱言】汤本求真：

一僧，痫证若发则乱言，或欲自缢，且足挛急，困于步，来请治。余知不以吐剂不能治，因被同道阻难，不肯治，而请他医治之。与四逆散加吴茱萸、牡蛎，服半年，无寸效，于是再来请余。用瓜蒂散、赤小豆末，以韭汁使服之。吐粘痰许多，痫不复发，足挛急顿治。（《皇汉医学》）

168、【瓜蒂散治卒然腹痛入于阴囊医案】吉益东洞：

一男子二十岁，晚饭后半时许，卒然腹痛，入于阴囊，阴囊挺胀，其痛如刺，身为之不能屈伸，辘辘闷乱，叫喊振伏。诊之，其脉弦，三动一止，或五动一止。四肢微冷，腹热如燔，囊大如瓜，按之石硬也。病者昏愤中，愀然告曰：心下有物，如欲上冲咽喉。先生闻之，乃释然抚掌谓之曰：汝言极当。以瓜蒂散一钱，涌出寒痰一升余。次与紫圆三分，泻五五行，及其夜半，熟睡达天明，前日之病顿如忘。（《皇汉医学》）

169、【陈南瓜蒂焙烧存性内服治左乳房外上方生一结节医案】李霜成：

杨某某，男，48岁。自幼多病，禀性怯薄，发育正常，营养欠佳，体质为瘦长型，性情孤僻，沉默寡言，面容憔悴，表情淡漠。左乳房外上方生一结节，如杏核大，不热不红，不痛不痒，全身亦无任何自觉症状。切诊时，触知结节异常坚韧，硬若碎石，与皮肤无粘连现象，微具活动性，腋下及腹股沟淋巴结略显肿大。人皆谓恶疾，求某中医治疗无效，自用艾灸局部50余壮亦不效。遂用：

陈南瓜蒂2个，焙烧存性内服。

服2次后，结节渐次缩小，半月后完全消失而痊愈。至今5年之久，未曾复发，健康如常。（中医杂志1958；〈12〉：818）

170、【甜瓜蒂致死医案】

崔某某，女，32岁。患者既往健康。近3年患神经官能症。数日来自觉心烦，郁闷，未用其它药物，仅用民间偏方干甜瓜蒂约50克，水煎药液半碗，于1973年8月5日晨7时许服下。服药后约10多分钟，出现呕吐，初吐物为粘液水、食物，继而吐绿水、血水。呕吐频繁，吐物总量达1,000毫升。当时午后一时许来诊，即刻住院治疗。入院检查：体温37℃，脉搏摸不清，血压测不到；发育正常，营养中等，神志清醒，面色苍白，大汗，略烦躁，口唇轻度发绀，瞳孔等大正圆，对光反应存在，颈软，心界不大，心音低弱，心率130次/分，律整，未闻及杂音，两肺呼吸音正常，腹部平软，胃脘具压痛，肝脾未扪及，四肢末梢发凉，神经系统无异常。

粪常规：见少量白细胞及蛔虫卵。肝功能：碘试验阴性，麝浊4单位，锌浊8单位，谷丙转氨酶356单位。心电图：ST段：II、III、avF、V₁、V₃、V₅均明显下降；T波倒置；S₁、I、段avR，上升；II高耸、III、avF及v₅也略高。入院后经多方抢救无效，于8月6日零时10分死亡。

171、【瓜蒂细粉致危证】

马某，男，16岁，患者于1988年2月10日18时急诊入院。其父代诉：患儿因癫痫病多年，久治无效，遂找某医用催吐法治之。于当日下午16时服瓜蒂细粉1克，以温水送服。药后半小时未见呕吐反应，遂再服0.5克，服后约10分钟，即出现严重的脘腹疼痛和剧烈的恶心呕吐，呕吐物为咖啡色液体，内含食物残渣约500毫升，继之呕出鲜血数次，每次约100毫升，半小时后脐腹绞痛，大便呈稀水样，数次，随即也转为鲜血样，先后便出四次，均为少量血液，于18时急来本院就诊。

查体：急性重病容，神清，精神萎靡，呈脱水貌，血压5.32/2.66KPa(40/20毫米汞柱)，心肺(一)，腹软，全腹广泛性压痛，肝脾未触及。急行常规洗胃，插管过程中又因恶心呕出鲜血少量，故改为口服清水洗胃，同时急给补液、升压、输血、止血、抗感染等对症处理，经综合治疗，吐泻停止，再未出血，经10多小时的抢救，血压回升到正常，腹痛等症状消失，精神好转，三日后大便一次，隐血试验转阴，能进少量饮食，于2月14日出院调治。

172、【瓜蒂散黄疸家头身痛】

一人素病黄，忽苦头痛不已，发散降火，历试无效。诊得脉大而缓，且一身尽痛，又兼鼻塞，乃湿家头痛也。投瓜蒂散一匕，内鼻中，黄水去大杯而愈。出处：《医学六要·头痛门》卷五。

173、【瓜蒂散治两膝与背互痛食后偶作恶心】

一人素肥盛，半年渐瘦，两膝与背互痛，两尺沉滑。古人有言，昔肥今瘦者，痰也。遂以加减豁痰汤，连进数服，一日食后偶作恶心，乃以瓜蒂散一钱投之，吐稠痰半升而愈。出处：《续名医类案·痰》卷十六。

174、【瓜蒂散心脐上结硬如斗】：

一妇人，心脐上结硬如斗，按之若石。人皆作痞治，针灸毒药，祷祈无数，如捕风然。一日，张见之曰：此寒痰也。诊其两手，寸关皆沉，非寒痰而何？以瓜蒂散吐之，连吐六七升，其块立消过半。俟数日后，再吐之，其涎沫类鸡黄，腥臭特殊，约二三升。凡如此者三，以人参调中汤、五苓散，调服以平矣。出处：《续名医类案·痰》卷十六。

175、【瓜蒂散加郁金目赤多泪】

青州王之一子，年十余岁，目赤多泪，众工无效。戴人见之日：此儿病目眵，当得之母腹中被惊。其父曰：妊娠时在临清被围。戴人令服瓜蒂散加郁金，上涌而下泄，各去涎沫数升。人皆笑之，其母亦曰：儿腹中无病，何吐泻如此？至明日，其目耀然爽明。《儒门事亲·十形三疗（一）》

176、【瓜蒂散胸膈痞满心下石硬脉沉而数】

一男子，胸膈痞满，恶闻食气，动作甚懒，好坐卧暗所。百方不验者半岁。先生诊之，心下石硬，脉沉而数。即以瓜蒂散吐二升余，乃痊。《生生堂治验》。

177、【瓜蒂散治呕吐不能食结成窠囊医案】张氏医通：

李士材治秦景明，素有痰饮，每岁必四五发，发即呕吐不能食，此病久结成窠囊，非大涌之弗愈也，须先进补中益气，十日后以瓜蒂散频投，涌如赤豆沙者数升，已而复得水晶色者升许，如是者七补之，七涌之，百日而窠囊殆尽，专服六君子、八味丸，经年不辍。

178、【瓜蒂散治气上冲痰塞喉中不能语言医案】易庆棠：

又一妾素无病。忽一日，气上冲，痰塞喉中，不能语言。予曰：“此饮邪横塞胸中，当吐之。”投以瓜蒂散，得吐后即愈。

罗注：辨证依据当为“气上冲”，这是个气机上逆，欲作呕吐之象，用瓜蒂散者，因其势而导之。

179、【瓜蒂散治哮喘】一道人：

信州老兵女，三岁，因食盐虾过多，得胸喘之疾，乳食不进。贫无可召医治，一道人过门，见病女喘不止，便叫取甜瓜蒂七枚，研为粗末，用冷水拌茶盏许，调澄取清汁呷一小呷。如其言，才饮竟，即吐痰涎若粘胶状，胸次既宽，胸喘亦定。少日再作，又服之，随手愈。凡三进药，病根如扫。（《名医类案》）

按语：因气喘时鼻息声高气粗而得名，属哮证范畴。多因过食鱼虾盐食，积痰、寒饮搏结于内而发病，并有随气候变化发病之特点。其证有喘息有声，胸闷气塞，但坐不得卧，甚至坐卧不得等表现。痰涎壅盛者，用甜瓜蒂研末饮服，探吐效佳，但甜瓜蒂有毒，用宜审慎。

罗按：甜瓜蒂研为粗末，用冷水拌茶盏许，调澄取清汁呷一小呷，此曰：茶调散。内经曰：其高者，因而越之。胸喘者，胸满而喘也。

180、【瓜蒂散治失语】唐祖宣：

周某某，女，41岁，1972年4月25日初诊。患雷诺氏病已3年，每遇寒冷则作。经服温阳和活血化瘀药物，肢端痉挛好转，供血改善。近因惊恐而致失语，四肢紫绀加重，厥冷如冰，时呈尸体色。经先后用低分子右旋糖酐和镇静药物，以及中药宁心安神、祛痰开窍之剂无效。饮食不进，卧床不起。证见面色苍白，精神呆滞，不能言语，以笔代言，胸闷烦躁，欲吐不能，肢冷色白，舌白厚腻，脉滑有力，两寸独大。此痰浊壅塞上脘，急则治其标，先宜涌吐痰浊。方用：

瓜蒂、赤小豆、白矾各9克，水煎服。

服后先吐浊痰碗余，继则泻下秽臭溏便，遂即能言，肢冷好转，而雷诺氏现象亦减轻。（浙江中医杂志）

按语：惊恐之后，脏腑功能失调，痰浊内生，阻塞于上，则胸闷烦躁，两寸独盛；清窍被蒙则语言难出；痰浊壅塞，阳郁不达，则四肢厥冷。状似阳微寒盛，而实非也。“邪气加诸身，速攻之可也，故以瓜蒂散加味投之，果获良效。

181、【瓜蒂散吐法治癫狂医案】

于某，32岁。产后两月，为七情所伤而病癫狂。症见咬牙切齿，称鬼詈骂，或闭目不应，呆若木鸡，或哭泣不休，如丧考妣，或高歌号叫，若庆圣诞。情绪多变，涎涕满襟。亦有清醒之时，谓称胆怯善惊，心胸胀满，气上冲逆，欲吐不得。视其舌，边尖红，苔白腻。切其脉，缓而滑，并触知双手厥冷如冰。

观其脉症，此为癫狂。初由肝气之郁，继而受惊气乱，气郁、气乱，痰饮遂生，侵踞神舍，蒙蔽心窍，故见上述种种怪状。《伤寒论》116条：“胸中痞硬，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之。”寒者，痰之误也。拟：瓜蒂3g，赤小豆3g，共研细末，豆豉15g煎汤送下。

服后片刻。呕吐不已，吐出痰涎如胶如涕，并泄泻数次，当日便狂定神清。翌日，虽无物可吐，仍干哕不止，或稍饮亦旋即吐出。急煎半夏10g，冷服，呕吐始止。后拟舒肝安神剂予以善后。

注家按：吐法，八法之一。余读《儒门事亲》后，知其用之得当，收效甚捷，但必须方证相合。如本案胸脘胀满，欲吐不得，涎涕多如泉涌，苔腻，脉滑皆属可吐之症。大胆用之，果然取效。

第十六章 桃核承气汤方证

182、【桃核承气汤狂证】

房镜堂客游省垣，抱病归，神识不清，言语善恶，不避亲疏，登高而呼，弃衣而走，治经旬日不应。细审之，每当少腹硬满难耐时，其症更甚，乃知蓄血发狂也。外用熨法，内服桃核承气汤。是夜小便下血一瓶，狂少定，服近二十剂，小便渐次清白，病乃痊愈。《疫证治例》

183、【桃仁承气汤治妄语如狂人和痛经】：

一妇人，患疫，身热如灼，口舌糜烂，渴好热饮，一日妄语如狂，自胸至少腹，硬疼不可近手，十余日不大便，先生投以桃仁承气汤，黑便通快，诸证悉去。

《方舆輶》曰：桃仁承气汤证本论曰下血，曰少腹急结，若比抵当汤证，其血犹未沉痼也，兹举余所治屡验之一于下：经血欲来，腹疼不可忍，甚至到心妄者，以桃仁承气攻之，二三帖，疼失如神。此证经年不瘥，久患成宿疾者，皆由轻剂微汤无效故也。每月经期时，用桃仁承气二三帖或四五帖，得以定疼即停服，至下月经期之问，经服逐瘀丸散之类，至期时，复服桃仁承气汤，过期后，复服缓攻之剂，如前，如是回环四五月，则数稔之滞患，亦得痊愈。

【桃核承气汤治经前如狂医案】：

妇女经来狂言谵语，据《竹林寺女科》载，多因月经来时多触烦怒，肝气逆乱，血随气逆，上攻于心所致。治宜舒肝宁心。因热与瘀血相搏而引起的经期发狂更为多见，由于感受实热之邪结于下焦，侵入血分，阻滞气血运行，产生瘀血，热与瘀血相搏，上扰心神，神明失聪，使人如狂、发狂。治宜清泻火热之邪，破血下瘀，瘀、热去而心神得安。用桃核承气汤治疗此病有良好的效果，如在经前服用效果更佳。

典型病例：向，教师，二十多岁，未婚。每到月经来潮时即成癫狂状态，妄见妄言，哭

笑无常，夜寐不安，月经过后，不治自愈，数月以来皆是如此。经患者的母亲回忆，此人有着痛经史，曾于数月前重感冒一次，那时正是月经期，以后即患此病。患者来就诊时，正是发病的时候，也就是正在月经期。虽然胡言乱语，嬉笑不常，但在问诊时还能够控制，准确的回答。经服桃核承气汤加减四剂而愈。随访数月，概未复发。

按：本例患者平素有痛经史，结合当时的证候，显然有瘀血阻滞，正值经期发生了感冒发热，外感热邪侵入下焦血分，以致瘀血不行，而引起发狂。其发病的机理和《伤寒论》中的蓄血证相同。即“瘀热”所致。如瘀血不与火热结合，仅能为癥积而已，不能发狂，只有热与瘀相挟，瘀浊才能上行清道而扰及神明。如徐灵胎《伤寒论类方》说：“热甚则血凝而上干心包，故神昏如狂。”故用桃核承气汤攻瘀兼清热，取得了速效。但是，这和《伤寒论》中所载的热入血室有根本上的区别，此有瘀血，彼无瘀血。所以在治疗方面，蓄血证是以逐瘀为主，而热入血室则是以疏解（小柴胡汤）针刺（期门）泄肝热为主。

《医方考》：桃仁，润物也，能泽肠而滑血；大黄，行药也，能推陈而致新；芒消，咸物也，能软坚而润燥；甘草，平剂也，能调胃而和中；桂枝，辛物也，能利血而行滞。又曰：血寒则止，血热则行。桂枝之辛热，君以桃、消、黄，则入血而助下行之性矣，斯其治方之意乎！

《古方选注》：桃仁承气，治太阳热结解而血复结于少阳枢纽间者，必攻血通阴，乃得阴气上承，大黄、芒消、甘草本皆入血之品，必主之以桃仁，直达血所，攻其急结，仍佐桂枝泄太阳随经之余热，内外分解，庶血结无留恋之处矣。

184、【桃核承气汤证治妇人月经未来发狂医案】曹颖甫：

门人沈石顽之妹，年未二十，体颇羸弱。一日出外市物，骤受惊吓，归即发狂，逢人乱殴，力大无穷。石顽亦被击伤腰部，因不能起。数日后，乃邀余诊。病已七八日矣，狂仍如故。石顽扶伤出见。问之，方知病者经事二月未行。遂乘睡入室诊察，脉沉紧，少腹似胀。因出谓石顽曰，此蓄血证也，下之可愈。遂疏桃核承气汤与之。

桃仁一两，大黄五钱，芒硝二钱，炙甘草二钱，桂枝二钱，枳实三钱翌日问之，知服后下黑血甚多，狂止，体亦不疲，且能啜粥，见人羞避不出。乃书一善后之方与之，不复再诊。

按：狂上体不疲者，以病者体弱不甚，而药复适中病也。即使病者体气过虚，或药量过剂，致下后疲惫者，不妨用补剂以调之。病家至此，慎勿惊惶，反令医者不克竞其技也。

185、【桃核承气汤治生产后如狂病案】：

忆余滥竽医界六载时，仅从书本知有辨血致狂之说，临床尚未之见。1975年春一日，大有张村罗某，23岁，忽哭一无常，妄言乱语，如见鬼状；或沉睡如醉，呼喊摇晃犹不苏醒。家人惊惧不已，请出诊。询知生产已8旬，初恶露甚多，至今仍淋漓不断，色暗夹块，少腹疼痛一直未休，触之急结拒压。大便干秘，小便自利。口苦、口渴思饮。舌淡红略青。脉象沉弦。观其脉症，此瘀血致狂也。盖产后胞宫恶露不尽，冲任之血难安，瘀血入心，扰乱神明而见狂妄。古有在上蓄血喜忘、在下蓄血如狂之说，此例正是。治宜攻逐瘀血，以安神宅。若拘于产后宜补则谬矣。拟桃仁承气汤加味：桃仁15g，川军12g，桂枝6g，芒硝6g，甘草6g，灵脂10g，蒲黄10g，二剂。二诊：服药一剂，泻下黑便甚多，神明清朗如昔。继服二剂，恶露消失，少腹痛止，拟圣愈汤善后。（《经方躬行录》）

186、【桃核承气汤治狂病案】：

闫某，男，36岁，余村木匠也。自幼重情谊，讲义气。因好友意外死亡化悲痛太过，致气机逆乱，气滞血瘀，郁而化火，炼津成痰。痰为乱世之贼，瘀乃造反之寇，痰瘀相合，狼狽为患，蒙障神明，蹂躏净土，后竟丧心病狂，杀死妻女。逮捕后，查属精神病，予以释放。乡人愚昧，不信医而求巫，几经折磨，致痰瘀益盛，狂妄愈剧。毁物詈骂（1责骂），通宵达旦，昼夜由家人轮流守护。不得已，方请医诊治。

狂者体胖腰圆，大腹便便，双目白睛贯有血丝，眼神半清半浊，眉毛环口，面垢如煤，舌边尖红赤，隐有青色，苔黄厚腻。语言半醉半醒，声音洪亮似钟，俟其静时，好言劝慰，

诺以食糕，方许诊治。谓称头昏脑胀，心悸怵惕，恶心胸闷，吐痰甚多，小便不畅，胃纳甚亢。切得脉象沉滑有力。腹诊，左少腹急结。脉症俱实，当逐瘀攻痰，还我河山。拟桃仁承气汤合礞石滚痰丸：桃仁 15g，川军 15g，芒硝 10g，桂枝 6g，甘草 6g，煎汤送服礞石滚痰丸 9 克，一日二次。

二诊：其父叙称，药后解脓便盆许，喧嚣渐息，狂妄顿减，药已中的，守方续服五剂。三诊：狂妄已止，可睡寐三四小时，少腹压痛消失，舌苔黄腻，脉仍沉滑，痰挤已去大半，改用温胆汤治之：陈皮 15g，半夏 15g，茯苓 15g，枳实 10g，甘草 6g，黄连 6g，竹茹 10g，石菖蒲 15g，龙牡各 30g，三剂。

四诊：一昼夜酣睡十时以上，此补偿先前不寐之亏空也。头脑昏沉随之减轻，心悸亦止，小便畅利。舌苔白腻，脉仍沉滑。原方五剂。五诊：治疗月余，神恭恢复正常人已能从事木工作业，与其讲述往为，不之信也。

后记：患者愈后，复娶妻生子，可叹天不作美。一日，家人疏忽，孩子掉入锅中烫死，致狂病复发，时轻时重，轻时尚能做工。某日又痰蒙心窍，杀死拒付工钱之东家母女，被太原市公安局拘捕入狱。由是观之，狂病者须有诸事遂心之环境，谨防情志不快而旧病引发。（《经方躬行录》）

第十七章 百合地黄汤方证

【原文】：百合病，不经发汗、吐下，病形如初者，百合地黄汤主之。（金匱）

病因和病机：病在血分，潜血血瘀病，心、肺二经之病，阴虚有热，精神恍惚证，阴虚内热证

辨证依据：指精神恍惚不定，饮食、行动失常，以口苦、小便赤、其脉微数，虚热

尤在泾曰：此则百合病正治之法也。盖肺主行身之阳，肾主行身之阴，百合色白入肺，而清气中之热，地黄色黑入肾，而除血中之热，气血既治，百脉俱清，虽有邪气，亦必自下，服后大便如漆，则热除之验也。外台云：大便当出黑沫。

陈载安曰：不经吐、下、发汗，正虽未伤，而邪热之袭于阴阳者，未必透解，所以致有百合病之变也。病形如初，指百合病首节而言。地黄取汁，下血分之淤热，故云大便当如漆，非取其补也。百合以清气分之余热，为阴阳和解法。

《金匱辑义》：地黄汁服之必泻利，故云中府勿更服。

《金鉴》曰：百合一病，不经吐、下、发汗，病形如初者，是谓其病迁延日久，而不增减，形证如首章之初也。以百合地黄汤，通其百脉，凉其百脉，中病勿更服，恐过服生地黄，大便常如漆也。

高世栻曰：百合色白味甘，手太阴之补剂也。其花昼开夜合，如气之日行于阳，夜行于阴，司开阖，以行荣卫和阴阳。

曹颖甫曰：不经吐下发汗，而见百脉俱病自来注家，未有知其病由者，陈修园知其病在太阳，不能从伤寒太阳篇悟到太阳之变证，黄坤载识为瘀浊在里，不能定瘀浊之名，识病而不能彻底，非所以教初学也，予以为此证直可决为太阳标热内陷蒸成败血之证，故方治用百合七枚以清肺，用生地黄汁以清血热，（一升约今一大碗、须鲜生地半斤许）血热得生地黄汁清润，则太阳标热除，败血以浸润而当下，观其分温再服，大便如漆，可为明证矣。按：肠中本无血、惟热郁蒸腐经络乃有之，此亦利下脓血之类、观于病蓄血者大便必黑，于此证当可了解。

胡希恕曰：这个正是正治，就是百合病开始是什么样子，没经过发汗吐下，就像前头讲的那一大段，这个用百合地黄汤。大量用生地黄汁，生地黄汁一升，就是一碗，很不少了。

从这个用药可以看出，说病在血分，就是从他用这个生地上看的，百脉一宗，悉致其病，到这个地方它的本来面目可以看得出来。但是生地黄汁有凉血作用，它是一个强壮性的活血化瘀的药，还祛瘀血，有补益作用，有补血的作用，同时它是寒性药，它能够去热，咱们说去血热，其实就是去虚热、解烦。由于这个虚热而失血，它能够止血，有瘀血的它还能祛瘀。

所以这个当归、川芎、生地都是祛瘀药，不过它是强壮性的。当归它是一个苦温，它不利于热性病，你看这个病不能搁当归，他虚热。虚寒呢，当归就好了，所以肚子疼那种瘀血症都用当归，他不用生地。

由于这个方剂上来看，虚热，血有瘀，是这么一个病，所以这个他影响脑子，这个想一想《伤寒论》桃仁承气汤，其人如狂，抵当汤也是其人如狂，或者其人喜忘，都是脑子的事，所以这个瘀血对这个疯、狂或癫、痫有相当的作用。

可是用药得时候要斟酌，实证用这个桂枝茯苓丸，桃核承气汤都对实证来说的。这个病是个虚，虚你不能攻，一攻就坏了，他是有瘀血，但攻不但不能祛瘀血反而害他了，你要用强壮性的祛瘀药，他瘀血也去了，虚也好了，就是这个道理。从这个方剂上看出这百合病，是虚热性的有瘀血，所以影响脑系官能上的一种症候。

中病，勿更服，怎么这中病呢，大便当如漆，漆就是黑的，黑就是咱现在说潜血，就是瘀血下来了，所以这个病从外观上看，虚热，由于这个精神失常，有瘀血的问题。这是从辨证上可以这么认识他。虚热就得用甘寒，这个百合是最好的，有瘀血你非搁血分药不可，当然要生地，它是祛虚热的嘛。由这个正面的治疗，对这个病的真实面目才能认识。

曹颖甫曰：太阳寒水，由三焦下达膀胱为溺，由肾阳蒸化膀胱，外出皮毛为汗，故溺与汗为一源，寒水下陷，轻则为蓄水，重则为蓄血，汗之由肺出皮毛者，属水分，由脾出肌腠者，属血分，故血与汗为证，营为血之精，行于脉中，卫为水之精，行于脉外，人一身之水，藉血热面化气，故肌腠孙络温而后皮毛固，一身之血，得水液而平燥，故三焦水道通而后海濡，今方治标准，可知病之轻重，汗伤肺阴者，治以百合知母汤。

但滋肺阴已足，下后水液下出大肠，由府病累及藏阴，湿热逗留为病，则治以百合滑石代赭汤，吐后液亏，阳气上冒，累及主脉之心藏，而怔忡不宁，或至不能卧寐，则治以百合鸡子黄汤，此其易知者也。

惟不经吐下发汗，而见百脉俱病自来注家，未有知其病由者，陈修园知其病在太阳，不能从伤寒太阳篇悟到太阳之变证，黄坤载识为瘀浊在里，不能定瘀浊之名，识病而不能彻底，非所以教初学也。予以为此证直可决为太阳标热内陷蒸成败血之证，故方治用百合七枚以清肺，用生地黄汁以清血热，（一升约今一大碗、须鲜生地半斤许，）血热得生地黄汁清润，则太阳标热除，败血以浸润而当下，观其分温再服，大便如漆，可为明证矣。

按：肠中本无血、惟热郁蒸腐经络乃有之，此亦利下脓血之类、观于病蓄血者大便必黑，于此证当可了解。

百合地黄汤方：

百合七枚，地黄汁一升

上二味，先洗煮百合如上法，去滓，纳地黄汁，煎取一升五合，分温再服，中病勿更服，大便当如漆。

注：百合地黄汤。方中以百合润肺，安心神；生地黄养心营，清心热；更以泉水煎汤，则以利小便而下热气。王雪华曰：“中病，勿更服”说中病后应当守方，不要更换方药。

187、【百合地黄汤结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎医案】贺德震：

患者，男，50岁。欲卧不能卧，欲行不能行，一月来寒战，时发烧，时昏睡，时惊叫，时而能食，进而汤水不能下咽，大便硬，尿如血水，涓滴作痛。经县医院检查，诊断为结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎。此证颇与百合病相似，用百合地黄汤治疗，日服1剂。十天后病

情好转，再用枯萎牡蛎散加减出入，服药 30 余剂后，诸症消失，至今六个月，一切情况良好。（中医杂志 1965；（11）：21）

188、【经方百合地黄汤治皮疹痴呆双手舞动医案】网文：

利某，女性，84 岁。有高血压、糖尿病病史，数年前开始出现近事遗忘，但对答尚切题。曾行 CT 提示多发腔梗、动脉硬化。1 年前不慎跌倒致左股骨髁上骨折长期卧床。3 个月前因护理不当开始出现骶尾部褥疮，褥疮逐渐增大。1 个月前开始出现双手不自主舞动。

2009 年 12 月 17 日因褥疮来我院住院。当时见其全身皮肤干燥开裂，因颧及双手潮红，全身散在红色皮疹，以下腹及骶尾、腹股沟区为主，骶尾部褥疮。

予甘草泻心汤治之，处方：甘草 30g，黄芩 15g，黄连 6g，党参 30g，大枣 15g，干姜 6g，4 剂无效，皮疹有增无减，两颧及双手通红。

12 月 20 日黄师查房，见其双手十指型似兰花，撮空舞动而无休止，结合本患者高龄，长期卧床，既往 CT 提示多发腔梗、动脉硬化，近年有认知功能下降，1 个月前开始出现双手不自主舞动的病史，考虑此乃血管性痴呆引起的行为异常。患者虽有褥疮、皮疹，无明显渗液，非甘草泻心汤证也。全身皮肤干燥开裂，两颧及双手潮红，一派阴津亏耗之象，故当以大剂量生地黄治之。

以百合地黄汤，更加苦参。处方：百合 45g，生地黄 90g，甘草 30g，苦参 15g，4 剂，两颧及双手潮红稍减轻，双手舞动有所减少。

12 月 25 日考虑皮疹已明显减少，遂专任防己地黄汤，予处方：防己 24g，生地黄 90g，甘草 30g，防风 24g，桂枝 12g，4 剂，两颧及双手已潮红，双手无不自主舞动，皮疹亦明显减少。诸医皆称奇，对黄师用药之神效心悦诚服。

黄师曰：“仲景治疗精神异常多使用大剂量的鲜地黄，百合地黄汤用生地黄汁 1 升、防己地黄汤用生地黄 2 升就是其中代表方。患者一脉阴津亏耗之象，使用鲜地黄更为合适”。

注家按：百合地黄汤、防己地黄汤两方均主治精神异常之证，均用生地黄，故黄师认为防己地黄汤可治中风患者的认知功能障碍及精神症状。

189、【经方百合地黄汤治嘴巴不自主抖动医案】网文：

卢某，女，75 岁。2010 年 9 月 3 日因头晕入院。入院时，见其嘴巴不自主地抖动，作不停咀嚼状，与其对话，因嘴巴抖动，几不能成句，双手托腮，而不能止。走路步态如常。追问病史，既往有脑梗塞后遗症史，2009 年 8 月自中风后开始出现此现象。入院后，考虑未排帕金森综合症，予多巴比肼口服，服药后嘴巴不自主抖动未见好转。9 月 7 日，黄师查房。见其舌红少苔，口干欲饮，皮肤干燥。

阴虚液枯也。当选防己地黄汤合芍药甘草汤，处方如下：防己 24g，生地 90g，甘草 30g，防风 24g，桂枝 12g，白芍 60g，4 剂。患者服中药后出现呕吐，纳差，拒绝服用中药，暂予对症处理。但仔细观之，其嘴巴不自主抖动却较前明显减少。

9 月 15 日，患者已无呕吐，经反复劝说，仍予继续服用防己地黄汤，因恐防己味苦致呕，暂去之，又服 4 剂。不自主运动症状进一步好转，予出院。

出院后，患者坚持就诊于黄师。仍予防己地黄汤合百合地黄汤，但不复再有呕吐。服药至国庆前夕，患者嘴巴不自主抖动症状进一步减轻。

9 月 28 日，黄师认为此非帕金森综合症，建议尝试停用多巴丝肼，但患者又恐停药后症状复发，暂未敢停用。中西药合用至 10 月 8 日，其嘴巴不自主抖动已基本缓解，始停用多巴丝肼。

10 月 15 日复诊，症状未见复发，续守前方。

10 月 26 日，多巴丝肼已停用半月。未见嘴巴不自主抖动，料是中药之交效，黄师遂同意于本书中加入此例。心烦不寐，口干咽干，拟结合阿胶鸡子黄汤法：龙牡各 30g，（先煎）生地 90g，麦冬 30g，防风 15g，防己 15g，桂枝 12g，百合 30g，阿胶 15g，（烊化）炙甘草 15g，鸡子黄 1 个（兑）7 剂，水煎服。

11月22日电话随访，嘴巴不自主抖动未见发作，患者遂自停药。

按：多巴丝肼对帕金森综合症是症状控制药，并不能阻止帕金森的病情发展。理论上停用后又复出现。但现停用十天，症状不复出现，显然疗效与多巴丝肼无关。

此证其实与前述“皮疹痴呆双手舞动案”及后述之“左侧上下肢不自主舞动案”相似。均有阴虚液枯之兆。一者表现为“双手十指状若兰花，撮空舞动而无休止及手足舞动”，一者表现为“嘴巴不自主抖动，作不停咀嚼状”。都是不能自主。

沈明宗之《金匱要略编注》曰：“非治中风之剂，乃编书者误入，何能得其狂状妄行？”黄师认为，沈氏有所不知，看似非中风之剂，实中风之后遗症。此方重用鲜地黄二斤，较之炙甘草汤等尤重。因剂量特大，难以煎煮，故蒸后绞汁，尽取其浓液。实重滋阴养血，开后人有阴息风之端。配以桂枝、防风、防己通而不滞。“如狂状，妄行，独语不休”均属神志之疾，仲景常以地黄为治。此两例虽非妄行等症，但不能自主者，犹“妄”也。黄师屡用不爽。

190、【百合地黄汤结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎医案】贺德震：

患者，男，50岁。欲卧不能卧，欲行不能行，一月来寒战，时发烧，时昏睡，时惊叫，时而能食，进而汤水不能下咽，大便硬，尿如血水，涓滴作痛。经县医院检查，诊断为结核性脑膜炎及慢性肾盂肾炎。此证颇与百合病相似，用百合地黄汤治疗，日服1剂。十天后病情好转，再用枯菱牡蛎散加减出入，服药30余剂后，诸症消失，至今六个月，一切情况良好。（中医杂志1965；（11）：21）

191、【百合地黄汤滑石代赭汤加减彻夜不眠神志恍惚医案】夏学传：

刘某，男，43岁，1977年2月26日初诊。患者于廿余日前患上呼吸道感染，高热数日，后汗出热退。伴有头痛，口苦，心烦，小便黄赤，尤以心烦不寐日渐严重。近一周来，彻夜不眠，神志恍惚，坐卧不安，曾用中、西药安神镇静，其效甚微。观其神态，不是辗转不安，就是沉默寡言。舌质红，苔薄黄，脉弦细数。投以百合地黄汤、滑石代赭汤加减。百合20克，生地15克，滑石12克，知母10克，麦冬12克，茯神12克，枣仁18克，甘草3克，7剂。

1周后，每晚可睡3、4小时，心烦不安减轻，继守前方5剂，小便已清，脉细，舌稍红，每晚睡眠可达4、5小时。前方去知母、滑石、麦冬，加扁豆、陈皮理脾健胃，10剂。前后经1个月调治，诸症悉平。（浙江中医学院学报1983；〈5〉：35）

192、【百合地黄汤百合鸡子黄汤啼哭不宁】

山西中医研究所肝病科医案：患者王某某，男，44岁。因肝炎后肝硬化合并克鲍二氏征，第二次出现腹水已9个月，于1970年9月4日入院。入院后经综合治疗，腹水消退，腹围减到71厘米。1971年1月15日因食冷餐引起急性胃炎，予禁食、输液治疗。1月21日患者性格改变，一反平日谨慎寡言而为多言，渐渐啼哭不宁，不能辨认手指数目，精神错乱。考虑肝昏迷Ⅰ度。因心电图上有V波出现，血钾3.26mmol/L，补钾后，心电图恢复正常，血钾升到4.3mmol/L。同时用谷氨酸钠，每日23~46克，达12天之久，并用清营开窍、清热镇静之方。患者症状无改变，清晨好转，午后狂乱，用安定剂常不效，需耳尖放血，始能平静入眠，而精神错乱如故。考虑其舌红脉虚，神魂颠倒，乃从百合病论治。从2月1日起加用百合鸡子黄汤。百合30克，鸡子黄1枚，日1剂，煎服。

2月2日患者意识有明显进步，因多次输入钠盐，腹水出现，加用氨苯喋啶每日200毫克，并继用百合鸡子黄汤。2月3日患者神智完全恢复正常，继用百合鸡子黄汤2剂后改服百合地黄汤（百合30克、生地15克），患者病情保持稳定。1971年3月21日出院时，精神良好，如常人行动，腹水征（-），肝功能化验基本正常。1972年6月与患者联系，情况保持良好。（新医药学杂志1974；〈2〉：13）

193、【百合地黄汤合酸枣仁汤视物不清头晕眼花神呆耳塞医案】王占玺：

患某，男性，19岁。于1965年2月11日初诊。于一周前因旅行之后，发现咽中异物感，

似有一物停于咽中，咯之不出，吞之不下，纳差不知饥饱，睡眠不佳，同时尿道中有似痛非痛之感，头晕发木，口中乏味，耳内有阻塞感，视物不清，神呆，对外界刺激不敏感，尿黄，曾服用牛黄清心丸等清心除热之剂不效。观其舌净尖红，脉象弦而稍滑。胸腹部无阳性体征。尿常规化验正常。此阴虚为患，虚火上浮，阴虚于下，不能上润，以致出现咽中异物感，头晕眼花神呆耳塞等症状。拟养阴潜阳，开窍安神为治，用百合地黄汤合酸枣仁汤加减：百合30克，知母10克，鲜生地30克，滑石18克，川芎4.5克，远志4.5克，茯神10克，节菖蒲6克，炒枣仁18克。每日煎服1剂，服用3剂后，上述诸症状减去大半，又服3剂，改为隔日1剂而痊愈。愈后随访至1966年8月30日，诸证未发。（《张仲景药法研究》1984：509）

194、【百合地黄汤患鼻腔干燥吸气不畅双目干涩感医案】千千：

张某，男，69岁。1995年3月14日初诊。患鼻腔干燥，吸气不畅2年，伴有双目干涩感。查见：鼻中隔肥厚，左侧有嵴突，粘膜充血而干。舌苔薄，脉细。杖国之年，金枯肺燥。治从养阴润燥。处方：百合10g，生地10g，玄参10g，知母10g，玉竹10g，桑白皮10g，柿霜10g，麦冬10g，白芍6g，桔梗6g。7剂。

二诊：药进6剂，干燥面觉滋润，涕仍不多，时挟血丝。查见：鼻粘膜充血，舌苔薄微黄。此金枯必燥，肺热乃血。治宗前旨，参以凉营止血。原方减玉竹、白芍、桔梗，加赤芍、丹皮各6g，芦根30g。7剂。（江苏中医1996；（12）：19）

195、【百合地黄汤治右肢活动受限语言欠清医案】李一立：

郑某某，女，32岁。1980年10月3日初诊。三月前因下肢出现麻木，某医院诊断为“末梢神经炎”。近日发现右肢活动受限，语言欠清，心悸不安，面色潮红，饮食无味。脉细而涩，舌质黯红，苔薄黄。此为阴虚内热，肺津亏乏，不润筋脉。治拟滋阴清热。予百合地黄汤加味：百合、地黄各30克，麦冬15克，丹参30克，玉竹18克，丝瓜络、忍冬藤各20克。10剂后患侧肢体渐能活动，语言自如。继以前方加减，继服40余剂告愈。（四川中医1985；（10）：21）

196、【百合地黄汤治百合病得药剧吐剧泻神志恍惚案】彭履祥：

曾某某，男性，56岁，农民。患者神志恍惚多年，中西治疗不效。证现心慌不宁，劳动中情绪不定，欲动不能动，欲行不能行，心神涣散，情绪低落，烦躁易怒，寢寐不安，不耐劳力，遂整日钓鱼养病。唯口苦口渴，小便黄，舌质红赤少苔，脉弦略数。同时，遍身疮疹，甚似杨梅疮毒。问其故，乃偶遇打鱼人，吸其烟具后，遂遍身生疮，顽固不愈。据证审因，乃心肺阴伤，里热偏盛，为百合病之典型者。方用：百合，生地黄，知母，滑石等味。服10剂后，诸证略减，唯疮疹如故。于原方加金银花以解疮毒。但1剂未已，翻胃呕吐，腹泻如水，再次来诊。审其所由，恐系银花伤其胃气，非百合病所宜，故再投原方，吐利即止，守方20多剂，疮疹隐没而愈，诸证若失，恢复劳力，从事生产。《老中医医案选》

第十八章 百合知母汤方证

【原文】：百合病，见于发汗之后者，百合知母汤主之。（金匱）

病因和病机：肝肾同病，虚热

辨证要点：发汗后出现百合病

注家曰：人之有百脉，犹地之有众水也。众水朝宗于海，百脉朝宗于肺，故百脉不可治，而可治其肺，百合味甘平微苦，色白入肺，治邪气，补虚清热，故诸方悉以之为主，而随证加药治之，用知母者，以发汗伤津液故也。

赵以德曰：日华子谓：百合安心定胆、益志养五脏，为能补阴也。治产后血眩晕，能去血中热也，除帘满、利大小便，为能导瘀血之淤塞也。而是证用之为主，益可见淤积者矣。若汗之而失者，是涸其上焦津液，而上焦阳也，阳官体轻之药，故用知母佐以救之。知母泻火、生津液、润心肺。

陈载安曰：得之汗后者，其阳分之津液必伤，余热留连而不去。和阳必以阴，百合同知母、泉水以清其余热，而阳邪自化也。

高学山曰：百合病发汗后者，犹言发汗之后，因而成百合病也。发汗，则心肺之阴液大伤，而上焦神气，有懒散不完之象，故见首条诸症，知母滋阴清热，善走肝肾，肝为心之母，肾为肺之子，合子母而两补心肺之阴精，然后以形象心肺，瓣瓣朝宗之百合，收摄其神气而抱拢之。则知母滋阴以调百脉，百合敛阳以归一宗，针锋逼对矣。先必别煎者，各完其性也。然后合和者，相与有成也。煎用泉水者，取其上泛而流长，盖上泛之性归宗，流长之性贯脉也。

胡希恕曰：百合病，他虚热病与实热不同了，这个实热可以攻，在表可以发汗，在里可以下之，在上可以吐之。汗吐下，全是对实热而言，虚热不能攻，所以百合病有热是肯定的，口苦、小便赤嘛。可是这个反而发其汗是不会好，只能够伤其津液，而其越烦躁，他这个病不会好的，就上头这个糊涂病、精神失常还是不会好的，那还是存在，只能够增添他的烦热，所以他在百合里头加知母，知母是去烦热的。

百合先用水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，就是泡了一宿，它出些白沫子，然后把这个水不要了，更以泉水二升，煎取一升，另换泉水二升，就是两碗了，再煮这个百合，取一升，这个时候百合不要了，去滓，别以泉水二升，煎知母，再另以泉水两升煎知母，也取一升也把也滓去了。后会和，煎取一升五合，分温再服，然后把两个药汁，一个百合药汁、一个知母药汁，各一升都搁一起，合到一起不是二升了嘛，再上火煎，取一升五合，分温再服，分两回来用。

百合，在本草上它是甘寒，这个甘寒的药都是养阴补虚，同时去热。在《本草经》说大量吃百合，能够通利二便，它这个小便赤涩，当然吃这个百合适是吧。由于发汗更亡失津液，更助其热，所以加知母。所以以百合治这个病，这也说明这个病是虚热了。

百合，味甘，性寒。归心、肺经。用于阴虚燥咳，劳嗽咳血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

百合知母汤方：

百合七枚（擘），知母三两

上二味，先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，另以泉水二升，煮取一升，去滓，别以泉水二升，煮知母取一升，去滓，后会煎取一升五合，分温再服。

罗注：此处说用泉水，而不用水，很有深意。以山泉之水入药。

【方解】百合知母汤是养阴清热的方剂，以百合润肺清心，益气安神；以知母养阴清热，除烦润燥；以泉水煎药清其内热。三者共起补虚、清热、养阴、润燥作用。

曹颖甫曰：太阳寒水，由三焦下达膀胱为尿，由肾阳蒸化膀胱，外出皮毛为汗，故尿与汗为一源。寒水下陷，轻则为蓄水，重则为蓄血。汗之由肺出皮毛者，属水分；由脾出肌腠者，属血分，故血与汗同体。营为血之精，行于脉中；卫为水之精，行于脉外。人一身之水，藉血热而化气，故肌腠孙络温而后皮毛固；一身之血，得水液而平燥，故三焦水道通而后血海濡。今以方治为标准，可知病之轻重。汗伤肺阴者，治以百合知母汤，但滋肺阴已足；下后水液下出大肠，由腑病累及脏阴，湿热逗留之病，则治以百合滑石代赭汤；吐后液亏阳气上冒，累及主脉之心脏，而怔忡不宁，或至不能卧寐，则治以百合鸡子黄汤，此其易知也。惟不经吐下发汗，而见百脉俱病，自来注家，未有知其病由者。陈修园知其病在太阳，不能从伤寒太阳篇悟到太阳之变证；黄坤载识为瘀浊在里，不能定瘀浊之名，识病而不能彻底，非所以教初学也。予以为此证直可决为太阳标热内陷蒸成败血之证，故方治用百合七枚以清肺，用生地黄汁一升以清血热。血热得生地黄汁之清润，则太阳标热除，败血以浸润而当下，观其分温再服，大便如漆可为明证矣。

197、【百合知母汤百合病医案】吴方纶：

王某，女，13岁，学生。1960年4月15日在看解剖尸体时受惊吓，随后因要大便跌倒厕内。经扶起抬到医院治疗，据代诉查无病，到家后颈项不能竖起，头向左右转动，不能说话，问其痛苦，亦不知答，曾用镇静剂2日无效，转来中医诊治。患者脉浮数，舌赤无苔，无其他病状，当即从“百合病”治，用百合7枚，知母4.5g。服药1包后，颈项已能竖起十分之七，问她痛苦，亦稍知道一些，左右转动也减少，但仍不能说话，再服1剂，颈项已能竖起，不向左右转动，自称口干燥大渴，改用瓜蒌牡蛎散(瓜蒌、牡蛎各9g)，服1剂痊愈。[江西中医药]

198、【洪氏用百合知母汤合甘麦大枣汤治疗失眠60例】

方药：百合20g，知母10g，炙甘草10g，淮小麦30g，大枣6枚。治愈(症状消失，每日睡眠时间大于6小时)。30例，显效(症状明显改善，每日睡眠时间4~5小时)。9例，无效(症状无改善，每日睡眠仍少于2小时)。6例，总有效率为90%。[洪燕.百合知母汤合甘麦大枣汤治失眠60例疗效观察.江西中医药]。

199、【百合知母汤合甘麦大枣汤治疗乳腺病双乳胀痛】高秀飞：

乳癖严某，女，53岁，2005年4月4日就诊。双乳胀痛3周，时有刺痛，心烦，急躁，浑身不适，夜寐欠安，腰酸，曾口服乳癖消、逍遥丸等中成药，效果不佳。体检发现双乳无明显肿块，触痛明显。苔少，舌尖红，脉细数。证属肝郁化火，阴虚内热。治拟养阴舒肝。药用：百合30g，知母12g，甘草6g，淮小麦30g，红枣20g，郁金12g，香附9g，元胡12g，莪术30g，三棱12g，巴戟肉15g，肉苁蓉12g，八月札30g，川楝子9g，杜仲15g。并鼓励患者在生活、工作中放松自己，保持愉悦心情。服14剂后，双乳胀痛明显改善，情绪较前稳定，夜寐转安。以后随证加减，服药3个月后，诸症渐消。[辽宁中医杂志]。

200、【百合知母汤治疗乳腺病乳腺癌术后难以入睡】高秀飞：

郑某，女，39岁，2005年8月29日就诊。左乳癌术后2年2个月，近来情绪波动较大，心烦躁热，坐立不安，夜寐难以入睡，睡后易醒，醒后彻夜不眠，不能自己，神疲乏力，小便频数。苔薄，边尖红，脉弦细。诊断：乳癌术后。证属气阴两虚，冲任失调，心神不养。治拟养阴安神，益气补肾。药用：百合30g，知母12g，生黄芪30g，党参、茯苓各12g，白术9g，枸杞子、南沙参、淫羊藿各15g，肉苁蓉、巴戟肉各12g，莪术、石见穿各30g，蜂房、石菖蒲各12g，磁石(先煎)、丹参各30g，杜仲15g，覆盆子、益智仁各12g，怀牛膝30g，制黄精12g，龙葵30g。同时对患者进行耐心解释和开导，帮助病人解除顾虑，树立信心，劳逸结合，稳定情绪。服14剂后，夜寐明显好转，心烦躁热有所改善，小便次数减少。再服该方2个月，夜寐转安，情志舒畅，小便正常。[辽宁中医杂志]。

201、【小柴胡汤合百合知母汤治疗长期低热】王有章：

张某，女，49岁，工人，1991年2月27日入院。午后发热3年，体温多在37.5℃~38℃之间，夜半后汗出热退。心电图示冠状动脉供血不足，B型超声检查结论为胆囊炎。用扩冠脉药，多种抗生素、灭滴灵、转移因子、血浆等治疗3个月，病情无明显变化。形体消瘦，精神抑郁，甚时恍惚，叹息为快，急躁易怒，心烦失眠，口苦咽干，胸闷胁痛，舌质红，苔薄白，脉象弦细数。辨证为肝胆郁热灼阴扰神。用小柴胡汤合百合知母汤(柴胡、百合各30g，黄芩、知母各15g，半夏、人参各10g，生姜3片，大枣6枚)加炒酸枣仁30g，远志15g。水煎，嘱其上午10时许1次服下。服药8剂后失眠除，发热减轻。去炒酸枣仁、远志，又服4剂后，体温降至37.3℃以下。减柴胡用量为20g，又服6剂，体温正常，诸症消失，复查心电图，B超肝胆脾均无异常。遂停药出院，随访3年未发。(河南中医)

【临证提要】百合知母汤用于治疗情志异常引起的疾病，主要病机为心阴不足，虚热内扰，症状与原书所属“百合病”症状接近时可以直接用原方。心阴不足的失眠可合用甘麦大枣汤。长期心情抑郁不畅而导致肝失疏泄可加用疏肝药，若气郁化火则加用疏肝清热药，若痰核内生则加化痰散结之品。对于不明原因的长期发热若辨为少阳枢机不利，肝胆郁热，在

郁热伤阴时也可考虑合用此方。

202、【百合知母汤胆囊炎冠状动脉供血不足发热医案】王有章：

张某，女，49岁，工人，1991年2月27日就诊。发热3年余，体温波动在37.5℃~38.1℃之间，夜半后汗出热退。心电图示：冠状动脉供血不足。B型超声示：胆囊炎。形体消瘦，精神抑郁，急躁易怒，心烦失眠，胸闷口苦，食欲不振，舌质红，苔薄白，脉弦细数。辨证为肝胆郁热，灼阴扰神。柴胡、百合各30g，黄芩、知母各15g，人参、半夏各10g，甘草6g，生姜3片，大枣6枚。日1剂，嘱其头煎上午10时许一次服，二煎加炒枣仁30g，远志15g，临睡前服。连服6剂后发热轻，失眠除，但汗多乏力，又去枣仁、远志，减柴胡为20g，加黄芪30g，连服10剂。午后发热除，余症消失，复查心电图、B超均无异常。随访4年未复发。（国医论坛1995；(6)：22）按语：

原按：肝主疏泄，与胆相表里。情志所伤，气失疏泄，气机郁遏不得发泄而化热。人与天地相应，1人体气机的升降浮沉，随昼夜阴阳的消长转化而变化，午时一阴生，阴生气机沉降，肝胆气机郁遏加重而发热；子时一阳生，阳升气机升浮，肝胆气机得以疏泄而热退。小柴胡汤升清降浊、调和阴阳，擅开肝胆郁热；百合知母汤养阴安神，清热除烦。诸药相合，使气机调畅，肝胆郁热自消，阴足火降，心神自安。发热前2小时服药，使之在午时发挥最佳效果，以适应阴阳气机之升降，有利于打破定时发热节律，故获佳效。

203、【百合知母汤栝蒌牡蛎散治百合病精神疾病医案】吴才伦：

王某，女，13岁，学生。1960年4月15日在看解剖尸体时受惊吓，随后因要大便跌倒在厕所内，经扶起抬到医院治疗。据代诉查无病，到家后颈项不能竖起，头向左右转动，不能说话，问其痛苦，亦不知答。曾用镇静剂2日无效，转来中医诊治。脉浮数，舌赤无苔，无其它病状，当即从“百合病”处理。百合7枚，知母4.5克。服药1剂后，颈项已能竖起十分之七，问她痛苦亦稍知道一些，左右转动也减少，但仍不能说话。再服1剂，颈项已能竖起，不向左右转动，自称口干燥大渴。改用栝蒌牡蛎散，服1剂痊愈。（江西中医药1960；(12)：14）

204、【栝蒌牡蛎散合百合知母汤胸闷乳胀周身瘫软乏力神经官能症医案】秦书礼：

吴某某，女，44岁，家务。1984年5月5日就诊。自述五月前因吵架而情志受挫折，胸闷乳胀，周身瘫软乏力，欲行无力，终日烦扰，口干而渴，思食难进，欲言懒语，如寒无寒，似热而无热。西医诊为神经官能症，服用镇静安眠药未效，后请中医诊治，服百合地黄汤十余剂，病情有所缓解。近日又感风寒，发热达39℃，心中烦热，一医给服解热发汗药后，口干苦，渴甚。化验血糖、尿糖均正常。患者头晕目眩，默默无言，时觉有热，小溲深赤，舌红少苔，脉浮数。诊为百合病，治拟清热润燥，生津止渴，方用栝蒌牡蛎散合百合知母汤治之，并嘱怡情养性。经先后用本方加减治疗二个半月，渴止神安，一如常人。（江苏中医杂志1987；(2)：9）

第十九章 大承气汤方证

大承气汤方：

大黄四两（酒洗），厚朴半斤（炙去皮），枳实五枚，芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，纳大黄更煮取二升，去滓，纳芒硝，更上微火，一两沸，分温再服，得下，余勿服。

【原文】：阳明病，脉实（通行本：迟），虽汗出，而不恶热者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解可攻里也。手足濇然汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮者，未可与承气汤；若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令大泄下。（208）

诹古本对照：阳明病，其脉迟，虽汗出，不恶寒，其体必重，短气，腹满而喘，有潮热，

如此者，其外为解，可攻其里。手足濇然汗出，此为已坚，大承气汤主之。

若汗出多而微恶寒，外为未解，其热不潮，勿与承气汤。若腹大满而不大便者，可与小承气汤，微和其胃气，勿令至大下。阳明病，潮热，微坚，可与承气汤；不坚，勿与之。

病因和病机：里有热

辨证依据：大承气汤证：腹满而喘，有潮热者。小承气汤证：腹不满不通者。

成无己曰：此正阳阳明也，邪自阳明经传入府。迟而有力，为内实之象；汗出不恶寒，主谓表证已罢；阳明之气，旺于申酉二时，若见日晡潮热、痞满躁实诸证已具，故以大承气汤攻下。

《金鉴》曰：阳明病脉迟，虽汗出不恶寒，外证欲解而脉不实，尚未可攻也。若其人身重，热困于体也；短气而喘，热壅于上也；腹满潮热，热聚于中也；手足濇然汗出，大便已硬，热结于下也，斯为外邪已解，内实已成，始可攻之，主以大承气汤可也。若汗出，微发热恶寒者，则外犹未解也，其热不潮者，里犹未实也，不可与承气汤。即有里急、腹大满、不通等证，亦只宜与小承气汤微和胃气，勿令大泄下，盖以脉迟故也。

方有执曰：潮热，阳明王于申酉戌，故热作于此时，如潮之有信也。手足濇然而汗出者，脾主四肢而胃为之合，胃中燥实而蒸蒸腾达于四肢，故曰：大便已硬也。

林澜曰：此节辨脉迟内结之，或宜大承气攻之，或但可以小承气微和之也。阳明病脉迟证，兼汗出不恶寒，身重短气，腹满而喘，似属可攻。然必有潮热者，为外证已解，里证已具，手足濇然汗出者，为大便已结，主以大承气汤攻之奚疑！若汗出虽多，犹见发热恶寒，则表尚在也，其热不潮，汗亦非手足濇然之汗，安可与承气以攻之乎？即腹大满不通，亦只可与小承气微和，勿令大泄下。此何以故？脉迟便非必下之脉，虽内结亦岂大承气所宜哉！

205、【大承气汤治神志恍惚歌唱无序歌唱无序】曹颖甫门人：

【按】友人施君。甲戌孟秋某晚，匆匆邀诊乃弟病。入其室，见病者仰卧榻上。叩其所苦，绝不应。余心异之。私谓施君曰：乃弟病久耳聋，无所闻乎，抑舌蹇不能言乎？则皆曰：否。余益惊异。按其脉，一手洪大，一手沈细，孰左孰右，今已莫能记忆。因询家人以致病之由。曰：渠前任某军电职，因事受惊，遂觉神志恍惚。每客来，恒默然相对，客去，则歌唱无序。饮食二便悉如常人，惟食时阙上时有热气蒸腾，轻则如出岫朝云，甚则如窑中烟，状颇怪特。前曾将渠送往本市某著名医院诊治，经二十余日，医者终不识其为何病，既无术以疗，故于昨日迁出，请先生一断。余细按其腹，绝不胀满，更不拒按。沈思良久，竟莫洞其症结。于是遂谢不敏，赧然告辞。

越日，施君告余曰：舍弟之病，昨已延曹颖甫先生诊治。服药后，大泄，阙上热气减。余闻而愕然，遂急访之，并视所服方。忆其案尾略曰：此张仲景所谓阳明病也，宜下之，主以大承气汤。方为：生大黄三钱，枳实三钱，芒硝三钱冲，厚朴一钱。

又越数日，余再晤施君，悉其弟服药后，已能起床，且不歌唱。惟两肋胀痛，经曹师诊治，顷又愈矣。审其方，乃小柴胡汤也。

柴胡三钱，黄芩三钱，党参三钱，半夏三钱，生姜三片，大枣十二枚，甘草二钱嗣是施君之弟似可告无恙矣，顾尚苦自汗，精神不振。又经曹师投以桂枝加龙牡汤，一剂而愈。

川桂枝三钱，大白芍三钱，生草二钱，生姜三片，大枣十二枚，花龙骨五钱，煅牡蛎五钱以上二味先煎。

自此以后，健康逾常人。一日与兄俱出，值余于途，各微笑颔首以过。翌日遇施君，问其弟昨日途间作何语。施曰：无他。固诘之，乃笑曰：彼说吾兄脉理欠精耳。余不禁重为赧然。于是深服吾师医术之神，遂执贽而列门墙焉。

【又按】本案病者所患似系所谓精神病，或神经病。顾西医用神经药治之，绝不见效。中医用经方治之，反奏肤功。其理深奥，莫可究诘，殆所谓治病必求其本欤？按初方系阳明方，次方系少阳方，末方系太阳方。以三方疏其三经之阻滞，诸恙乃痊，殆当日受惊之时，周身筋络器官，即因惊而有所滞乎？顾饮食二便如常，腹不痛，又不拒按，谁复有胆，敢用

承气？乃吾师独以阙上热气之故，遂尔放胆用之，殆所谓但见一证便是，不必悉具之意乎？曹颖甫曰：此证予亦不能识，惟诊其脉，则右极洪大，左极微细，阴不足而阳有余，意其为少阴负趺阳之脉，而初非逆证。加以热气出于阙上，病情正属阳明，与右脉之洪大正合。故决为大承气汤的证，而不料其应乃如响也。

206、【大承气汤汗出烦躁不宁谵语咳嗽吐黄痰腹胀不大便医案】胡希恕：

岳某，男，67岁。初诊1965年7月3日：恶寒发热五天，伴头痛、咳嗽、吐黄痰，体温39.5℃。曾服桑菊饮加减（桑叶、菊花、连翘、薄荷、杏仁、桔梗、荆芥、芦根、黄芩、前胡、枇杷叶等）二剂，热不退。经X线检查，诊断为左肺上叶肺炎。又用银翘散加减二剂，汗出而热仍不退。又与麻杏石甘汤加减一剂，汗大出而热更高，体温41.1℃。请胡老会诊时症见：汗出，烦躁不宁，时有谵语，咳嗽吐黄痰，腹胀，大便五日未行。舌红苔黄腻，脉弦滑数。胡老认为证属阳明里实证，为大承气汤方证，药用：

大黄四钱（后下），厚朴六钱，枳实四钱，芒硝五钱（分冲）。

上药服一剂，大便通四次，热退身凉。余咳嗽吐黄痰，继与小柴胡加杏仁、桔梗、生石膏、陈皮，服三剂而愈。

207、【循衣摸床谵语不可治医案】许学士：

仪真一妇，病伤寒，八九日，发热，昏闷不识人，手循衣缝，摸床，谵语，不识人事，他医不识，或汗或利，旬日增甚，予诊之曰：此脉涩而小便不利，不可治也。翌日死，论曰：华佗云：病患循衣摸床谵语，不可治，仲景云：伤寒，吐下后不解，不大便，五六日，发潮热，不识人，循衣，撮空，微喘，直视，脉弦者生，脉涩者死，又云小便利者可治，今脉涩，小便不利，见其两死，不见一生，吾莫能为也。

208、【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：

一人病伤寒，大便秘，日晡发潮热，手循衣缝，两手撮空，直视喘急。更数医矣，见之皆走，此诚恶候，得此者，十中九死。仲景虽有症而无治法，但云：“脉弦者生，涩者死”。已经吐下，难于用药，谩且救之，若大便得通而脉弦者，庶可治也。与小承气汤一服，而大便利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。或问曰：下之而脉弦者生，此何谓也。许曰：《金匱玉函》云：循衣妄撮，怵惕不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者但发热，谵语，承气汤主之。予尝观钱仲阳《小儿直诀》云：手循衣领及捻物者，肝热也。此症在《玉函》列于阳明部，盖阳明者胃也，肝有热邪，淫于胃经，故以承气泻之，且得弦脉，则肝平而胃不受克，所以有生之理。读仲景论，不能博通诸医书，以发明其隐奥，专守一节，吾未见其能也。尝治循衣撮空得愈者数人，皆用大补气血之剂也。惟一人瞿兼振，脉代，遂于补剂中略加桂二分，亦振止脉和而愈。

209、【大承气汤治低热不大便医案】樊文有：

李某，女，40岁，1985年4月就诊。患者间断性低热年余，发热多在下午3时许，有时夜间亦作，体温37℃至38℃之间，曾按阴虚治疗而无效。内服消炎药（土霉素、四环素，磺胺）和中药清热剂，其热可停，五六日或十余日复作，用攻下剂可使发作间隔时间延长。由于时间已久，其效不显，改为输液，其热也可暂停，如此反复年余，多次检查原因不明。来郑再查，除胆囊收缩功能差外，无异常发现，邀余诊治。症见低热37.50，口干舌燥，食少不馨，心烦腹满，大便秘结，三至五日一次，有时下硬粪数枚，入梦则喃喃自语，如见鬼状，舌红苔黄，脉沉实有力。根据《伤寒论》212条“不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热”为阳明腑实证的论述，予以大承气汤一剂。

处方：大黄12克（后下），芒硝15克（沸化），厚朴12克，枳实9克。

服药后2小时许，腑气转动，肠鸣漉漉，大便日行八次，所下之物，为污浊之水和硬粪。陈积已除，脉静身和，其病获愈。（河南中医）

注家按语：潮热有虚、实之分，本案为燥热结聚所致，实也。长期低热，津液耗伤，易致燥热结聚，当其经气旺时而外张，是发潮热。汪苓友说：“日晡所发潮热者，腑实燥甚，

故当其经气旺时发潮热也”。燥结成实，腑气不通，则见大便秘结，腹满食少；邪热上扰神明则心烦，甚则寐梦自语，如见鬼状，正所谓“谵语由便硬，便硬由胃燥，胃燥由津少，层层相因，病情显著”（徐灵胎语）。治当以大承气汤通腑泻实，急下存阴，则低热自除。

210、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝9克，大黄12克，枳实12克，厚朴12克，当归15克。

服1剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服3剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草6克，又服1剂，神识清楚，语言正常。（陕西中医药1976；（1）：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

211、【承气汤治大便不通谵语心中懊恼】许学士：

一人病伤寒，八九日，身热无汗，时时谵语，时因下后，大便不通三日矣，非躁非烦，非寒非痛，昼夜不得卧，但心中无晓会处，或时发一声，如叹息之状，医者不省是何症。许诊之曰：此懊恼、怫郁二症俱作也。胃中有燥屎者，承气汤下燥屎二十余枚，得利而解。

（琇按：身热无汗，似大柴胡较胜。）仲景云：阳明病下之，心下懊恼，微烦，胃中有燥屎者，可攻。又云：病者小便不利，大便乍难乍易，时有微热，怫郁不得卧者，有燥屎也，承气汤主之。《素问》云：胃不和，则卧不安，此夜所以不得眠也。仲景云：胃中燥，大便坚者，必谵语，此所以有时发谵语也，非躁、非烦、非寒、非痛，所以心中懊恼也。声如叹息时发一声，所谓外气怫郁也，燥屎得除，大便通利，胃中安和，故其病悉去也。

212、【大承气汤证治大便八日不行脉实心痛彻背医案】曹颖甫：

方左，病延二候，阙上痛，渴饮，大便八日不行，脉实，虽今见心痛彻背，要以大承气汤主治。生大黄四钱（后入），小枳实四钱，中川朴一钱，芒硝二钱（后入），全瓜蒌五钱。

拙巢注：下后胸膈顿宽，惟余邪未尽，头尚晕，乃去硝黄，再剂投之，即愈。

【按】大论曰：“问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”此概统白虎承气而言之。若求大承气汤之全部证状，当为：一、大便不行，腹痛拒按，此以胃中有燥矢故也。二、阙（眉目间）上痛。《内经》以阙上属喉间病，此概以气色言之，若阳明燥气上冲及脑，则阙上必痛，其不甚者则但胀耳。三、右髀有筋牵掣，右膝外旁痛，此为吾师所独验而得之者。四、脉洪大而实，然亦有迟者。五、日晡潮热。他若舌苔黄燥厚腻，大渴引冷，当在应有之例。然此不过言其常耳，若下列诸案所引，则其变也，知常知变，乃可与言大道。

吾师善用诸承气汤，历年治阳明实证，十九全愈。吾师之用药也，麻桂膏黄，柴芩姜附，悉随其证而定之，绝不似世之名家，偏凉偏热，以执一为能事者。余敢曰：凡仲圣所称某某汤主之云者，此皆一剂知，二剂已之方也，倘能药量适合，则一帖愈病，原属平淡无奇之事，安足怪者？而《伤寒论》中之阳明病占全书篇幅四之一，于承气汤尤反复推论，其详备明确远出三阴诸方之上，然则硝黄之用，复有何疑者？阅者能明此旨，是为知吾师者，是为知仲圣者。

213、【大承气汤证坐则满头剧痛咳嗽引腹中痛不可忍治医案】曹颖甫：

若华忽病头痛，干呕，服吴茱萸汤，痛益甚，眠则稍轻，坐则满头剧痛，咳嗽引腹中痛，按之，则益不可忍，身无热，脉微弱，但恶见火光，口中燥，不类阳明腑实证状。盖病不专系肠中，而所重在脑，此张隐庵所谓阳明悍热之气上循入脑之证也。按即西医所谓脑膜炎之类。及其身无热，脉微弱之时，而急下之，所谓釜底抽薪也。若身有大热，脉大而实，然后论治，晚矣。

生大黄三钱，芒硝三钱，枳实四钱，厚朴一钱。

【按】若华女士服本方后约三小时，即下，所下非燥矢，盖水浊也，而恙乃悉除，不须再诊。是时，余按日从师受课，故知之稔。

头满头剧痛，病所在脑也。一下而愈，病源在肠也。合而言之，所谓上病下取，治求其本也。盖肠中既燥，胃居其上，声气互通，乃亦化热。胃有神经上通于脑，辗转相传。脑神经受热熏灼，故发为满头剧痛。抑又肠胃燥实者，周身血液亦必随之化热，其敷陈血管壁间之诸神经，自受同一之影响。而脑部为全身神经之总汇，枢机重要，所系更巨，故非特满头剧痛，甚则神昏谵语，发狂喜妄。考之抵当汤证有发狂之象，桃核承气汤证有如狂之状，此皆血热影响于脑神经之明证。故用药总不离乎稍黄，无非脱胎于承气汤，深足长思也。然肠热有易犯脑者，有不易犯脑者，则其人之神经脆弱与否殊为一大主因，要以脆弱者易被犯，如本案所载者是，其理极显。又小儿神经脆弱，故惊厥之病特多。

曹颖甫曰：阳明证之头痛，其始则在阙上，甚则满头皆痛，不独承气汤证有之，即白虎汤证亦有之。且阳明府实证燥气上冲，多致脑中神经错乱，而见谵语头痛。或反在大便之后，无根之热毒上冒，如大便已、头卓然而痛、可证也。惟肠中有湿热蕴蒸，其气易于犯脑，为水气易于流动，正如汤沸于下，蒸气已腾于上，不似燥矢之凝结必待下后而气乃上冲也。此证但下浊水，即可证明湿热之蕴蒸阳明。不然，目中不了了，无表里证，大便难，身微热者，何以法当急下乎？

214、【大承气汤证治目中不了了睛不和壮热头汗出脉大便闭医案】曹颖甫：

予尝诊江阴街肉庄吴姓妇人，病起已六七日，壮热，头汗出，脉大，便闭，七日未行，身不发黄，胸不结，腹不胀满，惟满头剧痛，不言语，眼张，瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，证颇危重。余曰：目中不了了，睛不和，燥热上冲，此《阳明篇》三急下证之第一证也。不速治，病不可为矣。于是遂书大承气汤方与之。

大黄四钱，枳实三钱，川朴一钱，芒硝三钱。

并嘱其家人速煎服之，竟一剂而愈。盖阳明燥气上冲颠顶，故头汗出，满头剧痛，神识不清，目不辨人，其势危在顷刻。今一剂而下，亦如釜底抽薪，泄去胃热，胃热一平，则上冲燥气因下无所继，随之俱下，故头目清明，病遂霍然。非若有宿食积滞，腹胀而痛，壮热谵语，必经数剂方能奏效，此缓急之所由分。是故无形之气与有形之积，宜加辨别，方不至临诊茫然也。

【按】余尝见一男子病者，神志恍惚，四肢痠厥，左手按额上，右手按其阴器，两足相向弯曲而崛起。傍人虽用大力，不能使之直伸，目张而赤，近光则强闭，脉凌乱隐约，大便多日不行，数日来头痛，病起仅七八日，服药五六日，即至如此地步，据谓前曾宿娼患疮，外治而愈。余曰：此大承气证失治者也。顾口噤药不能下，侍者用简便法，纳甘油锭于其肛中，凡三次，毫无效验。惜无亲人作主，不能试胆导法。次日汗出、夜毙，是可悯也。又一男子病者感病数日，腹中微痛，医以四逆散作汤与之，痛略差，而目中不了了更显。与之言，半是半非，其夜即毙。

由上实验证之，目中不了了，睛不和，确为至危至急之候，虽伤寒不过六七日，无表里证，身但微热，大便但难而不结，即为实，当急下之，宜大承气汤。仲圣笔之于论，同甚明了也。果能治之得法，获效亦捷，如本案所示者是。

目中不了了，睛不和，即为脑病之外征。外见目疾，内实脑病，较之上案所言仅满头剧痛者，其病为更胜一筹，其情为更急一等，其方药分量当更重若干，而治无第二法门，舍大承气莫属也。

虽然，大论又曰：“伤寒，若吐，若下后，不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语，如见鬼状，若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘，直视，脉弦则生，涩者死，微者，但发热谵语者，大承气汤主之。”可见脑神经病至于不识人，至于独语如见鬼状，至于循衣摸床，至于脉涩，其微者大承气汤尚可而得主之，其剧者纵投

本汤，亦无效矣。试推求其无效之故安在，曰：大承气但能治肠热之病源，不能治神经之病所，病源虽去，而病所燎原之势已成，诸神经悉受烧灼，故外见种种恶状，卒致不救也。然则当此时也，将何药以救之乎？曰：有之，其惟羚羊角乎。

《本草纲目》曰：本品平肝舒筋，定风安神，散血下风，辟恶解毒，治子痫痉疾云云。所谓恶者，毒者，因热而生也，所谓肝者，筋者，即指神经也。热毒熏灼神经，则见痉挛抽搐，是即所谓肝风动阳。羚羊角能凉和神经，使之舒静，故用之得法合量，可以治大承气所不能治之证。他药如石决、钩钩、蝎尾、蜈蚣，皆可以为佐。

曹颖甫曰：悍铁樵治王鹿萍子脑膜炎，用羚羊角犀角奏效，此王鹿萍子亲为予言之。证以佐景所言，益复可信。足见治危急之证，原有经方所不备，而借力于后贤之发明者，故治病贵具通识也。

215、【大承气汤证治厥应下之医案】曹颖甫：

《伤寒论》曰：“厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”按寒郁于外，热伏于里，则其证当俟阳热渐回而下之，俾热邪从下部宣泄，而病愈矣。若发其汗，则胃中液涸，胆火生燥，乃一转为阳明热证，为口伤烂赤所由来。

此正与反汗出，而咽痛，喉痹者，同例。由其发之太过，而阳气上盛也。此证余向在四明医院亲见之。其始病，余未之见，及余往诊，已满口烂赤。检其前方，则为最轻分量之桂枝汤，案中则言恶寒。夫病在太阳而用桂枝，虽不能定其确当与否，然犹相去不远。既而病转阳明，连服白虎汤五剂，前医以为不治。

老友周肖彭属余同诊。问其状，昼则明了，暮则壮热，彻夜不得眠。夫营气夜行于阳，日暮发热属血分，昼明夜昏与妇人热入血室同。热入血室用桃核承气，则此证实以厥阴而兼阳明燥化。病者言经西医用泻盐下大便一次，则中夜略能安睡。诊其脉，沈滑有力。余因用大承气汤，日一剂，五日而热退。肖彭以酸枣仁汤善其后，七日而瘥。

【按】大论曰：“厥深者，热亦深，厥微者，热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”今已口伤烂赤，考其原，咎在发汗，则更应下矣，此经文之可据以用承气者一也。阳明病，有日晡所发潮热之证，大论言之者屡，今病人昼日明了，暮则壮热，殊相合，此经文之可据以用承气者二也。更诊其脉，沉滑而有力，是为实，此脉象之可据以用承气者三也。西医曾以泻盐微下，则中夜略得安睡，此前治之可据以用承气者四也。有此四证，已可谓细心，若仍不能大胆投剂，尚得称为医家乎？

曹颖甫曰：口伤烂赤，胃热也，大便燥结，肠热也，手足阳明俱热，不急泻之，病何能去？

216、【大承气汤合槟榔顺气汤加减急下宿食兼清湿热赤痢】

彭××，男，年三十五岁，四川人，住云南省昆明市珠市桥。禀赋素强，偶停宿食，兼有湿热，于1929年9月15日，夜起入厕，感受风寒而起病。初起即发热吐泻，头疼体痛，自汗而畏寒，继则下痢赤白，小腹痛甚，里急后重，每便仅一、二匙，日夜无度，小便短赤，噤口不食，脉来浮弦而兼紧象，舌苔白腻，舌尖绛。按病原系湿热挟食积阻遏肠胃，复感风寒外邪，闭束太阳经气运行之机，表寒外束，又有湿热内逼，以致身热下痢，此即所谓“协热痢”。法当表里双治，以桂葛汤解肌表之邪，佐小承气汤加黄连下宿食而清湿热。

葛根12克，桂尖10克，杭芍20克，大黄10克(泡水兑入)，油朴12克枳实10克(捣)，黄连5克，生姜10克，小枣7枚，甘草3克

次日复诊。服上方一剂始尽，即见汗出，汗后热退脉平，表邪已解，痢亦减轻，惟湿热食积尚阻遏胃肠，湿热内逼，痢未全止，每痢仍腹痛后重，遂以“通因通用”之法，拟大承气汤合槟榔顺气汤加减急下宿食兼清湿热。

生杭芍24克，生大黄12克(泡水兑入)，，枳实10克(炒、捣)，，厚朴10克(炒)，，槟榔12克，麦冬12克，广木香5克，芒硝5克黄连4克

三诊，上方服后，得快利稀粪二、三便，腹痛后重及赤白痢均减去十之七、八，腻苔已

退，稍进稀粥。惟小便仍短赤，思食冷物水果。此病状虽减而湿热痢毒未净，仍照原方加减主之。

生杭芍 20 克，生大黄 6 克(泡水兑入)，黄连 5 克，油朴 10 克，麦冬 12 克，玄明粉 5 克，广木香 4 克。

服后又下出溏薄粪便二次，痢遂止，肛门稍坠，食量较增，小便尚赤。余热尚未全清，继拟下方治疗。

沙参 13 克，寸冬 13 克，木通 10 克，生杭芍 13 克，酒炙大黄 5 克，厚朴 10 克

服上方后饮食复常，神形健如，痢止溺清、腹痛若失而瘥。

按：余遇下痢之证，身热头体痛有表证者，当即以桂葛汤先解表邪。若无表邪，则当头以凉下为急，如此疗法，无不效如桴鼓。苟不解除表邪，则身热不退，易转危笃。故《内经》云：“利证身热不休者死。”不行攻下，邪热痢毒亦不能除。若属久痢虚寒者，又当以温固之法治之。

217、【大承气汤产后燥热腹胀】

同乡姻亲高长顺之女……产后六七日，体健能食，无病，忽觉胃纳反佳，食肉甚多。数日后，日晡所，觉身热烦躁，中夜略瘥，次日又如是。延恽医诊，断为阴亏阳越。投药五六剂，不效。改请同乡朱医，谓此乃桂枝汤证，如何可用养阴药？即予轻剂桂枝汤，内有桂枝五分，白芍一钱。二十日许，病益剧。长顺之弟长利与余善，乃延余诊。知其产后恶露不多，腹胀，予桃核承气汤，次日稍愈。但仍发热，脉大，乃疑《金匱》有产后大承气汤条，得毋指此证乎？即予之，方用：生大黄五钱，枳实三钱，芒硝三钱，厚朴二钱。方成，病家不敢服，请示于恽医。恽曰：不可服。病家迟疑，取决于长顺。长顺主与服，并愿负责。服后，当夜不下，次早，方下一次，干燥而黑。午时又来请诊，谓热已退。但觉腹中胀，脉仍洪大，嘱仍服原方。实则依余意，当加重大黄，以病家胆小，姑从轻。次日，大下五六次，得溏薄之黑粪，粪后得水，能起坐，调理而愈。出处：《经方实验录》下卷。

218、【大承气汤瘟疫身黄发斑】

周郁吾，江右疡医也，得时疫热证，原兼停滞而起，因新娶，即寄居秦氏叔岳家，就近延医，渐致沉重，身目俱黄如柏，遍身紫斑点如蚊迹之状，目无所见，耳无所闻，呼亦不应。乃叔岳已代备衣棺，闻予医愈其乡人何云从之弟，乃迎余过诊一决。见其舌上黄苔，问之，数日未更衣，而脉已散乱。问还可救否？余曰：论脉无起色，但伤寒有凭症不凭脉者，今用背水一阵，或侥幸于万一，如再迟延，非余所知也。乃以大承气汤，倍加硝、黄灌下。一时许，腹中作响，缘昏沉不能起来，因而秽污满床。大行数次，便开目能认人，调治月余而愈。出处：《程茂先医案》卷二。

219、【大承气汤下之伤寒便闭呃逆医案】

一人伤寒，阳明内实，地道不通发呃逆，其脉长而实，以大承气汤下之而愈。出处：《续名医类案·呃逆》卷十四。

罗注：仲景曰：“伤寒，嘔而腹满，视其前后，知何部不利，利之则愈”。地道不通。

220、【大承气汤产后阳明病】

同乡姻亲高长顺之女嫁王鹿萍长子，住西门路，产后六七日，体健能食，无病，忽觉胃纳反佳，食肉甚多。数日后，日晡所，觉身热烦躁，中夜略瘥，次日又如是。延恽医诊，断为阴亏阳越。投药五六剂，不效。改请同乡朱医，谓此乃桂枝汤证，如何可用养阴药？即予轻剂桂枝汤，内有桂枝五分，白芍一钱。二十日许，病益剧。长顺之弟长利与余善，乃延余诊。知其产后恶露不多，腹胀，予桃核承气汤，次日稍愈。但仍发热，脉大，乃疑《金匱》有产后大承气汤条，得毋指此证乎？即予之，方用：

生大黄五钱，枳实三钱，芒硝三钱，厚朴二钱方成，病家不敢服，请示于恽医。恽曰：不可服。病家迟疑，取决于长顺。长顺主与服，并愿负责。服后，当夜不下，次早，方下一次，干燥而黑。午时又来请诊，谓热已退，但觉腹中胀，脉仍洪大，嘱仍服原方。实则依余

意，当加重大黄，以病家胆小，姑从轻。次日，大下五六次，得溏薄之黑粪，粪后得水，能起坐，调理而愈。独怪近世医家遇虚羸之体，虽大实之证，不敢竟用攻剂。不知胃实不去，热势日增，及其危笃而始议攻下，惜其见机不早耳！

【按】王季寅先生作《产后之宜承气汤者》篇曰：“产后虚证固多，实证间亦有之，独怪世医动引丹溪之说，谓产后气血双虚，惟宜大补，虽有他证，均从未治，执此以诊，鲜不贻误。

221、【大承气汤加桃仁丹皮发狂见鬼多言骂詈不认亲疏】

余友王百安君于月前治一郭姓妇人。该妇于双产后，发狂见鬼，多言骂詈，不认亲疏。其嫂曾被其掐颈，几至惊毙。家人因使强有力者罗守之。遂延王君往诊，车至中途，病家喘急汗流奔告曰，病者角弓反张，口吐涎沫，现已垂危，后事均已备妥，特询还可医否？如不可医，毋徒劳先生往返也。王君答以果系实证，不妨背城借一，或可挽回，然未敢必也。及至病所，见病人反张抽搐，痰涎如涌，诊其脉，数而疾，因病者躁动，未得细诊。询以恶露所见多寡，腹中曾否胀痛，二便若何，该家惊吓之余，视病者如虎狼，此等细事全无人知。王君以无确凿左证，力辞欲去。病家苦求立方，坚不放行。王君默念重阳则狂，经有明文，加以脉象疾数无伦，遍体灼热，神昏流涎，在在均露热征。其角弓反张当系热极成痉。综合以上各点，勉拟下方。生石膏四钱，知母三钱，寸冬三钱，川连三钱，条芩三钱，阿胶三钱，白薇三钱，生地三钱，半夏三钱，木通三钱，枳壳三钱，大黄三钱，粉草一钱，竹叶三钱。一剂，痉愈，躁动略安。复延往诊，病者固拒不令诊脉，询以大便情形，据云水泄挟有燥粪，遂为立大承气汤加桃仁丹皮，嘱其分三次灌之。如初次服后矢气，便为对证，可将余药服下。次日，病家来云，躁动若失，已能进食，惟仍狂言不寐。遂处下方：川连、炒栀子、条芩、杭芍、阿胶、云苓、茯神、远志、柏子仁、琥珀、丹皮、当归、生地、鸡子黄。据称服后熟睡竟夜，此后可以无虑。

其母因其灌药艰难，拟令静养，不复服药矣。似此病症，若仍以产后多虚，妄用十全八珍，或生化汤加减，岂不促其命期耶？”录《医界春秋》）按本证初起，似属桃核承气汤证，或竟抵当汤证。仲圣曰：“其人如狂，但少腹急结者，乃可攻之。”又曰：“其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞕满”是也。此二条，如狂与发狂异，急结与鞕满异，是其辨也，迨后角弓反张，当为大承气汤证。仲圣曰：“卧不着席，脚挛急，必齿介齿，可与大承气汤”是也。最后，狂言不寐，亦如仲圣所谓“心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之”之证。故用药近似，即可以起死回生。呜呼，此仲圣之所以为万世法也！此证甚剧，亦属产后，引之可与吾师原案互证。

曹颖甫曰：产后宜温之说，举世相传，牢不可破。而生化汤一方，几视为金科玉律，何怪遇大实大热之证，而束手无策也。大凡治一病，必有一病之主药，要当随时酌定，不可有先入之见。甚有同一病证，而壮实虚羸之体不当同治者，此尤不可不慎也。

222、【大承气汤加黄连阳明大实】

陈左，住马浪路十四岁。初诊：八月十七日，发热有汗，阙上痛，右髀牵掣，膝外廉痛，时欲呕，大便不行，渴饮，舌苔黄燥，腹满，脉滑，阳明证备，于法当下，宜大承气汤加黄连。

生大黄四钱后入，枳实四钱，中朴钱半，芒硝三钱冲服，淡吴茱萸五分，细川连二分）

二诊：八月二十日拟方，下后，但见燥矢，阙上仍痛，时欲吐，痰多，是阳明燥气未尽，上膈津液化为痰涎也，宜小半夏加硝黄。

制半夏四钱，生大黄三钱后入，芒硝钱半冲，生姜五片。

【按】若仍用大承气汤加重厚朴，似亦甚佳，因厚朴并能去上湿也。

三诊：八月二十二日，进小半夏合承气，下后，热除，痛止，知饥。经食煮红枣六枚，顿觉烦闷，夜中谵语不休，甚至昏晕。此特下后肠中燥热上熏脑部，而又发于下后，要无根毒热，不足为患。夜不能寐，当用酸枣仁汤加减。

酸枣仁五钱，辰砂五分，潞党参三钱，知母三钱，天花粉一两，生姜三片，红枣三枚。

【按】本汤之用，似不得当，盖此时热势方稍稍受折，转瞬当复炽。观其仅服红枣六枚，即转为谵语昏晕，不可终日，可以知矣。酸枣仁汤功能安和神经，使人入睡，为病后调理之良方，而不宜于此热势嚣张之时，故服后少效，宜其然也。或者当时病家见两服稍黄，遂惧病者虚脱，故乃悬师用此似较平稳之方欤？

四诊：八月二十三日拟方，阳明之热未清，故尚多谵语，阙上痛，渴饮，宜白虎汤加味。

生石膏八钱，知母四钱，生甘草二钱，天花粉一两，洋参片五钱，滑石六钱，粳米一撮，牡蛎二两生打先煎）

五诊：八月二十四日，服人参白虎汤加味，渴饮，阙上痛定，夜无谵语，今尚微渴，饮粥汤便止，仍宜前法。

生石膏一两，知母三钱，生草三钱，天花粉一两，北沙参八钱，潞党参五钱，块滑石一两，左牡蛎二两（先煎）

拙巢注：此证不大便二十余日，始来就诊，两次攻下，燥热依然未尽。予所治阳明证未有若此之重者，自十七日至今，前后凡八日，方凡五易，始得出险。此与三角街吴姓妇相似，盖郁热多日，胃中津液久已告竭也。

曹颖甫曰：此证下后，湿痰未去。二诊悬拟方，因病家来告贫苦，减去厚朴，以致湿热留于上膈。三诊，但治不寐，未尝顾及阳明实证。下后胃热未除，以致病根不拔，诚如佐景所言。盖胃不和，固寐不安也。附志于后，以志吾过，而警将来。曾记八年以前，同乡周巨臣绍介一汪姓病人，初诊用生大黄四钱，厚朴二钱，枳实四钱，芒硝三钱，其人病喘不得眠，壮热多汗，脉大而滑，下后稍稍安眠，而时吐黄浊之痰，予用承气汤去大黄加皂荚末一钱，二剂而愈，与此证相似，并附存之。

223、【大承气汤恶寒发热，小便淋涩，大便不行】名医类案：

虞恒德治一人，三月间得伤寒证，恶寒发热，小便淋涩，大便不行。初病时，茎中出小精血片，如枣核大，由是众医皆谓房事所致，遂作虚证治，而用补中益气等药，七八日后，热愈甚，（用补而热愈甚，当思转矣。）大渴引饮，胃中满闷，语言错乱。召虞诊视，六脉俱数甚，右三部长而沉滑，左手略平，亦沉实而长。虞曰：此大实大满证，证属阳明经，宜大承气汤。众皆惊愕，虞强作大剂，连进二服，大泻后，热退气和而愈。十日后，因食鸭肉太多，致复热，来问虞，教用鸭肉烧灰存性，生韭汁调下六七钱，下黑粪一碗许而安。

224、【宜大承气汤十日不大便，恶气冲脑，则阙上痛，脑气昏，则夜中谵语】

陆左，初诊：三月二十二日，阳明病，十日不大便，恶气冲脑，则阙上痛，脑气昏，则夜中谵语，阳明燥气熏灼，则右髀牵掣，膝屈而不伸，右手亦拘挛，夜不安寐，当急下之，宜大承气汤。

生大黄四钱后入，枳实三钱，中朴一钱，芒硝三钱（冲服）

拙巢注：此证服药后，夜中大下二次，稍稍安睡。二诊三诊用白虎汤为主，以其右手足不伸，而加芍药，以其渴饮，而加天花粉。三诊后，闻延张衡山两次，又以无效中止。三十日后，闻其恶热甚，家人饮以雪水，颇安适，此即“病人欲饮水者，少少与之，即愈”之证也。予为之拟方用生石膏二两，知母五钱，生甘草三钱，西洋参一钱，和米一撮。煎汤服后，病者甚觉清醒。四月一日服二煎，至午后，病者忽然寒战，闭目若死，既而壮热汗出，此当在伤寒论战而汗出之例，非恶候也。

续诊四月六日拟方，此证自三月二十二日用大承气汤下后，两服凉营清胃之剂，不效。其家即延张衡山二次，不效中止。后于三十日闻其恶热渴饮，用白虎加人参汤，至一日战而汗出，意其愈矣。至四日，病家谓其右手足不伸，而酸痛，为之拟方用芍药甘草汤加味赤白芍各一两，炙甘草五钱，炙乳没各三钱，丝瓜络三钱。，手足乃伸。今日病家来云能食，但欲大便不得，小便赤，更为之拟方如左：

生大黄一钱五分，芒硝一钱冲，生甘草二钱拙巢注：下后诸恙悉愈，胃纳大畅。

【按】战而汗出，是为战汗。若本案之战汗，是阳明之战汗也。大论曰：“凡柴胡汤病证，而柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。”是少阳之战汗也。又曰：“太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗，汗出而解。”是太阳之战汗也。粗观之，似三阳皆有战汗。试问病人何以欲汗？曰：假此以逐邪耳。设其人正气充实，受邪不重，又得药力以助之，则澌然汗出，了无烦苦。设不假药力之助，但凭正气与邪相搏，则其人略有烦苦矣。故大论曰：“欲自解者，必当先烦，乃有汗而解。”设其人正气虚弱，邪气充实，即使得药力之助，亦必须鼓额慄栗，努力挣扎，方能得汗，而其外表不仅为烦，甚当为战矣。故大论又曰：“问曰：病有战而汗出，因得解者，何也？答曰：脉浮而紧，按之反芤，此为木虚，故生战而汗出也。其人本虚，是以发战，以脉浮，故当汗出而解，若脉浮而数，按之不芤，此人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也。”本条词句重叠，不类仲圣口吻，然而说理至精，可以奉信。抑余尤有说焉，伸之如下：

凡汗出而愈，属于太阳病居多，属于少阳病次之，属于阳明病者少。夫太阳之战汗，原不足以为异。少阳病服柴胡汤已，其澌然或战而汗出解者，或亦有太阳之邪错杂于其间也。至本案阳明病之战汗，亦无非旧日太阳或少阳之宿邪，寄于肌表三焦，医者不能善为汗解，及其病已转为阳明，则液灼不能化汗，医更无暇及之。及其后，阳明病愈，阴液少复，病者自己之正气欲除久伏之宿邪，故不得已出于一战耳。由是观之，谓本案曰阳明之战汗者，特就其近病而言之耳，犹非至通之论也。

战汗者，破釜沉舟，背城借一之谓也。战而胜，则生。不胜，则死。一战不决，则再三战，以求其果。盖久病之后，正气不堪病魔之缠扰，故宁与一决雌雄，以判胜负。是故战汗乃生死之枢机，阴阳所从分，医者病家，当共深晓，爰录三则，以为参考。

《伤寒证治明条》云：“凡伤寒疫病战汗者，病人忽身寒鼓颌战栗，急与姜米汤热饮，以助其阳。须臾战定，当发热汗出而解。或有病人恶热，尽去衣被，逆闭其汗，不得出者，当以生姜豆豉紫苏等发之。有正气虚不能胜邪，作战而无汗者，此为难治。若过半日至夜而有汗，又为愈也。如仍无汗，而神昏脉渐脱者，急以人参姜枣煎汤以救之。又有老人虚人，发战而汗不行，随即昏闷，不知人事，此正气脱而不复苏矣。”又云：“余见疫病有五六次战汗者，不为害也。盖为邪气深，不得发透故耳。又有二三次复举者，亦当二三次作战，汗出而愈。”

《医林绳墨》云：“应汗而脉虚弱者，汗出必难。战不得汗，不可强助，无汗即死。当战不得用药，用药有祸无功，要助其汗，多用姜汤。”

《温疫论》云：“应下失下，气消血耗，即下亦作战汗。但战而不汗者危，以中气亏微，但能降陷，不能升发也。次日，当期复战，厥回汗出者生，厥不回，汗不出者死，以正气脱，不胜其邪也。战而厥回无汗者，真阳尚在，表气枯涸也，可使渐愈。凡战而不复，忽痊者必死。痊者身如尸，牙关紧，目上视。凡战不可扰动，但可温覆，扰动则战而中止，次日当期复战。”又云：“狂汗者伏邪中溃，欲作汗解，因其人禀赋充盛，阳气冲击，不能顿开，故忽然坐卧不安，且狂且躁，少顷大汗淋漓，狂躁顿止，脉静身凉，霍然而愈。”

《温疫论》又云：“温疫得下证，日久失下，逐日下利纯臭水，昼夜十数行，乃致口燥唇干，舌裂如断。医者按仲景协热下利治法，与葛根黄连黄芩汤，服之转剧。余诊视，乃热结旁流，急与大承气汤一服，去宿粪甚多，色如败酱，状如粘胶，臭恶异常。是晚利止，次日服清燥汤一剂，脉尚沈，再下之，脉始浮。下证减去，肌表尚存微热。此应汗解，虽不得汗，然里邪先尽，中气和平，所以饮食渐进。半月后，忽作战汗，表邪方解。盖缘下利日久，表里枯燥之极，饮食半月，津液渐回，方能得汗，所谓积流而渠自通也。可见脉浮身热，非汗不解，血燥津枯，非液不汗。昔人以夺血无汗，今以夺液亦无汗，血液虽殊。枯燥则一，则知温疫非药可得汗者矣。”本节上半可作自利清水大承气证之补注，下半可作余说战汗多属太阳病之别解。

曹颖甫曰：战汗多属太阳，为前人所未发，盖太阳有寒水，他经不当有寒水也。凡战汗而愈之病，皆由太阳失表所致。在少阳一经，犹曰手少阳三焦为寒水下行之经隧。而阳明已经化燥，则断断不应有此。而卒见此证者，或由其人水分太多，上膈水气犹在，肠胃已经化燥，水气被蒸，化为湿热，与燥矢相持而不动，燥矢一去，湿热不能独留，乃战汗而外出，数十年来偶然一见，要未可据为成例也。

【又按】以上吾师各案，皆为依法治之而得生者，所谓验案是也。然而验案之书多矣，掩不善而着善，何足贵者？吾今特选吾师治而不验之案，详述于后，以存真迹，而昭大信。考其不治之由，或因病情之过重，或因证方之未合，或因药量之嫌轻，或因人事之未尽。拙按内悉旁征博引，细为推求，间有越仲圣之大范者，不计也。总冀阅者获此，庶了若观火，洞垣一方，以后即遇此种疑难险证，亦能治之而验。夫如是则今兹不验之案尤远胜于吾前此之验案也欤？

225、【大承气汤治哕而腹满】曹颖甫：

陆左八月二十九日住大兴街，伤寒八九日，哕而腹满，渴饮，小便多，不恶寒，脉急数，此即仲师所谓“知其何部不利，利之而愈”之证也。

生大黄三钱后入，生甘草二钱，枳实二钱，芒硝二钱（冲服）

拙巢注：此证下后，呃不止，二日死。

【按】大论曰：“伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。”按呕多与哕异，凡呕多不止者，其胃机能必衰逆，更加硝黄苦寒以伤其气，是为误治。法当先治其呕为是。吾师《伤寒发微》注本条云：“盖即《金匱》病人欲吐者，不可下之之说也。胃中郁热上泛，湿痰壅于上膈，便当用瓜蒂散以吐之。胃中虚气上逆，而胸满者，则吴茱萸汤以降之。否则，无论何药入咽即吐，虽欲攻之，乌得而攻之。故必先杀其上逆之势，然后可行攻下。予每遇此证，或先用一味吴茱萸汤。间亦有肝胆郁热，而用芩连汤者。呕吐既止，然后以大承气汤继之，阳明实热乃得一下而尽。须知‘有阳明证’四字，即隐示人以可攻。若不于无字处求之，但狃于胃气之虚，视芒硝大黄如蛇蝎，真瞌睡汉耳。”薛生白先贤曰：“湿热证，呕恶不止，昼夜不差欲死者，宜用川连三四分，苏叶二三分，两味煎汤呷下，即止。”可以互参。

226、【大承气汤治不大便呕吐渴而饮水】曹颖甫：

于昔治肉庄范阿良妇十五日不大便，终日呕吐，渴而饮水，吐尤甚。予诊其脉洪大而实，用大承气汤，大黄三钱，枳实三钱，川朴二钱，芒硝三钱。以其不能进药也，先用吴茱萸三钱，令其煎好先服，一剂愈。

227、【大承气汤治不大便呕吐】曹颖甫：

后治菜市街福兴祥衣庄男子，大热，脉实，大便七日不行，亦以其茶水入口即吐也，先用姜汁半夏三钱，吴茱萸一钱，川连三分，令其先行煎服，然后用大黄三钱，枳实四钱，厚朴一钱，芒硝三钱，亦以一剂愈。盖见呕吐者易治，见哕逆者难治，世有能治此者，吾当北面事之。

228、【白虎加人参汤治阳明津竭】张锡纯：

甘右，初诊：四月八日，阳明病，十四日不大便，阙上痛，谵语，手足濈然汗出，脉滑大，宜大承气汤。

生大黄五钱（后入）枳实四钱，川朴钱半，芒硝三钱（冲服）

二诊：四月九日，下经三次，黑而燥，谵语如故，脉大汗出，前方加石膏知母。

石膏一两，知母五钱，加入前方中。

【按】张氏锡纯曰：“愚临证实验以来，知阳明病既当下，其脉迟者固可下，即其脉不迟而又不数者，亦可下。惟脉数及六至，则不可下，即强下之，病必不解，或病更加剧。而愚对于此等病，则有变通之下法，即用白虎加入参汤，将石膏不煎入汤中，而以所煎之汤将石膏送服者是也。愚因屡次用此方奏效，遂名之为白虎承气汤。

方为生石膏八钱捣细，大潞党参三钱，知母八钱，甘草二钱，粳米二钱。药共五味，将

后四味煎汤一钟半，分二次将生石膏细末用温药汤送下。服初次药后，迟两点钟，若腹中不见动作，再服第二次，若腹中已见动作，再迟点半钟，大便已下者，停服。若仍未下者，再将第二次药服下。至若其脉虽数而洪滑有力者，用此方时，亦可不加党参。愚从来遇寒温证之当下，而脉象数者，恒投以大剂白虎汤，或白虎加人参汤，其大便亦可通下。然生石膏必须用至四五两，煎一大碗，分数次温服，大便始可通下。

间有服数剂后，大便仍不通下者，其人亦恒脉静身凉，少用玄明粉二三钱，和蜜冲服，大便即可通下。然终不若白虎承气用之较便也。按生石膏若服其研细之末，其退热之力一钱抵煎汤者半两，若以之通大便，一钱可抵煎汤者一两。是以方中止用生石膏八钱，而又慎重用之，必分二次服下也。寒温阳明病，其热甚盛者，投以大剂白虎汤，其热稍退。翌日，恒病仍如故。如此反复数次，病家终疑药不对证，而转延他医，因致病不起者多矣。愚复拟得此方，初次用大剂白虎汤不效，二次即将生石膏细末送服。其汤中用五六两者，送服其末不过两余，或至二两，其热即可全消矣。”张氏谓脉迟可下，脉数难下，吾师则谓下后脉和者安，脉转洪数者危，其理正有可通之处。要皆经验之谈，不可忽视者也，张氏谓生石膏研细末送服，一钱可抵煎汤者一两，信然。余则谓生石膏研细煎服，一钱亦可抵成块煎服者三钱。大论原文本谓打碎绵裹，可以知之。若夫熟石膏有凝固痰湿之弊，切不可用。张氏为此，曾大声疾呼以告国人，诚仁者之言也。

三诊：四月十日，两次大下，热势渐平，惟下后津液大伤，应用白虎加人参汤，无如病家贫苦，姑从生津着意。

生石膏五钱，知母三钱，生草二钱，天花粉一两，北沙参一两，元参三钱，粳米一撮先煎。

拙巢注：此证当两次下后，脉仍洪大，舌干不润，竟以津液枯竭而死，可悲也。

【按】张氏又曰：“愚用白虎加人参汤，或以玄参代知母产后寒温证用之），或以芍药代知母寒温兼下利者用之），或以生地黄代知母寒温兼阴虚者用之），或以生山药代粳米产后寒温证用之，寒温热实下焦气化不固者用之），或于原方中加生地黄玄参花粉诸药，以滋阴生津，加鲜茅根鲜芦根生麦芽诸药，以宣通气化。凡人外感之热炽盛，真阴反复亏损，此乃极危险之症。此时若但用生地玄参沙参诸药以滋阴，不能奏效，即将此等药加于白虎汤中，亦不能奏效。惟石膏与人参并用，独能于邪热炽盛之时立复真阴，此仲师制方之妙实有挽回造化之权也。”观本案以病家贫苦，无力用人参，卒致不起，可证张氏之言为不虚。

津竭而反当下之证，固不可冒然用大承气，除张氏之白虎承气汤法外，尚有麻子仁丸法，惟麻仁如不重用，依然无效。又有猪胆汁导法，取其苦寒软坚，自下及上，亦每有效。若节庵陶氏黄龙汤法，即大承气汤加人参地黄当归，正邪兼顾，屡建奇功。降至承气养营汤，即小承气汤加知母当归芍药地黄，效相仿佛。又闻有名医仿白虎加人参之例，独加人参一味于大承气汤中，预防其下后之脱，亦是妙策。至吴鞠通之增液承气汤，其功原在承气，而不在增液。若其单独增液汤仅可作病后调理之方，决不可倚为病时主要之剂。故《温病条辨·中焦篇》十一条增液汤主之句下，复曰“服增液汤已，周十二时观之，若大便不下者，合调胃承气汤微和之。”盖彼亦知通幽荡积，非增液汤所能也。

229、【大承气汤证治大便八日不行脉实心痛彻背医案】曹颖甫：

方左，病延二候，阙上痛，渴饮，大便八日不行，脉实，虽今见心痛彻背，要以大承气汤主治。生大黄四钱（后入），小枳实四钱，中川朴一钱，芒硝二钱（后入），全瓜蒌五钱。

拙巢注：下后胸膈顿宽，惟余邪未尽，头尚晕，乃去硝黄，再剂投之，即愈。

【按】大论曰：“问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”此概统白虎承气而言之。若求大承气汤之全部证状，当为：一、大便不行，腹痛拒按，此以胃中有燥矢故也。二、阙（眉目间）上痛。《内经》以阙上属喉间病，此概以气色言之，若阳明燥气上冲及脑，则阙上必痛，其不甚者则但胀耳。三、右脾有筋牵掣，右膝外旁痛，此为吾师所独验而得之者。四、脉洪大而实，然亦有迟者。五、日晡潮热。他若舌苔黄燥厚腻，

大渴引冷，当在应有之例。然此不过言其常耳，若下列诸案所引，则其变也，知常知变，乃可与言大道。

吾师善用诸承气汤，历年治阳明实证，十九全愈。吾师之用药也，麻桂膏黄，柴芩姜附，悉随其证而定之，绝不似世之名家，偏凉偏热，以执一为能事者。余敢曰：凡仲圣所称某某汤主之云者，此皆一剂知，二剂已之方也，倘能药量适合，则一帖愈病，原属平淡无奇之事，安足怪者？而《伤寒论》中之阳明病占全书篇幅四之一，于承气汤尤反复推论，其详备明确远出三阴诸方之上，然则硝黄之用，复有何疑者？阅者能明此旨，是为知吾师者，是为知仲圣者。

230、【大承气汤证坐则满头剧痛咳嗽引腹中痛不可忍治医案】曹颖甫：

若华忽病头痛，干呕，服吴茱萸汤，痛益甚，眠则稍轻，坐则满头剧痛，咳嗽引腹中痛，按之，则益不可忍，身无热，脉微弱，但恶见火光，口中燥，不类阳明腑实证状。盖病不专系肠中，而所重在脑，此张隐庵所谓阳明悍热之气上循入脑之证也。按即西医所谓脑膜炎之类。及其身无热，脉微弱之时，而急下之，所谓釜底抽薪也。若身有大热，脉大而实，然后论治，晚矣。

生大黄三钱，芒硝三钱，枳实四钱，厚朴一钱。

【按】若华女士服本方后约三小时，即下，所下非燥矢，盖水浊也，而恙乃悉除，不须再诊。是时，余按日从师受课，故知之稔。

头满头剧痛，病所在脑也。一下而愈，病源在肠也。合而言之，所谓上病下取，治求其本也。盖肠中既燥，胃居其上，声气互通，乃亦化热。胃有神经上通于脑，辗转相传。脑神经受热熏灼，故发为满头剧痛。抑又肠胃燥实者，周身血液亦必随之化热，其数陈血管壁间之诸神经，自受同一之影响。而脑部为全身神经之总汇，枢机重要，所系更巨，故非特满头剧痛，甚则神昏谵语，发狂喜妄。考之抵当汤证有发狂之象，桃核承气汤证有如狂之状，此皆血热影响于脑神经之明证。故用药总不离乎稍黄，无非脱胎于承气汤，深足长思也。然肠热有易犯脑者，有不易犯脑者，则其人之神经脆弱与否殊为一大主因，要以脆弱者易被犯，如本案所载者是，其理极显。又小儿神经脆弱，故惊厥之病特多。

曹颖甫曰：阳明证之头痛，其始则在阙上，甚则满头皆痛，不独承气汤证有之，即白虎汤证亦有之。且阳明府实证燥气上冲，多致脑中神经错乱，而见谵语头痛。或反在大便之后，无根之热毒上冒，如大便已、头卓然而痛、可证也。惟肠中有湿热蕴蒸，其气易于犯脑，为水气易于流动，正如汤沸于下，蒸气已腾于上，不似燥矢之凝结必待下而后气乃上冲也。此证但下浊水，即可证明湿热之蕴蒸阳明。不然，目中不了了，无表里证，大便难，身微热者，何以法当急下乎？

231、【大承气汤证治目中不了了睛不和壮热头汗出脉大便秘医案】曹颖甫：

予尝诊江阴街肉庄吴姓妇人，病起已六七日，壮热，头汗出，脉大，便秘，七日未行，身不发黄，胸不结，腹不胀满，惟满头剧痛，不言语，眼张，瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，证颇危重。余曰：目中不了了，睛不和，燥热上冲，此《阳明篇》三急下证之第一证也。不速治，病不可为矣。于是遂书大承气汤方与之。

大黄四钱，枳实三钱，川朴一钱，芒硝三钱并嘱其家人速煎服之，竟一剂而愈。盖阳明燥气上冲颠顶，故头汗出，满头剧痛，神识不清，目不辨人，其势危在顷刻。今一剂而下，亦如釜底抽薪，泄去胃热，胃热一平，则上冲燥气因下无所继，随之俱下，故头目清明，病遂霍然。非若有宿食积滞，腹胀而痛，壮热谵语，必经数剂方能奏效，此缓急之所由分。是故无形之气与有形之积，宜加辨别，方不至临诊茫然也。

【按】余尝见一男子病者，神志恍惚，四肢痿厥，左手按额上，右手按其阴器，两足相向弯曲而崛起。傍人虽用大力，不能使之直伸，目张而赤，近光则强闭，脉凌乱隐约，大便多日不行，数日来头痛，病起仅七八日，服药五六日，即至如此地步，据谓前曾宿娼患疮，外治而愈。余曰：此大承气证失治者也。顾口噤药不能下，侍者用简便法，纳甘油锭于其肛

中，凡三次，毫无效验。惜无亲人作主，不能试胆导法。次日汗出、夜毙，是可悯也。又一男子病者感病数日，腹中微痛，医以四逆散作汤与之，痛略差，而目中之不了了更显。与之言，半是半非，其夜即毙。

由上实验证之，目中不了了，睛不和，确为至危至急之候，虽伤寒不过六七日，无表里证，身但微热，大便但难而不结，即为实，当急下之，宜大承气汤。仲圣笔之于论，同甚明了也。果能治之得法，获效亦捷，如本案所示者是。

目中不了了，睛不和，即为脑病之外征。外见目疾，内实脑病，较之上案所言仅满头剧痛者，其病为更胜一筹，其情为更急一等，其方药分量当更重若干，而治无第二法门，舍大承气莫属也。

虽然，大论又曰：“伤寒，若吐，若下后，不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语，如见鬼状，若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘，直视，脉弦则生，涩者死，微者，但发热谵语者，大承气汤主之。”可见脑神经病至于不识人，至于独语如见鬼状，至于循衣摸床，至于脉涩，其微者大承气汤尚可得而主之，其剧者纵投本汤，亦无效矣。试推求其无效之故安在，曰：大承气但能治肠热之病源，不能治神经之病所，病源虽去，而病所燎原之势已成，诸神经悉受烧灼，故外见种种恶状，卒致不救也。然则当此时也，将何药以救之乎？曰：有之，其惟羚羊角乎。

《本草纲目》曰：本品平肝舒筋，定风安魂，散血下风，辟恶解毒，治子痫瘕疾云云。所谓恶者，毒者，因热而生也，所谓肝者，筋者，即指神经也。热毒熏灼神经，则见瘕挛抽搐，是即所谓肝风动阳。羚羊角能凉和神经，使之舒静，故用之得法合量，可以治大承气所不能治之证。他药如石决、钩钩、蝎尾、蜈蚣，皆可以为佐。

曹颖甫曰：恽铁樵治王鹿萍子脑膜炎，用羚羊角犀角奏效，此王鹿萍子亲为予言之。证以佐景所言，益复可信。足见治危急之证，原有经方所不备，而借力于后贤之发明者，故治病贵具通识也。

232、【大承气汤证治自利清水色青医案】曹颖甫：

陈姓少年住无锡路矮屋，年十六，幼龄丧父，惟母是依，终岁勤劳，尚难一饱。适值新年，贩卖花爆，冀博微利。饮食失时，饥餐冷饭，更受风寒，遂病腹痛拒按，时时下利，色纯黑，身不热，脉滑大而口渴。家清寒，无力延医。经十余日，始来求诊。察其证状，知为积滞下利，遂疏大承气汤方，怜其贫也，并去厚朴。计大黄四钱，枳实四钱，芒硝三钱。书竟，谓其母曰：倘服后暴下更甚于前，厥疾可瘳。其母异曰：不止其利，反速其利，何也？余曰：服后自知。果一剂后，大下三次，均黑粪，干湿相杂，利止而愈。此《金匱》所谓宿食下利，当有所去，下之乃愈，宜大承气汤之例也。

【按】大论曰：“少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干，咽燥者，急下之。宜大承气汤。”可以互证。《温疫论》曰：“热结傍流者，以胃家实，内热壅闭，先大便闭结，续得下利，纯臭水，全然无粪，日三四度，或十余度，宜大承气汤，得结粪而利止。服汤不得结粪，仍下利，并臭水，及所进汤药，因大肠邪胜，失其传送之职，知邪犹在也，病必不减，宜更下之。”延陵吴又可先贤能言此，诚不愧为仲圣之入室弟子矣。

客曰：“仲景论伤寒，又可论温疫，予乌可混而一之？”曰：“吁！是何言也？仲圣曰：‘观其脉证，知犯何逆，随证治之。’吾中医之长处，即在能识此证字，苟察病者所犯为大承气汤证，则投以大承气汤，所犯为四逆汤证，则投以四逆汤，服汤已，其效若响斯应，则其前病之何名，初可勿拘拘也。”

233、【大承气汤产后燥热腹胀】

同乡姻亲高长顺之女……产后六七日，体健能食，无病，忽觉胃纳反佳，食肉甚多。数日后，日晡所，觉身热烦躁，中夜略瘥，次日又如是。延恽医诊，断为阴亏阳越。投药五六剂，不效。改请同乡朱医，谓此乃桂枝汤证，如何可用养阴药？即予轻剂桂枝汤，内有桂枝五分，白芍一钱。二十日许，病益剧。长顺之弟长利与余善，乃延余诊。知其产后恶露不多，

腹胀，予桃核承气汤，次日稍愈。但仍发热，脉大，乃疑《金匱》有产后大承气汤条，得毋指此证乎？即予之，方用：生大黄五钱，枳实三钱，芒硝三钱，厚朴二钱。方成，病家不敢服，请示于恽医。恽曰：不可服。病家迟疑，取决于长顺。长顺主与服，并愿负责。服后，当夜不下，次早，方下一次，干燥而黑。午时又来请诊，谓热已退。但觉腹中胀，脉仍洪大，嘱仍服原方。实则依余意，当加重大黄，以病家胆小，姑从轻。次日，大下五六次，得溏薄之黑粪，粪后得水，能起坐，调理而愈。出处：《经方实验录》下卷。

234、【大承气汤证治厥应下之医案】曹颖甫：

《伤寒论》曰：“厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”按寒郁于外，热伏于里，则其证当俟阳热渐回而下之，俾热邪从下部宣泄，而病愈矣。若发其汗，则胃中液涸，胆火生燥，乃一转为阳明热证，为口伤烂赤所由来。

此正与反汗出，而咽痛，喉痹者，同例。由其发之太过，而阳气上盛也。此证余向在四明医院亲见之。其始病，余未之见，及余往诊，已满口烂赤。检其前方，则为最轻分量之桂枝汤，案中则言恶寒。夫病在太阳而用桂枝，虽不能定其确当与否，然犹相去不远。既而病转阳明，连服白虎汤五剂，前医以为不治。

老友周肖彭属余同诊。问其状，昼则明了，暮则壮热，彻夜不得眠。夫营气夜行于阳，日暮发热属血分，昼明夜昏与妇人热入血室同。热入血室用桃核承气，则此证实以厥阴而兼阳明燥化。病者言经西医用泻盐下大便一次，则中夜略能安睡。诊其脉，沈滑有力。余因用大承气汤，日一剂，五日而热退。肖彭以酸枣仁汤善其后，七日而瘥。

【按】大论曰：“厥深者，热亦深，厥微者，热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”今已口伤烂赤，考其原，咎在发汗，则更应下矣，此经文之可据以用承气者一也。阳明病，有日晡所发潮热之证，大论言之者屡，今病人昼日明了，暮则壮热，殊相合，此经文之可据以用承气者二也。更诊其脉，沉滑而有力，是为实，此脉象之可据以用承气者三也。西医曾以泻盐微下，则中夜略得安睡，此前治之可据以用承气者四也。有此四证，已可谓细心，若仍不能大胆投剂，尚得称为医家乎？

曹颖甫曰：口伤烂赤，胃热也，大便燥结，肠热也，手足阳明俱热，不急泻之，病何能去？

235、【小承气汤治循衣撮空医案】许学士：

一人病伤寒，大便秘利，日晡发潮热，手循衣缝，两手撮空，直视喘急。更数医矣，见之皆走，此诚恶候，得此者，十中九死。仲景虽有症而无治法，但云：“脉弦者生，涩者死”。已经吐下，难于用药，谩且救之，若大便得通而脉弦者，庶可治也。与小承气汤一服，而大便秘利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。或问曰：下之而脉弦者生，此何谓也。许曰：《金匱玉函》云：循衣妄撮，怵惕不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者但发热，谵语，承气汤主之。予尝观钱仲阳《小儿直诀》云：手循衣领及捻物者，肝热也。此症在《玉函》列于阳明部，盖阳明者胃也，肝有热邪，淫于胃经，故以承气泻之，且得弦脉，则肝平而胃不受克，所以有生之理。读仲景论，不能博通诸医书，以发明其隐奥，专守一节，吾未见其能也。尝治循衣撮空得愈者数人，皆用大补气血之剂也。惟一人瞶兼振，脉代，遂于补剂中略加桂二分，亦振止脉和而愈。

236、【大承气汤治低热不大便医案】樊文有：

李某，女，40岁，1985年4月就诊。患者间断性低热年余，发热多在下午3时许，有时夜间亦作，体温37℃至38℃之间，曾按阴虚治疗而无效。内服消炎药（土霉素、四环素，磺胺）和中药清热剂，其热可停，五六日或十余日复作，用攻下剂可使发作间隔时间延长。由于时间已久，其效不显，改为输液，其热也可暂停，如此反复年余，多次检查原因不明。来郑再查，除胆囊收缩功能差外，无异常发现，邀余诊治。症见低热37.5℃，口干舌燥，食少不馨，心烦腹满，大便秘结，三至五日一次，有时下硬粪数枚，入梦则喃喃自语，如见鬼状，舌红苔黄，脉沉实有力。根据《伤寒论》212条“不大便五六日，上至十余日，日晡所

发潮热”为阳明腑实证的论述，予以大承气汤一剂。

处方：大黄 12 克（后下），芒硝 15 克（沸化），厚朴 12 克，枳实 9 克。

服药后 2 小时许，腑气转动，肠鸣漉漉，大便日行八次，所下之物，为污浊之水和硬粪。陈积已除，脉静身和，其病获愈。（河南中医）

注家按语：潮热有虚、实之分，本案为燥热结聚所致，实也。长期低热，津液耗伤，易致燥热结聚，当其经气旺时而外张，是发潮热。汪苓友说：“日晡所发潮热者，腑实燥甚，故当其经气旺时发潮热也”。燥结成实，腑气不通，则见大便秘结，腹满食少；邪热上扰神明则心烦，甚则寐梦自语，如见鬼状，正所谓“谵语由便硬，便硬由胃燥，胃燥由津少，层层相因，病情显著”（徐灵胎语）。治当以大承气汤通腑泻实，急下存阴，则低热自除。

237、【大承气汤治狂证（精神分裂证）医案】老中医：

何某某，女，19 岁。发狂两月，语无伦次，近十天病情加重，四天不语，来院求治。余诊：不进饮食，性情急躁，两目怒视，狂乱无知，不避亲疏，弃衣欲走，叫喊不已，大便秘结，脉象浮滑洪紧，舌苔黄糙。证系怒伤肝脾，聚液成痰，痰气郁结于包络而发狂。法当降气以泻阳明实热，以大承气汤加味治之：芒硝 9 克，大黄 12 克，枳实 12 克，厚朴 12 克，当归 15 克。

服 1 剂，即便数次，浊去清升，较为安静。连服 3 剂，病情大减，神志较清，语言正常。上方加甘草 6 克，又服 1 剂，神识清楚，语言正常。（陕西中医药 1976；（1）：53）

注家按语：本案发狂，见便闭、苔黄燥、脉洪滑，及腑实内结、浊热上攻所致，故与大承气汤泻下腑实则愈。

238、【大承气汤治惕而不安急黄发斑（肝昏迷前期）医案】夏发镛：

曹某某，女，10 岁。因身黄、目黄、尿黄，伴呕吐、乏力 6 天，诊为“急性黄疸型肝炎”，于 1989 年 11 月 10 日入院。B 型超声：肝脏大小正常，肝实质炎性损害，重度胆囊炎。肝功能化验：黄疸指数 110 单位，麝浊 17 单位，锌浊 15 单位，麝絮（卅），凡登白直接立即，谷丙转氨酶 181 单位。中医以清热解毒，利湿退黄之法，用茵陈四苓散加减。西医以护肝、补能等处理，黄疸愈深，精神愈差，第三天出现神志模糊，循衣摸床，撮空理线，烦躁谵语，不饮不食，渐至神志不清，狂躁不安，拟诊为“急重肝”、“肝昏迷前期”。中医诊断为“急黄”，仍坚持中西医结合治疗。清洁洗肠，每日二次，均无大便。其舌苔黄燥，脉数有力，腹部虽无胀满，但隐隐约约有碍手之物，且患儿父母诉其已七日未大便，故辨证为阳明实热、燥屎内结。即投大承气汤一剂。5 小时后间断解出如桃核大燥屎六枚，坚硬如石，次日神志清楚，言语正常，并欲饮食，黄疸亦渐渐消退。（新中医）

注家按语：腑热浊毒，壅滞肝胆，胆汁不循常道，而致急黄；上扰神明而致神昏发狂。

《伤寒论》212 条：“若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安……但发谵语者，大承气汤主之。”故与大承气汤原方，通其腑而黄自去，彻其热而神自清。

舒氏云：吾家有时宗者，三月病热，予与仲远同往视之，身壮热而谵语，胎刺满口，秽气逼人，少腹硬满，大便闭，小便短，脉实大而迟。仲远谓热结在里，其人发狂，小腹硬满，胃实而兼畜血也，法以救胃为急，但此人年已六旬，证兼畜血，下药中宜重加生地，一以保护元阴，一以破瘀行血。予然其言，主大承气汤，硝黄各用八钱，加生地一两，捣如泥，先煎数十沸，乃纳诸药同煎。连进五剂，得大下数次，人事贴然。少进米饮，一二口辄不食，呼之不应，欲言不言，但见舌苔干燥异常，口内喷热如火，则知里燥尚未衰减。复用犀角地黄汤加大黄，三剂，又下胶滞二次，色如败酱，臭恶无状，于是口臭乃除，里燥仍盛，三四日无小便，忽自取夜壶小便一回。予令其子取出视之，半壶鲜血，观者骇然，经言“血自下，下者愈”，亦生地之功也。复诊之，脉转浮矣，此溃邪有向表之机，合以柴胡汤迎其机而导之。但此时表里俱还热极，阴津所存无几，柴胡亦非所宜，惟宜白虎汤加生地、黄芩以救里，倍用石膏之质重气轻，专达肌表而兼解外也。如是二剂，得微汗而脉静身凉，舌苔退而人事清矣。再用清燥养荣汤（知母、天花粉、当归、白芍、地黄、陈皮、甘草）二十剂而痊愈。

239、【承气汤治大便不通谵语心中懊恼】许学士：

一人病伤寒，八九日，身热无汗，时时谵语，时因下后，大便不通三日矣，非躁非烦，非寒非痛，昼夜不得卧，但心中无晓会处，或时发一声，如叹息之状，医者不省是何症。许诊之曰：此懊恼、怫郁二症俱作也。胃中有燥屎者，承气汤下燥屎二十余枚，得利而解。

（琇按：身热无汗，似大柴胡较胜。）仲景云：阳明病下之，心下懊恼，微烦，胃中有燥屎者，可攻。又云：病者小便不利，大便乍难乍易，时有微热，怫郁不得卧者，有燥屎也，承气汤主之。《素问》云：胃不和，则卧不安，此夜所以不得眠也。仲景云：胃中燥，大便坚者，必谵语，此所以有时发谵语也，非躁、非烦、非寒、非痛，所以心中懊恼也。声如叹息时发一声，所谓外气怫郁也，燥屎得除，大便通利，胃中安和，故其病悉去也。

240、【大承气汤加石膏瘟疫病阳明急下证】

陈××，年虽六旬，体素康健。1916年4月初，因事赴邻村，值村中时疫流行，遂被传染。返家数日，忽觉胸闷食少，头昏体困，口渴思饮而起病。初起即感慄慄憎寒，继则发热，渴思冷饮，头体疼痛，小便短少，其色如茶，病卧已七、八日，自服发表消导药二剂无效，始延余诊视。

脉来洪数，唇焦口燥，舌苔厚腻，边白中黄而生芒刺。但头汗出，余处无汗，壮热烦渴饮冷，时发谵语，小便短涩但又随时点滴遗出。大便已六、七日不通，腹满而不能食。此乃瘟疫误于表散，大伤真阴，疫毒传入阳明之腑，邪热内蒸而呈是状，急宜凉下以救真阴，拟仲景大承气汤加石膏、寸冬，急下救阴，犹釜底抽薪之意，务将胃肠中之邪热疫毒下尽为度。

大黄16克（泡水兑入），芒硝：3克（后放），枳实13克（炒，捣），厚朴13克（炒），生石膏30克（碎，布包），寸冬26克。

此方煎服三次后，畅下黑酱粪半小桶之多，臭不可当，身热约退七、八，口津渐回，苔刺变软，谵语止，小便已不滴遗，稍见清长，色仍黄，仍渴喜冷饮，当即索取石缸内冰凉冷水一碗与饮之，饮后病者自云心中爽快，再饮一碗，顿觉全身清凉，竟得安卧熟寐片刻。余热未尽，继拟小承气汤加清热养阴生津以治之。

沙参16克，生石膏15克（碎，布包），枳壳10克，寸冬16克，厚朴10克，生地13克，玄参10克，大黄6克（泡水兑入）。

服二剂后，大便溏泻数次，色由酱黑而渐次转黄，脉静身凉，津液满口，苔皮退去八、九，烦渴止，已能进稀粥少许。拟方：沙参20g 杭芍10克，生地13克，寸冬13克，北芪30克，当归13克甘草6克。连服三剂，食增神健，诸证全瘳。

241、【大承气汤治不大便】姜春华

患者，男，42岁。初诊：头部剧痛10余日。大便多日未行，目赤舌红，脉大。证属胃家实，治宜通腑去毒。投以大承气汤。处方：大黄9g（后下），芒硝6g，川朴9g，枳实6g。3剂。仅1剂，大便通，头痛除。《内科名家姜春华学术经验集》

242、【大承气汤治不寐不大便】姜春华

战某，男，38岁。初诊：1982年3月4日。连续失眠10余日，彻夜不寐，服大量安眠药无用，痛苦不堪。面红目赤，大便不通多日，舌苔黄厚，脉大。用大承气汤。处方：大黄9g，芒硝6g，枳实6g，厚朴9g。仅服1剂，腑通，当夜酣然入眠。《内科名家姜春华学术经验集》

243、【大承气汤伤寒身热便秘】：

一武弁李姓，在宣化作警，伤寒五六日矣。镇无医，抵郡召予，予诊视之曰：脉洪大而长，大便不通，身热无汗，此阳明证也，须下。病家曰：病者年逾七十，恐不可下。予曰：热邪毒气，并畜于阳明，况阳明经络，多血少气，不问老壮当下，不尔别请医治。主病者曰：审可下，一听所治。予以大承气汤，半日殊未知。诊其病，察其证，宛然在。予曰：药曾尽否。主者曰，恐气弱不禁，但服其半耳。予曰：再作一服。亲视饮之，不半时间，索溺器，先下燥粪十数枚，次溏泄一行，秽不可近，未离已中汗矣，濺然周身，一时顷汗止身凉，诸

苦遂除。次日予自镇归，病人索补剂，予曰：服大承气汤得差，不宜服补剂，补则热仍复，自此但食粥旬日可也。故予治此疾终身，止大承气一服而愈，未有若此之捷。

244、【大承气汤伤寒失下昏不知人】

苏州柴行倪姓，伤寒失下，昏不知人，气喘舌焦，已办后事矣。余时欲往扬州，泊舟桐泾桥河内，适当其门，晚欲登舟，其子哀泣求治。余曰：此乃大承气汤证也，不必加减，书方与之。戒之曰：一剂不下，则更服，下即止。遂至扬月余而返，其人已强健如故矣。古方之神效如此，凡古方与病及证俱对者，不必加减。若病同而证稍有异，则随证加减，其理甚明。而人不能用。若不当下者，反下之，遂成结胸，以致闻者，遂以下为戒。颠倒若此，总由不肯以仲景《伤寒论》潜心体认耳。《洄溪医案》

245、【大承气妊娠染疫厥阴绝舌卷乳缩】王寿芝：

蓉城东隅大慈寺侧近机匠妇赵氏，怀孕弥月，得晚发疫，过十八日矣，日日服药，病转增剧，乃延余诊。入其门，诸医满座，见予至，去者半，留二人焉。予召机匠至前，详询所苦，拉杂道之，引入内室，见病妇卧地上，盖单被，离尺许，热气蒸人，面红黑，口裂，鼻息粗壮，唤使举手诊脉，不动，知已耳聋。伊夫以手式示之，忽摇头大叫，掀去单被，体赤露不知羞耻。脉得沉洪而实，见两乳伸缩，不禁大惊，语曰：病于申酉时当死，此时辰初，犹可用药挽救，然非大下不为功。留者两医曰：温疫实证当下，孕妇敢下耶？下不大小俱伤耶？予曰：妇之罹此危也，皆诸公固执误之耳。明明阳明热证，当热未团结，白虎汤可解，今已恶候齐备，延至申酉阳明旺时，邪热亢极，津液尽倾，不死何待？且不见乳之伸缩乎？男子厥阴绝，舌卷囊缩而死；女子厥阴绝，舌卷乳缩而死。趁此一线未绝，姑尽吾技，以对病者，心乃安也。急书大承气与之，两医咋舌而退，予亦乘车而返。坐未定，伊夫奔来，谓诸医先告药店：王寿芝所开系送终汤，万不可卖，卖必招祸。予愤极，自撮一剂，复命与同至病所，督令煎服，坐视之。异哉！异哉！药不香也，病妇闻之，大呼：好香药！好香药！予知闻药而香，胃气未绝，即大佳兆。煎成，妇又大呼：快与我吃。伊夫掬一小碗灌之，顷又索药，予令与一大碗，且告以刻许，当得战汗，战时尔勿畏，汗出热退，病人必欲上床卧，卧或两三日，断不可惊醒，俟自醒大泻，病自解矣。伊云：先生施恩小坐，替予壮胆。连连叩头，见之实不忍走，而腹号甚，令煮饭食我。饭未熟，病妇四支乱动，口眼翕张，而大摇颤约两三刻，汗如雨下，热乃渐退；退尽手如冰，口无气而人死矣。斯时也，若母若姨若姊若妹一齐奔出，大哭大闹大骂，门外观者，目瞪口呆，老姬嫩妇，如观戏剧，而其夫乃请予走，余亦心摇目眩，耳聋口干。固不肯走。起而诊脉，脉乍时一动，动而复止，止又续动，大声呼曰：众人且息，听予一言。若辈谓若死，若顷刻复生何以谢我？其母曰：谢线绉袍褂两套。语际，病者大呻，若姨若姊若妹狂奔入室，恐尸走也。予起复诊，脉续续出，又告之曰：病者再呻，必语欲上床卧，乃可扶起。果应言而长呻，其气缓，其音平，谓：何掷我地下。予促其夫扶之上床，乃去。见老姬嫩妇指予偶语，不闻何说，归始早餐。噫嘻！名医岂易为哉！次日，其夫尚以睡为死，复来问故。予曰：前言，睡当二三日，汝回静候，不死也。果二日半乃醒。泻一次，又睡一日，醒大泄如注，腹馁思食。与粥，不欲，欲酸菜汤下饭。其夫来询，可与否？告以少与，归而与食，复睡，神气大安。问再与何药，予曰：不必药，少与饮食，自此无恙矣。

246、【承气汤治伤寒谵语便秘遗尿】

朱笠庵，感寒，屡用发表清里药不愈。脉乍大乍小，数而无力，谵语，舌黄燥，遗尿，大便秘，欲饮滚热茶。时予初习医，因脉虚热饮，不敢再进寒凉消伐之剂。远延两名医，一与以连理汤，一与以六君子汤，愈剧。后不服药，止频饮松萝热茶，数日后渐觉清明。自主以承气汤，下胶粪一遍，遂渐愈。是知脉虚者，屡用发表，中气虚也；思热饮者，滞化为痰，中气弱不能利痰，故借汤之暖，以运荡之也；遗尿者，心移热于小肠也。标虽虚而本却实。故现舌苔干黄，仍归攻下而愈也。《医权初编》

247、【大承气汤治瘟疫谵语】

蒋星升仆人，二十余岁，仲秋患疫。一医始以麻黄汤发汗，终无汗。一医数下之，皆稀粪，不愈。予视时，已过经矣。肚皮黏腹，谵语，口渴，舌无苔，脉虚数。屡服清火药。小便已白，而余症不解。但脐下筑筑动气，矢气甚臭，大肠必有结粪也。以大承气汤小其制，下结粪数十枚，继自汗而愈。此证舌无苔，小便已白，脉小数无力，肚皮黏腹，全似虚证。惟谵语，矢气甚臭，无汗，脐下跳动，是为下证。《内经》脐下动气不可汗下之语，不可泥也。《医权初编》

248、【大承气汤癡狂】

彰德张相公子谊夫之妻许氏，乃状元许先之女，绍明之妹也。病阳厥怒狂，发时饮食四五倍，骂詈不避亲疏，服饰临丧，或哭或歌，或以刀伤人，不言如哑，言即如狂，素不知书识字，便读文选。人皆以为鬼魔，待其静诊之，六脉举按皆无，身表如冰石，其发也叫呼，声声愈高。余昔闻洁古老人云：本经言夺食则已，非不与之食而为夺食也，当以药大下之而使不能食，为之夺食也。予用大承气汤下之，得脏腑（指肠垢）数升，狂稍宁；待一二日复发，又下之，得便数升，其疾又宁；待一二日又发，三下之，宁如旧。但不能食，疾稍轻而不已，下之又五七次，计大便数斗，疾缓身温，脉生，至十四日其疾愈，脉如旧，困卧三四日后起苏，饮食微进，又至十日后得安。《阴证略例·海藏治验录》

249、【大承气汤治关格】

赵仪女，忽吐逆，大小便不通，烦乱，四肢渐冷，无脉，凡一日半。大承气汤一剂，至夜半，渐得大便通，脉渐和，翌日乃安。此关格之病，极为难治，垂死而活者，惟此一人。《续名医类案·呕吐》

250、【大承气症厥实证挛急抽搐】

李某之妻，30余岁。素日体壮无病，忽于某日上午挛急抽搐，齿握拳，不省人事，召余急诊，见：呼吸粗壮不匀，牙关紧闭，神志不清，触其腹硬而胀，脉实而大。急疏大承气汤一帖，令立即煎服。余亲自给患者掀齿喂药，约二时许，患者渐渐苏醒，全身诸症消失，即可下床自如活动。《名方广用》

251、【大承气癡狂数日不得大便】

甲寅岁四月初，予随翰耳朵行至界河里住。丑斯兀闾病五七日，发狂乱，弃衣而走，呼叫不避亲疏，手执潼乳，与人饮之。时人皆言风魔了，巫师祷之不愈而反剧。上闻，命予治之。脉得六至，数日不得大便，渴饮潼乳。予思之，北地高寒，腠理致密，少有病伤寒者。然北地此时乍寒乍热，因此触冒寒邪，失于解利，因转属阳明证，胃实谵语，又食羊肉以助其热，两热相合，是谓重阳则狂。阳胜宜下，急以大承气汤一两半，加黄连二钱，水煎服之。是夜下利数行，燥屎二十余块，得汗而解。翌日再往视之，身凉脉静。《卫生宝鉴·泻热门》

252、【大承气伤寒厥证口不能言目不得正视身体不动手足清冷】

一男子，年四十有余，热病十八九日，口不能言，目不得正视，身体不动，手足清冷。诸医以为阴证，与参附辈，不得寸效。余诊之，两脉如蜘蛛丝将绝。候其腹，脐下有物磊砢，乃作大承气汤饮之。通燥屎五六枚，诸症顿退。《古方便览》

253、【大承气大便干结五更咳嗽】李翰卿

靳某，男，8岁。1960年4月5日初诊。近1周来，每于后半夜咳嗽频作，咳有定时，多在五更时分，同时兼有气短，汗出，脐腹硬满拒按，大便干结，舌苔黄燥，脉弦滑而微数。诊为食滞肠胃，化火上冲于肺的大承气汤证。治宜通里攻下，釜底抽薪，兼以清理肺气。处方：枳实3g，厚朴3g，大黄2.5g，玄明粉1.5g（冲服），陈皮4.5g，柴胡2.5g，杏仁3g。1剂，水煎服。嘱咐患者，服第一煎后，会出现肚子拧痛，大便稀，日行1~2次，此为正常反应，应以流食调养。第二煎后，腑气大通，自觉上下通气，身轻气爽，次日五更以后咳嗽再未发作。《中国百年百名中医临床家丛书》

254、【大承气加槟榔腹痛二便闭】

曾香未客，患积热腹痛，医以疏寒消滞药迭进无效。痛极时大汗如雨，十指微冷，神昏

懒言，更请一医，见其形状，不究虚实，作阴寒治，拟投附桂理中。病者未敢遽服，延余诊视，脉沉而弦数，两颧赤，舌苔黄，口不渴，二便闭，胸腹胀痛，手不可按。以脉症细为推究，显属实热之象。但何得指冷大汗？因思内有实热，阳明痛极，必汗出指冷，其神昏懒言，乃痛难支持之故。若三阴虚寒之痛，必面青背曲，喜重按，下利，此为明辨耳。遂以大承气加槟榔攻之，一服二便通利，痛随利减，再剂胀痛如失，此正古人谓通则不痛之义也。《医案偶存》

255、【大承气汤急性肠梗阻】

全某，男，40岁。正值劳动时突然腹痛，蜷屈俯卧，嚎叫不已，抬至公社医院，诊为“急性肠梗阻”，因医院条件太差，不能施行手术救治。此时，余正在此地巡回医疗，应邀诊之。见：面赤身热，腹痛拒按，其脉洪大滑数，遂疏与大承气汤令速煎服。不足1小时，患者下床欲便，便后安然如常。《名方广用》

256、【大承气汤合调胃燥咳夜不安寐】

陈周溪，年近四旬，身体强盛，广德屠宰税经理，住本城。病名：燥咳。原因：时值秋燥司令，先患房事，后宴会，酒罢当风而卧则发咳。证候：干咳无痰，胸膈板闷，胃脘拒按，口干喜冷，日晡发热，夜不安寐。

诊断：六脉强直有力，舌苔黄燥。合病因脉象断之，乃肺燥胃实也。先以清燥化痰药投之，不应。继以消导豁痰药治之，转剧。此由时值燥令，胃肠积热化燥，燥火横行，宜其无济也。疗法：大承气汤合调胃法，君以苦寒荡积之大黄，佐以咸寒润燥之芒硝，臣以苦辛开泄之朴硝，少加甘草以缓硝黄之峻为使。处方：川锦纹一两（酒洗），川卷朴三钱，炒枳实三钱，玄明粉三钱，生甘草钱半。上药先煎，后纳玄明粉，俟玄明粉溶化，去滓顿服。效果：服一剂，下燥屎数十枚，其病霍然。改用清燥救肺汤二剂，以善其后。《全国名医验案类编·燥淫病案》

257、【大承气汤春温夹食头痛便秘烦躁谵语】

张修臣子，年十二岁，住广德北乡。病名：春温夹食。原因：初因伤风发热，头痛自汗，不寒而渴，余投以麻杏甘石汤加薄荷、银花，一剂即愈。后因误食鲫鱼半碗，其症复作，他医进以辛燥，病转剧。证候：目肿如桃，头痛如劈，烦躁谵语，大渴引饮，潮热自汗，小便短数，大便不通，胃脘拒按。诊断：脉象滑实，舌绛苔燥，合病因脉症参之，此胃实证也。疗法：以大承气汤原方，先煎枳、朴，继纳大黄，次入芒硝，盖取生者气锐而先行，熟者气钝而和缓之义，欲使芒硝先化燥屎，大黄继通地道，而枳、朴除其积滞，皆所以通泄大肠而逐热也。处方：厚朴五钱，枳实四钱，大黄四钱，芒硝三钱。以水三碗，先煮枳、朴取二碗，去滓，纳大黄，煮取一碗，去滓，纳芒硝溶化，顿服。效果：服一剂，下燥屎数十枚，诸恙霍然，即勿沾药。令以米饮调之，一周而愈。《全国名医验案类编·火淫病案》

罗按：所谓温病，是以温热所引发，此案以温热所致津液缺乏。

258、【大承气汤加大黄不寐】

陕西喻少川，久以开毡店居杭，体厚刚健，偏嗜炙煿，性躁动肝气，年逾五旬，终夜不寐者六年，用痰火气血之药多矣。早晨诊候，寸关洪浮有力，若坚实之象，惟两尺脉大。熟思之，以脉论，肥人当沉，今六脉洪浮有力；以症论，上身怕热，足反畏冷；以药论，清补俱已尽服。《难经》曰：人之安睡，神归心，魄归肝，意归脾，志藏肾，五脏各安其位而寝。且夜属阴主静，日属阳主动，阴阳和平，安然寤寐。此六年不睡，乃阳亢症也，当大泄其阳，使阴气渐复，则寐矣。用大承气汤加大黄二两，泄十余行，其人昏倦，睡数日方醒，进以粥食愈。《续名医类案·不眠》

罗按：大承气证：脉实，寸关洪浮有力。

259、【大承气汤、小陷胸汤治谵语发狂医案】：

一妇人，伤寒十余日，手足躁扰，口目动，面白身冷，谵语发狂。张令韶诊其脉全无，问其症不知，坐视良久，聆其声重而长，即作大承气汤灌服，至黄昏即下黑粪半床，次晨脉

出身热，人事已知，舌能伸出而黑。再进小陷胸汤二剂而愈。（《续名医类案》）

260、【大承气汤产后阳明病】

同乡姻亲高长顺之女嫁王鹿萍长子，住西门路，产后六七日，体健能食，无病，忽觉胃纳反佳，食肉甚多。数日后，日晡所，觉身热烦躁，中夜略瘥，次日又如是。延恽医诊，断为阴亏阳越。投药五六剂，不效。改请同乡朱医，谓此乃桂枝汤证，如何可用养阴药？即予轻剂桂枝汤，内有桂枝五分，白芍一钱。二十日许，病益剧。长顺之弟长利与余善，乃延余诊。知其产后恶露不多，腹胀，予桃核承气汤，次日稍愈。但仍发热，脉大，乃疑《金匱》有产后大承气汤条，得毋指此证乎？即予之，方用：

生大黄五钱，枳实三钱，芒硝三钱，厚朴二钱方成，病家不敢服，请示于恽医。恽曰：不可服。病家迟疑，取决于长顺。长顺主与服，并愿负责。服后，当夜不下，次早，方下一次，干燥而黑。午时又来请诊，谓热已退，但觉腹中胀，脉仍洪大，嘱仍服原方。实则依余意，当加重大黄，以病家胆小，姑从轻。次日，大下五六次，得溏薄之黑粪，粪后得水，能起坐，调理而愈。独怪近世医家遇虚羸之体，虽大实之证，不敢竟用攻剂。不知胃实不去，热势日增，及其危笃而始议攻下，惜其见机不早耳！

【按】王季寅先生作《产后之宜承气汤者》篇曰：“产后虚证固多，实证间亦有之，独怪世医动引丹溪之说，谓产后气血双虚，惟宜大补，虽有他证，均从未治，执此以诊，鲜不贻误。

余友王百安君于月前治一郭姓妇人。该妇于双产后，发狂见鬼，多言骂詈，不认亲疏。其嫂曾被其掐颈，几至惊毙。家人因使强有力者罗守之。遂延王君往诊，车至中途，病家喘急汗流奔告曰，病者角弓反张，口吐涎沫，现已垂危，后事均已备妥，特询还可医否？如不可医，毋徒劳先生往返也。王君答以果系实证，不妨背城借一，或可挽回，然未敢必也。及至病所，见病人反张抽搐，痰涎如涌，诊其脉，数而疾，因病者躁动，未得细诊。询以恶露所见多寡，腹中曾否胀痛，二便若何，该家惊吓之余，视病者如虎狼，此等细事全无人知。王君以无确凿左证，力辞欲去。病家苦求立方，坚不放行。王君默念重阳则狂，经有明文，加以脉象疾数无伦，遍体灼热，神昏流涎，在在均露热征。其角弓反张当系热极成痉。综合以上各点，勉拟下方。生石膏四钱，知母三钱，寸冬三钱，川连三钱，条芩三钱，阿胶三钱，白薇三钱，生地三钱，半夏三钱，木通三钱，枳壳三钱，大黄生三钱，粉草一钱，竹叶三钱。一剂，痉愈，躁动略安。复延往诊，病者固拒不令诊脉，询以大便情形，据云水泄挟有燥粪，遂为立大承气汤加桃仁丹皮，嘱其分三次灌之。如初次服后矢气，便为对证，可将余药服下。次日，病家来云，躁动若失，已能进食，惟仍狂言不寐。遂处下方：川连、炒栀子、条芩、杭芍、阿胶、云苓、茯神、远志、柏子仁、琥珀、丹皮、当归、生地、鸡子黄。据称服后熟睡竟夜，此后可以无虑。

其母因其灌药艰难，拟令静养，不复服药矣。似此病症，若仍以产后多虚，妄用十全八珍，或生化汤加减，岂不促其命期耶？”录《医界春秋》）按本证初起，似属桃核承气汤证，或竟抵当汤证。仲圣曰：“其人如狂，但少腹急结者，乃可攻之。”又曰：“其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞕满”是也。此二条，如狂与发狂异，急结与鞕满异，是其辨也，迨后角弓反张，当为大承气汤证。仲圣曰：“卧不着席，脚挛急，必齿介齿，可与大承气汤”是也。最后，狂言不寐，亦如仲圣所谓“心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之”之证。故用药近似，即可以起死回生。呜呼，此仲圣之所以为万世法也！此证甚剧，亦属产后，引之可与吾师原案互证。

曹颖甫曰：产后宜温之说，举世相传，牢不可破。而生化汤一方，几视为金科玉律，何怪遇大实大热之证，而束手无策也。大凡治一病，必有一病之主药，要当随时酌定，不可有先入之见。甚有同一病证，而壮实虚羸之体不当同治者，此尤不可不慎也。

261、【大承气汤加黄连阳明大实】

陈左，住马浪路十四岁。初诊：八月十七日，发热有汗，阙上痛，右髀牵掣，膝外廉痛，

时欲呕，大便不行，渴饮，舌苔黄燥，腹满，脉滑，阳明证备，于法当下，宜大承气汤加黄连。

生大黄四钱后入，枳实四钱，中朴钱半，芒硝三钱冲服，淡吴茱萸五分，细川连二分)

二诊：八月二十日拟方，下后，但见燥矢，阙上仍痛，时欲吐，痰多，是阳明燥气未尽，上膈津液化为痰涎也，宜小半夏加硝黄。

制半夏四钱，生大黄三钱后入，芒硝钱半冲，生姜五片。

【按】若仍用大承气汤加重厚朴，似亦甚佳，因厚朴并能去上湿也。

三诊：八月二十二日，进小半夏合承气，下后，热除，痛止，知饥。经食煮红枣六枚，顿觉烦闷，夜中谵语不休，甚至昏晕。此特下后肠中燥热上熏脑部，而又发于下后，要为本根毒热，不足为患。夜不能寐，当用酸枣仁汤加減。

酸枣仁五钱，辰砂五分，潞党参三钱，知母三钱，天花粉一两，生姜三片，红枣三枚。

【按】本汤之用，似不得当，盖此时热势方稍稍受折，转瞬当复炽。观其仅服红枣六枚，即转为谵语昏晕，不可终日，可以知矣。酸枣仁汤功能安和神经，使人入睡，为病后调理之良方，而不宜于此热势嚣张之时，故服后少效，宜其然也。或者当时病家见两服硝黄，遂惧病者虚脱，故乃愚师用此似较平稳之方欤？

四诊：八月二十三日拟方，阳明之热未清，故尚多谵语，阙上痛，渴饮，宜白虎汤加味。

生石膏八钱，知母四钱，生甘草二钱，天花粉一两，洋参片五钱，滑石六钱，粳米一撮，牡蛎二两生打先煎)

五诊：八月二十四日，服人参白虎汤加味，渴饮，阙上痛定，夜无谵语，今尚微渴，饮粥汤便止，仍宜前法。

生石膏一两，知母三钱，生草三钱，天花粉一两，北沙参八钱，潞党参五钱，块滑石一两，左牡蛎二两(先煎)

拙巢注：此证不大便二十余日，始来就诊，两次攻下，燥热依然未尽。予所治阳明证未有若此之重者，自十七日至今，前后凡八日，方凡五易，始得出险。此与三角街吴姓妇相似，盖郁热多日，胃中津液久已告竭也。

曹颖甫曰：此证下后，湿痰未去。二诊悬拟方，因病家来告贫苦，减去厚朴，以致湿热留于上膈。三诊，但治不寐，未尝顾及阳明实证。下后胃热未除，以致病根不拔，诚如佐景所言。盖胃不和，固寐不安也。附志于后，以志吾过，而警将来。曾记八年以前，同乡周巨臣绍介一汪姓病人，初诊用生大黄四钱，厚朴二钱，枳实四钱，芒硝三钱，其人病喘不得眠，壮热多汗，脉大而滑，下后稍稍安眠，而时吐黄浊之痰，予用承气汤去大黄加皂荚末一钱，二剂而愈，与此证相似，并附存之。

262、【大承气汤恶寒发热，小便淋涩，大便不行】名医类案：

虞恒德治一人，三月间得伤寒证，恶寒发热，小便淋涩，大便不行。初病时，茎中出小精血片，如枣核大，由是众医皆谓房事所致，遂作虚证治，而用补中益气等药，七八日后，热愈甚，(用补而热愈甚，当思转矣。)大渴引饮，胃中满闷，语言错乱。召虞诊视，六脉俱数甚，右三部长而沉滑，左手略平，亦沉实而长。虞曰：此大实大满证，证属阳明经，宜大承气汤。众皆惊愕，虞强作大剂，连进二服，大泻后，热退气和而愈。十日后，因食鸭肉太多，致复热，来问虞，教用鸭肉烧灰存性，生韭汁调下六七钱，下黑粪一碗许而安。

263、【大柴胡合桂枝茯苓丸加生石膏汤哮喘医案】胡希恕：

康某，男，36岁，中学教师。初诊1964年4月29日：三年前因食青辣椒而引发哮喘，始终未离西药治疗迄今未愈，冬夏无休，每次发作，常因偶尔咳嗽或喷嚏引发。自觉消化不好，大便干燥即为将发之预兆。发作时喘满胸闷，倚息不得卧。曾在长春、沈阳、哈尔滨等各大医院治疗均不见效而来北京治疗。来京亦多处求医，曾用割治疗法，两侧颈动脉体手术等疗法，皆毫无效果。又多处找名中医诊治，一名中医以宣肺定喘、补肾纳气等方药治疗7个多月，证有增无减，并告之：“伤色太甚，虚不受补。”颇感精神痛苦，以致绝望。计近

故里等死，后听别人介绍，到胡老这里最后一试。现在症状：喘闷，胸腹胀满，昼轻夜重，晚上哮喘发作，倚息不得卧，大汗淋漓，口干，便秘，心中悸烦，眠差易醒，舌苔薄白，脉沉缓。据证与大柴胡合桂枝茯苓丸加生石膏汤：

柴胡四钱，黄芩三钱，半夏三钱，生姜三钱，枳实三钱，炙甘草二钱，白芍三钱，大枣四枚，大黄二钱，桂枝三钱，桃仁三钱，茯苓三钱，丹皮三钱，生石膏一两半。

二诊 5 月 3 日：上药服第二剂后，症状减轻，服第三剂时，大便通畅，哮喘已，胸胁满、腹胀、心中悸烦均不明显，已不用西药氨茶碱等，上方继服三剂。

三诊 1966 年 9 月 25 日：出差来京，告知病情，两年来曾数次感冒咳嗽，但未出现哮喘。

264、【大承气汤治不寐不大便】姜春华

战某，男，38 岁。初诊：1982 年 3 月 4 日。连续失眠 10 余日，彻夜不寐，服大量安眠药无用，痛苦不堪。面红目赤，大便不通多日，舌苔黄厚，脉大。用大承气汤。处方：大黄 9g，芒硝 6g，枳实 6g，厚朴 9g。仅服 1 剂，腑通，当夜酣然入眠。《内科名家姜春华学术经验集》

265、【大承气汤经年头痛】

吕某，女，50 余岁。患头痛十多年，间作间止，经断续治疗未愈。因该形体较消瘦，前医多以虚证论之，偏以补气、补血，或气血双补之法，虽经医甚多，但十数年来未见显效。据诉，头痛多发生在盛夏，或受热、着风、情绪不佳而引起。初诊时正在发病，正额头痛如劈，痛苦万状。面部自觉灼热，汗出，口干，舌燥，渴而能饮，大便三四日未解，小便短赤，脉实大，舌质赤老苔，有芒刺。证属阳明实热，腑气不通，上冲头部。服大承气汤 1 剂，解下燥粪少许，头痛稍有好转，脉舌如前。考虑药轻病重，未能彻底攻下。再投原方，服后次日泄下燥粪甚多，恶臭异常，其中并夹杂有紫血块，头痛及诸症十去其八九。续服增液承气汤而愈。随访 2 年未复发。《经方发挥》

266、【大承气汤高热谵语，泻水恶臭】

单某，男，57 岁，1974 年 11 月 5 日初诊。高热 10 余日不退，体温 39℃~39.7℃，在某医院住院，拟诊为肠伤寒，但未查出伤寒杆菌，故未确诊。经用多种抗生素治疗，高热不退，邀余会诊。患者壮热神昏谵语，舌苔黄燥，脉沉实，但已腹泻多次，泻出污水奇臭难闻，腹部坚硬拒按。辨证：阳明腑实，热扰神昏。立法：泻热攻结，急下存阴。方药：大黄 25g，芒硝 25g（冲），枳实 20g，厚朴 20g。水煎，2 次分服。11 月 6 日复诊：遵嘱服药 1 剂，于当日夜间燥屎 10 余枚，坚硬如石，高热渐退，神志转清，继服 1 剂。11 月 7 日三诊：服药后又下燥屎及稠状粪便甚多，奇臭难闻，热退神清。此燥屎已尽，腑实已除，宜以养阴和胃之剂善后调理。《张琪临床经验辑要》

按语：本例壮热神昏，舌苔黄燥，脉沉实，据此脉证，辨为实热内结，扰及神明，耗伤阴津，欲用急下存阴之法，投泻剂治之。但其陪护家属及经治医生皆曰病人已腹泻多次，担心不堪再泻。余以手触其腹部硬满拒按，察视病人泄泻，见其泻下污水奇臭难闻，知乃阳明腑热，燥屎已成，而致热结旁流，不急下之不可救其危。故以“通因通用”之法，用大承气汤投之。果然其效如鼓应桴。

267、【大承气汤痢疾】

北门内杨姓妇人，年七旬，禀赋甚厚。六月患痢一月未瘳，某医用十全八珍等汤，服十帖不愈。请余诊治，六脉有力有神，年虽老确属实证，如贼在室，理应驱逐，用大承气汤一帖，泻下燥屎如核桃大五六枚，饮食大进，不治痢而痢自止。《湖岳村叟医案·痢疾门》

268、【大承气汤伤食腹痛】

杨某，男，38 岁，1961 年 12 月 14 日初诊。主诉腹痛 2 天。前天晚上从外地回京，腹中饥饿，即急食米面蒸糕约半小盆，食后即睡，未盖被而受了凉。次晨即觉上腹部及脐左处疼痛，胃脘痞塞胀满，不思饮食，小便短赤，大便 3 日未行，今日疼痛难忍，急来就诊。观其舌苔白，脉象弦滑有力。上腹及脐左处疼痛拒按。白细胞计数 11.7×10⁹/L，分类：中性粒

细胞 0.86。据此脉症诊为食滞腹痛。治以消导攻下之法，以大承气汤随证加减，处方如下：酒军 12g，枳实 12g，厚朴 9g，芒硝 6g（后下），焦槟榔 9g，焦三仙各 9g。水煎服 1 剂。立即针合谷、内关、商阳、天枢四穴，不留针，以迅速止痛。药后排出稀臭大便两次，胃脘及脐部之疼痛完全消失，病即痊愈。以后随访，腹痛未作。《焦树德临床经验辑要》

269、【大承气汤伤寒误补发咳逆】

一人，病伤寒阳明内实，医以补药治之，而发咳逆。十日后召虞诊，其脉长而实大。与大承气汤大下之，热退而咳亦止。《名医类案·咳逆》

270、【大承气汤治痢疾下利便浓血医案】

马某，男，38 岁。夏秋之季因染痢疾，日下 20 多次脓血便，里急后重，腹痛阵阵，发热而渴。前医给予中西药治疗，次日痢止。但隔日又现腹痛大作，发热欲吐，口干渴，里急后重，欲便不能，痛苦万分。诊其脉数而有力，苔黄厚，舌质红。此是因痢虽止，但湿热之毒郁于胃肠，无所出处。投以大承气汤 1 剂，泻下数次脓血便，次日诸症若失。《经方发挥》

271、【大承气汤腹部胀满拒按便秘】

赵某，男，50 岁。平素体健，偶然感到胸腹满闷，食后尤甚，一二日后，病情逐渐加重，继则喘息，抬肩不得卧，腹部胀满、拒按，3 日未解大便，身热，口渴能饮，小便短赤，汗出。诊得脉象实大而数，苔黄厚腻，投以大承气汤。大黄 12g，厚朴 12g，枳实 12g，芒硝 10g，加瓜蒌 15g。服 1 剂后，泻下粪便颇多，喘息随之而愈。《经方发挥》

272、【大承气汤治宿食积滞】

李某，男，23 岁。饮食不节，暴饮暴食，致胃中宿食 1 月之久，症见食欲不振，口渴能饮，大便不利，小便短赤，日晡手心潮热，胸下及少腹疼痛拒按，脉洪大而数，舌质红，老苔。经服大承气汤 1 剂，大便泻下数次，3 日后痊愈。《经方发挥》

273、【大承气汤治少腹积块】

一患者，女，40 岁，患病半年，身体很虚，骨瘦如柴，饮食难进，胃腹胀满，胸满喘促，大便不通，曾经多方医治。医者一见此状，即断为虚证无疑，或谓气虚，予以补气；或谓血虚，予以补血；或认为气血均亏，拟以双补；或给止喘之西药；或谓腹中有恶性病变。诸说纷纭，莫衷一是，辗转治疗半年，无寸效。诸医束手，患者待毙。后经友人介绍延余诊治，细观其诸症，虽然一派虚弱之象，但少腹部可触及积块，自觉下坠疼痛，常以两手扶持，方能行动。舌苔黄厚，脉尚有力。又阅前医药方，皆为峻补之剂，余告病家，此为虚中夹实，虽身形虚羸至极，但胃肠结有实邪，阻碍其脾胃消化吸收之功能。此时水谷尚自不能运化，安能吸收补养之药乎？前医只知其虚象，未见其实邪，即使有人虑及其实，在此种情况下，也不敢用泻下攻克之剂，屡用补剂，致肠胃之实更实，气血之虚愈虚。遂给以大承气汤 1 剂。

服药约 2 小时后，开始腹痛，难以忍耐，举家惶惶，以为用药有误。余告曰：此是药力所致，再过片刻必有发作。果应我言，过 2 小时后，腹痛肠鸣加剧，泻下数次，量颇多，皆为各色污秽之物，秽臭异常，泻后顿觉浑身轻快，即思饮食，腹畅喘平，腹中积块消失。次日即能进一小碗面条，随后给予健脾补气之品调补，病情日趋好转，继而痊愈。《经方发挥》

274、【大承气汤治重感冒后目不了了】

韩某，男，21 岁。于 8 个月前，患重感冒，经治愈后，遗眼睛视力不佳。患者口干，舌燥，喜饮，溺短，便燥，脉大而实。据此脉证，为热邪伏里，灼伤津液，不能上润于目所致的“目不了了”“睛不和”。宗仲景启示，以大承气汤试之，詎料应手取效，两剂而愈。以后凡遇到热邪伤津而致的视力不佳，眼光蒙眬缭乱的患者，投以大承气汤，大多能收到满意的效果。《经方发挥》

275、【大承气汤治暴发火眼】

刘某，男，18 岁。于 1 周以来，患目睛红、肿、涩、痛，迎风流泪，怕光羞明，奇痒难忍，先服疏风清热之剂未效，后治以大承气汤，1 剂而愈。《经方发挥》

276、【大承气汤治产后身热口渴腹痛胸满便秘耳聋医案】

刘式聪乃室，年逾四稔，体强，住西乡石牛。病名：胃肠实热。原因：初患温热，又复

生产，邪热乘虚而陷入阳明，遂成实热之症。证候：单热不寒，舌黑口渴，两耳无闻，腹痛胸满，大便旬余不解。诊断：脉左手沉数，右手沉实。脉症合参，此手足阳明实热证也。疗法：急则治标，仿仲景治产后实热例，用大承气汤以夺其邪。下后，即用归、芍、地以养其血，元、麦、生草以滋其液，治分标本先后，庶无实实虚虚之弊。处方：生锦纹三钱，芒硝钱半，川朴一钱，枳实一钱，水六杯，先煮枳、朴，后纳硝、黄，煮取三杯，分二次服，一剂知，即勿服。又方：当归身三钱，大生地四钱，生白芍三钱，元参钱半，破麦冬三钱，生甘草八分。效果：一日大便利，耳能闻，舌黑退，胸腹舒。改服次方，旬余就痊。《全国名医验案类编·火淫病案》

277、【大承气汤加附子治腹痛医案】

一人于六月投渊取鱼，至秋深雨凉，半夜小腹痛甚，大汗。脉沉弦细实，重取如循刀责然。于大承气汤加桂二服，微利痛止。仍连日于申酉时复痛，坚硬不可近，每与前药，得微利，痛暂止。于前药加桃仁泥，下紫黑血升余，痛亦止。脉虽稍减而责然犹在，又以前药加川附子，下大便五行，有紫黑血如破絮者二升而愈。又伤食，于酉时复痛，在脐腹间，脉和，与小建中汤，一服而愈。《名医类案·腹痛》

278、【大承气汤潮热谵语五日不大便医案】：

谢某，潮热谵语，五日不大便，腹痛拒按，舌苔黄燥，脉象沉实。张耀裕先用小承气汤试探，服后腹中转矢气，乃改用大承气汤攻之，一剂即便通病减，再剂而愈。（《函讯》）

279、【大承气汤目肿如桃头痛如劈医案】：

张子，目肿如桃，头痛如劈，烦躁谵语，潮热自汗，大渴引饮，腹胀拒按，大便不通，小便短数，舌绛苔燥，脉象滑实。钱存济用大承气汤一剂，下燥矢数十枚而愈。（《全国名医验案类编》）

280、【大承气汤目肿如桃头痛如劈医案】邢锡波：

于某，女，14岁，学生。病史：初因伤风发热，头痛自汗，恶寒心烦，余以麻杏石甘汤加银花、连翘1剂而愈。后因食肉过多，病又复发，初起目肿如桃，头痛如劈，烦躁谵语，大渴引饮，潮热自汗，小便短涩，大便不通，腹胀拒按，舌绛苔燥，两脉滑实。证属：阳明燥实。治宜：泄热通下。处方：生大黄12g，厚朴12g，芒硝10g，枳实10g。服药1剂，下燥屎数十枚，诸症霍然痊愈。后以清热和胃之剂，调理而愈。

281、【大承气汤大便不通脉洪大而长医案】：

李某，伤寒五六日，身热无汗，大便不通，脉洪大而长。许叔微投以大承气汤，病者因年高但服其半，不应。许询知后，乃亲视再进一剂，不半时，先下燥矢十数枚，继而溏泻一行，臭秽不可近，旋即汗透周身，一时顷，汗止身凉而愈。病人求补剂以善其后，许叔微谓服大承气汤得瘥，不宜服补剂，补则热复，但糜粥自养可耳。（《伤寒九十论》）

282、【大承气汤四肢俱冷，六脉俱无医案】：

一人伤寒九日，口不能言，目不能视，体不能动，四肢俱冷，六脉俱无，但按其腹，则病者以手护之，眉皱作楚，按其趺阳大而有力，李士材用大承气汤下燥矢而愈。（《续名医类案》）

283、【大承气汤阙上痛大便八日不行医案】：

方男，病延二候，头晕，阙上痛，渴饮，大便八日不行，脉实，而胸痛彻背。曹颖甫用大承气汤加瓜蒌实，一剂得下，胸膈宽舒，惟余邪未净，头尚晕，乃去硝、黄，再剂而愈。（《经方实验录》）

284、【大承气汤右髀牵掣膝外痛腹满不大便医案】：

陈男，发热有汗，阙上痛，右髀牵掣膝外痛，渴饮，时欲呕，腹满不大便，舌苔黄燥，脉滑。曹颖甫用大承气汤加吴茱萸、黄连，虽下燥矢，而阙上仍痛，仍时欲呕而痰多，改用小半夏汤加硝、黄，下后痛定呕止知饥，因自食红枣数枚后，顿觉胸闷，夜中谵语昏晕，改用酸枣仁汤加减，病益剧，谵语不止，阙上复痛而渴饮，乃用白虎汤加洋参、花粉、滑石、牡蛎，服后阙上痛定，渴饮渐止，夜无谵语，守原方再进而愈。（《续名医类案》）

285、【大承气汤按脐则痛医案】：

一人伤寒五日，下利不止，按脐则痛，懊，目胀，脉沉数。李士材认为协热下利，中有燥矢，用小承气汤倍大黄予之，果下燥矢而愈。（《续名医类案》）

286、【大承气汤壮热头汗出大便闭医案】：

吴妇，病六七日，壮热，头汗出，大便闭，而腹不胀满，满头剧痛，不言语，目张瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，脉大。曹颖甫急投大承气汤一剂而愈。（《经方实验录》）

287、【大承气汤脐周阵发性疼痛伴吐蛔医案】何语金：

胡某某，男，10岁，1979年8月13日诊。5天前患儿因脐周阵发性疼痛伴吐蛔，在校医务室服“宝塔糖”10个，第二天早晨感腹部呈持续性胀痛，伴恶心呕吐，急送某卫生院就诊。该院以“肠蛔虫”病给予肌注“654—25”毫克、非那根25毫克及补液、消炎药治疗，4天来，病情未见好转，且逐渐加重，遂请余诊治。证见：急性重病容，发热，脘腹胀满疼痛，拒按，烦躁不安，手足抖动，几天未进食，水入即吐，口渴，下痢稀水，小便短赤，舌苔黄厚，脉滑数。证属阳明腑实，予大承气汤急下之。药用：

枳实10克，厚朴6克，生大黄12克，芒硝15克。以朴、枳先煎。大黄后下，芒硝兑药水冲服，1日1剂。

服1剂后，患儿即解出少量硬大便，并下死蛔虫数十条，腹胀痛有所减轻，继进1剂。8月15日复诊：腹痛消失，稍感脘腹胀满，大便日4行，并又下死蛔虫数十条，发热烦躁已除，能进食少量稀饭，倦怠乏力，舌质淡红、苔薄白，脉细无力。此脾胃气虚，给柴芍六君子汤治之，并配合西药补液、消炎治疗，5天后痊愈。（湖南中医杂志1987）

288、【趺阳大而有力乃知腹有燥矢大承气汤伤寒厥证】

一人伤寒，九日以来，口不能言，目不能视，体不能动，四肢俱冷，咸谓阴症。诊之，六脉皆无；以手按腹，两手护之，眉皱作楚；按其趺阳，大而有力，乃知腹有燥矢也。欲与大承气汤，病家惶惧不敢进。李曰：吾郡能辨是症者，惟施笠泽耳。延诊之，若合符节。遂下之，得燥矢六七枚，口能言，体能动矣。故按手不及足者，何以救此垂绝之证耶？《续名医类案·伤寒》

289、【大承气汤治发热口渴咳嗽不大便但见白睛黑睛全无医案】黎庇留：

黄某某，15岁。四日患发热，口渴，咳嗽，大便三四日一行，十余日不愈，始延余诊。以大柴胡汤退热止咳，五月四日热退尽，可食饭，惟青菜而已。六日晚，因食过饱，夜半突然腹痛甚，手足躁扰，循衣摸床，肆咬衣物，越日午刻延诊。诊时手足躁扰，惕而不安，双目紧闭，开而视之，但见白睛，黑睛全无，其母骇甚，惊问何故？余曰：“此阳明悍热也，悍滑疾之气上走空窍，目系为其上牵而黑睛为之抽搐，故只见白睛也。”其母曰：“可治否乎？”余曰：“急下则可医，如救焚之救，稍缓则无及也。”即立大承气汤一剂，嘱其速煎速服，务必大下乃有生机。其母畏惧，留余座医。三时服药，四时未下，再与大承气汤一剂，五时依然未动，再照此方加重其量，七时许，腹中雷鸣，转矢气，知为欲下之势，当乘机直鼓而下，惟大承气汤已服数剂，始欲下而未下，遂嘱其将全数药渣煮，半敷脐上，半熏谷道。不及二十分钟即下泥浆状黑粪一大盆。

一般大承气所下为水，此连服数剂而仅下泥浆，其悍热之凶险可知。下后，手足安静，宁睡一宵。次早诊之，人事虽醒，两目依然白睛。悍热已退，大势安定，毋庸再下。但热极伤阴，燥极伤络，阴伤无以荣筋，故目系急而睛未下耳，当清热养阴为要。遂拟竹叶石膏汤去半夏加竹茹，或黄连阿胶汤，或芍药甘草汤加竹茹、丝瓜络，交替煎服，十五日黑睛仅露一线，十六、七日再露一半。十八日晨，黑睛全露，并能盼顾自如，再调理数日而愈。（《经方临证集要》1983：98~99）

290、【大承气汤治多食多便舌苔中黄厚而燥医案】周凤梧：

赵某某，女，32岁。因病住铁路医院内科病房前后达一年之久，先是内服西药，后又经该院中医科会诊，服中药十数剂，仅睡眠稍有好转，其它诸证均乏效验，于1963年3月出院。出院时经内科确诊为“神衰、肝炎、内分泌失调、胃神经官能症（似柯兴氏综合征）”。4月6

日迎余诊治：症见多食多便，每日进餐十余次，甚至口不离食，不吃则心慌无主，日食量达3斤半许……且食后即感腹隐痛而里急，每天入厕亦达十余次之多，所便量少，再便辄晕厥，少时自苏，故入厕必须有人扶持。面胖如圆月，色现晦滞，腹大似鼓，肢体丰硕，体重大增，经常心悸失眠，胸闷腹胀而气短，右胁疼痛，头目眩晕，只能多卧少坐，无力下榻活动。脉见右缓、左沉涩，舌苔中黄厚而燥。

生大黄9克，姜川朴4.5克，炒枳实4.5克，元明粉3克，生甘草6克，水煎频服。

上方连进4剂，每天大便8至10数次。续服4剂，大便逐渐减为3次，均系软便挟有脓污胶质，食量次数均减少，惟便时排泄迟钝，约半小时方可。守方进药至4月17日，大便下一块状物，长可达尺，色黑如酱（医者未查系何物），觉腹内轻舒，但多食一症，去而不彻。（山东中医学院学报1977；〈3〉：49）

291、【大承气汤治腹部膨胀如鼓腹硬拒按肠梗阻医案】张仁宇：

张某，男，57岁。因急腹痛四日，于1959年5月6日求治。无热，初起呕吐频频，均为胃内容物。现仅见干呕，渴欲饮水。饮后而吐，因此病人畏惧饮水。大便已三日不解，小便一日内点滴全无。精神萎顿·唇干舌绛，被黄燥苔，口喷臭气，上腹部膨胀如鼓，腹硬拒按，脐下有一黄瓜状物，压痛明显。听诊：隆起处时有金属音及水过气声发生，发生时剧烈绞痛，呼号甚惨。面色苍白，头汗淋漓，四肢厥冷·脉弦紧数。诊为“肠梗阻”，《外台秘要》列为“关格，嘱住院开刀。因病人家境困难，年老病重，无法开刀，为处一方：

大黄15克，芒硝15克（冲服），厚朴9克，枳实9克，蒺苈30克（细捣），法半夏9克。煎药两碗。

服第一碗，本未呕，因饮水作呛，呕出大半。又缓服第二碗，病人感腹部大痛。听诊得水过气声如潮，其后疼痛逐渐消失。后下硬粪块，然后稀便，腹部大舒松。夜半，病人饥饿索食，喝稀粥一碗入睡，后调理而愈。（中医杂志1963；〈9〉：27）

按语，本案二便俱备，类似中医之“关格”证。脉证所见，乃燥屎内结，故予大承气汤一剂通导而愈。

292、【大承气汤治睡中遗尿医案】秦亮：

患儿，女，8岁4个月，于1987年8月2日初诊。二年来睡中遗尿，一夜三四次，甚则五六次，每因腹胀便秘而遗尿加重，曾服缩泉丸及桑螺蛸散数十帖，治疗罔效。平素小便臊臭，色黄量少，大便干燥，三四日一行，面赤唇红，舌苔薄黄，脉滑数。证属里热炽盛，大腑腑气失畅，肺气失宣，以致膀胱气化失职。拟方通腑缩泉，大承气汤加味治之。处方：

厚朴10克，枳实10克，生大黄8克（后下），芒硝6克（冲服），桑螺蛸10克，益智仁10克，炙甘草6克。

服药一帖，大便畅通，解稀大便五六次，小便气味明显改善，色亦转清，当天夜间遗尿减至二次，原方继进一帖，遗尿已止。转投益气养阴剂，以善其后，随访半年，遗尿未作。（天津中医1989；〈5〉：45）

293、【大承气汤治下腹压痛医案】李素卿：

寇某，男，11岁，1985年9月8日初诊。患儿持续高热8小时，伴阵发性腹痛，恶心、呕吐1次，而来就诊。曾有不洁饮食史。体温40.2℃，痛苦表情，舌尖红，苔黄腻·咽不充血，心肺正常，下腹压痛，以左下腹较为明显，可触及条索状物。大便常规：白细胞10~15，诊为“痢疾”。证属食积内停，生湿化热，湿热挟滞，互阻肠胃，通降失司。治宜通腑导滞，清热利湿。方用大承气汤：

生大黄10克（后下），玄明粉10克（冲服），枳实6克，厚朴6克。1剂，水煎服。

复诊：昨天药后，第1次大便开始为脓血便，后为稀便，以后连续3次水样便，量多，其味臭秽，入暮身热已解，夜间再未解大便，已能上学。（广西中医药1987~〈2〉~11）

294、【大承气汤治午后壮热大便秘结医案】熊寥笙：

张某，男，3岁。患儿受凉伤食，发热汗出，气逆咳嗽，病已七日。曾服疏表理肺之剂

数剂，病仍不解，每日午后壮热尤甚，彻夜咳嗽不休，不能合目。小便黄少，大便秘结三日。舌苔微黄而燥，指纹色紫，脉滑数。此表邪不解，入里化热，而成阳明燥实之候。当上病下取，釜底抽薪，急下存阴以拯津液，宜大承气汤急下之。

大黄 6 克，枳实 3 克，厚朴 6 克，芒硝 6 克，玄参 3 克，甘草 3 克，水煎服。

上方服 1 剂，当晚咳嗽大减，能食入睡，翌晨得大便，下燥粪一次，午后咳嗽，高热亦平，竟 1 剂收功。(重庆医药 1975)

295、【大承气汤治牙龈红肿充血便秘医案】王国勤：

张某某，女 23 岁。于 1988 年 2 月患牙痛，头痛头昏，不思饮食，痛不得眠。检查：牙无龋齿，左下第 1、第二磨牙牙龈红肿充血，予青霉素、庆大霉素、安痛定注射五天无效，要求中药治疗。询知病人腹胀，四天没解大便，腹下可扪及硬结粪块。中医辨证：热结阳明、风火牙痛。即用大承气汤 2 剂，服第一剂后解下燥屎十余枚，腹胀大减，牙痛减轻，得眠；第 2 剂后续之泻下恶臭大便，周身舒服，牙痛止，告愈。(新中医 1990；〈3〉：44)

296、【大承气汤治咽痛医案】秦亮：

医案：余某，男，5 岁，于 1987 年 9 月 4 日初诊。其母代诉：咽痛 3 天，在当地医院予肌注青霉素、口服六神丸治疗，效果不显。刻下吞咽不利，喉核红肿，不咳，口臭，烦渴喜冷饮，纳少，小便色黄，大便干结，4 日未行，舌质红、苔黄厚，脉滑数。查：体温 38.6U，咽部充血，两侧扁桃体 I。肿大。血检：白细胞 12400，中性 74，淋巴 26。治宜通腑泻火，方选大承气汤：

生大黄 8 克(后下)，厚朴、枳实各 10 克，芒硝 6 克(冲服)。

1 帖后泻下热臭便 4 次，热度正常，咽痛明显减轻，饮食见增，前方去芒硝，加玄参、麦冬各 10 克，继进 1 帖而收功。(陕西中医 1989)

297、【大承气汤治口腔溃烂医案】秦亮：

陆某，女 5 岁，于 1987 年 10 月 29 日初诊。病起 3 日，舌尖及颊内见有 7 枚黄白色的溃烂点，大小不等，疼痛拒食，烦躁，口臭流涎，溲赤便秘，舌红、苔黄腻，脉滑数，体温 37.5℃，曾用西药治疗罔效。血检：白细胞 10600，中性 72，淋巴 28。治宜通腑泻火，方投大承气汤。药服 1 帖，解稀便 5 次，其味热臭，烦躁止，口臭除。前方去大黄、芒硝，加连翘 10 克，川连 1.5 克，继服 1 帖，口疮已愈。(陕西中医)

298、【大承气汤腹胀拒按口气臭秽医案】覃海能：

陈某，男，59 岁，1983 年 7 月 13 日入院。头痛且胀 2 天。1977 年以来血压波动在 150/170/90~98 毫米汞柱，时觉头晕而胀，平时间歇自服复方罗布麻等药。前晚因暴饮，头痛且胀，口苦口干，纳呆，腹胀眠差，大便 3 日未解，小便短赤。检查：血压 192/110 毫米汞柱。痛苦病容，面红体壮，腹胀拒按，口气臭秽，舌红苔粗黄，脉弦数。西医诊断：原发性高血压。中医辨证，阳明腑证，肝火上扰。专用中药治疗，治宜先攻下实热。方选大承气汤：

大黄 15 克，厚朴 12 克，枳实 15 克，芒硝 10 克。1 剂。煎取 250 毫升，分 2 次服。

次日解稀烂便数次，腹胀大减，血压降至 132/94 毫米汞柱，后改用平肝潜阳法调治。于第 7 天症状消失而出院。(广西中医药 1985)

299、【大承气汤治麻疹医案】陆安铝：

周某某，男，46 岁，1973 年 11 月 13 日诊。因食鱼蟹，当夜全身出现大小不等淡红皮疹，搔痒难忍，伴有发热、头晕、纳呆、腹痛、舌红苔黄腻，脉弦数，诊为荨麻疹后，用扑尔敏等药未效，即以大承气汤攻下：生大黄(后下)、元明粉(冲)各 12 克，枳实、制川朴各 9 克。

1 剂后，泻下稀便，疹块顿时大减；次日再进 1 剂而愈。(浙江中医杂志 1983)：

罗按：荨麻疹的形成机理，一个是血液中有水毒，二是水毒透于表，而不能出。用大承气汤，清水毒形成之源头胃肠。发热、腹痛不大便，热结成实故也，此皆辨证论治。

第二十章 大柴胡汤证

300、【大柴胡汤治精神分裂症颜面痤疮医案】曾荣修：

白某某，女，20，住华西大西园宿舍。1975年8月23日，初诊：其母伴随，耳语告知：患精神分裂症，曾住院二次，医药从未间断，并患有肝炎，目前肝区痛，胃脘胀，大便秘结。常服番泻叶，胃酸呃逆欲呕，烦躁、失眠、停经五月有颜面痤疮，有慢性咽炎、痰多、恶热、汗多。脉弦滑偏数，苔黄腻。

症属：少阳阳明。治宜：双解二阳。

方一：银翘马勃散加味

方二：柴胡25g，半夏10g，黄芩10g，枳实10g，白芍10g，生大黄6g，大枣10g，生姜10g，三付。

1975年9月2日，二诊，服药后每日泻三、四次，矢气多，汗仍多，但减少些，恶热，思凉饮，睡眠好转，但仍服安眠药，小便灼热，脉弦滑偏数苔黄减。原方加桃仁10g，红花10g，滑石20g，三付。

1975年9月8日，三诊，最近大便一直通利，溲已不灼热，颜面痤疮愈，肝区仍痛，腹胀痰多不爽，烦躁，汗仍多，苔白微腻，脉弦滑偏数

原方去滑石加瓜蒌15g，三付。

以后一直用大柴胡汤加桃仁、红花为主，随症略加一、二味共服三、四十付，诸症悉愈，月经已来，以后已结婚生子，也参加某校工作。此精神分裂症曾住院两次，按该病情治之为何不效，该病人除少阳兼阳明证外，更兼有热入血室一派实证，而正气不虚，故小柴胡汤去人参、甘草，以免缓中留邪，因实邪继滞，心下满故用大黄，枳实攻泻热结，芍药敛阴和营，缓心下急痛，为外解少阳，内泻热结，该病人加之热入血室，血蓄不行，故令人发狂，月经不行，痰多，及颜面痤疮，加瓜蒌之后，痤疮自愈。

301、【大柴胡汤兼用当归芍药散治腹中痛大便难通】吉益南涯：

某者，尝患腹痛，腹中有一小块，按之则痛剧，身体尪羸，面色青，大便难通，饮食如故，乃与大柴胡汤，饮之岁余，少差，于是病者徐怠慢，不服药，既经七八月，前症复发，块倍前日，颇如冬瓜，烦悸喜怒，剧则如狂，众医交疗而不差，复请治。先生再与以前方，兼用当归芍药散，服之月余，一日大下异物，其形状如海月，色灰白，似囊，内空虚，可盛水浆，其余或圆或长，或大或小，或似纽，或黄色如鱼馁，或如肉败，千形万状，不可枚举。如此者九日，而后旧疴顿除。

【注】鱼馁者，鱼肉腐烂之谓。如鱼馁、如败肉者，即不外为瘀血也。以是得知当归芍药散有驱瘀血之作用，又可知男子亦有瘀血也。

第二十一章 防己地黄汤证

【原文】：病中风，如狂状，妄行，独语不休，无寒热，其脉浮者，宜防己地黄汤。（依涪古本补）

赵以德曰：狂走谵语身热，脉大者，则阳明。若此无寒热其脉浮者，血虚从邪并于阳而然也。《内经》曰：“邪入于阳则狂”，此狂者谓五脏阴血虚乏，魂魄不清，昏动而然也。桂枝、防风、防己酒浸其汁用，是轻清归之于阳，以散其邪。用生地黄之凉血补阴，熟蒸以归五脏益稍养神也。盖药生则散表，熟则补衰，此煎煮法也，又降阴法也。阴之不降者，须少升以提其阳，然后降之方可下。不然则气之相并，不得分解矣。

徐忠可曰：此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滞涎，涎滞则留湿，湿留雍火邪聚于心。故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火，凉血热。谓如狂妄行独语不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚不疑耳。后

人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。

防己地黄汤方：

防己、甘草各一分，桂枝、防风各三分

上四味，以酒一杯渍之一宿，绞取汁。生地二斤，咬咀，蒸之，如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

《千金方》：风眩门防己地黄汤，治言语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。防己、甘草各二两，桂心、防风各三两，生地黄五斤别切，勿合药渍。疾小轻用二斤。

上五味，咬咀，以水一升渍一宿绞汁，著一面取滓著竹箬上，以地黄著药滓上，于五斗米下蒸之，以铜器承取汁，饭熟以向前药汁合绞取之，分再服。

徐灵胎曰：此方他药轻而生地独重，乃治血中之风。生渍取清汁归之于阳以散邪热，蒸取浓汁归之于阴以养血，此皆治风邪归附于心，而为癫痫惊狂之病。与中风、风痹，自当另看。又曰：凡风胜则燥，又风能发火，故治风药中，无纯用燥热之理。此方他药轻而生地独重，治血中之风也。

302、【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民：

防己地黄汤，几味治风寒湿的药怎么会治癫狂症呢？殊不知此方之妙，妙就妙在“不安神而神安，不治狂而狂自愈。”1960年，宋老向我传授《金匱要略》经方的用法时，告诉我，他在广州行医时不止一次用此方治疗“失心风”，奇怪的是，病人痊愈后告诉他：“你这个药能‘开悟’，我比吃药前聪明了好多。”

1962年春节，我应邀到怀柔黄花镇村做客。当天晚上，村支部委员来找我，请我给看一个狂躁型精神病病人。我问他，什么原因疯的，他说，秋天收板栗的时候，此人从地里回来，衣服鼓鼓的，村外站岗的民兵告诉我，他偷了板栗，因此人是个老前辈，不好问他，可在全村流传开来，说他偷了板栗。老前辈听说，向村委会说明，是他从板栗沟回来时，又拐到自留地拔了几个萝卜，还摘了一个小南瓜，根本一个板栗也没偷。不管老人怎么解释，满村人怀疑他偷板栗之言风愈传愈烈。老人一生耿直，一气之下疯啦。晚秋每天晚上出去，谁家自留地菜都给拔掉。为了防止他再祸害村里人，派民兵用铁链把他锁起来，直到大年三十才把他放出来。初一，他到别人家拜年，把祭祖的馒头装在裤裆拿走，害得全村人都怕他。我说，我现在是一个未毕业的学生，但父亲善治精神病，我学得不好，你带来我看看，能治我就给开药治疗。

不一会，两个民兵把病人押来，我让病人坐下，诊完脉，我说：“我给你开个方试试”，病人马上说：“我没病，不吃药，只想喝酒”，我笑着回答：“我给你买酒喝”。病人走后，我开了防己地黄汤：防己9g，防风9g，桂枝9g，生地黄100g（另煎），甘草9g，5副。告诉病人家属，把防己、防风、桂枝、甘草泡在酒里一宿，把生地放入大碗里，蒸一顿饭功夫，然后找个铜盆洗净，将两种药汁倒在盆内混合，温服，1天1副药，还只吃1次。病人家属后来告诉我，吃完5副药，疯病就好啦。我先后用防己地黄汤治“失心风病”好几例，都很快能好。

防己地黄汤原为酒浸水煮法，我改用水煮法，温服时加酒1杯，疗效不变。

防己地黄的方解：失心风，多发生于肝郁难以疏解，卒然暴发，失去理智。防风疏肝解郁，疏所郁之肝气。防己利湿，湿去则痰不生，先防痰迷心窍。桂枝通心阳、伐肝气；肝木最怕桂枝，所以有“木得桂而枯”之说。生地甘寒养心阴，安心神，心安，神才能藏住；生地大剂量能清肝郁所化之热，热泄，神欣然而安。甘草调和诸药。所以，防己地黄药能“不安神而神自安”。

我常用它治疗肝郁不疏引起的失眠，配百合地黄汤治疗更年期抑郁症，合酸枣仁汤治难以入眠症。若在防己地黄汤中加半夏秫米汤，都是安神定志、促进睡眠的好方药。

从药论该方之功用，确能治痹，治类风湿性关节炎，但非防己地黄汤之主治。直到1984

年《河南中医》刊登丁先生用防己地黄汤治疗4种精神病的报道，读后让我敬佩不已。

303、【防己地黄汤治癫证医案】高齐民：

周XX，女，16岁，汨罗公社茶南大队人。因患慢性血吸虫病，1964年收入省血防试点组进行归剂20日疗程治疗。因其入院较晚，同病室的病友都先后出院，室内只剩下她一人。一日深夜，电闪雷鸣，风雨大作，霎时树摇窗动，少女惊怕交加，又忽然想起村人常讲，诊室窗外大树上曾吊死一人，顿觉毛骨悚然，蒙被战栗，彻夜未眠。翌日精神欠佳，苦愁少语，后渐渐精神失常，时而痴呆，时而哭笑无常，欲自杀。经二次电疗后，近来静卧不语，不知饥饱，天黑不能离灯，日落不能离人，六脉柔中带弦，舌苔薄白稍腻。

经云：“惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣”。气乱生风，风逆于少阴，故发为癫。法当滋阴平肝，安神潜阳。方选防己地黄汤加生龙牡。防己10g，生地30g，防风10g，桂枝6g，甘草6g，生龙牡各30g。三剂，水煎服，每日一剂。

二诊：其母代诉说：服药后，精神不再痴呆，能帮母亲做点家务，有时还敢到大门口站，夜晚睡觉不再要灯，不再要人陪伴。效不更方，继服三剂。

三诊：患者已谈笑自如，每日勤做家务，与常人无异，脉缓苔薄，改用百合地黄汤以善其后。生地15g，百合10g，菖蒲10g，生龙牡各30g。三剂，水煎服，每日一剂。不久接到其父来信，函告女病痊愈，并致谢意。

304、【防己地黄汤不寐医案】高齐民：

张XX，男，56岁，海军离职干部：1983年来京求医。自诉：长期失眠，以为工作繁忙、夜间加班所致，离休后，整天闲遐无事亦失眠，经海军XX医院检查，多种化验均正常，诊断为“神经官能症”“植物神经紊乱”，每天依靠安眠药只能睡3~4小时；诊其六脉弦中带数，舌苔薄白、质红润。系操劳公事，伤及心肾，阴不潜阳。当用防己地黄汤，引阳归阴。生地30g，防己10g，防风10g，桂枝6g，甘草6g。六副，每日一剂，水煎服。

二诊：服上药后，中午已能睡1~2小时，但易醒，夜间睡眠时间延长，晨起倍觉精神爽快。继以上方加生龙牡各30g，再加生地10g，六副，每日一剂，并嘱其隔日减一片安眠药。

三诊：自诉服药后半小时便能入睡，夜间一次能熟睡六小时，安眠药四种共八片，已减至二片。嘱其逐渐减少安眠药剂量，继服上药六副而愈。

305、【防己地黄汤狂痹案】高齐民：

王XX，男，45岁，甘肃酒泉清水公社人。1973年冬外感风寒后，周身关节红肿疼痛，连绵半月不解，尤其手指关节已轻度变形，六脉浮而数，舌苔薄白、质红润。系寒邪留着关节，郁而化热。法当清热祛风，通阳利湿。防己地黄汤最为合拍：防风祛风，桂枝通阳祛寒，防己通络利湿，生地清热养血，一方而风寒湿热之邪尽解。

生地30g，防风10g，桂枝6g，防己10g，甘草6g。五副，每日一剂，水煎服。

二诊：进上药后，外感解，红肿消，自觉药后尿多。继服原方五剂而愈。

306、【防己地黄汤治寒痹医案】高齐民：

张XX，男，30岁，中条山有色金属公司公安干部。深秋执行任务时理水过河，寒水透骨，入冬患关节疼痛，喜暖，尤以膝关节为重。诊其六脉沉，舌苔薄，质稍淡。系风寒之邪留着关节。法当养血祛风散寒，取阳和之意。

熟地30g，防己10g，防风10g，桂枝12g，甘草6g。六副，水煎服，每日一剂。

二诊：服上药后，腰膝关节疼痛大减。继服六副。三诊：关节已不疼痛。继予八味丸以善其后。

307、【防己地黄汤阴虚外感医案】高齐民：

褚XX，女，30岁，住本市东城区门楼胡同。1982年春，一日洗澡受风，鼻塞，流清涕，口舌糜烂，五心烦热，咽干，低烧37T，脉微而数，舌苔薄、质润体瘦。系素体阴虚，外感风寒。化验检查：血白细胞（WBC）3000/mm³，血小板（PLT）50000/mm³，胸透（一）。法当滋阴解表。防己地黄汤加味。

生地 30g, 防己 10g, 防风 10g, 桂枝 10g, 桔梗 10g, 甘草 5g。四副, 每日一剂, 水煎服。

二诊: 服上药四剂, 外感解, 口舌糜烂未痊愈。继予自拟“镇翊汤”, 滋阴清热而愈。

防己地黄汤对后世方剂影响很大。陈修园说: “此方表里兼治, 后世方祛风至宝方从此方悟出。”徐忠可也认为: “犀角地黄汤、地黄饮子实祖于此。”

近贤章太炎先生, 依据现代药物成分分析, 指出: “《素问·病能论篇》以生铁落治阳厥怒狂, 本方重用生地黄, 含铁质, 与生铁落饮同意。”

308、【防己地黄汤失心风案案】高齐民:

褚 XX, 女, 28 岁, 已婚五年, 婚后夫妻生活甜甜蜜蜜。自从去年丈夫提为副科长后, 经常加班, 夜间经常不回来, 时间一长, 心一中起了疑惑, 开始趁丈夫洗澡时, 查爱人手机的信息, 看有没有小蜜发的信息, 从中必出不归的理由; 手机查不到, 就偷偷去单位查是否真的加班。这样一来, 夫妻之间感情渐渐冷落, 开始不给丈夫做饭, “饿死他”; 夜间丈夫敲门也不开门, “冻死他”……生气啦, 门一锁, 就到妈妈家住几天, 气消啦, 再回来。由于长期肝气不舒, 开始哭笑无常, 沉默寡言, 有时痴呆, 有时整夜不睡, 全家害怕她犯精神病, 2006 年 7 月由她大姐带来诊病。

诊完脉, 问了半天, 不说一句话, 只是唉声叹气。初步诊断为“失心风”。当养心舒肝祛风, 治以防己地黄汤。

处方: 生地 30g, 防己 9g, 防风 9g, 桂枝 9g, 甘草 6g。7 剂, 日 1 剂, 水煎, 分 2 次服。嘱睡前服时, 药煎好倒在碗中, 药汁温时加绍兴黄酒 30g 兑入服下。

二诊: 患者坐下来, 敢面向大夫, 对话都很有条理, 唯睡眠尚差。效不更方, 上方加生龙牡各 30g, 再予 7 剂。

三诊: 患者面带微笑, 是个非常善谈的姑娘, 谈了她下岗之后, 心里想不开, 又无可奈何, 加之家务事, 疑心太多, 导致心情不畅, 郁火从肝而生, 慢慢思维紊乱……服药后, 心情舒畅了。还说, 是否再吃 7 剂可以休息啦。患者姐姐每次带她来诊病, 她认为病基本好啦, 夫妻又恩爱如初。效不更方, 继服 10 剂善后。

309、【防己地黄汤四十年少寐医案】高齐民:

贾 XX, 男, 60 岁。自诉 40 年来睡眠不好, 每天顶多睡 3~4 小时就再也睡不着啦。除睡眠不好外, 其他没有什么毛病。诊其六脉沉缓, 无明显异常, 当属长期心肾不交之证。方用防己地黄汤加百合、紫苏。

处方: 生地 30g, 防己 9g, 桂枝 9g, 防风 9g, 甘草 6g, 百合 30g, 紫苏 10g。7 剂, 日 1 剂, 水煎, 分 2 次服。嘱睡前服药时加绍兴黄酒 30g 兑入服下。

二诊: 服上药 21 剂, 睡眠时间延长至每晚 5~6 小时, 且头脑比以前聪明, 好像年轻了好几岁。

310、【防己地黄汤治神经衰弱案医案】高齐民:

张文元, 男, 56 岁, 1989 年 6 月 3 日初诊。自 1956 年就患神经衰弱病, 每天入睡困难, 全靠速立眠、眠而通、甲苯噻哩酮度过每一个夜晚。服药可安眠, 但起床后打不起精神, 吃饭不香, 周身疲乏, 人都有不老先衰之感, 听朋友说门诊有个带进修生的老师治失眠有名, 特闻名而来。

六脉沉, 舌苔薄白, 神情疲倦。处方: 生地黄 30g, 防己 10g, 防风 10g, 桂枝 10g, 甘草 6g, 枣仁 10g, 生龙牡各 30g, 柏子仁 10g, 生姜 6g。7 副, 水煎服。

二诊: 患者说, 上次看病, 我看大夫舍不得开药, 只开了 7 味药, 就说我失眠长达 33 年, 7 味药是否少啦吧, 说完大夫给加了生姜、甘草、柏子仁。我半信半疑开始服药, 晚上 8 点把药煎好服下, 8 点半即入睡, 一觉睡了 7 个多小时, 醒来一身轻松, 周身力气增一倍。效不更方, 继用上方。

三诊: 7 天来每天睡眠很好, 为了巩固疗效, 继用防己地黄汤巩固疗效。

311、【防己地黄汤恐惧性失心风治验案】高齐民：

孙x，女，28岁。2009年4月15日初诊。从小是妈妈的宝贝，在妈妈爱抚中长大成人。当婚之年，她找了一个比自己大十多岁的生意人，但双方爸爸妈妈坚决反对，甚至提出断绝儿女关系。孙x在父母坚决反对之中结了婚，爸妈都处于无奈，婆婆进一步提出苛刻条件：不抚养孙子；同是自己的儿子，却偏爱小叔之子。孙x忍了又忍，但不能再忍时精神崩溃，哭笑无常，喃喃自语，怀疑家中装了放射性物质和探头害她。四邻和藹，知孙X患病，大家都关心她，任她到楼上楼下、朋友家中寻找放射源或探头，虽找过多少遍，但四邻不厌烦。每当哭笑无常，睡眠稍差，自己不能控制时，就送到精神病院住半年。丈夫做生意，治病花销多少万不感到什么困难，但人如坐牢一样痛苦。经朋友介绍，求我予以治疗。来诊时，她老说：“我晚上不能睡就好了，我好观察是否放射。”

诊其六脉浮而数，舌苔稍厚。诊脉几分钟，笑了十多次，她妈再三劝阻不听，我行我素，旁若无人。诊断为失心风，当用养阴熄风，交通心肾。选用仲景防己地黄汤。

防己10g，生地40g，防风10g，桂枝10g，甘草10g。7剂。

嘱其头煎晚上服，待药温能服时，加一杯白酒以增药力。服防己地黄汤28剂时，仅生地增加到120g，病情大为好转，哭笑大为减少，夜间睡眠恢复正常。

家务事繁杂，头绪万千，一时理不顺，肝火旺时，睡眠又反复。我用黄连阿胶汤，即朱雀汤，泻肝火，平心火，诸症好转，改用防己地黄汤。三个月后，儿子上小学，需要自己接送，督促每日作业，一紧张，病有轻度反复。改用酸枣仁汤7剂，不再日夜紧张。此后，防己地黄汤作丸服用。生地300g，防己50g，防风50g，桂枝50g，甘草50g，百合100g。1料。上药共研极细，炼蜜为丸，丸重10g，每日3丸，早一晚二，已服一个多月，病情无反复。

312、【防己地黄汤治案失心风案】高齐民：

谭XX，男，40多岁，湖南宜章黄土岭人。在北京施工。谭XX，自以为性功能旺盛，每晚不同房则不能入睡，更以为夫人已满足，不会再另抱琵琶。一日，他上夜班，因无事便中途回家，见夫人和自己的好朋友通奸，被他抓了一个正着。夫人和朋友向他赔礼，发誓再不越轨，但谭某非常生气，气无处可撒，强忍不语，叹气，胸满闷，夜晚渐渐不能入睡，通奸之事无法解脱，常整夜哭笑不休，叹气声连绵不断，断为失心风。

防己地黄汤加味：防己10g，防风10g，生地10g，桂枝12g，甘草6g，生龙牡各30g。进药21剂。已能从晚11点睡到凌晨4点，但4点醒来再也无法入睡。再用防己地黄汤加百合20g，服7~14剂。疑虑、多疑消失，半夜醒后还是不能入睡。

细思之：夜半一阳生，丑时阳生渐旺，阳主动，故而不能入睡，选用《辨证奇闻》中一治不寐方，仅六味药：重用熟地30g、麦冬30g、黄连6g以滋阴降火，茯神10g、生枣仁10g以安神。服7~21剂后已能正常入睡，心情也感舒畅。自诉：“我已好啦，能吃，还能睡，我可以上班了”。最后以黄芪建中汤以建胃土。

张泽生老先生说：“非详究古人治验，不能识治法之奥。”为了治法上两全其美，我开始将防己地黄汤加入熟地、麦冬、黄连、枣仁，去防风加茯神10g，命名为加味防己地黄汤。其组成为：生熟地各30g，麦冬30g，桂枝9g，防己9g，生枣仁12g，甘草9g，茯神10g。临床用于前半夜睡眠很好、后半夜醒后再难入睡之患者。已用2例，确实有效。

313、【防己地黄汤加味医案】赵守真：

刘君肃一，年二旬。其父叔皆大贾，雄于贾，不幸于1943年次弟殁，谢丧停未葬。君因自省休学归，店务烟集，不谙经营，业大败。折阅不知凡几，以致债台高筑，索债者络绎于门，苦孰甚焉。乃只身走湘潭收旧欠，又兴讼，不得值，愤而归。因之忧郁在心，肝气不展，气血暗耗，神志失常，时而抚掌大笑，时而歌哭无端，妄言错语，似有所见，俄而正性复萌，深为赦然，一日数潮而已。医以为癲也，进加味温胆汤，并吞白金丸，曾吐涎少许，证状未少减。吾以事至零陵，君为故人，顺道往访，渠见吾述家事刺刺不休，状若恒人，顷而大哭，继而高歌。其家人恳为治之，此义不容辞者也。俟其静，用好言慰解，诊脉细数，舌绛无苔，

胸中痞闷，夜不安卧，小便黄短，是为志怫郁而不伸，气横逆而不降，心神耗损，肾水亏乏，火气妄凌，痰涎泛滥，有癫之意不若癫之甚，所谓心风证也。治以益血滋阴安神调气为主，拟《金匱》防己地黄汤加味：生地 60 克（捣汁兑），甘草 6 克，防己 9 克，桂枝 3 克，加香附 9 克，首乌、竹沥各 15 克。兼吞安神丸 12 克，日服 2 剂。

三日复诊，神志渐清，潮发减少。随进滋阴安神汤：生地、芍药、川芎、党参、白术、茯神、远志、南星、枣仁、甘草、黄连。服后略觉头胀心闷，微现不宁，审由余热未清，难任参术之补，故证情微加。乃改弦更张，趋重清心养神略佐涤痰。

早晨服清神汤：黄连、黄芩、柏子仁、远志、菖蒲、枣仁甘草、姜汁、竹沥。

晚进二阴煎：生地、麦冬、枣仁、玄参、茯苓、木通、黄连、甘草、灯芯、竹叶。每日各 1 剂。如是者四日，遂热不再潮，人事清悉，诊脉细数而有神，余热似尽，而参术之补，现犹所忌，尚有余焰复燃之虑，处以天王补心丹，以易汤：生地、人参改为洋参、玄参、丹参、茯神、桔梗、远志、天冬、麦冬、枣仁、柏子仁、五味、当归，送服磁朱丸，补心滋血，安神和胃。嗣即精神健好，食纳增进，又调理半月，改用梳麦归脾汤，仍吞服磁朱丸，善后补养，再一月而身健复元。吾临归，彼不胜依依之感。（《治验回忆录》1962：60）

314、【防己地黄汤加味治失心风精神病医案】赵守真：

刘君肃一，年二旬。其父叔皆大贾，雄于贾，不幸于 1943 年次第殁谢，丧停未葬。君因自省休学归，店务烟集，不谙经营，业大败。折阅不知凡几，以致债台高筑，索债者络绎于门，苦孰甚焉。乃只身走湘潭收旧欠，又兴讼，不得值，愤而归。因之忧郁在心，肝气不展，气血暗耗，神志失常，时而抚掌大笑，时而歌哭无端，妄言错语，似有所见，俄而正性复萌，深为赦然，一日数潮而已。医以为癫也，进加味温胆汤，并吞白金丸，曾吐涎少许，证状未少减。吾以事至零陵，君为故人，顺道往访，渠见吾述家事刺刺不休，状若恒人，顷而大哭，继而高歌。其家人恳为治之，此义不容辞者也。俟其静，用好言慰解，诊脉细数，舌绛无苔，胸中痞闷，夜不安卧，小便黄短，是为志怫郁而不伸，气横逆而不降，心神耗损，肾水亏乏，火气妄凌，痰涎泛滥，有癫之意不若癫之甚，所谓心风证也。治以益血滋阴安神调气为主，拟《金匱》防己地黄汤加味：生地 60 克（捣汁兑），甘草 6 克，防己 9 克，桂枝 3 克，加香附 9 克，首乌、竹沥各 15 克。兼吞安神丸 12 克，日服 2 剂。

三日复诊，神志渐清，潮发减少。随进滋阴安神汤：生地、芍药、川芎、党参、白术、茯神、远志、南星、枣仁、甘草、黄连。服后略觉头胀心闷，微现不宁，审由余热未清，难任参术之补，故证情微加。乃改弦更张，趋重清心养神略佐涤痰。

早晨服清神汤：黄连、黄芩、柏子仁、远志、菖蒲、枣仁甘草、姜汁、竹沥。

晚进二阴煎：生地、麦冬、枣仁、玄参、茯苓、木通、黄连、甘草、灯芯、竹叶。每日各 1 剂。如是者四日，遂热不再潮，人事清悉，诊脉细数而有神，余热似尽，而参术之补，现犹所忌，尚有余焰复燃之虑，处以天王补心丹，以易汤：生地、人参改为洋参、玄参、丹参、茯神、桔梗、远志、天冬、麦冬、枣仁、柏子仁、五味、当归，送服磁朱丸，补心滋血，安神和胃。嗣即精神健好，食纳增进，又调理半月，改用梳麦归脾汤，仍吞服磁朱丸，善后补养，再一月而身健复元。吾临归，彼不胜依依之感。（《治验回忆录》1962：60）

315、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正：

宋某某，女，25 岁。1979 年 3 月 5 日入所。患者发病于 1971 年 5 月，少眠，多动，语无伦次，狂躁异常。诊为精神分裂症青春型，经多方治疗，时轻时重，迄未痊愈。近年来，狂象虽减，但痴病癡癡，秽浊不知，随地便溺。问之多不答，答亦多非所问。胡行乱走，间或妄笑，独语不休。且喜时搔头部，剃光之头皮被抓得血迹斑斑。诊查：患者身肢拘强，面容消瘦惨白，双颊微红，脉洪大无力，舌质红，干而少津。综观脉证，显属狂久火盛伤阴，阴血不足，风邪入侵，扰及神明。处以防己地黄汤。服 10 剂，独语妄笑略减，夜能稍眠，胡乱游走，呼之能止。又服 20 剂，疾瘳约半。又服 20 剂，神情、言行皆恢复正常，已参加工作。（河南中医 1984；〈5〉：31）

316、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正

张某，男，38岁。1975年4月8日诊。上年六月，正劳动时突然发病。双目直视，重复咀嚼，微作哼哼之声，且盲目走动。片刻醒转，于病中之况一无所忆。以后发作渐频，且持续时间渐长，发作后，如醉如疾，独语喃喃，外出走动约二里许方醒转。来诊时，发作已十一天，昼夜游荡，妄行不休，虽然数剂化痰息风类中药亦无效。诊其脉浮数无力，舌质红略干，无苔，体温 37.2°C ，“无寒热”。知系心肝血虚，虚而生热，加之风邪内扰，心神失持而致。治以养血清热，祛风散邪；处以防己地黄汤5剂。4月14日二诊：神志清，妄行止，夜里睡眠甚酣，晨起惟困乏而已。再以上方5剂巩固之。出所时，嘱常服磁朱丸（磁石、朱砂、神曲）佐服少量苯妥英钠片等：随访迄今，未再复发。（河南中医1984；（5）：31）

317、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正医案：

李某某，女，33岁，已婚，1978年2月7日入所就诊。患者数年来，眩晕易乏，少眠多梦，时或心悸躁慌。月余前，其疾发作，时而哭啼吵闹，时而昏仆欲绝。经当地诊为癔病，用甘麦大枣汤等十数剂无效。来诊前夜，症象益剧，或张嘴吐舌，称鬼弄怪；或神情恍惚，奔走村外，自言自语。诊查：患者清瘦，面略赤，脉轻取浮，重按细数，舌质红，无苔，唇干，口苦。家属云：“患者常谓项强，头皮紧拘，如绳缚之。”此症显系阴血匮乏，风邪外并，阳热内郁，神明失司而致。处以防己地黄汤，服2剂，神思略定，妄行独语大减；又服3剂，症象若失。头皮发紧及项强等症亦去。出所时，予朱砂安神丸续服以善后，随访迄今，健康如常。（河南中医1984；（5）：31）

318、【防己地黄汤治患慢性风湿性关节炎医案】谭日强：

崔某某，女，51岁。患慢性风湿性关节炎，其人身体羸瘦，四肢关节疼痛，手指变形，下肢肌肉萎缩，双踝关节肿大，病已经年，卧床不起，患者本人是针灸医生，曾用针灸，中药多方治疗不效，大便干结，小便尚可，舌淡无苔，脉象弦细。此营气不通，肝肾俱虚，拟养血和营，兼益肝肾，缓缓图功，师防己地黄汤意：生地30克，防己10克，桂枝10克，防风10克，甘草3克，加当归10克，白芍10克，川芎3克，草薢10克，木瓜6克，苡米12克。

嘱服30剂，踝关节肿痛渐消。仍用原方去防己、苡米，加地龙10克，红花3克，再服30剂，关节疼痛减轻。继用原方去桂枝、防风，加牛膝、桑寄生，又服30剂，下肢活动进步。后用原方加党参、杜仲、续断、鸡血藤等味作丸剂常服，并嘱下床适当活动，调理年余，身体渐次康复，已能上班工作，坚持来去走路。（《金匱要略浅述》1981：80~81）

319、【防己地黄汤治手足抽搐医案】何耀普：

王某，男，14岁，学生，1990年5月12日初诊。患者5天前玩耍出汗后下河摸鱼，2天后出现左上肢麻木，僵硬，抽搐，并逐渐加重，伴阵发性项背强急，牙关紧闭，手足抽搐等症，每日发作3~5次，发病时神志清楚，能感觉到不适与痛苦。经用多种中西药治疗均无效。各种检查无异常，舌红苔黄，脉弦数。中医诊为痉证，证属血虚受风，筋脉拘挛。治宜养血祛风，舒筋止痉。方用防己地黄汤加味：生地60g，防风、防己、川芎、胆星、炙甘草各12g，桂枝10g，泽泻20g，生苡米30g，白芍15g。每日1剂，水煎服。

服药2剂，症状缓解，抽搐次数减少，程度减轻。连续服药15剂后，诸症悉除。随访2年无复发。（国医论坛1993；（5）：17）

320、【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫：

李某，男，24岁，1986年7月5日初诊。患者3个月前因感冒出现心悸胸闷，周身乏力，微有寒热，四肢酸楚等症，在蚌埠市某医院化验检查：ESR120mm/h，ASO600单位，心电图不：窦性心动过速，频发性室性早搏。经抗感染、抗风湿、大量激素，及心律失常等综合治疗，病情一直未能控制，同时又出现心悸加剧，肢体肿胀，颜面潮红，烦躁失眠，咽干口苦等症，心率110~140次/min。舌质红胖，苔薄黄脉滑数有力。证属风邪稽留，营血郁热。治宜清热凉血，祛风利水，防己地黄汤加味：生地60克，防己20克，防风15克，桂枝、甘草、

苦参各 10 克。3 剂水煎服，地塞米松 1.5mg，2 次 / d，其它药物停用。

服药 1 周后，诸症减轻，舌质红胖，继用上方加木通 10 克，再进 5 剂。1 个月后复查，ASO：400 单位，ESR25mm / h，心率 78 次 / mi。心电图示窦性心律。体胖渐退，舌转淡红、苔薄白，脉濡滑，原方加玉竹 30 克，再进 10 剂而愈。（陕西中医 1991；（4）：173）

321、【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫：

任某，男，14 岁，1985 年 2 月 6 日诊。患儿半月前感冒发烧，咳嗽，咽痛，继而出现眼睑浮肿，伴有血尿。经用青霉素、止血敏、激素等治疗，效果不显著。证见发热，T38℃，但四肢不温，微恶寒，面浮肢肿，咽红，口渴，尿少色赤，舌质稍红、苔薄白，脉浮数。化验检查小便：尿蛋白（+），红细胞（+），白细胞 4~6 / HP，颗粒管型 2~5 / HP。血象偏高，ESR85mm / h。证属风热袭表，肺气失宣，热伤肾络而致血尿水肿。西医诊断：急性肾小球肾炎。治则：清热解毒，疏风凉血，防己地黄汤加味：生地 30 克，防己 15 克，防风、桂枝、紫草、甘草各 10 克，花粉 15 克，鲜浮萍一把，2 剂水煎服。

3d 后浮肿消退，体温正常，微渴有汗，但血尿未消。仍予上方生地加至 60 克，加白茅根 30 克，贯众炭 15 克，2 日服 1 剂，又服 5 剂。1 月后小便转清，血尿消失，尿检正常。随访 2 年未复发。（陕西中医 1991；（4）：173~174）

热；则见尿血、口渴、舌红等症。血热而风胜，正合防己地黄汤证之病机，用之即效。为增强本方药力，故加浮萍以祛风邪，加紫草以清热凉血，用花粉以养阴止渴。

第二十二章 甘草小麦大枣汤方证

【原文】：妇人脏燥，悲伤欲哭，数欠伸，象如神灵所作者，甘草小麦大枣汤主之。

别本对照：妇人脏燥，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠喜伸，甘麦大枣汤主之。

病因和病机：心脾虚证，心脏虚而躁扰，心血气少，肺中津液干燥

辨证依据：喜悲伤欲哭，打呵欠和伸懒腰。日本人扩展：左腹直肌紧张

罗按：渔民夏成锡说的理论很中肯：他说“《金匱》脏躁症与梦游症都是神经系统的病变，它们虽然临床表现不一样，但是可以看成是相似的主症，所以治疗脏躁症的药方也可以治疗梦游症”。他认为“脏躁”就是内脏的津液干燥，当然引起“脏躁”的原因很多，比如这个患儿的原因就是长期的盗汗。“脏躁，就是内脏的津液干燥”。中医学方面还从来没有听说过如此注释，但是从说文解字的角度来看也顺理成章。

“喜悲伤欲哭”，看上去似情志精神病，但“喜悲伤欲哭”中有深层次的原因，是病人痛苦莫名，但她无法用言语进行表达。我看过矢数道明的一个医案就是如此，头痛欲裂，痛苦不能名状。可能病位直指脑子。“数欠伸”是病人有数次欠伸的动作，疲倦时打呵欠和伸懒腰，反映是身体一个状况。

尤在泾曰：脏燥，沈氏所谓子宫血虚，受风化热者是也。血虚脏燥，则内火扰而神不宁，悲伤欲哭，有如神灵，而实为虚病。前《五脏风寒积聚篇》所谓“邪哭，使魂魄不安者，血气少而属于心也”。“数欠伸”者，经云：肾为欠、为嚏，又肾病者，善伸、数欠、颜黑，盖五志生火，动必关心，脏阴既伤，穷必及肾也。小麦为肝之谷，而善养心气，甘草、大枣，甘润生阴，所以滋脏气而止其燥也。

曹颖甫曰：师但言妇人藏燥而不言何藏，然病情方治可知也。肺主悲，亦主哭，悲伤欲哭，病当在肺，凡人倦则欠伸，精神强固则否，所以数欠伸者，脾阳不振而中气怠也。凡人饮食入胃，由脾也散津上输于肺，脾精不能运输，则肺藏燥，肺阴虚则主气之藏室塞，故悲伤欲哭，方后别出亦补脾气四字，可知病机专属肺藏矣，方用甘麦大枣，专取甘未之药，俾脾精上输于肺，肺阴既充，则下足以贯注百脉，外足以输精皮毛，内外调达，气机舒畅，略无抑变不和之气，悲伤欲哭之证，乃可不作，曰如有神灵者，甚言不能自主也。

张石顽曰：脏燥者，火盛烁津，肺失其润，心系了戾而然，故用甘草缓心系之急而润肺

燥，大枣行脾胃之津，小麦降肝火之逆，火降则肺不燥而悲自己也。戴人云：少阳相火，凌烁肺金，金受屈制，无所投告，肺主悲，故但欲痛哭为快耳。石顽曰：凡肺燥悲愁欲哭，宜润肺气降心火为主，余尝用生脉散、二冬膏，并加姜、枣治之，未尝不随手而效，若作颠疾，用金石药则误矣。经云：精气并于肺则悲，在藏为肺，在志为悲，悲，肺之志也。金本燥，能令燥者，火也。心火主于热，善痛，故悲痛苦恼者，心神烦热躁乱而非清静也。所以悲哭而五液俱出者，火热亢极，而反兼水化制之也。

《金鉴》曰：藏，心藏也，心静则神藏。若为七情所伤，则心不得静，而神躁扰不宁也。故喜悲伤欲哭，是神不能主情也。象如神灵所凭，是心不能神明也，即今之失志癫狂病也。数欠伸，喝欠也，喝欠顿闷，肝之病也，母能令子实，故证及也。

高学山曰：脏指心肺而言，脏躁言脏中阳液枯干，而脏真之气，尝不能自立，而有躁急之义，故其心神肺魄，如失援失根据，不可自支，而悲伤欲哭者，烦冤之所致也。如神灵所作，正言无故而悲伤欲哭，如有凭借之象，气失所根据，而时引上下则欠，气自微长，而时欲外达则伸也。小麦为心之谷，大枣为肺之果，又皆甘寒甘温，而偏滋津液者，得甘草以浮之在上，则正行心肺之间，而神魄优裕，又岂止食甘以缓其躁急乎哉，亦补脾气，又见首卷补肝下，盖补心中之火液，既可因母以生子，而补肺中之金液，又可因子以荫母，故也。补脾，非补脾气，当指脾中之津液，故本汤可与脾约丸为表里之剂。

周扬俊曰：内经以肺之声为哭。又曰：并于肺则悲。《灵枢》曰：悲哀动中则伤魂，此证因肝虚肺并，伤其魂而然也。盖肝阳脏也。肺阴脏也。阳舒而阴惨，肝木发生之气，不胜肃杀之邪，并之。屈而不胜，生化之火被抑，扰乱于下，故发为脏躁，变为悲哭，所藏之魂，不得并神出入，遂致妄乱，象如神凭，木气被抑而不前，筋骨拘束而不舒，故数作欠伸，然治相并之邪，必安之和之。用小麦养肝气止躁，甘草、大枣之甘，以缓气之苦急，躁止急缓，则脏安而悲哭愈，然又曰亦补脾气者，乃肝病先实脾，不惟畏其传，且脾实而肺得母气以安，庶不离位过中而复下并矣。

胡希恕曰：藏躁是指心脏，《风寒积聚篇心中风》说：“邪哭，使魂魄不安者，血气少也；血气少者属于心，其人则畏，合目欲眠，梦远行而精神离散，魂魄妄行。阴气衰者为癫，阳气衰者为狂”，这一段正是说的是这个。血少心气虚，其人不安，躁就是不安不宁，是指的心说的。“数欠伸”，频繁打哈欠，这都是魂魄不安的一种反应。这类的病，就是由于血虚，或血少心气虚，才发生这种病，这也就是癫的一种。

应该用补药，尤其要用甘缓，甘以缓急。甘草、大枣、小麦，这都是甘性药，而缓其急迫。小麦是补心、补心气，所以这个藏躁指的是心脏，有的人说是指补阴血说的，错了。这个药也挺有意思，这个妇人悲伤喜哭，可以用这个药，就是小孩子夜间哭得特别厉害，有时候有的人用这个药也起作用。不过不是虚证可不行，不是虚证吃这个药觉都睡不着。我有这个经验，我有次给人看病就给弄错了，她不虚，可这人精神失常，她当时也是好哭，给她开的这个药，第二天她就找我去，说：你给我吃的什么药，我一宿没睡着。然后就赶紧换了药，后来给吃的桂枝茯苓丸那种药就对了，她是实证，所以虚实还是很有关系的。所以藏躁，心脏虚而躁扰不宁，可以用这个，实证用这个就坏了。

岳美中云：脏躁不单妇人也，男子如是，有是证用是方也。脏躁者，悲伤欲哭，时出妄言，与癫狂相近，癫狂者，前后相失，出口即忘。

唐容川曰：妇人子宫，古亦名子脏，子脏之血液本于胃中，胃中汁液多则化乳化血，下达与催乳相似。肺散津而主悲，肺津虚则悲伤欲哭。心藏血而主神，心血虚则神乱而如有神灵所凭。津血两虚则不能下润子脏，故统以滋补汁液者化生津血。

《汉药神效方》：妇人脏躁，西医谓之子宫病，即今舞蹈病。

《方极》云：甘麦大枣汤，治急迫而狂惊者。《方机》云：心中烦躁，悲伤欲哭，腹中濡者，紫圆或解毒散兼用。

雒间焕云：脏躁之“脏”，与脏坚癖(案见下矾石丸条)之“脏”同。此阴中急躁，色欲妄动也，兼以狂疾者，服此方如神，故吉子于此独不删“脏”字(谓东洞类聚方也)，可谓得矣，弗可容易看过。

《类聚方广义》云：脏子宫也，此方能治脏躁者，以能缓急迫也。孀妇室女，平素忧郁无聊，夜夜不眠等人，多发此症发则恶寒发热，战栗错语，心神恍惚，居不安席，酸泣不已，服此方立效。又癔症狂症仿佛前症者，亦有奇验。渊雷按：脏躁之“脏”，赵氏以为肝肺，徐氏以为五脏，《金鉴》以为心脏，惟沈氏尤氏以为子宫，与癔病之西方旧说正合。雒间尾台亦以为子宫，丹波则斥为甚误，盖见男子亦有此病之故。脏躁之发作，间有发热者，热度有高至摄氏四十五乃至四十九度者，但少耳。又，官能性神经系诸病，如舞蹈病、疑病、癔病等，证候皆与癔病类似，故癔狂症有可用本方者。

《方函口诀》云：此方虽为主妇人脏躁之药，凡上侧腋下脐旁拘挛有结块者，用之亦效，又用于小儿啼泣不止者，有速效。又用于大人之病，皆病急者食甘以缓之之意也。先哲治夜啼客忤，拘挛在左者用柴胡，拘挛在上者用此方，此不可泥，客忤大抵此方所治也。

汤本氏云：本方以有甘草大枣，于腹证上为上腹直肌挛急，若有此腹证，又心识其他急迫征候时，不问老幼男女，与本方为佳。

程氏云：《内经》曰“悲则心系急”，甘草大枣者，甘以缓诸急也。小麦者，谷之苦者也。《灵枢经》曰“心病者宜食麦”，是谷先入心矣。丹波氏云：《素问》以小麦为心之谷，《千金》云“小麦养心气”，本方所主，正在于此。而《金鉴》云“方义未详，必是讹错”，此说大误，验之于病者，始知立方之妙也。渊雷按：《药征》谓甘草主治急迫，故治里急急痛挛急，大枣主治挛引强急，程云甘以缓诸急，是二说者，实二而一也。凡运动神经之作用，古人属之肝，知觉神经之作用，古卷七人属之心，大脑皮质为知觉中枢，癔病为其官能病，云小麦养心气者，犹言小麦恢复大脑皮质之官能耳。古方药理，难晓者多，独本方之治癔病，则病理药能，丝丝入扣，有玉合子底盖相合之妙。癔病为常见之病，本方平缓而效速，今之医者，乃有弃置弗用者，何哉？

闫氏云：此脏躁之治方，临床运用以无故悲哭，数欠伸为目标。脏躁证者，其人性格内向，多由精神创伤，情志不遂，或积忧成疾而成。症见神情抑郁，悲观厌世，心神不宁，无故哭泣，或叫笑难以自忍，或作种种不自主动作，脉象沉弦，腹肌挛急。

陆渊雷概括本证有四：一、精神障碍：幻觉谵妄与剧烈之情感俱有之。二、知觉障碍：喜独居暗室，自觉身体某部疼痛，或某部有压痛，其部位多在颅顶中央、左胁骨窝及卵巢部。三、运动障碍：痉挛而肌肉短缩，麻痹而成偏瘫状，或牙关紧急，或头项倾侧，或四肢百节轮替作挛缩搐搦，或有虫状物若虫行，自小腹上升至咽。四、血管分泌及五官障碍：皮肤潮红，唾涎增多；丧失知觉部皮肤常白而冷，刺之无血。色盲眼花，重听耳鸣，及嗅觉、味觉特殊或过敏。复引日本医家之述，“阴中急躁，色欲妄动”，“孀妇室女，平素忧郁无聊，夜夜不寐之人多发此症，发则恶寒发热，战栗错语，心神恍惚，居不安席，酸泣不已。”以上之状，杂乱无绪，梳理殊难，针对悲伤欲哭，喜欠伸，即可视为脏躁，投本方治疗。脏躁，古人有其病在心，在肝，在子宫之说，余以为脏者，五脏也，躁者，阴躁也。其症阴隐，非阳狂可比。以心藏神主笑，肺藏魄主悲、主哭，肾藏精主欠，肝藏魂主郁，方中甘草、大枣俱脾家之药，故临床以有是证用是方惟务。

曾治一牛姓妇女，苦带下数年，补脾益肾，清热渗湿，杂治不效。余以其喜怒无常，频频作欠，投甘麦大枣汤，用药七剂，带下遂止。肝郁气滞，忧思气结，惊则气乱，缠绵日久，皆可化火，出现心烦易怒等阳变症状。《难经》云：“重阳者狂，重阴者癔。”以此而论，脏躁属郁结阴变，与柴胡加龙骨牡蛎汤证相反，故不宜苦寒而宜甘温。本方组成看似平淡无奇，且系日常普通食品，然三物相伍，则健脾养心；宁神缓急之力甚佳，其效多出乎意外，临床中屡屡建功，切不可贵金贱土，以貌取人。服药同时，心理治疗亦甚为重要，管仲云：

“悦其神者忘其形，所谓心病总需心药医是也。”

甘草小麦大枣汤方：

甘草三两，小麦一升，大枣十枚（擘）

上三味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

小麦：娄绍昆言是浮小麦。在水中，小麦之浮者。

方輿锐曰：此方虽云治妇人脏躁，然不拘男女老少，凡妄悲伤啼哭者，一切用之有效。近有一妇人笑不止，诸药罔效，以甘麦大枣汤与之愈。后用治小儿啼哭，亦效。

322、【麦甘大枣汤治无故悲泣不止】本事方：

乡里打一妇人，数欠伸，无故悲泣不止。或谓之有祟，祈壤请祷备至，终不应。用麦甘大枣汤，尽剂而愈。

323、【妊娠四五月遇昼则惨戚悲伤泪下】妇人良方：

程虎卿内人妊娠四五月，遇昼则惨戚悲伤泪下，数欠如有所凭。医巫兼治，皆无益。与大枣汤一投而愈。（即本方）

324、【甘草小麦大枣汤治精神病医案】岳美中：

一男子，年约30余，中等身材，黄白面色，因患精神病，曾两次去济南精神病院治疗无效而来求诊。查其具有典型的悲伤欲哭，**喜笑无常，不时欠伸**，状似“巫婆拟神灵”的脏躁证，遂投以甘麦大枣汤。甘草9克，淮小麦9克，大枣6枚。药尽7剂而愈，追踪3年未发。（《岳美中医案集》）。

按语：可见脏躁不唯妇人独有，男子亦间患之，其治相同。

【甘麦大枣汤癫痫医案】陈汉云：

患女，12岁。癫痫大发作六年，用苯妥英钠治疗无效，改用甘麦大枣汤，每日加明矾米粒大1枚冲服，连服半年而愈。随访6年未发作。（《浙江中医杂志》）

按语：本案标本兼治，值得借鉴。

【甘麦大枣汤喉暗医案】马玉起：

喉暗（癔病性失音）陈某，女，31岁，1989年3月4日初诊。患者平时少言寡语，与邻人争吵后突发失音，当地卫生院给服中西药10余天，病情未减。诊见：表情淡漠，仅发出微弱耳语音，但咳嗽声音正常，舌红苔薄，脉弦细。间接喉镜检查：声带正常，吸气时外展良好，发“衣”音时不能闭拢，咳嗽时闭合尚可，诊为癔病性失音。遂用上方，3剂后症除声扬。随访4年未复发。（国医论坛1994）

按语：癔病性失音与精神突遭刺激，气机逆乱有关，临床实践证明，运用甘麦大枣汤疗效显著。

【甘麦大枣汤医案（虚损）】叶天士：

某21岁。诵读身静心动，最易耗气损营，心脾偏多，不时神烦心悸，头眩腕闷，故有自来也。调养灌溉营阴，俾阳不升越，恐扰动络血耳。淮小麦9克，南枣肉1枚，炒白芍3克，柏子仁4.5克，茯神9克，炙草1.2克。（《临证指南医案》）

按语：劳心欲动，耗伤心肝之血，竭损心脾之营，投甘麦大枣汤加味以补益心脾，和阳熄风。

325、【甘麦大枣汤梅核气(慢性咽炎)医案】王振录：

梅核气(慢性咽炎)张某某，女，31岁。1985年5月12日诊。咽中有物梗塞，咯之更甚，颈部郁胀，有压迫感，已有半年余，自疑为“食道癌”，曾作各种检查，无异常发现，诊为慢性咽炎，服中西药，局部放血，症状不减。情志抑郁，呆滞，胸闷，纳差，泛恶，咽中粘液附着，时时咯吐，吐后稍舒，颈部稍红，水肿。舌淡无苔，脉弦。疏方：甘草、栀子、苏梗各15克，小麦50克，大枣10枚，百合30克，桔梗6克。服5剂，胸闷除，饮食增。泛呕减，咽部无郁胀梗塞感。继服原方8剂，基本痊愈。追访3月，未见复发。（《浙江中医杂志》）

罗按：按上一个条文：妇人咽中如有炙藿者，半夏厚朴茯苓生姜汤主之。却不用半夏厚朴茯苓生姜汤，却用甘麦大枣汤。

326、【甘麦大枣汤午后低热五心烦热医案】林君平：

葛某，女 64 岁，干部。于 5 年前开始午后低热，曾服清骨散、秦艽、鳖甲、散之之类症状未减。后因体重锐减而求诊，西医诊断为“植物性神经功能紊乱”，口服谷维素等低热未退，五心烦热，收住入院。余思蒲辅周老中医之训：“慢性病应重视脾胃为本，内伤低热脾胃已弱，苦寒药不宜多用。”本症低热久羁，病在阴分，阴虚生内热，前医过用苦寒之品，反伤阴分。遂用甘麦大枣汤调治，再加百合、沙参连服 15 剂，五心烦热减轻，惟低热未退兼见难眠，故上方去沙参，加枣仁、朱砂、太子参，数剂而取效。（《福建中医药》1987）

按语：心肝血虚，脏阴不足之低热不退，本方用之有较好疗效。

327、【甘麦大枣汤干咳无痰医案】刘铁蕃：

万氏，干咳无痰，常发于夜半。每嗽须数十声，汗出始止。舌苔薄黄，口苦食少。此病乃脏躁化热，上乘于肺。龙骨 24 克，生牡蛎 24 克，小麦 9 克，甘草 3 克，红枣 3 枚，苦杏 6 克。服 2 剂立愈。（《刘铁蕃医案》）

注家按语：心脾阴亏，虚热乘肺，母病及子，治以甘麦大枣汤培土生金，加龙、牡、杏仁以镇心止咳。

328、【甘麦大枣汤盗汗医案】周意萍：

李某，女，5 岁。1988 年 7 月 28 日初诊。患儿 5 周前曾发高热，体温达 39.8℃，经治热虽退，但寐则汗出，盗汗，初以前额汗出为多，渐至全身大汗淋漓，曾服当归、六黄汤等罔效，睡眠不佳，且面黄消瘦，纳食不馨，口干心烦，神疲乏力，舌口少津，苔薄白，脉细微数。此系感受暑热，耗伤津气，心脾失其濡养，治拟益气健脾，滋阴养心，甘麦大枣汤加味：淮小麦、浮小麦各 12 克，朱茯神、太子参、麦冬各 9 克，五味子、炒枣仁各 6 克。炙甘草 5 克，大枣 6 枚。3 剂后，盗汗显减，睡眠亦安，余症均有好转，前方有效，加生谷芽 9 克，续进 4 剂，病瘥。（浙江中医杂志 1991）

按语：盗汗之症，多从阴虚内热论治，然小儿稚阴稚阳之体，脏腑功能未健，复受暑热之邪，伐伤津气，心脾失养，而致心液外泄而为盗汗，故当以益脾养心为先，若拘于成法，恣用清燥，反使心脾更伤，故拟甘麦大枣汤加味，补而不滞，药证相得，故收全功。

329、【甘麦大枣汤尿道涩痛医案】邵金治：

袁某某，淋证，女，48 岁，干部。初诊：1982 年 10 月 10 日，尿道涩痛，时轻时重，甚则尿频尿急，疼痛难忍，已有年余，久治罔效。患者形体清瘦，精神抑郁，心烦易怒，夜寐欠安，口干喜饮，舌红苔薄黄，脉弦细，证属心肝阴亏移热小肠，治宜育阴利水，养心安神，甘麦大枣汤加味：生甘草、生地各 15 克，大枣 10 枚，小麦、白茅根各 30 克，黄芪、淡竹叶、当归各 10 克。二诊：10 月 16 日，服前方 5 剂后诸证明显减轻，效不更方，续服 10 剂告愈，随访至今，未再发作。（《湖北中医杂志》1989）

注家按语：本案为心肝阴虚，志火内动，移热小肠。治病求本，以甘麦大枣汤加生地、当归养心肝阴血；以淡竹叶、白茅根利水通淋，治其标也。

330、【甘麦大枣汤小便不禁医案】张正海：

潘某，女 16 岁，学生，1984：年 8 月初诊。患者每见流动之水则小便不禁。经西医泌尿系统及化验检查均无异常发现，于 1984 年 8 月经介绍前来中医治疗。为验其病情，当即令其目睹杯水泄地之状，果然云已遗尿于裤内。查患者发育正常，似无病之人；望其舌质淡红，苔薄白；诊其脉左寸稍弱，余部皆平。虽属小恙，处方尚觉棘手，寻思良久，复究其因，方知两年前行打水时被恶犬惊吓，值时毫无不适，日久却见此疾。姑拟甘麦大枣汤加味，以观消息。药用炙甘草 15 克，淮小麦 30 克，大枣 8 枚，桑螵蛸 15 克，益智仁 24 克，生牡蛎 12 克。2 剂。越二日，其父来告，药后已不再遗尿。药已中的，勿需易辙，原方迭进 3 剂，以资巩固。（国医论坛 1987），按语：病发于惊恐，为情志所伤。《素问·举痛论篇》云“余知

百病皆生于气也，……恐则气下。”年方二七，肾气初盛，卒逢惊恐，气机下趋，恐能伤肾，开阖失司；肾为牝脏，主运五液，外水之动，亦从其类。又心主神明，职司五神，故恐动于心则肾应之，乃发斯证。治宜养心气以宁心神，固肾气以利开阖，故以甘麦大枣汤加味而收功。

331、【甘麦大枣汤泄泻(癔病性泄泻)医案】刘一民：

患女，34岁。发作性泄泻5年，有癔病发作史，稍触动则四肢拘急麻木，泄泻有加重之势，每食后半小时即腹泻3次，舌红苔薄黄，脉弦细。证属肝虚动风，脾失健运。拟养肝熄风，健脾止泻。甘草40克，淮小麦、白芍各30克，大枣20枚，生龙骨牡蛎各20克，僵蚕6克，桂枝2克。6剂后便次渐减，食纳增，继加滑石20克，枳壳10克。26剂后，诸症消失。(吉林中医药1985)

按语：肝阴不足，肝气横逆乘脾，致发泄泻，当抑肝扶脾为治，又泄泻起于精神因素(有癔病史)，故以甘麦大枣汤加味，以芍、龙、牡抑肝，草、麦、枣补脾宁心也。

332、【甘麦大枣汤闭经医案】王国璠：

王某某，女，35岁，1979年3月10日初诊。患者于18岁结婚，生育二胎，因在24岁分娩二胎时出血过多，自此月经一直未潮十一年，伴有头晕目眩，胃中嘈杂，神疲肢倦，腰膝酸软，两颧发赤，心悸，夜卧多梦，善太息，舌质淡红，苔薄黄，脉弦细。病由产后失血过多，血虚无以灌注冲任，心火亢盛，脾阴不足，拟甘润滋补以益心脾之法。处方：甘草10克，小麦30克，红枣15枚，每日1剂，嘱服半月。3月17日二诊：服上方10剂后，月经来潮，腰腹略有胀痛，经色正常，四天月经干净，诸证渐向愈。按前方续服一月，随访两年月经按期来潮，于1982年5月生一男孩。(新中医1984)

注家按语：《景岳全书·妇人规》谓：“凡妇人病损，至旬月半载之后，未有不经过者。正因阴竭，所以血枯，枯之为义，无血而然。”本案产后失血过多，肝血虚少，脾阴暗耗。津血两亏，经源枯竭，月水自然难于来潮。此证虽为虚证，不宜大补，虽有虚火，又不宜苦降，唯用甘麦大枣取其甘平之味，养胃生津化血以达胞室，使肝血得养，脾阴得滋，水火得济，则经自通矣。若妄投通行利滞之品，急切图功，即或能竭蹶一行，而血海益涸。

333、【甘麦大枣汤产后自汗医案】吴德熙：

泮某，产后自汗，38岁，产后一周，恶露量小，小腹疼痛，日间汗出津津，入夜盗汗如洗，醒后心神恍惚，极度疲乏，口渴引饮，饮食无味，舌淡、边黯紫、苔白，脉细涩，辨证为产后气血虚，营卫失调兼胞宫留有瘀血，方用甘麦大枣汤补益心脾，调和营卫以敛汗，佐生化汤祛瘀生新以止恶露。1剂后小腹不疼，汗少；3剂汗止，口不渴，饮食有味。(浙江中医杂志1982)

按语：吴氏认为，妇人产后自汗不止，或盗汗如洗，或口渴引饮，或渴不欲饮，系产后耗气伤血，心脾不足，营卫不和；阴阳失调居多。宜用甘麦大枣汤主之，阴虚偏重，酌加首乌、熟地、当归、沙参、麦冬、五味子；气虚偏重，加黄芪、白术、党参；兼血瘀者，和生化汤合用。

334、【甘麦大枣汤外阴瘙痒医案】邵金阶：

邹某某，女，40岁，护士。初诊：1985年8月6日。外阴瘙痒11个月，多方医治，均少效验。患者面色萎黄，头昏肢倦，梦多寐差，心烦易怒，口干纳呆，月经量中等，白带不多，外阴干燥瘙痒。证属肝血不足，生风化燥之阴痒证，治当补血以安神，滋肝以润燥，拟用甘麦大枣汤加味：炙甘草15克，大枣10枚，小麦30克，黄芪、当归、苦参各10克，茯苓15克，3剂，每日1剂。二诊：8月10日，精神转佳，痒减过半，宗前方继服6剂告愈，至今未发。(湖北中医杂志1989)按语：肝经之脉自足上行，沿腹内侧，入阴毛中，环绕阴器，血虚不能濡润肝经，生风化燥，故生阴痒。治用甘麦大枣汤加味有效。

335、【甘麦大枣汤多动症医案】孙浩：

刘某某，男，9岁。4~5岁时即有多动表现，近几年来有增无减，常因多动而跌破头皮

或损伤手足，上课时思想不集中，好做小动作，甚至在室内外走动。患儿形体瘦弱，但神情甚旺。询其饮食起居，寐则易醒，纳少，便干。脉弦数，舌红，舌中心见微薄白苔。小儿心肝之阳有关，心阳浮越，则神不守舍；风阳鸱张，乃动摇不止。予甘草 10 克，淮小麦 50 克，大枣 10 枚。服法：先将淮小麦淘洗干净，冷水浸泡 2 小时，主火煎煮至麦熟为止，然后加入甘草大枣再煎，须煎至枣烂易于去皮始可。令患儿饮汤食枣，上下午各 1 次。连服 3 个月，多动逐渐收敛，能安坐课堂听讲，学习成绩明显上升。（中医杂志 1994）

按语：钱乙认为小儿体质有“三有余”（心、肝、阳有余）、“四不足”（脾、肺、肾、阴不足），三有余似为本病的发病因素，其病理变化以心肝之阳偏亢为主，用甘麦大枣汤甘缓济急有一定效果。孙氏用本方治疗 6 例小儿多动证，均达本案治疗效果。

336、【甘麦大枣汤小儿夜啼医案】周意萍：

严某某，男，8 个月。1989 年 6 月 6 日初诊。近月余来，患儿每于深夜无故啼哭，乳哺、抚抱、轻摇均难使其安静，白昼如常。曾服多种中西药乏效。见其面色觥白，形体消瘦，常自汗出，哭声低怯，性情较躁，纳差，唇舌淡红，苔薄白，指纹淡红不显。证属心脾气虚，拟甘麦大枣汤加味：淮小麦 12 克，甘草 3 克，大枣 5 枚，茯神、龙齿、朱麦冬、山药各 9 克。药尽 2 剂，夜啼偶作，上方加蝉衣 3 克，再进 3 剂，诸证皆愈，夜啼未再复发。（浙江中医杂志 1991）

原按：夜啼，前贤或以脾寒而治以温散；或以心热而投以清降；或因受惊而资以镇摄。然临床上常见素体禀赋不足，或因热病之后，调理失当，脾气不振，心神失养，至夜而发啼哭，此时清、温皆非所宜，故笔者常投甘麦大枣汤以调理心脾，加茯神、龙齿、朱麦冬安神定志，每能一举获效。

337、【甘麦大枣汤小儿厌食医案】周意萍：

陈某某，男，9 岁。1987 年 5 月 25 日诊。患儿数月前因患热病后，出现食欲不振，每餐仅进食 1 两左右，前医曾投化湿消滞之品及保和丸之类，未见起色。情况：面色苍白，形瘦便干，夜寐欠安，舌淡，脉细乏力。拟健脾益气，养心安神。甘麦大枣汤合四君子汤加减：淮小麦 15 克，山药、党参、麦冬、茯苓、生山楂各 10 克，五味子 4 克，炙甘草 6 克，大枣 6 枚。另嘱每日以莲子煮羹进食。5 剂后，食欲渐开，药已中的，再进 5 剂，纳食香甜，余症也减，继以益气健脾之品调理。半年后随访，患儿一切正常。（《浙江中医杂志》1991）

按语：厌食多由饮食不节，喂养不当，或因病致脾胃受损，运化无力所致。然小儿脏腑清灵，易虚易实，既不任克伐，亦不可过补。本案前医采用香燥消积之品，克伐太过，而使脾胃之气难复，今拟甘润调养，心脾兼顾为法，故效如桴鼓。

338、【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】姜绍昆

夏成锡一脸兴奋地问：“姜老师，梦游症与《金匱》中的脏躁证有没有共同的病理基础？”我从来没有思考过这个问题，我也无法回答这个问题。

“梦游症是指睡眠中突然爬起来进行活动，一会儿又睡下，醒后对睡眠期间的活动一无所知的一种病症。它大多发生在小儿六岁到十二岁之间。脏躁证属于现代医学神经官能症的一种类型，更年期妇女发病较多，主要表现为表情忧郁，神志恍惚，悲伤欲哭，喜怒无常等。甘麦大枣汤证在脏躁证中比较多见。你用甘麦大枣汤加太子参治愈梦游症多例，也就可以说它们两者共同拥有一个方证。”我根据教材的内容泛泛而谈。

“姜老师，你有用甘麦大枣汤治疗过梦游症吗？”“我临床，上治疗过几例梦游症，用得较多的是甘草泻心汤，但没有用甘麦大枣汤治疗梦游症的经验。”

“我治愈了一个七岁男孩的梦游症。”原来夏成锡问我是有的放矢，并非蹈空之言。他眼睛发亮对着我说，“患儿是我外甥的儿子，三个月前发病，每天晚上一睡，下来不久就从床上爬起来，也不穿衣服，也不穿鞋子就在房间里乱走。第二天问他夜晚的情况，他一点也不知道。看过几个医院的医师，都说是梦游症，要家人在他发作时叫醒他就可以治愈。但是这个办法没有效果，依然每天晚上如此发作。这个患儿很消瘦，半年前因为夜里盗汗不止而

被我用一个民间单方治愈。所以我外甥就来询问我是否有什么办法。”

“噢，就是那个你用浮小麦一两加大枣十个而治愈的那个小孩吗？”“是的，那次吃了三天就好了。当外甥询问我有什么办法的时候，我就想这次的梦游症与上次的盗汗是不是有联系，就问外甥有关他孩子盗汗的情况。我外甥说，开始不注意，最近发现半夜盗汗还是很多。我突然想到《金匱》治疗脏躁的甘麦大枣汤。因为患儿消瘦所以加 20g 太子参，当时给他开了三帖。过了一天，外甥就打电话来，说是吃药以后当晚就一夜睡到天亮，没有出现梦游症，也没有盗汗。三帖以后就好了。为了巩固疗效，我叫外甥给他儿子连续服用了十帖。现在三年过去了，梦游症没有复发，大概是治愈了吧。”

他有这样的治疗成绩，我十分高兴。这也证明了经方医学力证相对的方法简易可行，只要捕捉到用方的主症就能取效。夏成锡有常人罕见的敏感性，所以一点就懂，并在实际中有了成果。我还有一事不明白，就问：“阿锡，你为什么想到用甘麦大枣汤治疗梦游症？”夏成锡不假思索地说：“我认为《金匱》脏躁症与梦游症都是神经系统的病变，它们虽然临床表现不一样，但是可以看成是相似的主症，所以治疗脏躁症的药方也可以治疗梦游症。这是第一个理由。”

同一个神经系统的病变，就把它看作是一个相似的主症，这种跳跃式的思维方法在受过正规教育的人会认为是一种逻辑的错误。我也还从来没有做过这样的联想，不过仔细想想也不是完全没有道理。夏成锡伸出右手的两个指头说：“第二，我认为‘脏躁’就是内脏的津液干燥，当然引起‘脏躁’的原因很多，这个患儿的原因就是长期的盗汗。‘脏躁，就是内脏的津液干燥’。中医学方面还从来没有听说过如此注释，但是从说文解字的角度来看也顺理成章，有所依据。夏成锡继续说：“第三，我已经用浮小麦与大枣治愈了患儿的盗汗，现在仍旧有盗汗的症状，上方依然可以使用，加一味炙甘草就是甘麦大枣汤治疗‘脏躁’，再加太子参益气生津，所以能迅速取效。”

339、【渔民夏成锡甘麦大枣汤梦游症】

去年秋天的一天傍晚，有人在我家的门口点香、烧纸钱。我就问他干什么？他说自己是一个安徽人，全家住在我的隔壁已经有好几个月了，由于他们起早摸黑外出打上，所以进进出出我们都不认识。他家的胖儿子今年十岁，发现夜间梦游症一年了，每天夜间起床到处乱跑，第二天问他什么也不知道，其他方面都正常，中西医屡治无效，所以在这里点香求求菩萨。我看他在家打工不容易，就毛遂自荐说：“这个毛病我能治疗，你带我去瞧瞧。”他很高兴，就带我去他的房子，我看见患儿在睡觉，满头大汗，就给他开了三帖甘麦大枣汤加黄芪 30g。第三天晚上，他登门道谢，说这帖药比仙丹还要灵验，才吃一帖就一夜平安无事。总共也就吃了三帖药，至今还没有复发。”

我对他的诊治思路与疗效都很感兴趣，就问：“加黄芪 30g 有什么根据？”“我对胖人的盗汗多重用黄芪。”

夏成锡从一个病患者渐渐地成为一个经方医学的爱好者，正因为没有正式行医，也就不存在职业中医师的许多矜持与拘谨，所以说话直来直去，不加掩饰。他对《伤寒论》与《金匱》的理解不一定都合理，但是也不乏精到之处。听了他的谈话以后，我改变了自己过去一些固化了的看法。譬如，过去我一直认为“一人一仲景，一家一伤寒”的涵义就是对许多注家各说一套的批评，批评有的《伤寒论》注家脱离临床，故弄玄虚。认为这样的“公说公有理，婆说婆有理”的现象，会把初学者置于迷惑阵之中不得自拔。然而听了他的一席话才发觉自己只是想对了一半，实际上“一人一仲景，一家一伤寒”的状态也无限丰富了经方医学的内容与不断开阔了经方医师的视野。尽管近两千年来，诸多的解释与理解人多是对仲景医学思想的误读，但是只要经过临床实践的检验并得到了证实，那么这种误读就是有价值的。

340、【用甘麦大枣汤治疗剧烈的头痛】矢数道明：

患者 55 岁，女，初诊于 1971 年 1 月。这次是 20 年来所患的头痛。近 3~4 年剧烈起来，去年 5 月起右眼像被挖出来那样痛。疼痛还扩大后头部，实在忍耐不住。消瘦，脸色苍白，

苦闷状，患者滔滔不绝地诉苦。早晨一起床头痛也就开始，中午、傍晚，一天疼痛不断。在医院内科检查，结果原因不明，三次脑电图检查都弄不清什么病。血压 120/80，脚冷、尿频，起夜小便 3~5 次。疼痛严重时右手掌抽搐发痛。

治疗：以前对偏头痛或三叉神经痛用五苓散常有效果，但此患者服五苓散却疼痛不减轻。患者继续诉头痛，有时手足很冷。我让她改服当归四逆加吴茱萸生姜汤，但无效。后来针对打喷嚏，流鼻涕而改服小青龙汤，但也无效。有时针对头痛和眩晕改服半夏白术天麻汤，但也无效。以后改服藤平健先生发表的桂枝人参汤，但对这位剧烈头痛的患者都没有疗效。

有一次患者来院说头部中心像被绞那样，像眼睛深部被针扎那样疼痛，我让她服对神经症疼痛有效的抑肝散加陈皮半夏但仍然无效。患者说忍耐不住，有时候去扎针，有时候去医院检查。还服过治疗阴虚头痛的吴茱萸汤或服清上蠲痛汤，但都无疗效。

1971 年 10 月患者说：近来头痛从右下牙龈开始向头中针扎进去那样痛。很可能病牙是其原因，因而改服五味立效散。我正等待着出观奇效，但仍然无效。改服七味立效散也无效。

我又让她服对牙龈痛有效的桂枝五物汤，仍然毫无疗效。患者在 1972 年 4 月住入某医科大学附属医院脑血管造影时检查出浅侧脑动脉血管炎并进行了颅内手术，两次进行烧灼，但还是无效。服该医院的西药，结果呕吐不止，走路摇晃跌倒。患者害怕起来不敢吃西药。由于西药治不好，过了半年在 1972 年 9 月 12 日又来到我院。

患者诉说疼痛从右下腭部牙龈开始，该处像被挖出那样的感觉，像针扎那样疼痛，从该处向右头中心部疼痛进一步扩展。听她的诉说，真令人同情，每次来院患者都哭着来说只有来到这里治疗，再也没有地方去了，患者说：您无论如何也得想办法给我治啊！患者左腹直肌紧张。1973 年 5 月 4 日我想到此患者属甘麦大枣汤证：“妇人脏躁（瘵病），喜悲伤，欲哭，象如神灵所作”。服该药 20 日后初诊以来两年半，第 1 次头痛减轻。再服两周，患者来院说：头基本上不痛，只是牙龈像轻轻地被碰了一样感觉。患者说，这一点痛，只要到附近一个县的健康村取药服就会好的。以后的经过如何不能判断，但甘麦大枣汤有效这一点是确实不能否认的。

341、【甘麦大枣桂枝加桂汤合方治面赤筋胀浑身大汗悲伤欲哭】陆渊雷：

一家小本经商的江北人。来报急病，要求拨号出诊。去时，见病人是四十岁左右的妇女，盘膝坐在地板上，三数人扶持之中，闭着眼睛张着嘴，面赤筋胀，浑身大汗，望她胸脯的呼吸，只见一阵阵上气，不见下气。抚她下额，试使闭口，则僵硬如石，再也闭不拢来。摸她肚子，皮肉一块块虬结起，形状委实可怕，热度大概高起一度左右，脉象舌色，却甚平和。方持脉时，旁人慰之曰：“先生来了，来搭救你，你有命了。”病人则张目微仰其头，做困苦求救状。告以“病尚可治，安心服药，可以即愈”。则复闭目俯头，做感谢状。因其闻言能表示态度，知其神志自清，并非中风脑出血。细问既往症，据云十年以前有宿病，常常发厥，十年之内久不发，近因新殇幼女，时时啼泣，顷中饭时忽然泪下，放下饭碗，即便发厥。自始发厥至诊察，不过两小时。在下因其病有发作性，断为脏燥，又以其冲逆挛急特甚，遂用甘麦大枣桂枝加桂汤合方，桂汤用四钱。明日上午，病人安然来复诊。适门诊甚拥挤，病人与其他候病者杂坐闲谈，喉咙甚高，满耳朵“拉块拉块”，叫得在下烦躁起来。戏之云：“替你医好了病，不知言谢，反来高声拉块，使我头疼，是何道理？”因问其服药情形，据云：“药下刻许钟，即困倦思睡，扶上床去酣眠。黄昏醒来，病已霍然若失。”这两案皆是桂枝治冲逆的事实。在下因此格外听信张仲景与吉益东洞，知他们决不哄人。

342、【甘麦大枣汤治无故悲泣不止】

《本事方》云：乡里有一妇人，数欠伸，无故悲泣不止，或谓之有祟，祈禳请祷备至，终不应，予忽忆《金匱》有一症云“妇人脏燥，悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸者，麦大枣汤”，予急令治此药，尽剂而愈。古人识病制方，种种妙绝如此，试而后知。

343、【甘麦大枣汤治遇昼则惨戚悲伤】

《妇人良方》云：乡先生程虎卿内人，妊娠四五个月，遇昼则惨戚悲伤，泪下数次，如

有所凭，医与巫兼治，皆无益。仆年十四，正在斋中习业，见说此证，记忆先人曾说此一证，名曰脏躁悲伤，非大枣汤不愈，虎卿借方看之，甚喜对证，笑而治药，一投而愈矣。

344、【甘麦大枣汤硝石大圆治腹皮挛急小腹有块】

《古方便览》云：一妇人，年二十八，无故悲泣不止，余诊之，腹皮挛急，小腹有块，即作此方及硝石大圆与之，四五日而痊愈。

345、【甘麦大枣汤治笑不止】

方輿輗云：此方《金匱》虽主妇人脏躁，然不拘男女老少，妄悲伤啼哭者，一切用之有效，凡心疾急迫者，概可用也。近有一妇人，笑不止，诸药无效，于是予沉思，笑与哭，是皆病出于心，因与甘麦大枣汤，不日而得愈。

346、【甘麦大枣汤治小儿昼夜啼哭不止】

方輿輗云：某小儿，昼夜啼哭不止，甘连紫丸芍药甘草等无寸效，试与甘麦大枣汤，一两日而止。自后用此治小儿啼哭甚多，此本疗妇人脏躁悲伤之方，然有利于婴儿又如此。凡药，无老少男妇之别，方书所标，云妇人，称小儿者，切勿拘执。

347、【甘麦大枣汤治发痴狂呼妄骂】

《生生堂治验》云：某女，妊娠至五月，患水肿。及分娩，尚甚，尔后发痴，狂呼妄骂，昼夜无常，将脉则张目举手，势不可近，因与甘麦大枣汤，服数百帖，渐渐得复故。

348、【甘麦大枣汤治之子宫痛】

《洛医汇讲》云：一妇人，年二十四五，尝患疾症，愈后，乃患一种奇症，请予诊之。诊脉候腹无大异，饮啖便溲亦如常，但其月水，时或愆期云，于是诊毕。俟少顷，病妇自告曰“今病方将发矣”，趋就枕席，则其喉内有一种声响，非喘非哮，非呕非噫，不可名状，作甚苦闷烦扰之态，继而左手拇指自然回转旋戾，如木偶戏之机关，渐次遍及五指，互相回转，次则腕臂肩，而上足跗胫腿，而上手，而左脚，以及眼球鼻尖两耳头颈腰髋，皆顺次回转振摇。予于是提其掌曰：“有是哉，汝之病情，余今尽得之矣”。征之仲景所说妇人脏躁，若合符节，而兰医（案日本先与荷兰人通商，其西医亦先从荷兰传入，故曰兰医）乃谓之子宫痛，即投以甘麦大枣汤，一二日而神志条畅，不旬日即不复发。其后两三年中，更试治二妇，亦随愈。

349、【栀子厚朴枳实汤合甘麦大枣汤治郁证精神失常医案】萧美珍：

任某，女，26岁，干部。1982年4月5日初诊。2年前因情志不遂致精神失常。发病前先觉胸中烦乱异常，脘腹胀满，坐卧不安，时常悲伤啼哭不能自控，继而两目不睁，呼之不应，移时症消如常人，1周或半个月发作1次，遇精神刺激则发作更趋频繁。某医院诊为“癔症”，经暗示治疗稍好转。近月来诸症加重，精神恍惚，终日烦闷不安，哭笑无常，口渴纳差腹满，尿黄便干，经色黑量少，经期正常。舌质红、苔黄，脉弦数。诊为郁证。证属肝郁化火，上扰心神。方药：栀子15g，厚朴12g，炒枳实10g。每日1剂，水煎服。10剂后自感腹内舒适，情志舒畅，食欲增进，舌红、苔黄，脉数。继以上方合甘麦大枣汤，进20剂后症消病除，随访已结婚生子，至今未复发。（湖南中医学院学报）

现代临证：栀子厚朴汤现代应用于杂病食积化热、急性胃肠炎、消化不良、肝胆疾病等疾病，凡栀子豉汤下所列诸证，病位偏下，界于脘腹之间者，可用本方治之。

罗按：此病证，有心烦而腹胀满的栀子厚朴枳实汤证，也有时常悲伤啼哭的甘麦大枣汤方证。

350、【洪氏用百合知母汤合甘麦大枣汤治疗失眠60例】

方药：百合20g，知母10g，炙甘草10g，淮小麦30g，大枣6枚。治愈（症状消失，每日睡眠时间大于6小时）。30例，显效（症状明显改善，每日睡眠时间4~5小时）。9例，无效（症状无改善，每日睡眠仍少于2小时）。6例，总有效率为90%。[洪燕.百合知母汤合甘麦大枣汤治失眠60例疗效观察.江西中医药]。

351、【百合滑石散合甘麦大枣汤加味治分手后失眠医案】

王某，女，22岁，2019年4月24日初诊。主诉：失眠月余，患者因与恋人分手后情绪

不佳，夜难成寐，后因学习压力过大，失眠加重。刻下症：面容倦怠，两颊微红，乏力，喜泣，手足心热，善太息，纳呆，厌饮，小便稍黄，大便坚，舌红苔薄黄，脉弦细数。

中医辨证：脏躁。方选百合滑石散合甘麦大枣汤加味。处方：百合 15 克，竹茹 10 克，滑石 15 克，炙甘草 6 克，小麦 30 克，大枣 10 枚，夜交藤 15 克，生地 12 克。5 剂，每日 1 剂，水煎 2 次合并分 3 服。

二诊：头痛，纳呆，口干，大便干结，2 日解 1 次，小便可。余症皆有缓解。后将夜交藤换成木香 10 克，石菖蒲 6 克，郁金 6 克。

三诊：症状皆有所改善，后随诊问之服药期间小便量未增。

按：滑石解热之力胜于利尿，湿困中下焦者可祛湿利尿，而阴虚热扰者用之则多清热而不伤阴。

代赭石。《金匱要略》各版教材皆认为滑石代赭石汤乃服苦寒泻下之品后损伤胃气，而出现胃气上逆、呕吐呃逆诸症，故以代赭石降胃止呕，取旋覆代赭汤之意。但旋覆代赭汤里代赭石用量是一两且入汤剂，而本方代赭石为如弹丸大一枚。根据对古代用药剂量的考证，代赭石如弹丸者一枚远小于旋覆代赭汤中代赭石的剂量，故认为滑石代赭石汤乃取代赭石之性。

《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》云：“得药则剧吐利。”近代医家黄竹斋云：“既云下后所得，则必有大便下利，小便不通之见证，故佐以代赭石之固肠止脱，以治大便之下利”。《日华子本草》载：“月经不止，反胃，止泻痢，脱精，尿血，遗溺。”故知代赭石有涩肠之功，可治“得药则利”。张锡纯亦云：“其生研服之不伤肠胃，即服其稍粗之末亦与肠胃无损。”故下后脾胃虚弱者用之无妨也，所以代赭石在滑石代赭石汤中当取涩肠固脱，降气除热之功。

352、【酸枣仁汤合甘麦大枣汤抑郁症】

李某，女，46 岁。2007 年 11 月 26 日初诊。患者 3 年前无明显原因出现心情郁闷、憎恶他人及厌恶人生，曾在当地医院诊治，各项检查均为正常，诊为抑郁症，服谷维素、维生素 B1 等效果不佳。近半年情绪愈加难以自控，失眠多梦，故前来诊治。症见：失眠多梦，情绪低落，急躁易怒，困倦乏力，手足心热，胸背恶寒，大便干结。舌红、少苔，脉细数。证属阴血不足，心神被扰。治宜滋阴养血，养心安神。方予酸枣仁汤合甘麦大枣汤加味。处方：酸枣仁 20g，白芍、知母、柴胡、枳实各 12g，茯苓 10g，川芎 9g，淮小麦 15g，大枣 5 枚，生甘草 5g。每天 1 剂，水煎 2 次，分 3 次服。6 剂。二诊：心情略有改善，大便通畅，前方又服 6 剂。三诊：睡眠增加至 4 小时，手足心热亦除，心情愉快，续服 6 剂。之后，以前方辨证加减再服 15 剂，诸证悉除。

注家按：本例患者失眠多梦，情绪低落，手足心热，大便干结，为阴血不足，虚热内扰，心肝失养，神识不能自主所致。故选用酸枣仁汤与甘麦大枣汤合方加味。方中酸枣仁益血养心，安神定志；茯苓宁心安神；知母清热除烦；柴胡、枳实疏肝解郁，调理气机；白芍、大枣滋阴养血；川芎行气理血；淮小麦补益心气；生甘草益气和中，调和诸药。诸药合用，共奏养心宁神、清心除烦之功，故获佳效。

353、【酸枣仁汤治哭骂不休夜不睡觉神志失常医案】张孟林：

鲍某，女，12 岁，学生。1982 年 9 月 9 日就诊。患儿精神失常半年，被迫停学。据其母说考试不及格被其父责骂两次，其后到处乱跑，哭骂不休，夜不睡觉，神志失常，大小便不避人群，服药不效。舌淡苔腻，脉律紊乱，此乃情志内伤，心神紊乱，故以酸枣仁汤加味：炒枣仁 12 克，知母、茯苓各 9 克，川芎、甘草各 6 克（甘草用朱砂拌），3 剂。

复诊：服后症状改善，哭闹妄动减少，坚持服 10 剂症状控制。故原方茯苓改茯神，甘草不在用朱砂拌，服 30 剂症状全控制，可照常上学。

罗按：酸枣仁汤，治虚劳虚烦不得眠。烦与不得眠皆与神经官能证相关。故此患儿当见虚劳证。而“烦”之一证，可当作“精神失常”之轻证。

354、【酸枣仁汤治经常夜间抽风医案】张孟林：

陶某，男，7岁。1983年9月17日就诊。患儿近半年经常夜间抽风。近日白天亦发。四肢抽动，上肢为重，每次数分钟，不吐白沫，神清疲倦颈软，舌淡红、苔黄腻，口苦，脉弦细。此乃肝胆湿热，扰乱心神，治宜利胆静心。方以酸枣仁汤加味：人宝（人胆结石醋泡三天以上可用）15克，炒枣仁10克，知母、茯苓、川芎各8克，甘草6克，煎后加藕汁15毫升。3剂。复诊：服药后尚可，白天惊平，夜仍有复发，故再服10剂，晚上亦平。

罗按：“抽风”与神经官能证相关。

355、【酸枣仁汤治惶恐不安且颤抖不已医案】于德正：

张某，男，38岁。1968年12月5日诊。患者被推入诊室，惶恐不安且颤抖不已。时而东张西望，欲伺机逃走；时而嘘唏长叹，以头撞壁，欲寻自尽。家属代诉：患精神分裂症已十年，自认为遭亲属及他人陷害，时有被捕被害之虞。曾长期服氯丙嗪及化痰安神类药品，病势时轻时重。肤略瘦而多灰垢，面觥多青，眩晕，烦躁不眠，舌质淡红，舌苔中后稍有灰浊腻略干，爪甲枯白扁平，脉弦细。此乃肝血虚损，魂失所养而浮越，复为浊痰乘间袭其舍而致也。予酸枣仁汤加枳实、胆南星各9克以助茯苓化痰清舍。俾肝血充，则浮魂得养而必敛；浊痰祛，则舍清而魂可归宅。服药30剂，被害妄想开始动摇，惶惧及虚烦不眠之象亦大减；且肌肤渐洁而有润色，舌上浊苔亦去。于上方去枳实、胆南星，加龙齿30克。又服40剂，被害妄想消失。夜寐佳，神情怡然。后以上方制丸，嘱续服10个月以巩固之。至今已17年未复发。

356、【酸枣仁汤治肝豆状核变性头部与右侧肢体皆震颤不眠医案】丁德正：

尚某某，女，23岁，未婚。1981年1月5日诊。患肝豆状核变性已七年，头部与右侧肢体皆震颤，手足强直拘挛，并发精神障碍，性情急躁，虚烦不眠，幻听颇重。自谓为人所嘲讽与辱骂，惶惧焦虑，坐卧不安，常且哭且骂。肌肤瘦削而干枯，面色萎黄，有黯紫色斑，双目干涩而昏，有棕色“角膜色素环。”爪甲枯白扁平，舌淡红，舌边有青色斑点，脉细涩。此乃肝血虚挟痰之候也。予酸枣仁汤，加红花3克，郁金9克，以助川芎活血化瘀，通肝调荣；并加龙齿、灵磁石各30克以镇敛浮魂。服药25剂，幻听大大消失，虚烦不眠之象亦减；继服30剂，幻听尽失，夜寐亦安。且肌肤略润，面部黯紫色斑及舌边青斑渐退。肢体震颤及手足拘挛亦稍减。上方去红花、郁金、龙齿、磁石，又稍事加减，迭进150余剂，病告痊愈。随访至今，情况良好。（以上四案见《河南中医》1987；（1）：21）总按：据丁氏家传经验，酸枣汤用于各种精神障碍症之属于肝阴（血）不足者，有良好效果。

357、【酸枣仁汤治经常夜间不眠不自主地运动自语不休医案】张孟林：

乔某，男，11岁，学生。1982年10月14日就诊。患儿经常夜间不眠，不自主地运动，自语不休，有时睡着后突然起床，下地走动，不抽筋，不跌倒，家人不知所然。白天除精神疲倦外，意识清楚，学习尚可，纳食正常，二便通畅。无其它反常，近因发作频繁，用西药镇静而症状不能控制，故来求治于中医。证见体质尚可，意识正常，舌质淡红，脉数。此乃心阴不足，心气有余所致之夜不安而动，治宜滋阴养血，宁心安神。

方以酸枣仁汤加味：鲜猪心一具，炒枣仁12克（打），知母9克，茯苓10克，川芎、甘草各6克，米泔水煎，每日午后、傍晚各服1次，1日1剂。服上方5剂，症见减轻，已能安睡，偶尔复发，时间亦短，舌脉已和，故守服5剂，症状控制，随访3月尚安。

358、【甘麦大枣汤治脏躁病案】：

王某，女，25岁，唐林村人。经常无故悲哭，寡言默语，神志呆滞，已逾四月。因田畴歉收，家境不丰，治疗一拖再拖，病情愈演愈重。近缄口不言，形同木偶，或嗤嗤向人苦笑。经反复慰导，偶亦回答一二。视其舌，淡红少苔，诊其脉，沉弦有力。观其脉症，知为脏躁，由忧虑而得。张景岳云：“至若情志之郁，则总由乎心，此因郁而病也。”治宜舒肝解郁，养心通窍，再延不治，将成癥矣。拟逍遥散加味：柴胡12g，白芍15g，当归10g，白术10g，薄荷3g，甘草4.5g，茯苓10g，麦冬10g，竹叶6g，郁金10g，石菖蒲10g，三剂。

二诊：神志虽明显好转，然尚不能问答如流，每天仍有神情恍惚、悲哭发作。《金匱要略》云：“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之，”故合二为一。上方加甘草 5.5g，小麦 30g，红枣 10 枚，三剂。

三诊：病情大有改观，仅偶尔悲哭，因褐衣疏食之家，钱来不易，嘱服甘麦大枣汤善后。并慰以宽言，以去杞忧。2. 失眠邓某，男，40 岁，公社食堂炊事员。因人多齿繁，薪水微薄，入不敷出，百忧集结，杂绪萦怀，辗转床褥，竟夕不寐。鲁米那、利眠宁服之不应。白昼则百无聊赖，愁恨难遣，若住无边苦海。于 1978 年 9 月 4 日来诊。观其面色黯淡，神情呆滞，舌淡红，苔薄白。询知茶饭无味，二便正常，喜呵欠，时太息。诊得脉象沉弦细。沉主内，弦主郁，细主虚。为忧思过度，心脾两伤之脏躁也。拟：甘草 10g，小麦 30g，红枣 10 枚，五剂。邓以药价低廉，认为与敷衍塞责。经再三解释，勉强服之岂料，三剂后竟酣睡如昔。（《经方躬行录》）

359、【酸枣仁汤治患焦虑性神经症医案】丁德正：

医案：李某某，女，24 岁，已婚。1980 年 5 月 7 日诊。患焦虑性神经症已五年，诊前月余症象加剧。自谓“病重危在旦夕。”故惶恐焦虑，紧张万分，烦躁不眠，悲泣不已，频呼“救命”。诊时，惶惶然频频询问：“我是心脏病？治不好吧？”余虽再三解释，然其惶惧焦虑之情，终难尽释。患者肤瘦面觥，双颧微红，间或午后潮热，口干咽燥，舌红苔少，脉细数，头晕，目昏，肢体麻木，爪甲枯白凹陷。

诊为肝阴不足。予酸枣仁汤，服药 25 剂，焦虑惶惧及虚烦不眠之象大减；继服 20 剂，虚烦止，夜寐佳；焦虑尽失。后于上方酌事增损以制丸，嘱续服 8 个月以资巩固。据访，现健康如常。

360、【酸枣仁汤治患者精神沮丧患忧郁症医案】丁德正：

梁某某，男，28 岁。1976 年 4 月 27 日诊。患者精神沮丧，垂首向隅，频频太息，且啜泣不已。唤其就诊，潸然泪下。言：“我已变笨，成为废物，徒为家人之累赘。且耳已聋，目已昏，爪甲枯白。命既如风中残烛，治之复何益哉？”据查，患忧郁症已四载，曾屡服疏郁悦神一类药物，罔效，形容枯槁，面白而惨，唇舌色淡，脉弦细，虚烦少眠。此乃肝血虚所致。盖肝血虚，肝气失养，则“将军之官，一反其气急多动，志坚刚强之性，而为怠惰志馁，懦怯抑郁之态。治宜补肝血。予酸枣仁汤，服 15 剂，忧郁减半；且肤有润色，虚烦少眠之象亦减。继服 20 剂，忧郁消失，夜寐转佳，后以上方制丸，嘱续服六个月以巩固之。随访至今情况良好。

361、【酸枣仁汤言语恍惚恶食不寐】

少司马讳雅尔图，以扈从打围至德州，抱病给假回京。医投小陷胸汤一剂，顿即仰卧，神昏不语。又一医进参三钱，神气稍苏，言语恍惚，恶食不寐。延诊，雅云：素有肝病，遂述前方。按左关脉平和，惟心部空大。此心家之疾，与肝无涉，用酸枣仁汤而愈。《续名医类案·内伤》

362、【酸枣仁汤治疗癫狂】：

患者，女，21 岁，因精神受刺激过度，整日情志抑郁，悲伤无度，心烦不眠，入睡时常作噩梦，心惊胆怯，时而惊醒，醒后冷汗淋漓，近日病情加重，昼夜徘徊唠叨，无故哭泣，吵闹，躁动不宁。刻诊：表情淡漠，二目直视，舌红少津，脉弦细。证属思虑过度，悲伤至极，暗耗阴血，肝血不足，心失所养，神不守舍。宜补肝养血，安神定志。予酸枣仁汤加味：酸枣仁 45g，茯苓（朱砂拌）30g，川芎 10g，知母 10g，甘草 6g，珍珠母 24g（先煎），龙齿 15g（先煎），玳瑁 10g（先煎），远志 12g，玄参 20g，丹参 15g，大枣 7 枚，淮小麦 30g。每日 1 剂，水煎，分早、晚 2 次服，药进 9 剂痊愈。随访 2 年未复发。

363、【酸枣仁汤合黄连温胆汤治疗忧郁症】

雷某，女，41 岁。2009 年 2 月 18 日初诊。患者因长期家庭不和，而出现神志恍惚，失眠，食欲不振等症状。西医检查后诊为忧郁症，经西药治疗数月未瘥，而转来我处就诊。症

见：不寐，胸闷，心烦，口苦，食则欲呕。舌红、苔浊黄厚，脉弦滑数。证属胆胃不和，痰火上扰。治宜清热化痰，安神除烦。方予酸枣仁汤合黄连温胆汤加味，处方：法半夏、枳实、竹茹、知母、石菖蒲各 10g，茯苓 15g，酸枣仁、郁金各 12g，川芎、远志、陈皮各 6g，黄连、甘草各 5g。每日 1 剂，水煎 2 次，分 3 次服。5 剂。药后诸症减轻。原方加减继续治疗近 1 个月，诸症均除，随访半年未再复发。

第二十三章 柴胡加龙骨牡蛎汤方证

364、【柴胡加龙骨牡蛎汤调瓜蒂散治幼患癫痫长而益剧】

《生生堂治验》云：一妇人，幼患癫痫，长而益剧，立辄晕倒，少时始苏醒者，日一二次，如此三十余年，众医杂疗而无效。其主人偶闻先生之异术，乃来请治。往诊之，脉紧数，心下硬满，乳下悸动，谓先生曰：心神惛惛，虽饮食须臾不得安，数十年如一日也。视其颜色，愁容町伶。先生慰之曰：病可治也。病妇信以为实，乃服柴胡加龙骨牡蛎汤，精神颇旺，又调瓜蒂散五分，吐黏痰数升，臭气冲鼻，毒减过半，或五日六日一发，凡期年而痊愈，其间行吐剂约十六度。

第二十四章 防己地黄汤方证

【原文】：病中风，如狂状，妄行，独语不休，无寒热，其脉浮者，宜防己地黄汤。（依涪古本补）

病因和病机：血虚生热，邪并阳分，血热而风胜

辨证依据：狂状，妄行，独语不休，无寒热，其脉浮者

注家曰：《内经·癫狂》篇说：“癫疾者，疾发如狂者，死不治。”但“死不治”，也并非绝对不治。有关癫证治疗，叶天士认为当分虚、实，“癫之实者，以滚痰丸开痰壅闭，清心丸泄火郁勃；虚者当养神而通志，归脾、理中之类主之”（《临证指南医案》）。防己地黄汤所主之癫证，为血虚生热，邪并阳分所致，故现“如狂”之阳分征象，“其脉浮”，正是血虚受风之标志，总属本虚标实，虚中挟实之候，故治疗当以养血清热，祛风散邪为法。本方重用生地，并绞浓汁，侧重入阴分以养血清热；轻用防己、防风、桂枝，并浸于酒内，在于取轻清之性，入于阳分以散风祛邪；甘草和中补气，调理阴阳。待阴分血充，则阳分风熄。阳分风去，而阴分自安。临床上，防己地黄汤不惟治精神情志之疾病，凡属“血虚受邪”者，皆可化裁使用。

赵以德曰：狂走谵语身热，脉大者，则阳明。若此无寒热其脉浮者，血虚从邪并于阳而然也。《内经》曰：“邪入于阳则狂”，此狂者谓五脏阴血虚乏，魂魄不清，昏动而然也。桂枝、防风、防己酒浸其汁用，是轻清归之于阳，以散其邪。用生地黄之凉血补阴，熟蒸以归五脏益稍养神也。盖药生则散表，熟则补衰，此煎煮法也，又降阴法也。阴之不降者，须少升以提其阳，然后降之方可下。不然则气之相并，不得分解矣。

徐忠可曰：此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滞涎，涎滞则留湿，湿留雍火邪聚于心。故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火，凉血热。谓如狂妄行独语不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚不疑耳。后人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。

倪海厦曰：防己地黄汤，治病如狂状，妄行独语不休，无寒热，其脉浮。这个处方，并不是真正的我们在治疗中风用的。突然跑出一段出来，我们就把它放在这里，按照他的顺序。我讲过你如果读伤寒《金匮要略》突然跑一段出来你也不要怪他。那这个我们治病如狂，

妄行独语不休有两证，一个实一个虚。中医辨证大家只要掌握八纲，阴阳表里，阴阳表里虚实寒热。

实证，一个人走在马路边，你看他奇怪一个人自言自语讲话，一个人走来走去晃来晃去，然后自言自语讲话，如果是实证的时候，大承气汤证。这个大承气汤，因为大便的沼气跑到脑部去了，那这个人就是妄行独语不休，甚而至于会更严重的会发狂奔走，衣服一脱就跑这样，很严重，拿刀去杀人，里面全部是大承气汤证。那你如果说这些人不会讲话，那你就稍微忍耐一下跑到厕所去看，小便是黄的全部是大承气汤证，小便出来白的就是防己地黄汤证。那这个，没有寒热，其脉浮，这个就是防己地黄汤，因为防己地黄汤是补虚用的，所以他的处方方法很特殊，用酒一杯把这个防己、甘草、桂枝，防风。这些东西，把它用酒泡一下，泡一下以后再绞汁出来用那个把它挤出来。生地黄，重用了生地黄，因为生地黄是补血，生地黄你看用它稍微蒸一下，然后用它煮米蒸米一样，再把那个绞地黄汁，在铜器里面跟前面的汤汁混合在一起，所以里面实际上只有生地黄真的去蒸了一下，蒸下去也是绞汁出来，其它的泡酒以后再绞汁出来用的。这里比较生用，比较生用。那我们用酒去制过以后，泡过以后的药，比如说我们常常讲大黄，因为大黄生用的时候攻下力量很大，所以大黄又叫做将军嘛，很强。你吃那个大黄下去大便都不出来，肯定是有那个大肠癌，有肿瘤堵到了。一般来说大黄吃下去一定出来，那如果用酒泡制过大黄的话就不会了，炮制过，它就会比较温，他那个性就不会往下走，性会有比较升提的性，升提的性，就不会跑出来。

防己地黄汤方：

防己、甘草各一分，桂枝、防风各三分

上四味，以酒一杯渍之一宿，绞取汁。生地黄二斤，釜咀，蒸之，如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

《千金方》：风眩门防己地黄汤，治言语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。防己、甘草各二两，桂心、防风各三两，生地黄五斤别切，勿合药渍。疾小轻用二斤。

上五味，釜咀，以水一升渍一宿绞汁，著一面取滓著竹箬上，以地黄著药滓上，于五斗米下蒸之，以铜器承取汁，饭熟以向前药汁合绞取之，分再服。

徐灵胎曰：此方他药轻而生地独重，乃治血中之风。生渍取清汁归之于阳以散邪热，蒸取浓汁归之于阴以养血，此皆治风邪归附于心，而为癲痫惊狂之病。与中风、风痹，自当另看。又曰：凡风胜则燥，又风能发火，故治风药中，无纯用燥热之理。此方他药轻而生地独重，治血中之风也。

365、【防己地黄汤治失心疯探秘】高齐民：

防己地黄汤，几味治风寒湿的药怎么会治癲狂症呢？殊不知此方之妙，妙就妙在“不安神而神安，不治狂而狂自愈。”1960年，宋老向我传授《金匱要略》经方的用法时，告诉我，他在广州行医时不止一次用此方治疗“失心风”，奇怪的是，病人痊愈后告诉他：“你这个药能‘开悟’，我比吃药前聪明了好多。”

1962年春节，我应邀到怀柔黄花镇村做客。当天晚上，村支部委员来找我，请我给看一个狂躁型精神病病人。我问他，什么原因疯的，他说，秋天收板栗的时候，此人从地里回来，衣服鼓鼓的，村外站岗的民兵告诉我，他偷了板栗，因此人是个老前辈，不好问他，可在全村流传开来，说他偷了板栗。老前辈听说，向村委会说明，是他从板栗沟回来时，又拐到自留地拔了几个萝卜，还摘了一个小南瓜，根本一个板栗也没偷。不管老人怎么解释，满村人怀疑他偷板栗之言风愈传愈烈。老人一生耿直，一气之下疯啦。晚秋每天晚上出去，谁家自留地菜都给拔掉。为了防止他再祸害村里人，派民兵用铁链把他锁起来，直到大年三十才把他放出来。初一，他到别人家拜年，把祭祖的馒头装在裤裆拿走，害得全村人都怕他。我说，我现在是一个未毕业的学生，但父亲善治精神病，我学得不好，你带来我看看，能治我就给开药治疗。

不一会，两个民兵把病人押来，我让病人坐下，诊完脉，我说：“我给你开个方试试”，病人马上说：“我没病，不吃药，只想喝酒”，我笑着回答：“我给你买酒喝”。病人走后，我开了防己地黄汤：防己 9g，防风 9g，桂枝 9g，生地黄 100g（另煎），甘草 9g，5 副。告诉病人家属，把防己、防风、桂枝、甘草泡在酒里一宿，把生地放入大碗里，蒸一顿饭功夫，然后找个铜盆洗净，将两种药汁倒在盆内混合，温服，1 天 1 副药，还只吃 1 次。病人家属后来告诉我，吃完 5 副药，疯病就好啦。我先后用防己地黄汤治“失心风病”好几例，都很快能好。

防己地黄汤原为酒浸水煮法，我改用水煮法，温服时加酒 1 杯，疗效不变。

防己地黄的方解：失心风，多发生于肝郁难以疏解，卒然暴发，失去理智。防风疏肝解郁，疏所郁之肝气。防己利湿，湿去则痰不生，先防痰迷心窍。桂枝通心阳、伐肝气；肝木最怕桂枝，所以有“木得桂而枯”之说。生地甘寒养心阴，安心神，心安，神才能藏住；生地大剂量能清肝郁所化之热，热泄，神欣然而安。甘草调和诸药。所以，防己地黄药能“不安神而神自安”。

我常用它治疗肝郁不疏引起的失眠，配百合地黄汤治疗更年期抑郁症，合酸枣仁汤治难以入眠症。若在防己地黄汤中加半夏秫米汤，都是安神定志、促进睡眠的好方药。

从药论该方之功用，确能治痹，治类风湿性关节炎，但非防己地黄汤之主治。直到 1984 年《河南中医》刊登丁先生用防己地黄汤治疗 4 种精神病的报道，读后让我敬佩不已。

366、【防己地黄汤治癲证医案】高齐民：

周 XX，女，16 岁，汨罗公社茶南大队人。因患慢性血吸虫病，1964 年收入省血防试点组进行归剂 20 日疗程治疗。因其入院较晚，同病室的病友都先后出院，室内只剩下她一人。一日深夜，电闪雷鸣，风雨大作，霎时树摇窗动，少女惊怕交加，又忽然记起村人常讲，诊室窗外大树上曾吊死一人，顿觉毛骨悚然，蒙被战栗，彻夜未眠。翌日精神欠佳，苦愁少语，后渐渐精神失常，时而痴呆，时而哭笑无常，欲自杀。经二次电疗后，近来静卧不语，不知饥饱，天黑不能离灯，日落不能离人，六脉柔中带弦，舌苔薄白稍腻。

经云：“惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣”。气乱生风，风逆于少阴，故发为癲。法当滋阴平肝，安神潜阳。方选防己地黄汤加生龙牡。防己 10g，生地 30g，防风 10g，桂枝 6g，甘草 6g，生龙牡各 30g。三剂，水煎服，每日一剂。

二诊：其母代诉说：服药后，精神不再痴呆，能帮母亲做点家务，有时还敢到大门口站，夜晚睡觉不再要灯，不再要人陪伴。效不更方，继服三剂。

三诊：患者已谈笑自如，每日勤做家务，与常人无异，脉缓苔薄，改用百合地黄汤以善其后。生地 15g，百合 10g，菖蒲 10g，生龙牡各 30g。三剂，水煎服，每日一剂。不久接到其父来信，函告女病痊愈，并致谢意。

367、【防己地黄汤不寐医案】高齐民：

张 XX，男，56 岁，海军离职干部：1983 年来京求医。自诉：长期失眠，以为工作繁忙、夜间加班所致，离休后，整天闲遐无事亦失眠，经海军 XX 医院检查，多种化验均正常，诊断为“神经官能症”“植物神经紊乱”，每天依靠安眠药只能睡 3~4 小时；诊其六脉弦中带数，舌苔薄白、质红润。系操劳公事，伤及心肾，阴不潜阳。当用防己地黄汤，引阳归阴。生地 30g，防己 10g，防风 10g，桂枝 6g，甘草 6g。六副，每日一剂，水煎服。

二诊：服上药后，中午已能睡 1~2 小时，但易醒，夜间睡眠时间延长，晨起倍觉精神爽快。继以上方加生龙牡各 30g，再加生地 10g，六副，每日一剂，并嘱其隔日减一片安眠药。

三诊：自诉服药后半小时便能入睡，夜间一次能熟睡六小时，安眠药四种共八片，已减至二片。嘱其逐渐减少安眠药剂量，继服上药六副而愈。

368、【防己地黄汤狂痹案】高齐民：

王 XX，男，45 岁，甘肃酒泉清水公社人。1973 年冬外感风寒后，周身关节红肿疼痛，连绵半月不解，尤其手指关节已轻度变形，六脉浮而数，舌苔薄白、质红润。系寒邪留着关

节，郁而化热。法当清热祛风，通阳利湿。防己地黄汤最为合拍：防风祛风，桂枝通阳祛寒，防己通络利湿，生地清热养血，一方而风寒湿热之邪尽解。

生地 30g，防风 10g，桂枝 6g，防己 10g，甘草 6g。五副，每日一剂，水煎服。

二诊：进上药后，外感解，红肿消，自觉药后尿多。继服原方五剂而愈。

369、【防己地黄汤治寒痹医案】高齐氏：

张 XX，男，30 岁，中条山有色金属公司公安干部。深秋执行任务时理水过河，寒水透骨，入冬患关节疼痛，喜暖，尤以膝关节为重。诊其六脉沉，舌苔薄，质稍淡。系风寒之邪留着关节。法当养血祛风散寒，取阳和之意。

熟地 30g，防己 10g，防风 10g，桂枝 12g，甘草 6g。六副，水煎服，每日一剂。

二诊：服上药后，腰膝关节疼痛大减。继服六副。三诊：关节已不疼痛。继予八味丸以善其后。

370、【防己地黄汤阴虚外感医案】高齐氏：

褚 XX，女，30 岁，住本市东城区门楼胡同。1982 年春，一日洗澡受风，鼻塞，流清涕，口舌糜烂，五心烦热，咽干，低烧 37℃，脉微而数，舌苔薄、质润体瘦。系素体阴虚，外感风寒。化验检查：血白细胞（WBC）3000/mm³，血小板（PLT）50000/mm³，胸透（一）。法当滋阴解表。防己地黄汤加味。

生地 30g，防己 10g，防风 10g，桂枝 10g，桔梗 10g，甘草 5g。四副，每日一剂，水煎服。

二诊：服上药四剂，外感解，口舌糜烂未痊愈。继予自拟“镇翊汤”，滋阴清热而愈。

防己地黄汤对后世方剂影响很大。陈修园说：“此方表里兼治，后世方祛风至宝方从此方悟出。”徐忠可也认为：“犀角地黄汤、地黄饮子实祖于此。”

近贤章太炎先生，依据现代药物成分分析，指出：“《素问·病能论篇》以生铁落治阳厥怒狂，本方重用生地黄，含铁质，与生铁落饮同意。”

371、【防己地黄汤失心风案案】高齐氏：

褚 XX，女，28 岁，已婚五年，婚后夫妻生活甜甜蜜蜜。自从去年丈夫提为副科长后，经常加班，夜间经常不回来，时间一长，心一中起了疑惑，开始趁丈夫洗澡时，查爱人手机的信息，看有没有小蜜发的信息，从中必出不归的理由；手机查不到，就偷偷去单位查是否真的加班。这样一来，夫妻之间感情渐渐冷落，开始不给丈夫做饭，“饿死他”；夜间丈夫敲门也不开门，“冻死他”……生气啦，门一锁，就到妈妈家住几天，气消啦，再回来。由于长期肝气不舒，开始哭笑无常，沉默寡言，有时痴呆，有时整夜不睡，全家害怕她犯精神病，2006 年 7 月由她大姐带来诊病。

诊完脉，问了半天，不说一句话，只是唉声叹气。初步诊断为“失心风”。当养心舒肝祛风，治以防己地黄汤。

处方：生地 30g，防己 9g，防风 9g，桂枝 9g，甘草 6g。7 剂，日 1 剂，水煎，分 2 次服。嘱睡前服时，药煎好倒在碗中，药汁温时加绍兴黄酒 30g 兑入服下。

二诊：患者坐下来，敢面向大夫，对话都很有条理，唯睡眠尚差。效不更方，上方加生龙牡各 30g，再予 7 剂。

三诊：患者面带微笑，是个非常善谈的姑娘，谈了她下岗之后，心里想不开，又无可奈何，加之家务事，疑心太多，导致心情不畅，郁火从肝而生，慢慢思维紊乱……服药后，心情舒畅了。还说，是否再吃 7 剂可以休息啦。患者姐姐每次带她来诊病，她认为病基本好啦，夫妻又恩爱如初。效不更方，继服 10 剂善后。

372、【防己地黄汤四十年少寐医案】高齐氏：

贾 XX，男，60 岁。自诉 40 年来睡眠不好，每天顶多睡 3~4 小时就再也睡不着啦。除睡眠不好外，其他没有什么毛病。诊其六脉沉缓，无明显异常，当属长期肾不交之证。方用防己地黄汤加百合、紫苏。

处方：生地 30g，防己 9g，桂枝 9g，防风 9g，甘草 6g，百合 30g，紫苏 10g。7 剂，日 1 剂，水煎，分 2 次服。嘱睡前服药时加绍兴黄酒 30g 兑入服下。

二诊：服上药 21 剂，睡眠时间延长至每晚 5~6 小时，且头脑比以前聪明，好像年轻了好几岁。

373、【防己地黄汤治神经衰弱案医案】高齐民：

张文元，男，56 岁，1989 年 6 月 3 日初诊。自 1956 年就患神经衰弱病，每天入睡困难，全靠速立眠、眠而通、甲苯噻哩酮度过每一个夜晚。服药可安眠，但起床后打不起精神，吃饭不香，周身疲乏，人都有不老先衰之感，听朋友说门诊有个带进修生的老师治失眠有名，特闻名而来。

六脉沉，舌苔薄白，神情疲倦。处方：生地黄 30g，防己 10g，防风 10g，桂枝 10g，甘草 6g，枣仁 10g，生龙牡各 30g，柏子仁 10g，生姜 6g。7 剂，水煎服。

二诊：患者说，上次看病，我看大夫舍不得开药，只开了 7 味药，就说我失眠长达 33 年，7 味药是否少啦吧，说完大夫给加了生姜、甘草、柏子仁。我半信半疑开始服药，晚上 8 点把药煎好服下，8 点半即入睡，一觉睡了 7 个多小时，醒来一身轻松，周身力气增一倍。效不更方，继用上方。

三诊：7 天来每天睡眠很好，为了巩固疗效，继用防己地黄汤巩固疗效。

374、【防己地黄汤恐惧性失心风治验案】高齐民：

孙 x，女，28 岁。2009 年 4 月 15 日初诊。从小是妈妈的宝贝，在妈妈爱抚中长大成人。当婚之年，她找了一个比自己大十多岁的生意人，但双方爸爸妈妈坚决反对，甚至提出断绝儿女关系。孙 x 在父母坚决反对之中结了婚，爸妈都处于无奈，婆婆进一步提出苛刻条件：不抚养孙子；同是自己的儿子，却偏爱小叔之子。孙 x 忍了又忍，但不能再忍时精神崩溃，哭笑无常，喃喃自语，怀疑家中装了放射性物质和探头害她。四邻和蔼，知孙 x 患病，大家都关心她，任她到楼上楼下、朋友家中寻找放射源或探头，虽找过多少遍，但四邻不厌烦。每当哭笑无常，睡眠稍差，自己不能控制时，就送到精神病院住半年。丈夫做生意，治病花销多少万不感到什么困难，但人如坐牢一样痛苦。经朋友介绍，求我予以治疗。来诊时，她老说：“我晚上不能睡就好了，我好观察是否放射。”

诊其六脉浮而数，舌苔稍厚。诊脉几分钟，笑了十多次，她妈再三劝阻不听，我行我素，旁若无人。诊断为失心风，当用养阴熄风，交通心肾。选用仲景防己地黄汤。

防己 10g，生地 40g，防风 10g，桂枝 10g，甘草 10g。7 剂。

嘱其头煎晚上服，待药温能服时，加一杯白酒以增药力。服防己地黄汤 28 剂时，仅生地增加到 120g，病情大为好转，哭笑大为减少，夜间睡眠恢复正常。

家务事繁杂，头绪万千，一时理不顺，肝火旺时，睡眠又反复。我用黄连阿胶汤，即朱雀汤，泻肝火，平心火，诸症好转，改用防己地黄汤。三个月后，儿子上小学，需要自己接送，督促每日作业，一紧张，病有轻度反复。改用酸枣仁汤 7 剂，不再日夜紧张。此后，防己地黄汤作丸服用。生地 300g，防己 50g，防风 50g，桂枝 50g，甘草 50g，百合 100g。1 料。上药共研极细，炼蜜为丸，丸重 10g，每日 3 丸，早一晚二，已服一个多月，病情无反复。

375、【防己地黄汤治案失心风案】高齐民：

谭 XX，男，40 多岁，湖南宜章黄土岭人。在北京施工。谭 XX，自以为性功能旺盛，每晚不同房则不能入睡，更以为夫人已满足，不会再另抱琵琶。一日，他上夜班，因无事便中途回家，见夫人和自己的好朋友通奸，被他抓了一个正着。夫人和朋友向他赔礼，发誓再不越轨，但谭某非常生气，气无处可撒，强忍不语，叹气，胸满闷，夜晚渐渐不能入睡，通奸之事无法解脱，常整夜哭笑不休，叹气声连绵不断，断为失心风。

防己地黄汤加味：防己 10g，防风 10g，生地 10g，桂枝 12g，甘草 6g，生龙牡各 30g。进药 21 剂。已能从晚 11 点睡到凌晨 4 点，但 4 点醒来再也无法入睡。再用防己地黄汤加百合 20g，服 7~14 剂。疑虑、多疑消失，半夜醒后还是不能入睡。

细思之：夜半一阳生，丑时阳生渐旺，阳主动，故而不能入睡，选用《辨证奇闻》中一治不寐方，仅六味药：重用熟地 30g、麦冬 30g、黄连 6g 以滋阴降火，茯神 10g、生枣仁 10g 以安神。服 7~21 剂后已能正常入睡，心情也感舒畅。自诉：“我已好啦，能吃，还能睡，我可以上班了”。最后以黄芪建中汤以建胃土。

张泽生老先生说：“非详究古人治验，不能识治法之奥。”为了治法上两全其美，我开始将防己地黄汤加入熟地、麦冬、黄连、枣仁，去防风加茯神 10g，命名为加味防己地黄汤。其组成为：生熟地各 30g，麦冬 30g，桂枝 9g，防己 9g，生枣仁 12g，甘草 9g，茯神 10g。临床用于前半夜睡眠很好、后半夜醒后再难入睡之患者。已用 2 例，确实有效。

376、【防己地黄汤加味治失心风精神病医案】赵守真：

刘君肃一，年二旬。其父叔皆大贾，雄于贾，不幸于 1943 年次弟殁谢，丧停未葬。君因自省休学归，店务烟集，不谙经营，业大败。折阅不知凡几，以致债台高筑，索债者络绎于门，苦孰甚焉。乃只身走湘潭收旧欠，又兴讼，不得值，愤而归。因之忧郁在心，肝气不展，气血暗耗，神志失常，时而抚掌大笑，时而歌哭无端，妄言错语，似有所见，俄而正性复萌，深为赦然，一日数潮而已。医以为癲也，进加味温胆汤，并吞白金丸，曾吐涎少许，证状未少减。吾以事至零陵，君为故人，顺道往访，渠见吾述家事刺刺不休，状若恒人，顷而大哭，继而高歌。其家人恳为治之，此义不容辞者也。俟其静，用好言慰解，诊脉细数，舌绛无苔，胸中痞闷，夜不安卧，小便黄短，是为志怫郁而不伸，气横逆而不降，心神耗损，肾水亏乏，火气妄凌，痰涎泛溢，有癲之意不若癲之甚，所谓心风证也。治以益血滋阴安神调气为主，拟《金匱》防己地黄汤加味：生地 60 克（捣汁兑），甘草 6 克，防己 9 克，桂枝 3 克，加香附 9 克，首乌、竹沥各 15 克。兼吞安神丸 12 克，日服 2 剂。

三日复诊，神志渐清，潮发减少。随进滋阴安神汤：生地、芍药、川芎、党参、白术、茯神、远志、南星、枣仁、甘草、黄连。服后略觉头胀心闷，微现不宁，审由余热未清，难任参术之补，故证情微加。乃改弦更张，趋重清心养神略佐涤痰。

早晨服清神汤：黄连、黄芩、柏子仁、远志、菖蒲、枣仁甘草、姜汁、竹沥。

晚进二阴煎：生地、麦冬、枣仁、玄参、茯苓、木通、黄连、甘草、灯芯、竹叶。每日各 1 剂。如是者四日，遂热不再潮，人事清悉，诊脉细数而有神，余热似尽，而参术之补，现犹所忌，尚有余焰复燃之虑，处以天王补心丹，以易汤：生地、人参改为洋参、玄参、丹参、茯神、桔梗、远志、天冬、麦冬、枣仁、柏子仁、五味、当归，送服磁朱丸，补心滋血，安神和胃。嗣即精神健好，食纳增进，又调理半月，改用栀麦归脾汤，仍吞服磁朱丸，善后补养，再一月而身健复元。吾临归，彼不胜依依之感。（《治验回忆录》1962：60）

377、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正：

宋某某，女，25 岁。1979 年 3 月 5 日入所。患者发病于 1971 年 5 月，少眠，多动，语无伦次，狂躁异常。诊为精神分裂症青春型，经多方治疗，时轻时重，迄未痊愈。近年来，狂象虽减，但痴痴癡癡，秽浊不知，随地便溺。问之多不答，答亦多非所问。胡行乱走，间或妄笑，独语不休。且喜时搔头部，剃光之头皮被抓得血迹斑斑。诊查：患者身肢拘强，面容消瘦惨白，双颊微红，脉洪大无力，舌质红，干而少津。综观脉证，显属狂久火盛伤阴，阴血不足，风邪入侵，扰及神明。处以防己地黄汤。服 10 剂，独语妄笑略减，夜能稍眠，胡乱游走，呼之能止。又服 20 剂，疾瘳约半。又服 20 剂，神情、言行皆恢复正常，已参加工作。（河南中医 1984；〈5〉：31）

378、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正

张某，男，38 岁。1975 年 4 月 8 日诊。上年六月，正劳动时突然发病。双目直视，重复咀嚼，微作哼哼之声，且盲目走动。片刻醒转，于病中之况一无所忆。以后发作渐频，且持续时间渐长，发作后，如醉如疾，独语喃喃，外出走动约二里许方醒转。来诊时，发作已十一天，昼夜游荡，妄行不休，虽然数剂化痰息风类中药亦无效。诊其脉浮数无力，舌质红略干，无苔，体温 37.2℃，“无寒热”。知系心肝血虚，虚而生热，加之风邪内扰，心神失

持而致。治以养血清热，祛风散邪；处以防己地黄汤 5 剂。4 月 14 日二诊：神志清，妄行止，夜里睡眠甚酣，晨起惟困乏而已。再以上方 5 剂巩固之。出所时，嘱常服磁朱丸（磁石、朱砂、神曲）佐服少量苯妥英钠片等：随访迄今，未再复发。（河南中医 1984；（5）：31）

379、【防己地黄汤治失心风精神病医案】丁德正医案：

李某某，女，33 岁，已婚，1978 年 2 月 7 日入所就诊。患者数年来，眩晕易乏，少眠多梦，时或心悸躁慌。月余前，其疾发作，时而哭啼吵闹，时而昏仆欲绝。经当地诊为癔病，用甘麦大枣汤等十数剂无效。来诊前夜，症象益剧，或张嘴吐舌，称鬼弄怪；或神情恍惚，奔走村外，自言自语。诊查：患者清瘦，面略赤，脉轻取浮，重按细数，舌质红，无苔，唇干，口苦。家属云：“患者常谓项强，头皮紧拘，如绳缚之。”此症显系阴血匮乏，风邪外并，阳热内郁，神明失司而致。处以防己地黄汤，服 2 剂，神思略定，妄行独语大减；又服 3 剂，症象若失。头皮发紧及项强等症亦去。出所时，予朱砂安神丸续服以善后，随访迄今，健康如常。（河南中医 1984；（5）：31）

380、【防己地黄汤治患慢性风湿性关节炎医案】谭日强：

崔某某，女，51 岁。患慢性风湿性关节炎，其人身体羸瘦，四肢关节疼痛，手指变形，下肢肌肉萎缩，双踝关节肿大，病已经年，卧床不起，患者本人是针灸医生，曾用针灸，中药多方治疗不效，大便干结，小便尚可，舌淡无苔，脉象弦细。此营气不通，肝肾俱虚，拟养血和营，兼益肝肾，缓缓图功，师防己地黄汤意：生地 30 克，防己 10 克，桂枝 10 克，防风 10 克，甘草 3 克，加当归 10 克，白芍 10 克，川芎 3 克，萆薢 10 克，木瓜 6 克，苡米 12 克。

嘱服 30 剂，踝关节肿痛渐消。仍用原方去防己、苡米，加地龙 10 克，红花 3 克，再服 30 剂，关节疼痛减轻。继用原方去桂枝、防风，加牛膝、桑寄生，又服 30 剂，下肢活动进步。后用原方加党参、杜仲、续断、鸡血藤等味作丸剂常服，并嘱下床适当活动，调理年余，身体渐次康复，已能上班工作，坚持来去走路。（《金匱要略浅述》1981：80~81）

381、【防己地黄汤治手足抽搐医案】何耀普：

王某，男，14 岁，学生，1990 年 5 月 12 日初诊。患者 5 天前玩耍出汗后下河摸鱼，2 天后出现左上肢麻木，僵硬，抽搐，并逐渐加重，伴阵发性项背强急，牙关紧闭，手足抽搐等症，每日发作 3~5 次，发病时神志清楚，能感觉到不适与痛苦。经用多种中西药治疗均无效。各种检查无异常，舌红苔黄，脉弦数。中医诊为痉证，证属血虚受风，筋脉拘挛。治宜养血祛风，舒筋止痉。方用防己地黄汤加味：生地 60g，防风、防己、川羌、胆星、炙甘草各 12g，桂枝 10g，泽泻 20g，生苡米 30g，白芍 15g。每日 1 剂，水煎服。

服药 2 剂，症状缓解，抽搐次数减少，程度减轻。连续服药 15 剂后，诸症悉除。随访 2 年无复发。（国医论坛 1993；（5）：17）

382、【防己地黄汤治心悸胸闷医案】魏雪舫：

李某，男，24 岁，1986 年 7 月 5 日初诊。患者 3 个月前因感冒出现心悸胸闷，周身乏力，微有寒热，四肢酸楚等症，在蚌埠市某医院化验检查：ESR120mm/h，ASO600 单位，心电图不：窦性心动过速，频发性室性早搏。经抗感染、抗风湿、大量激素，及心律失常等综合治疗，病情一直未能控制，同时又出现心悸加剧，肢体肿胀，颜面潮红，烦躁失眠，咽干口苦等症，心率 110~140 次/min。舌质红胖，苔薄黄脉滑数有力。证属风邪稽留，营血郁热。治宜清热凉血，祛风利水，防己地黄汤加味：生地 60 克，防己 20 克，防风 15 克，桂枝、甘草、苦参各 10 克。3 剂水煎服，地塞米松 1.5mg，2 次/d，其它药物停用。

服药 1 周后，诸症减轻，舌质红胖，继用上方加木通 10 克，再进 5 剂。1 个月后复查，ASO：400 单位，ESR25mm/h，心率 78 次/min。心电图示窦性心律。体胖渐退，舌转淡红，苔薄白，脉濡滑，原方加玉竹 30 克，再进 10 剂而愈。（陕西中医 1991；（4）：173）

383、【防己地黄汤治血尿水肿急性肾小球肾炎医案】魏雪舫：

任某，男，14 岁，1985 年 2 月 6 日诊。患儿半月前感冒发烧，咳嗽，咽痛，继而出现眼

脸浮肿，伴有血尿。经用青霉素、止血敏、激素等治疗，效果不显著。证见发热， $T38^{\circ}\text{C}$ ，但四肢不温，微恶寒，面浮肢肿，咽红，口渴，尿少色赤，舌质稍红、苔薄白，脉浮数。化验检查小便：尿蛋白（+），红细胞（+），白细胞 $4\sim 6/\text{HP}$ ，颗粒管型 $2\sim 5/\text{HP}$ 。血象偏高， $\text{ESR}85\text{mm}/\text{h}$ 。证属风热袭表，肺气失宣，热伤肾络而致血尿水肿。西医诊断：急性肾小球肾炎。治则：清热解毒，疏风凉血，防己地黄汤加味：生地 30 克，防己 15 克，防风、桂枝、紫草、甘草各 10 克，花粉 15 克，鲜浮萍一把，2 剂水煎服。

3 日后浮肿消退，体温正常，微渴有汗，但血尿未消。仍予上方生地加至 60 克，加白茅根 30 克，贯众炭 15 克，2 日服 1 剂，又服 5 剂。1 月后小便转清，血尿消失，尿检正常。随访 2 年未复发。（《陕西中医》1991；（4）：173~174）

热；则见尿血、口渴、舌红等症。血热而风胜，正合防己地黄汤证之病机，用之即效。为增强本方药力，故加浮萍以祛风邪，加紫草以清热凉血，用花粉以养阴止渴。

384、【防己地黄汤治精神病】高齐民：

1960 年冬，我第一次用治 1 例七十多岁老者，因艾怨而狂，夜间外出，不管谁家的自留地的蔬菜全部拔光。村里无法，动用民兵把他用铁链拴起来，春节倒放他出来拜年，可他又把人家祭祖的馒头装到裤裆里。我应朋友之约来到黄花镇村，村干部把他带来看病。因提前知道他是“失心风”，诊完脉，病人要喝酒，我便开了防己地黄汤：桂枝 6g，防风 6g，防己 6g，甘草 6g，4 味用酒浸泡，另生地 100g 放笼里蒸一顿饭许，待温，同药酒放铜盆中混合，5 副，1 副只浸蒸 1 次。

我回北京请教恩师宋孝志先生，他说方子开得与方证相符，本方的关键是掌握君药生地的分量。“生地二斤”，我的经验最少 40g，最多 150g，超过 150g，病人则感躁烦不舒；若病重药轻则疗效就差。用此方后，病人反映：“服了防己地黄汤，我的脑子比以前更聪明了”。

第三届中国当代名医集萃大会期间，住在太原迎泽宾馆。一天，吃完晚饭散步时，我和刘渡舟老师相遇，他谦逊地问我：“宋老用防己地黄汤，生地最重用多少克？”我告诉他：“最重用 150g”。

我常用此方治狂病，弃衣而走，登高而歌，裸体不避亲戚之“失心风”；愈后反复，再用仍效。

第二十五章 抵当汤方证

【原文】：太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。（125）

联系条文：妇人时腹痛，经水时行时止，止而复行者，抵当汤主之。亦治男五膀胱急满，有瘀血者。

联系条文：太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也，抵当汤主之。

联系条文：阳明病，其人喜忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。

联系条文：病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之；假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者，有瘀血，宜抵当汤。

病因和病机：下焦蓄血，热与血结

辨证要点：少腹有证：少腹硬、或痛、或急结，小便通利。（或见：身黄、脉沉结、其人如狂）。

罗按：抵当汤证，身黄不是主证，小便自利，少腹有证（或硬满、或急结），若其人如狂者，血证无疑了，抵当汤主之。若是小便不利，这不是蓄血证，是蓄水证。

尤在泾曰：“身黄，脉沉结，少腹硬”，是皆血瘀之脉证。血司于肝，血结木郁，贼伤己土，则发黄色，缘木主五色，入土为黄故也。然使小便不利，则三者乃膀胱湿热之瘀，是茵陈五苓证，非血证也。小便自利，其人如狂，血证已谛，故宜抵当。

《金鉴》曰：此承上条详其脉证，互发其义也。太阳病，无论中风、伤寒，但身黄脉大，腹满小便不利兼头汗出者，乃湿热之黄，非瘀血也。今身黄，脉沉结，少腹硬满，小便自利，其人如狂者，则是血证，非湿热也，故宜抵当汤以攻其血。

方有执曰：谛，审也。言如此为血证审实，无复可疑，必须抵当汤，勉人勿二之意。

程知曰：身黄，脉沉结，少腹硬满，三者皆下焦蓄血之证。然尚与胃热发黄证相近，故当以小便辨之。其少腹满而小便不利者，则为无形之气病，属茵陈证也；其少腹硬满而小便自利者，则为有形之血证，属抵当无可疑矣。

汪琥曰：按本文云：小便不利者之下，仲景不言治法。成注云：可与茵陈汤。《补亡论》云：与五苓散。后条辨云：属茵陈五苓散。此三方可选而用之。

胡希恕曰：这个辩的是血瘀水瘀之辩。太阳病身黄，这是黄疸证，有一种这个血瘀性黄疸，你不去瘀血，这黄也是去不了的，它这个不是一般的黄疸。“脉沉结”，沉者为在里，结，就是结代的结，由于里有所阻碍，所以脉沉而结。少腹硬，跟我们前面的少腹硬满也是一样，就是里有所结了。“小便不利者，为无血也”，如果小便不利，膀胱蓄水也会使得少腹硬，利小便就行。“小便自利”，所以这个少腹硬有这么两种情况，瘀血症，轻者急结甚者硬满，这是瘀血病了，小便可自利。小便要是不利是水。

这一段，是蓄水瘀血的辨证。如果小便自利，其人如狂，这个瘀血症，十有八九影响脑系。这在临床上要注意了，有很多特殊的头痛、癫狂、女性癫痫，属瘀血证的都不少，所以瘀血症最容易影响头脑。其人如狂，血证谛也，这是清清楚楚的是瘀血症。那它是要用抵挡汤。

陈逊斋曰：盖少腹硬满，有“血结”，有“水结”，有“水血两结”；“血结”必见狂妄，如有小便不利，“桃核承气汤证”是也，若小便自利，用抵挡汤；“水结”必小便不利，“五苓散证”是也；“水血两结”必小便难，少结满如墩状，如“大黄甘遂汤证”是也。

刘渡舟曰：这条说瘀血还会身上发黄。上边的脉沉而微，这个说是脉沉而结，结就是脉跳一跳有停止，脉沉而结是气血凝滞不利的一个脉象。

身黄有两个可能，一个是湿热发黄，一个是瘀血发黄。这两个都可以出现少腹硬，其鉴别点是湿热凝结的发黄有小便不利，成无己主张是用茵陈蒿汤，后世医家是主张用茵陈五苓散。小便不利，少腹硬，清利湿热，黄就退了。

如果小便自利，还加上一个如狂，柯琴的意见，这个如狂的如字，不要把它看的太死了，不要看作像狂，当助词来理解，就是其人狂，其人发狂。小便自利就不是湿热，就把茵陈蒿汤证、茵陈五苓散证排除在外。那么惟一的就是热与血瘀，热与血结。同时，湿热发黄只能是心烦，不能发狂。所以说小便自利，其人如狂，到这时候，血证谛也。谛者，就是没有错误了，实实在在的属于血证了，而不是其他。要用抵挡汤进行治疗。瘀血发黄和湿热发黄是不同的，瘀血发黄的，黄而不鲜泽，黄色有点儿晦黯的样子。湿热发黄，阳黄，身黄如橘子色，它带有亮头的。

古人对于瘀血发黄的病机没有太多的阐述。怎么瘀血就发了黄了？没有像现代医学说的那么确切，反正他知道瘀血的患者出现黄疸，不要用茵陈蒿汤，什么栀子柏皮汤啊，那都是无济于事的，要下瘀血，瘀血一下去，狂也好了，少腹也不硬、黄也退了。

水蛭，虻虫，它们破血的力量不是一般的，比桃仁、红花、三棱、莪术劲大。《新序》记载，有个叫楚惠王的，吃寒菹，就是凉菜，这个凉菜做的不干净，这里有水蛭。楚惠王一看有个水蛭在饭菜里，若把这件事声张出去，这个做饭的庖人，就要有杀戮之祸。所以他感觉不忍，他就连着菜把水蛭吃了。吃了以后，他也没有说，到了晚上了，楚惠王要大便。楚

惠王有一个老病根，有心腹之疾，就是胃脘疼痛，这样就好了。就因为吃了水蛭以后，大便一泄啊，这个心腹之疾就好了。因此王充在《论衡》里就提出来了，水蛭性嗜血，楚惠王的心腹之疾，盖积血也，是个瘀血病，故嗜血之虫食，积血之病愈。吃了水蛭以后，才能把这个心腹之病给治疗好，这是个瘀血病。从这个记载看，古人就已经知道水蛭能够活血化瘀。

水蛭药咸，以咸而破血。虻虫这个药是带点儿苦的，以苦而破血，咸和苦相配来活血逐瘀，再加上大黄、桃仁，大黄能够荡涤，能够推陈出新破血结，桃仁能滑利，能行血的瘀滞。这四味药合在一起，破血逐瘀的力量是相当厉害的。

“熬”当“炒”字讲。“不下再服”意在言外，已经泻下来了，就不要吃了。这个方子在临床还很好用，治疗很多的气血郁积的疾病，同时还能够治疗不是一般的疾病，让人感觉到很惊奇。

抵当汤方：

水蛭三十个，虻虫三十个（去翅足），大黄三两（酒洗），桃仁二十个（去皮尖）

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下更服。

385、【抵当汤合桃核承气汤失笑散治头皮上头发紧精神分裂症医案】刘渡舟：

姓魏的河南人，女性，30岁，1969年就患精神分裂症，在家里呆不了，住到医院。医院用电疗和胰岛素的疗法，病见好。但是没有完全好，后来就出院了，出院以后，感觉头皮上头发紧，就像裹了一层铁箍。这是一个特殊的症状，再一个，人善忘，记性不好。言听视动，随过随忘，很短的一段时间她就把它忘记了。患者的表现，两目呆滞，精神淡漠，月经的周期还是准的，28天，但是经期的时候小肚子作痛，脉是沉滑的。舌苔有一点儿腻，舌色略暗。

《内经》说瘀血在下，使人发狂；瘀血在上就使人善忘。同时有痛经，脉见沉滑，李濒湖说“滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎。”根据这个情况，我当时就给她辨为有瘀血。于是就开了大黄3钱，桃仁4钱，冰蛭2钱炒，虻虫2钱炒，还有半夏、柴胡，配点儿柴胡和半夏舒肝祛痰。吃了两付后她有点儿泻下，不太厉害，像是见点儿好，而又不明显，大便也没有太泻。

后来就转方了，用的是：一个是有桃核承气汤的意思，一个是有桂枝茯苓丸的意思，一个是有失笑散的意思，这三个方子合在一起了。就是桂枝2钱，桃仁4钱，大黄3钱，丹皮3钱，茯苓8钱，蒲黄2钱，五灵脂2钱，赤芍2钱，主要还是活血。茯苓我用8钱，主要因为她的舌有点儿腻，同时茯苓这个药能治疗一些精神上的毛病，能够理气安定精神。这个药吃了两付，和前面那两付的药的力量可能有所衔接了，也不要只看后面这两付药的力量，她的大便多泻下臭秽之物，泻下之后，就觉得头上的铁箍就解除了，喜忘症状大大的减轻，再一次来的时候，神气啊，面容啊，判若两人。我就问她了，她说忘性吃了药见好，好到什么程度？她说是好了十分之七八。这时候她说她要回河南了，给她开了桃核承气汤加上菖蒲、郁金。

386、【抵当汤治眼珠子痛棕褐色斑医案】刘渡舟：

女，姓刘，37岁，主诉在两年前由于产后得了感冒，出现眼睛疼，就是眼珠子痛，失眠，睡不着觉。开头就是这么个病，眼睛疼，失眠。以后就不是眼睛疼的问题了，出现视力下降，先从右眼开始的，从1.2降到0.1，到眼科检查，诊断为中心型的视网膜炎，进行了治疗，见效。右眼的视力恢复到1.0，而左眼反倒从1.5降到0.01，就是左眼不好了。检查眼底，眼底有水肿。

这时候她就不找西医看了，找了老中医看，给开了石斛夜光丸，吃了以后，视力降低就控制住了，左眼的视力升至0.08，右眼视力恢复到1.2。但是，这时候又出现了一些症状，就是后背疼痛，小肚子右侧也疼痛，月经期的时候两条腿发胀。同时精神紧张，也是喜欢忘事，但轻得多。脉是六脉沉弦、沉滑，舌质绛暗黯，边上有瘀血斑，舌头边就像豆瓣那么大的蓝色的瘀血斑，辨证就是气血瘀滞，上扰于心，所以心神就被瘀阻所扰乱，惊悸善忘；气

血瘀滞，不通则痛，所以她有腰背疼，有后背疼，肚子疼，腿发胀，腰腹疼痛这些疼痛的症状出现。

视力问题我当时没考虑，因为她的眼睛已经比过去见好；所以就给开了一个方子：桃仁五钱，大黄三钱，丹皮三钱，虻虫二钱，炒水蛭二钱，白芍二钱，也就是抵当汤里加上白芍、丹皮，白芍、丹皮是通肝的。这个患者第二次来看病的时候就给我反映了，说是吃了药以后大约在六七个小时吧，出现一个特殊的感受，就是脑袋后边这个地方就跳动，同时还疼痛，又跳动又疼痛，这是一个感受。

另外肚子这时候就疼了，肚子疼得还很难受的，这是一个感受，同时就来了大便了，大便拉得很多，尿的颜色她说就像血液，如血汁，尿如血汁。从此以后，她就感觉周身非常轻松，各种疼痛皆见好转。更感觉出奇的是，视力大有好转。以前没给她治眼睛的视力，但是吃了很见好，所以这个病人也挺高兴，我听了也挺高兴的，她见好，所以第二次我就不敢用这个抵当汤了，已经大便泻下来了，尿一些红尿，还敢再用吗，不敢再用了。（罗注：血自下，下者愈，下血是正常的）

第二次我就用血府逐瘀汤，加上茺蔚子、决明子，就照顾点儿眼睛。这个方子服了六剂，她就到眼科检查去了。又到眼科去检查去了，那么为什么？她眼睛觉得特别好啊，她要找西医指标化验化验，看一看这个病到底好不好。光是自觉症状不行，还得有点儿客观的指标。她到过去常去看眼睛的那个医院，眼科医生都认识就跟她说，你那黄斑区的那个棕褐色病变现在已经变浅变小了。眼科医生说你这个病还是很怪的，怎么现在突然间变小变浅了？她的视力见好、恢复和这个黄斑区的那个棕褐色的病变有关系，那个地方一变浅变小了，所以她看东西就亮堂了，视力就好了。后来她又来了，来了她就跟我说这个情况，最后开的是血府逐瘀汤加蛭螭，蛭螭是虫子，就地里那个虫子，白虫子叫蛭螭，蛭螭有明目之说，加上土鳖虫、鸡血藤、茺蔚子，后来这个方子吃了几付这个病就好了。在这个方子上，我有一个意外的收获，就是抵当汤也好，血府逐瘀汤也好，能治眼睛，能治这个视网膜中心性的视网膜炎，这个事其实也不是什么怪事，因为《内经》说：“故人卧，血归于肝”，肝开窍于目啊，目得血而能视，手得血而能摄，她这个人产后感冒了有瘀血，瘀血不去影响新血不生，就使血对于眼睛的作用受到了影响，所以吃一些活血化瘀的药，瘀血解决了，瘀血解决了血能养目，肝开窍于目，咱也不知道那黄斑区在什么地方，反正这个就见好了。

月经的毛病，妇人产后恶露不下出现的一些精神病或者肚子疼痛等等的，这个方子都好用。

387、【抵当汤治脑血管瘤、头痛伴有偏盲医案】郝万山：

30年前，我跟着宋孝志老师抄方，有一个病人是从宣武医院转去的，她的临床症状，是剧烈的头痛伴有偏盲。宣武医院当时做脑血管造影，诊断为脑血管瘤压迫了视神经的通路，那个时候这个区域进行手术，是很困难的。所以那个西医大夫说，我们没有更多的办法，手术很具有危险性，要不干脆找中医去试一试。我们中国的西医大夫很好，当他们没有办法的时候，就会推荐病人去找中医大夫试试。

到东直门找了我们宋老，宋老沉思良久，这个病人给我的印象很深，头痛、眼睛睁不开、有偏盲，她感到很痛苦、很绝望，给我很深的印象，是个女同志，40岁左右。宋老沉思良久，开的是破血逐瘀的抵当汤，只是不让她做汤剂，而是选这几个药让她做散剂，装在胶囊里吃，一个胶囊装0.3克左右，开始是让她早一粒，晚一粒，吃吃看。如果大便还是一天一次，没有一点稀软的表现的话，再增加1粒，早1粒，午1粒，晚1粒，如果还不行的话，主要观察大便，保持一天大便有1次比较稀软的就行了。超过两次就减量，1~2次就不要减量，就这个量，就让她长期的吃，这个病人吃了一个月症状没有改善，宋老说再接着吃；吃到两个月的时候，头痛减轻许多了，视野开始恢复；吃了三个月的时候，几乎头不痛了，她前后吃了半年，视野完全恢复，头也不痛了。半年以后她去复诊，因为症状全没有了。

我就觉得很奇怪，这个血管瘤难道能够化掉吗？我就劝她再作一次脑血管造影，大家知

道那个时候没有核磁共振，没有CT，连B超都没有，30年前那时候能够诊断脑血管瘤的唯一方法就是脑血管造影，而脑血管造影又有一定危险性，有一定的痛苦，所以病人不愿意做。但是我总想看看这个病人症状为什么改善，脑血管瘤到底还有没有。

所有有一天，我背着宋老，说你必须去做检查，没准这个瘤子跑到别的地方，更要害的地方，现在藏在那个地方，哪一天突然破裂出血的话，就可能有生命危险，所以必须做一个脑血管造影，证实一下，我说这东西是很难消掉的。她听我这么一说，后来她告诉我，一晚上没睡着觉，我后来想起来，我太年轻，不应当这么说。她第二天就到宣武医院拍片子去了，拍完片子以后拿片子的时候，她和放射科拍片子的那个人说，你跟我对照一下，这两个片子有什么不同？对照完以后医生说，这个片子是你的吧？这个片子不是你的。她问这个片子怎么不是我的呢？他说这个片子上有脑血管瘤，这个没有。她说这个片子就是我的，当初检查做报告的也是你，他说不可能，宣武医院说不可能，原来有血管瘤，现在怎么没有呢？所以那个人当然对照起来前后差了半年，就是没有了。他就问怎么治疗的？她说我就是找一个中医大夫，一直吃一种胶囊治好的，但是从那（时候）到现在，用抵当汤做成散剂治疗脑血管瘤有这么好的效果的我只遇到这么一例。这个病人，能够坚持用半年，而使脑血管瘤完全消失，所有的临床表现都消失了。

388、【抵当汤合大柴胡汤治皮肤有紫癜医案】胡希恕：

李某，男，17岁。游泳时发现下肢皮肤有紫癜点点。继之腹痛、腹泄，紫癜延及遍身。入道济医院住院治疗，予止血针、止痛针等对症治疗，腹痛、紫癜不见明显好转，却人渐消瘦，以至骨瘦如柴。后因大便干结，予蓖麻油口服，便出大量污血而腹痛止，紫癜渐消，人也渐胖，而出院。但半年后病又复发，又入道济医院，再用蓖麻油则毫无疗效，无奈接回家拖延时日。后请胡老诊治。

来诊时症状：皮肤紫癜散在，常少腹痛，大便干燥，烦躁，舌苔黄，舌紫，脉沉弦。认为是瘀血阻络，为抵当汤合大柴胡汤方证。水蛭二钱，虻虫二钱，桃仁二钱，大黄三钱，柴胡四钱，白芍三钱，生姜三钱，半夏四钱，枳壳三钱，黄芩三钱，大枣四枚。

结果：上药服一剂，泄下大便及黑血数升，腹痛已，紫癜随之好转，证已，身体健康，随访10年未见复发。

注家按：本例是胡老在50年代的治验例，诊余胡老曾讲述过该病例。尤其是讲到辨证时，胡老特别指出，患者服蓖麻油后大便泻下污血便，可证为内有瘀血，故果断投与抵当汤合大柴胡汤，仅服一剂沉疴向愈。经曰：太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤，下之则愈。

389、【太阳蓄血证抵当汤治发狂医案】许学士：

仇景莫子仪，病伤寒七八日，脉微而沉，身黄发狂，小腹胀满，脐下如冰，小便反利，医见发狂，以为热毒蓄伏心经，以铁粉牛黄等药，欲止其狂躁。予诊之曰：非其治也。此瘀血证尔，仲景云：“太阳病，身黄，脉沉结，小腹硬，小便不利，为无血，小便自利，其人如狂者，血证也。可用抵当汤”，再投，而下血几数升，狂止，得汗而解。经云：“血在下则狂，在上则忘”。太阳膀胱经也，随经而蓄于膀胱，故脐下胀，自阑门会渗入大肠，若大便黑者，此其验也。

《注解伤寒论》：苦走血，咸胜血，虻虫、水蛭之咸苦以除蓄血；甘缓结，苦泄热，桃仁、大黄之苦以下结热。

【五苓散和桃核承气汤治太阳蓄血太阳蓄水证同时存在医案】郝万山：

太阳蓄水证是膀胱的气分证，太阳蓄血证是膀胱的血分证。气分证就涉及到气化不利，突出的一个症状之一就是小便不利。蓄血证只是血热互结，血不和，它没有影响到气化。《伤寒论》在鉴别太阳蓄水和太阳蓄血的时候，多次提到了小便自利的为有血也，小便不利的是太阳蓄水，所以小便的利与不利就成了辨太阳蓄水和太阳蓄血的一个分水岭。

可是我们在临床上也能够遇到既有蓄血证的表现也有小便不利。

有一年在北京联合大学，在兴化路的校址办了一个北京市西医学习中医班，晚上上课我去讲《伤寒论》。

第二天早上，一上班就有人往我办公室打电话，郝老师我就某某医院的某某医生，昨天晚上听了你的课以后我就联想起我最近治的这个病人，我不知道他是太阳蓄水还是太阳蓄血。这个病人是个老太太，二周前她有寒战，随后发热、尿频、尿急、尿痛、肉眼血尿，然后到医院做化验，尿中红白血球满视野，就诊断为急性膀胱炎收入住院。这是个西医的综合医院，住院以后就用了抗菌素来治疗，很快，大概两、三天以后，发烧就退了，一个星期以后尿的化验就正常了，尿中就检查不出红白血球了。从尿中的化验完全正常的，可是这个病人还是自觉症状不见缓解，小便还是一会解一会解。你化验尿什么都没有，原来尿的培养结果出来的是大肠杆菌，但是再给她做尿的培养的时候，尿培养是阴性的，这医生说你的病我已经给你治好了。可是这个老太太出现了什么情况呢？晚上狂躁，心烦，睡不着觉，骂大夫说我这病是怎么回事，刚开始的时候我还没这么难受，怎么你们治得越来越难受了？晚上睡觉的时候，即使给她用镇静药她睡着了，这个手还是在摸着这个小肚子。所以这个医生就不知道，她是属于蓄水还是蓄血，少腹不舒服，你看睡觉的时候她还在摸着肚子，还有小便频数。另外，晚上烦躁，睡不着觉，说话很不礼貌，对大夫说话很不礼貌，这不就是一种如狂的表现吗？这个医生结合我头一天晚上上课讲的内容给我打电话，说老师，你说她是蓄水还是蓄血？我说她大便怎么样。他说，好几天没有大便了。我说你看看她的舌象。他放下电话就看舌象，回来后他说，舌红，舌苔又厚又黄，舌面又干燥，这是上午。

我说这样，既然如此的话，蓄血和蓄水这两个症状同时存在，因为她既有其人如狂又有少腹不舒服，还有小便不利，那你就用五苓散和桃核承气汤联合应用。三天以后他就给我打电话，他说郝老师，你那个方子很神。那一天你开了方子，她下午吃的药，吃了药以后，小便量也多了，大便拉了两次，当天晚上睡得非常塌实，不再狂躁，第二天早上起来，小肚子也舒服了。她说我刚入院的时候，你们要早给我吃这个药，我不早就出院了吗？她说给我办出院手续吧。

我们现在回想这是一个什么证候呢？这是个急性膀胱炎的证候。用西药是把细菌给她杀灭了，毫无疑问这种治疗方法是正确的，但是她的膀胱的功能没有恢复，中医所说的气化功能，中医所说的膀胱的微循环功能，就是血液循环的功能没有完全恢复，所以她的自觉症状还没有缓解。

后来我注意到有许多膀胱炎的病人，当他化验尿正常了之后，仍然遗留了一些症状，像尿频尿急，可是你化验他的尿，做尿培养都是阴性的。所以这实际上是膀胱泌尿系统的功能没有恢复的一种表现。我说你前面的治疗是完全有效的，也完全是应当的，是针对细菌的，但是差一步的就是膀胱。这个生理机能没有完全恢复，你稍后用中药的促进气化，促进微循环的这种药物，只要用上一次，这些症状就可以缓解。

所以我们今天在临床上，见到不少膀胱炎的病人，泌尿系感染的病人，化验是阴性的，尿是阴性，尿是正常的，就是有些症状的时候，你就不妨用一用促气化，然后活血化瘀的药试一试，对改善这种症状是很有好处的。有人就把这种症状叫做神经性膀胱，或者叫做膀胱官能证。

看起来蓄水是病在气分，蓄血是病在血分，两者是以小便不利和小便利作为分水岭，好象分得非常严格，但是实际上在临床上常常有两种证候并发的時候。两种证候并发，你在用药上就把两张方子结合起来，这就叫合方治难证。

390、【桃仁承气治蓄血证全身发黄医案】日本《生生堂治验》：

某道士妻，年约四十，以全身发黄，医者误为黄疸。先生按之，至脐下即疼痛不堪，与桃仁承气汤，十余日而痊愈。

汤本按曰：是血性黄疸也，余曾用大柴胡汤与桃仁承气汤合方治此种黄疸者矣。

《证治准绳》曰：“血溢，血泄，诸蓄妄证，其始也，予率以桃仁大黄行血去瘀之剂，折其锐气，而后区别治之，往往获中，然不得其故，后来日明。遇故人苏伊举，共论诸家之术，伊举曰：吾乡有善医者，治失血、蓄妄，每先以快药下之，或问失血而复以下之，则虚何以当乎？答曰：血即妄行，迷失故道，若去蓄而不利瘀，则以妄为常，何以御之，且去者自去，生者自生，何虚之有乎？予闻之，愕然曰：名言也，昔日之疑，今始释然。

391、【抵当汤与瓜蒂散治腹脉坚实心下硬塞月经不来奇怪医案】漫游杂志：

一妇人，三十余岁，月事即断，年年肥大，腰带数围，每月必发头疼一二次，药食皆吐，不能入咽。余诊之，腹脉坚实，心下硬塞，推之难以彻底，与抵当丸，湿膝丸，数百帖，血亦不来，及与瓜蒂末一钱，大吐一日，翌日，按心下硬塞减半，又作抵当汤与之，数日大便溏泻，日五六次，十日后，再与瓜蒂散五分，又与抵当汤如前，肚腹剧疼，代用以丸，日三、五分，三十余日，经水来如常，头痛已除。此案颇奇，大有研究价值。

392、【抵当汤治壮热舌赤目赤发狂】《续名医类案·热病》

甬江焦姓人，七月间，患壮热舌赤，少腹满闷，小便自利，目赤发狂，已三十余日。初服解散，继则攻下，俱得微汗，而病终不解。诊之，脉至沉微，重按疾急。夫表证仍在，脉反沉微者，邪陷入于阴也。重按疾急者，阴不胜其阳，则脉流转疾，并乃狂矣。此随经瘀血，结于少阴也，宜服抵当汤。乃自为制虻虫、水蛭，加桃仁、大黄煎服。服后下血无算，随用熟地一味，捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液。候其通畅，用人参、附子、炙草，渐渐服之，以固真元。共服熟地二斤余，人参半斤，附子四两，渐得平复。

第二十六章 桂枝加龙骨牡蛎汤

【原文】夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩发落，脉极虚芤迟，为清谷，亡血，失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。（《金匮要略》第六篇）

【组成】桂枝 10g，白芍 10g，甘草 6g，红龙骨 15g，牡蛎 15g，生姜 10g，红枣 10 枚

【煎服】水浸 20 分，煎 30 分，取汁约 600 毫升，分早、午、晚服。

【主治】失精、梦交。

【禁忌】1.失精、梦交属相火妄动者，忌之。2.失精、梦交属阴虚阳亢者，忌之。

【类方】

1. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤：为治心阳虚损烦躁不安、心悸冲逆之方，较桂枝加龙骨牡蛎汤少一白芍，可知温补心阳为专。

2. 小建中汤：同可治失精。不同者，小建中汤证之失精因中虚而起，故有心悸，心烦，手足心热，咽干，衄血，腹痛里急，喜温畏寒等虚劳之症。

【龙骨家族类方】（原书无，罗补）

1、桂枝加龙骨牡蛎汤：“夫失精家少腹弦急，阴头寒，目眩，发落，脉极虚芤迟，为清谷、亡血、失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之”。适用于：噩梦、脱发、脉虚。

2、柴胡加龙骨牡蛎汤：“伤寒八九日，下之。胸满烦惊。小便不利。谵语。一身尽重。不可转侧者。柴胡加龙骨牡蛎汤主之”。适用于：晨起口苦、两胁胀满；胸闷、惊悸、脉弦。

3、桂枝甘草龙骨牡蛎汤：“火逆。下之因烧针烦躁者。桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之”。组成：桂枝一两、甘草、龙骨、牡蛎各二两适用于：怕声音、怕冷、烦躁。

4、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤：“伤寒脉浮。医以火迫劫之。亡阳，必惊狂。卧起不安者。桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之”。适用于：不能独行、独卧、怕冷

【运用】

1. 梦交失精，诸脉浮动，心悸，少腹急，隐处寒，目眶痛，头发脱者。（《外台秘要》）

2. 自汗、盗汗。（《万病回春》）

3. 禀赋薄弱之人，因色欲过多，则血精减耗，身体羸瘦，面无血色，身体常有微热，四肢倦怠，唇舌干燥，小腹弦急，胸腹动甚，乃至于穷，不死何待；妇人心气郁结，胸腹动甚，寒热交作，经行常衍期，多梦惊惕，鬼交漏精，身体渐就羸瘦，恰似劳瘵，孀妇室女，情欲妄动而不遂者多有此证，此方宜之。（《皇汉医学·类聚方广义》）少腹急痛，便溺失精，洩出白液者。（《张氏医通》）不寐，胃痛便血，盗汗，泄泻四案，皆有精神不振，面色萎黄，纳谷乏味，喜汗出，舌淡不红，脉虚之症。（《当代医家论经方》）

【浅议】此调和阴阳，潜阳固脱之方也。临床使用以失精，梦交，汗出，阴冷，少腹弦急，脉虚芤迟为目标。读《素问·生气通天论》，圣谕“阴者，藏精而起亟也，阳者，卫外而为固也”，“阴阳之要，阳秘乃固”，“阴平阳秘，精神乃治”，知阴藏精气于内以生养阳气，阳护卫于外以固腠理，只有阳气固秘，阴精充盈，阴阳二气调和，始能气血畅行，健康无病。本证失精、梦交，为精气内夺，阴损及阳，阳失固秘所致，故有心动悸，气上冲，头晕，耳鸣，脱发，失眠，多梦，自汗，盗汗，少腹弦急，阴头寒，舌红嫩少苔，脉象芤迟等阴阳乖戾、寒热错杂症状。其治疗，温阳则有火动之弊，滋阴则有助寒之嫌，二法皆非所宜，何也？形不足者温之以气，精不足者补之以味（《素问·阴阳应象大论》），损其肾者益其精（《难经·》）难道有误？非也，此虽阴精内夺，阳气不固，然与肾气丸证有别，其发热、汗出、恶风、畏寒等营卫不和之症，或多或少必然有之。故其治不二法门，唯和调营卫耳。倘潜阳入阴，阳固阴守，则热者不热，寒者不寒，梦交、失精诸症愈矣。阴阳失和，精关不固，非仅见于失精，梦交，近贤用本方治愈自汗，盗汗，遗尿，乳泣，早泄，不射精，睾丸疼痛，带下，小儿夜啼等。余亦有桂枝加龙骨牡蛎汤治愈阳痿、惊悸之案例。经观察本证有如下特点：

面色少华，神态萎靡，情绪低落，容易紧张，舌质淡嫩，脉弦细缓、或大而无力的，皮肤湿润，腹肌挛急，脐上动悸。

常汗出，恶风寒，口干不思饮，不欲食。虽病证呈虚弱之象，然药补食补终不见效。

黄煌云：桂枝加龙骨牡蛎汤针对的是一种以精神症状和生殖及性功能低下为表现特征的虚性体质。所谓精神症状，大多是焦虑、不安、失眠、多梦等。《金匮要略》原文提到桂枝加龙骨牡蛎汤治疗“男子失精，女子梦交”以及“阴头寒”；临床也发现，本方对与性相关的症状有效，如性梦、梦遗、阳痿、早泄等，甚至对男子精子质量低下以及女性更年期综合征也有效。

识别此方证还是要抓体质。一般来说，都是白瘦而且容易出汗者比较适用。临床上常见那些面白体瘦的儿童，目睛虽有神而多易惊、夜啼不安，且多汗；那些白瘦体弱的青年男女，也多见心腹动悸、易失眠、多梦、易盗汗。对此，可以注意桂枝加龙骨牡蛎汤证是否存在。我的经验，桂枝加龙骨牡蛎汤通常用于缺钙、缺锌孩子的睡眠不良、烦躁多动、自汗盗汗等。对如各种心脏病见心律不齐或血压偏低者，或心悸、自汗者，或脉空大无力者，也有改善症状的效果。决定本方能否应用的关键，是脉象与舌象。脉必见浮露、大而无力的，若沉细、沉实或大而有力均不是本方脉象，应当注意。舌质嫩红、湿润、舌苔薄白者可用，这表示正气虚而内无邪。舌质黯红坚老者，为里有郁热；舌质淡白胖大，为里有寒湿水饮；舌苔黄腻、焦干、厚腻分别代表里有痰热、积热、湿浊等，都妨碍本方作用的发挥，故慎用。

393、【桂枝加龙骨牡蛎汤治心悸】：

李某，奇村一老妪。心悸不宁，胆怯善惊，常有遇险临危之感，已逾三月。体倦神疲，纳谷不馨，夜寐甚难，肢体颤抖，不由自主。某医院门诊病历记录：心率 140 次/分，血压 120/80mmHg，心电图提示窦性心动过速。医治少效。视其舌，淡红少苔，边有齿痕。切其脉，疾速不宁。心者，生之本，神之变也。心虚则易受惊恐，惊恐则心悸不宁。治当补心阳，养心阴。设阴平阳秘，神安其舍，则悸从何来？拟桂枝加龙骨牡蛎汤治之：桂枝 10g，白芍 10g，炙甘草 6g，龙骨各 30g，生姜 6 片，红枣 6 枚。二剂。二诊：惊悸、颤抖均止。胃纳增，睡眠佳。恨求中医之晚，恐悸再发，前来索方，与付原方三剂。（《经方躬行录》）

李映淮老师评语：《素问·调经论》：“血有余则怒，本足则恐。”再从惊恐伤肾来论，当系血亏、肾虚导致之心悸不宁，心神不安。桂枝加龙骨牡蛎汤调阴阳，镇惊悸，然非补剂。故心悸止后，应予补血、滋肾以治。

394、【桂枝加龙骨牡蛎汤治心悸】：

赵某，女，55岁，西街人。家贫齿繁，操劳任重，气血暗耗于无形。加之疏食充饥，纳运不健，生化之源匮乏，心神失养累年日前忽觉胸中悸动，怔忡不安，胸憋短气，动则尤剧。望其面带菜色，头发枯槁，肌肤干燥，形体瘦削；舌淡红，苔薄白。询知时发热，自汗出，微恶寒，易外感，饮食不思，大便二三日一行。诊其脉，细数中参伍不调，此促脉也。触其腹，腹皮薄，柔软不痛。心电图检查：心房纤颤。观其脉症，病属营卫不和，血虚心悸。盖脾为营之源，胃为卫之本，劳伤脾胃则营卫不和，心神失养则悸动不宁，师《难经·“损其心者，调其营卫”之说，拟桂枝加龙骨牡蛎汤：桂枝10g，白芍10g，炙甘草6g，龙牡各30g，1生姜6片，红枣5枚二剂，二诊：心悸短气减轻，汗出、恶寒消失。然竟又出现五心烦热，口鼻干燥，牙龈出血，喜冷思饮等阴虚血热之状，此过用辛温故也，速宜滋阴凉血，以纠其偏。拟增液汤加味：生地24g，元参15g，麦冬15g，丹皮10g，茯苓10g，甘草6g，石膏30g，乌梅30g，三剂心悸止，烦热思冷大减，齿衄不再。心电图检查：窦性心律。守方三剂，嘱其好生养息，食疗善后。按：桂枝汤系调和营卫之方，药后寒热休、汗出止，示营卫和谐，阴阳平秘。其服法，仲圣有一服病差停后服，不必尽剂之训。而本案连用三剂，致使辛温过盛，出现阴伤之症，亦即“桂枝下咽，阳盛则毙”之候也。幸得及时滋阴，方使症状得解，实一教训也。（《经方躬行录》）

395、【桂枝加龙骨牡蛎汤治女子梦交】：

梦交男子遗精，临床多见矣。女性虽无精可遗，然有津可泄。有赵某者，26岁。梦交泄津，夜无虚夕，已逾三年。至后与孩吻亦泄。体倦无力，头晕嗜卧，五心烦热，善怒多疑，杂治不效。乡人愚昧，谓狐狸精作祟，求神祈巫，毫无应验。体形日瘦，容貌日焦。自视痊愈无望，不愿治疗，后其兄迫其来诊。视其舌，红瘦少津。诊其脉，弦长细数。《张氏医通》云：“肝热则火淫于外，魂不内守，故多淫梦失精。”观其脉症，初则相火失静，久则阴津亏虚，治当滋阴益津，清火宁心。拟封髓丹、增液汤加味：黄柏10g，甘草6g，砂仁4.5g，生地30g，元参15g，麦冬15g，乌梅30g，白芍15g，每日一剂。

二诊：疗疾用药三天打鱼，两天晒网，未遵余令。虽一月仅服九剂，然梦交已明显减少。头晕轻，烦热止，精神大好，其获效颇出想象。仍口干口苦，舌质红润，苔薄黄，脉象弦长。思《金匱要略》治失精梦交之桂枝加龙骨牡蛎汤，具有调和阴阳，潜阳固涩之功，今阴虚证状已轻，相火亢盛亦减。明未全内守，阳未皆固秘，投用桂枝加龙牡汤，已至其时。拟桂枝加龙牡汤加味：桂枝9g，白芍9g，甘草6g，龙牡各30g，乌梅15g，知母9g，黄柏9g，生姜2片，红枣6枚，五剂。

后见其兄，知病已愈。按：梦交一症，成年男女皆有，只是隐匿不言而已。体健者，偶有梦遗应属正常。若次数频繁，则属病矣。《类聚方》云：“妇人心气郁结，胸腹动甚，寒热交作，经行常衍期、多梦警惕，鬼交漏精，身体渐就羸瘦，其状恰似劳瘵，孀妇室女，情欲妄动而不遂者，多有此症。”小说《金瓶梅》第十八回：“六欲七情所致，阴阳交争，乍寒乍热，似有郁结于中而不遂之意也，似症非症，似寒非寒，白日则倦怠嗜卧，精神短少，夜晚则神不守舍，梦与鬼交。”可见心有所思、所欲不遂久者，必心火炎于上，相火炽于下而见梦遗。故初病火盛者清心为主。久病阴虚者滋阴为先；阴损及阳者，则宜阴阳双补。多数患者有忧虑、恐惧之状，用药同时，须释疑解惑，常有事半功倍之效。（《经方躬行录》）

396、【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈反复噩梦1年】网文：

商某，男，55岁，初诊日期：2018年1月15日主诉：反复做噩梦1年，加重两周。现病史：患者因1年前弟弟突发头痛，亲自目睹其在6小时内不治身亡，受到惊吓，反复夜间噩梦，梦到与死去的亲朋来往，平均2-3天1次。2周前加重，每日梦见与死人打交道，就

诊于我处。刻下症：每日噩梦，睡眠不佳，每晚9-10点上床休息，能立即入睡，但睡中噩梦连连，与死去亲人来往，12点即醒来，醒来后不能再次入睡，每晚能睡眠2-3小时，全身怕冷。查体：舌淡胖大，有齿痕，苔白腻，脉细。典型的“夫失精家”症状诊断：噩梦——桂枝加龙骨牡蛎汤证治疗：方用桂枝加龙骨牡蛎汤。桂枝15g，白芍15g，生姜15g，大枣12g（可以用到20g），生甘草10g，生龙骨15g，生牡蛎15g，14剂，水煎服，日1剂，分3次早、中、晚饭后半小时服用。疗效：患者服药14剂后，再未做噩梦，可睡到每晚2-3点醒，每晚能睡眠4-6小时，全身怕冷痊愈。随访1个月未复发。

397、【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈脱发2年案】网文：

王某，女，40岁。初诊日期：2020年10月15日主诉：反复脱发2年。现病史：患者2年前出现脱发，逐日加重至今，同事称其“发际线一直后移”，每天均有一大把头发脱落，洗头时尤甚，扫地时发现办公室工位周围、家中头发掉落遍地，现为求诊治就诊于我处。刻下症：脱发，紧张后或坐位时出现眩晕感，眩晕时伴反酸烧心，排气多，怕冷，纳可，眠差，大便1日1次，不干不稀，夜尿0次。

查体：体型偏瘦，舌淡，苔薄白，舌边有齿痕，脉沉弱。抓主证：脱发、脉虚诊断：脱发——桂枝加龙骨牡蛎汤治疗：方用桂枝加龙骨牡蛎汤。桂枝15g，生白芍15g，生甘草10g，生姜15g，大枣18g，生龙骨15g，生牡蛎15g。14剂，水煎服，每日早、中、晚饭后各服一次。二诊（11月2日）：患者自诉服药1剂后脱发便有明显减少，服药3-4剂后扫地时发现地上掉落的头发亦明显减少，已不再怕冷。

398、【桂枝加龙骨牡蛎汤治愈脱发6年案】网文管志敏：

潘某，女，38岁，2022年9月30日就诊。主诉：自觉头发脱落严重6年。现病史：患者6年前在产后出现头发脱落严重，梳头时可见大片头发脱落，身感乏力，畏寒怕冷，时有小腹冷痛，时有头晕，睡眠不佳，多梦，二便调。今为求中医针灸治疗，故来我科就诊。患者既往体质可，否认心，肺，肝，肾，内分泌，脑等重大器官疾病，否认手术、外伤、输血史。过敏史：否认食物、药物过，吸烟史无，末次月经2022-09-11。中医四诊：望诊：舌质淡，苔薄，脉芤。诊断：头风病脱发。1.处方：桂枝加龙骨牡蛎汤加减。方药：桂枝15，白芍15，生姜15，大枣15，炙甘草10，党参15，龙骨30，牡蛎30，附子15。颗粒剂，7贴，水冲服。2.于背部行隔姜灸治疗。经上述方法治疗月余，患者脱发问题基本得以解决。

按语：脱发是临床常见的症状，中医认为，肾藏精，主生殖，其华在发，而发为血之余，故头发与精血关系密切，脱发的产生，与精血亏虚关系密切。《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治第六》有云：夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩发落，脉极虚芤迟，为清谷亡血失精……桂枝加龙骨牡蛎汤主之。产后出现脱发，此可理解为“失精家”。临床发现，女性在产后、病后、术后、熬夜后、大汗后出现脱发较为多见。结合《金匱》的条文，面对脱发，可以首先考虑桂枝加龙骨牡蛎汤。

399、【经方桂枝加龙骨牡蛎汤生发黑发】网文古朴中医：

治疗一位未婚小伙子男科病，用了桂枝加龙骨牡蛎汤。获得一个意外效果：大片脱去的头发开始慢慢复生，黄黄干枯的头发开始变黑发亮，黏黏出油的头发开始干净爽利。

桂枝加龙骨牡蛎汤出自《金匱要略》：男子脉浮弱而涩，为无子，精气清冷（一作冷）。夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩（一作目眶痛），发落，脉极虚芤迟，为清谷，亡血，失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之。

此方为当今男科病极为对证之方，可惜很多同行滥用补肾药物，没有治好的。条文中有一个词，相信很多朋友没有注意到，那就是“发落”。真是神奇啊，我们的老祖宗是怎么观察到的？男人下面那点事，居然和上面关联着！记得曾经看过汉方医生论述说，他们发现牡蛎有助于生发，大意是在一些方剂里面加入牡蛎，治疗脱发的效果就会好。汉方医生研究中医，总是有点太“现代”了，往往会跑到某药治某病的不归路上去，不过，有时候还是有启发性的。这是我第一次观察到这个意外效果，不代表治疗脱发就用桂枝加龙骨牡蛎汤。但是

用桂枝加龙骨牡蛎汤治疗伴有男科症状的患者，当为有效。是这个逻辑吧？！

400、【经方桂枝加龙骨牡蛎汤治脱发案例】网文：

安某，男，14岁，学生。其母代诉：3个月前，原因不明出现脱发，在当地村、乡及县中医院、人民医院等经中西药治疗，不仅脱发未见好转，反而又出现头晕头痛、心烦急躁等。刻诊：脱发有20余处，大的直径约2.5cm左右，小的如黄豆大，心烦急躁，睡眠不佳，乏力，偶有少腹不适，夜间小便略多，腰膝酸困，口不渴，舌质淡，苔薄白，脉细弱。辨证为心肾虚寒证，其治当温阳散寒，交通心肾，以桂枝加龙骨牡蛎汤加味：桂枝9g，白芍药9g，生姜9g，大枣12枚，甘草6g，龙骨20g，牡蛎20g，何首乌24g，补骨脂10g，熟地黄12g，当归15g。12剂，1日1剂，水煎2次分2服。

二诊：自觉精神有明显好转，但仍然没有新发生出，复以前方12剂。

三诊：脱发处已有黄绒发生出，大的周围绒发长出比较明显，继以前方服用。之后，约服用有40余剂，头发全部长出，为巩固疗效，又服药12剂。1年随访，未再脱发。

401、【桂枝加龙骨牡蛎汤腰痛医案】网文：

袁某，男，35岁，腰痛月余，稍弯腰或久坐即觉腰痛，时觉腰酸，眠差，盗汗，纳可，大小便可，舌质淡红，苔白脉，细涩。《金匱要略》有云：“脉大为劳，极虚亦为劳”，患者正值壮年，却脉象细涩，加之夜间盗汗，形体瘦弱，故诊为虚劳，处方桂枝加龙骨牡蛎汤：

桂枝15g，生白芍15g，炙甘草10g，生龙牡各30g，生姜6片，大枣3个（切）为引。

患者服药后腰痛明显好转，以此方加减，服药一月，腰痛未再出现！

402、【桂枝加龙骨牡蛎汤证治精气不固两足乏力医案】曹颖甫：

周左，早年精气不固，两足乏力，头晕目花，证属虚劳，宜桂枝加龙骨牡蛎汤。川桂枝三钱，生白芍三钱，生甘草二钱，龙骨一两先煎，左牡蛎三两先煎，大黑枣十二枚，生姜八片。

按：《要略》云：“男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。”故本汤之治遗精，医者所尽知也。顾知之而不能用之，其所用者，每偏于肾气丸一方，加补益之品，如续断、杜仲、女贞子、菟丝子、核桃肉之属。吾师治此种病，一二剂即已。余依师法而行之，其效亦然。时事新报馆黄君舜君患遗精已久，多劳则剧，不喜服重剂药，为疏桂枝白芍各钱半，炙草一钱，生姜一片，大枣四枚，龙骨牡蛎各三钱，三服而瘥，另有邹萍君年少时，染有青年恶习，久养而愈。本冬遗精又作。服西药，先二星期甚适，后一星期无效，更一星期服之反剧。精出甚浓，早起脊痛头晕，不肚痛苦。自以为中西之药乏效，愁眉不展。余慰之曰：何惧为，予有丹方在，可疗之。以其人大胆服药，予桂枝白芍各三钱，炙草二钱，生姜三大片，加花龙骨六钱，左牡蛎八钱，以上二味打碎，先煎二小时。一剂后，当夜即止遗，虽邹君自惧万分，无损焉。第三日睡前，忘排尿，致又见一次。以后即不复发，原方加减，连进十剂，恙除，精神大振。计服桂枝芍药各三两，龙骨六两，牡蛎八两矣。其它验案甚多，不遑枚举。

曹颖甫曰：此方不惟治遗精，并能治盗汗。十余年中，治愈甚众，但以数见不鲜，未录方案，并姓名居址而忘之矣。按桂枝汤本方原为营弱卫强，脾阳不振，不能令汗出肌腠而设。故辛甘发散以助脾阳，令肌腠中发出之汗液，与皮毛中原有之汗液混合而出，然后营气和而自汗可止。盗汗常在夜分，营气夜行于阳，则其病当属肌腠不密，汗随营气而外泄。营病而卫不病，亦为卫不与营和，故用桂枝汤本方，以和营卫二气，加龙骨牡蛎以收外浮之阳，故盗汗可止。若营卫未和，而漫事收敛，吾知其必无济也。

403、【桂枝加龙骨牡蛎汤证治夜寐喜盗汗医案】曹颖甫：

季左，十月十二日，夜寐喜盗汗，脉阳浮阴弱，宜桂枝加龙骨牡蛎汤。

川桂枝四钱，生白芍三钱，生草一钱，龙骨四钱，左牡蛎一两，生姜八片，红枣十二枚。

按：《金匱要略》云：“男子平人，脉虚弱细微者，喜盗汗也。”《巢源·虚劳盗汗候》云：“盗汗者，因眠睡而身体流汗也。此由阳虚所致，久不已，令人羸瘠枯瘦，心气不足，亡津

液故也。诊其脉，男子平人脉虚弱微细，皆为盗汗脉也。”丹波氏云：“《金鉴》云此节脉证不合，必有脱简，未知其意如何，盖虚劳盗汗，脉多虚数，故有此说乎？”吾师则曰此证桂枝加龙骨牡蛎汤所得而主之也。如本案所示，即其一例。服药后，每每周身得微微热汗出，以后即不盗汗矣。余用本方者屡，得效与治失精同。吴兄凝轩昔尝患盗汗之恙，医用浮小麦、麻黄根、糯稻根以止其汗。顾汗之止仅止于皮毛之里，而不止于肌肉之间，因是皮肤作痒异常，颇觉不舒。后自检方书，得本汤服之，汗止于不知不觉之间云。本汤既可治盗汗，又可治遗精，更可治盗汗之兼遗精者，所谓虚劳人是也。

404、【桂枝汤加龙骨牡蛎治脱发医案】陈兆祥：

刘某某，男，41岁，干部，1982年10月15日初诊。素体不健，经常罹病感冒。此次发病缠绵不愈，继而头发成片脱落，呈不规则形。脱处头皮光滑，无痛痒。前医曾用首乌片、桑麻丸、神应养真丹等治疗，病情反复，头发将近脱光。伴有畏寒汗出，神疲乏力，形体消瘦。舌质淡胖、苔薄白，脉沉无力。脉证合参，辨为卫阳虚弱，发失温煦而脱落。治宜温卫固发。方用桂枝加龙骨牡蛎汤加味治之：桂枝10克，赤芍10克，炙甘草6克，生龙骨10克，生牡蛎10克，炮附子10克，黄芪15克，生姜6克，大枣10克。水煎服，15剂。

药后患者精神振作、脱发处已有绒毛状毛发长出。原方加当归10克，继服30剂。半年后随访：自述服上方20剂后，头发全部长出，且逐渐变黑。现发黑光泽如常人，未再脱落。（《北京中医杂志》1988；（1）：52）、

按语：“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也。”卫气的强弱，直接关系到毛发的生长、润泽和牢固。今患者除脱发外，经常感冒，加之畏寒汗出，神疲乏力，舌淡脉沉等，显是卫阳虚弱所致。卫虚不能温养皮毛，根不牢固而脱落。《金匱要略方论》说：“目眩发落……桂枝龙骨牡蛎汤主之。”故投以桂枝加龙骨牡蛎汤温卫固发，再加附子、黄芪温阳益气。卫阳充，皮毛固，则脱发自然痊愈。

【解说】本方主治阴阳两虚之证。夫阴阳二者，既相互对立，又相互维系，阴充于内，阳守于外，以保持“阴平阳秘”之状态。盖失精之人，不仅阴液耗损，而且阳气亦因久泄而亏虚，《素问·生气通天论》云：“凡阴阳之要，阳秘乃固”。今**失却阳气的固摄，故走而不守；阳气失却阴液的涵养，则浮而不敛，故见男子失精、女子梦交、头眩、发落等证。本方以桂枝汤调和阴阳（桂枝、甘草辛甘化阳，芍药、甘草酸甘化阴），加龙骨、牡蛎，不仅固敛走失之**，而且潜纳浮越之阳气，与桂枝汤相伍，可谓刚柔相济，标本兼治。本方为治疗遗精、滑脱、梦交、惊悸、虚劳诸疾属于阴阳两虚者之要方。

405、【桂枝汤加龙骨牡蛎治每伤风即吐血梦泄医案】张璐：

沈懋甫仲子，年17，每伤风，即吐血梦泄，此肝脏有伏火，火动则招风也。盖肝为藏血藏魂之地，肝不藏则血随火炎，魂不宁则精随梦泄。遂与桂枝汤加龙骨、牡蛎，4剂而表解血止。桂枝汤主和营散邪，加龙、牡以镇肝安魂，封藏固则风不易入，魂梦安则精不妄动矣。若以其火盛而用知、柏之属，鲜有不成虚损者。（《古今医案按》1959：10）

406、【桂枝汤加龙骨牡蛎治项部自汗竟日淋漓不止医案】岳美中：

李某某，年46岁，男性，于1972年6月11日就诊。患项部自汗，竟日淋漓不止，频频作拭，颇感苦恼，要求治疗。诊其脉浮缓无力，汗自出。分析病情，项部是太阳经所过，长期汗出，系经气向上冲逆，持久不愈，必致虚弱。因投以张仲景之桂枝龙骨牡蛎汤和阳降逆，协调营卫，收敛浮越之气。先服4剂，自汗止，再服4剂，以巩固疗效。（《岳美中医案集》1978年版）

407、【桂枝汤加龙骨牡蛎治间歇性盗汗医案】付美青：

刘某，男，78岁，1987年6月10日诊。间歇性盗汗8年，近日加重，寐时汗出如洗。曾做全身检查，未发现器质性病变，西医诊为特发性多汗症。经治疗效果不佳，而就诊于中医，先投以当归六黄汤无效，再进牡蛎散出入不应。细察：神疲乏力，面色萎黄，无寒热，小便清长，舌淡、苔薄白，脉浮细略弦。窃思此乃营卫不和，阳不摄阴所致。治宜调和营卫，

养阴潜阳。方用桂枝加龙骨牡蛎汤加桑叶治之。

处方：桂枝、白芍、桑叶各 10 克，生姜 5 克，大枣 5 枚，生龙骨、生牡蛎各 30 克，炙甘草 3 克。每日 1 剂，水煎分 2 次服。1 剂汗减，2 剂汗止，以后一直未发。（《新中医》1992；（6）：44）

408、【桂枝汤加龙骨牡蛎治上半身烘热汗出医案】张秀云：

魏某，女，48 岁，干部，1994 年 2 月初诊。患者近半年来出现阵发性上半身烘热、汗出，下半身如常，每次汗出前，周身烦躁，闷胀不舒，继则数分钟内上半身大汗出，汗后如常，发无定时，精神紧张时加重。近 2 个月发作频繁，日发 1~2 次，伴失眠、多梦、月经不调。经西医诊为“更年期综合症”，曾服谷维素片，维生素片等疗效不显。舌尖红，苔薄白，脉细缓。患者年近五十岁，处更年期，肝气失调致阴阳逆乱，治以调理阴阳，调疏肝气。方用桂枝 10g，白芍 9g，甘草 10g，生龙骨 20g，生牡蛎 20g，炒枣仁 15g，生姜 3 片，大枣 3 枚，合欢皮 15g。复诊：前方服 5 剂后睡眠佳，出汗次数明显减少，舌脉同前，原方再服 6 剂而愈。（《河南中医》1995；（6）：343）

409、【桂枝汤加龙骨牡蛎治夜不能寐寐则梦遗医案】赵守真：

黄某，青年工人，不知爱身，恣意情欲，又因劳动不节，以致精神不固，心火妄动，夜不能寐，寐则梦遗，头晕身倦，气短息低，诊脉，尺寸皆虚，左关独弦细数，口苦心烦，有潮热，小便黄等证象……惟患者羸孱如斯，为救眉计，先用金锁固金丸，安神丸合剂（改为汤剂），固精安神，滋阴清火，以治其标，三剂烦热、口苦悉退，而夜梦尤多，遗无虚夕，再进固精丸（改汤），药为牡蛎、菟丝子、韭子、龙骨、五味子、桑螵蛸、白石脂、茯苓等。又二剂不唯未减少，而遗尤甚，因而用之无益也……。改处清心饮：党参 9 克，当归 9 克，生地 15 克，甘草 3 克，茯神 12 克，枣仁 12 克，莲肉 12 克，远志 5 克，黄连 2.4 克，水煎服，日 2 剂，三日无寸效，精遗如故。

因思《金匱》桂枝龙骨牡蛎汤有治失精之明文，玩味其方药，此属心阳之虚并水气上逆之患而与上方之唯一补养有间，且桂枝汤原为调和营卫，如易其分两，则可变为益阳和阴之用，加之龙牡镇心安神，核于本证殊可适应。桂枝 5 克，白芍 15 克，甘草 9 克，大枣 9 克，生姜 3 片，龙骨、牡蛎各 18 克并加茯神 15 克、辰砂末 3 克（另冲）以为镇降宁神之助。首 2 剂效不显，3 剂方乃著，梦少能睡，遗可相间，三数日不等。除仍服原汤外，早晚用莲心、金樱子煎汤送服妙香散 15 克，以增强镇心固精力量，半月精不遗，嗣后自固其本，拟归脾汤配吞都气丸，持续一月，神旺体健，大异畴昔。（《治验回忆录》1962：63）

410、【桂枝汤加龙骨牡蛎治入夜每与人交医案】徐伯伦：

高某某，女，34 岁，农民。入夜每与人交，天明始去，已 4、5 年，误为“狐仙”，羞愧难言。初则不以为然，久则心悸胆怯，延期失治，病情日重。避卧于邻家，仍纠缠不散。形体消瘦，困倦乏力，少气懒言，头晕眼花，腰膝疲软，带多清稀，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。系阴阳两亏，心肾不交，属梦交症。拟用桂枝加龙骨牡蛎汤：桂枝 18 克，白芍、龙骨各 20 克，甘草、生姜各 9 克，生牡蛎 30 克，红枣 7 枚。5 剂后，诸证消除，予归脾丸巩固疗效。随访 1 年未复发。（浙江中医杂志 1984；〈1〉：46）

411、【桂枝汤加龙骨牡蛎治小至今每夜尿床医案】叶益丰：

李某某，男，14 岁，1980 年 4 月 3 日诊。从小至今每夜尿床，虽多方求医，遍服单验方亦未见效，面色灰黯，小腹常拘急动悸，头晕耳鸣，舌质淡，苔薄白，脉迟缓。乃阴阳两虚，气不固摄之证。治宜扶阳益阴，固脬止遗。桂枝、白芍各 5 克，甘草 3 克，生姜 3 片，大枣 10 枚，龙骨、牡蛎各 20 克，猪脬一只（另煮汤），汤和药汁服，猪脬亦可同服，嘱晚间禁服茶水。1 剂后，遗尿即止。服 10 剂而愈。至今未复发。（山东中医杂志 1985；（5）：20）

412、【桂枝汤加龙骨牡蛎治产后暴崩医案】连建伟：

冯某某，女，28 岁，1971 年 10 月 20 日诊。患者系初产妇，产后恶露已净，少腹不痛。突然于产后第 26 天晚上暴崩不止，急送某医院。经西医用止血剂治疗并输血 400 毫升，病情

有所好转，但漏下仍未止。又服当归炭、炒白芍、生地炭、丹参炭等养血止血之剂，反增心悸怔忡，饮食减少等证。改邀笔者诊治。患者脉来细弱，舌质淡白少华。辨证论治：产后暴崩，无腹痛，为气虚不能摄血之证。气为血之帅，气虚则血不循经而妄行。此证本应益气摄血，反投养血止血，滋腻之性，损伤阳气，心阳受损则心悸怔忡，脾阳不振则纳食少进。脉来细弱，舌质淡白少华，均为气血大虚之象。治拟益气养营，引血归脾。处方：桂枝 4.5 克，炒白芍 9 克，炙甘草 4.5 克，生姜 3 片，大枣 5 枚，龙骨 15 克，牡蛎 24 克，党参 12 克，炙黄芪 12 克，炒白术 9 克，广皮 6 克，黑归脾丸 12 克(吞)。3 剂。

10 月 23 日复诊：漏下渐止，纳食渐增，怔忡亦有好转，再服原方 3 剂，诸症悉愈。(《金匱方百家医案评述》1991: 75)

413、【桂枝汤加龙骨牡蛎治带下清稀绵绵不断医案】叶益丰：

吕某某，女，45 岁，1979 年 3 月 14 日诊。带下清稀，绵绵不断，时达两年，屡经医治，时缓时剧，面色觥白，头晕乏力，乱梦惊悸，黎明盗汗，小腹冷痛，腰痛如折，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。此为久带耗阴，阴损及阳，带脉失约之证。治宜扶阳摄阴，固涩止带。药用桂枝、白芍各 10 克，甘草 5 克，生姜 3 片，大枣 10 枚，鹿角胶、菟丝子、苏芡实各 20 克，煅龙骨、煅牡蛎各 30 克。连服 10 剂而愈。(山东中医杂志 1985; <5>: 20~21)

按语：带下为病，总属带脉失约，故《妇人良方》曰：“人有带脉，横于腰间，如束带状，病生于此，故名为带。”本例久带耗阴，阴虚阳衰。桂枝龙骨牡蛎汤扶阳益阴，更佐鹿胶、菟丝、芡实益精壮阳，补养带脉。阳充阴足。阳敛阴固，带脉约束，故诸疾自愈。

414、【桂枝汤加龙骨牡蛎治患心慌气短医案】罗卫东：

刘某，男，22 岁，战士，1985 年 5 月 17 日初诊。患心慌、气短半年余，查心电图示：预激症候群伴短暂性室上速。西药治疗月余疗效欠佳。刻诊：心悸易惊，四肢末端冷而不温，胸闷气短，动则汗出，头昏目眩，舌质淡嫩，苔薄白，脉细数。诊为惊悸，辨属心阳不足。治宜温补心阳，安神定悸。方药：桂枝 12g，白芍 12g，炙甘草 10g，龙骨 20g，牡蛎 20g，生姜 6g，大枣 10g，党参 10g，炒枣仁 15g。5 剂，日 1 剂，水煎服。

二诊：心悸好转，肢冷转温，仍觉气短，动则汗出。细察舌边尖有小紫色斑点，此乃阳虚夹瘀也，续用上方加丹参、桃仁，连服 20 余剂，以上诸症消失，复查心电图正常。(国医论坛 1995; (6): 18)

415、【桂枝汤加龙骨牡蛎治失眠年余寐则乱梦医案】叶益丰：

华某某，女，48 岁，1980 年 9 月 12 日诊。因烦劳过度，失眠年余，寐则乱梦，惊惕不安，头昏汗多，面色觥白，舌淡苔薄，脉缓弱。乃心阴不足，心阳亏损，神不安舍。治宜益阴扶阳，养心安神。桂枝、甘草各 5 克，白芍、远志、酸枣仁各 10 克，龙骨、牡蛎各 30 克，生姜 3 片，大枣 10 枚，连服 10 剂而愈。(山东中医杂志 1985; (5): 21)

416、【桂枝汤加龙骨牡蛎治眩晕耳鸣心悸寐差汗多怕风医案】叶益丰：

程某某，男，56 岁，1981 年 10 月 8 日诊。眩晕月余，诊为高血压病，服降压药眩晕益甚。现症：眩晕耳鸣，心悸寐差，汗多怕风，面色萎黄，舌淡白，脉浮缓，血压 180/96 毫米汞柱。乃阴虚阳浮，虚阳上越之证。治宜益阴扶阳，镇纳潜阳。桂枝、白芍、甘草各 10 克，龙骨、牡蛎各 50 克，生姜 5 片，大枣 10 枚。3 剂汗止，心悸除，略感眩晕，血压 150/90 毫米汞柱。继服 5 剂，眩晕消，血压正常，诸恙悉瘳。(山东中医杂志 1985; (5): 21)

按语：《素问·阴阳应象大论》曰：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。本例阴阳两虚，阴不足内使，故心悸寐差；阳不足外守，则汗出怕风；阴不恋阳，虚阳上越，则眩晕耳鸣，血压升高。桂枝龙骨牡蛎汤益阴扶阳，镇摄潜阳。阴平阳秘，则诸症自除，血压复常。

417、【桂枝汤加龙骨牡蛎治烦躁精神错乱医案】张季云：

孟某，女，53 岁，农民，1993 年 12 月 2 日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13 服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不

舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢沉胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，随访1年末再复发。（《河南中医》1995；（6）：343）

418、【桂枝汤加龙骨牡蛎治表情抑郁少语寡言时时惊恐医案】付美育：

吴某某，女，36岁，营业员，1986年6月24日就诊。5年前因与人口角而突然晕倒，不省人事，四肢僵硬，约数分钟后苏醒，但仍觉头晕乏力，后反复发作，每月2~3次，每逢情志不畅则发作频繁，多种检查未发现器质性病变。西医诊断为癔病。5年来，服多种中西药罔效，遂求诊于余。刻诊：发作后2天，表情抑郁，少语寡言，时时惊恐，伴头晕，时自汗出，舌淡、苔薄白，脉弦略浮。予桂枝加龙骨牡蛎汤治疗。处方：桂枝10克，白芍、炙甘草各20克，生龙骨、生牡蛎各30克，生姜5克，大枣30枚。每日1剂，水煎分2次服。服药5剂，自觉诸症消失，效不更方，守原方续进30余剂，5年沉痾遂愈，随访至今，未再复发。（《新中医》1992；（6）：44）

419、【桂枝汤加龙骨牡蛎治阴囊阴茎及小腹冰冷医案】：

李某，男，29岁。一年多来阴囊、阴茎及小腹冰冷，经用附子、肉桂、小茴香、吴茱萸：巴戟天、大茴香、硫磺等药及八味地黄丸、黑锡丹、龟龄集、附桂理中丸等无效。舌苔白，脉弦缓。心火浮越于上，肾阳亏损于下。拟桂枝龙牡汤摄浮阳，调阴阳。桂枝12克，白芍12克，龙骨12克，牡蛎12克，生姜12克，甘草6克，大枣10个。服药30剂痊愈。（山西医药杂志1976；（4）：31）

420、【桂枝汤加龙骨牡蛎黄芪汤治头晕耳鸣医案】叶益丰：

金某某，女，32岁，1978年3月4日诊。产后半月，发热十天，汗多，心悸纳呆，口淡不渴，头晕耳鸣，面色苍白，两颧泛红，二便调和，舌淡苔白，脉浮大，按之芤，体温39.5℃。此乃产后阴血内亏，阳气外浮之证，若误用表散，有漏汗亡阳之危。宜益阴扶阳，镇摄收敛。桂枝、白芍各10克，生姜5片，大枣10枚，龙骨、牡蛎各30克，黄芪40克，当归10克。2剂热退汗止，继服3剂而愈。

421、【桂枝汤加龙骨牡蛎治气从少腹上冲医案】张德超：

陈姓妇女，42岁。因受惊后，始感头昏，头痛，夜眠不宁，继则感气从少腹上冲，如奔豚之状，上至心胸则惊恐不安，甚则汗出，发则几乎欲死，移时冲气渐平，精神亦渐复。苔白而润，脉沉弦。如是者三年，时愈时发。证系心阳本虚，肾之阴气上逆。予本方重用桂枝加味。遂疏：桂枝15克，白芍10克，炙甘草5克，龙牡各30克（杵，先煎），紫石英15克，生姜4片，红枣7枚。服至20余剂，冲气渐平。后以甘麦大枣汤调理善后，竟收全功。（北京中医1984；（3）：34~35）

422、【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗精5年屡治不愈视力逐渐下降医案】叶益丰：

黄某某，男，38岁。1989年11月2日诊。患者遗精5年，屡治不愈。2月来视力逐渐下降，昨起两眼失明，仅呈见光感，来延余治。时见除上证外，察其两眼外形正常，伴见面色不华，形体瘦弱，头发稀疏干枯，汗出怕风，小腹拘急，腰酸阴冷，头晕耳鸣。舌淡少苔，脉迟弦大，按之无力。此乃阴阳两虚，固摄失职，精气衰弱，不能上营。治宜益阴固阳，扶阳摄阴。投桂枝龙骨牡蛎汤加味。桂枝、白芍各10克，甘草5克，龙骨、牡蛎、党参、熟地各30克，生姜5片，大枣5枚。水煎服，日1剂。服药5剂，视力好转，遗精一次，诸症减轻。效不更方，守方服35剂，两眼视物如常，视力恢复为1.5，遗精未作，诸症消失。（江苏中医1993；（4）：18）

423、【桂枝汤加龙骨牡蛎治咳嗽气喘医案】魏如恢：

刘某某，男，2岁，于1980年4月10日入院。小儿入院时咳嗽气喘，汗出，低热，面色苍白，烦躁啼哭，西医诊断为小儿肺炎。给青、链霉素注射，口服小儿四环素、氨茶碱之

类，汗出不止，曾用阿托品注射。当时汗出虽止，药效消失后又大汗淋漓，特邀请中医会诊。证见身热而面色觥白，咳嗽气喘，汗出淋漓，四肢欠温，消瘦神倦，舌淡而嫩，指纹沉而色淡，乃为后天失调，稚阳不足，受邪之后显现正气不支，营卫失和之证，拟桂枝加龙牡汤，重用龙骨、牡蛎。处方：桂枝6克，白芍9克，龙骨18克，牡蛎18克，甘草3克，红枣2枚，生姜2片，紫菀6克，川贝母3克。经服3剂，诸症消失。适当调理痊愈出院。（《江西中医药》1985；（4）：64）

按语：小儿肺炎，本以热证居多，但有些患儿出现心阳不振，营虚卫弱之证者，乃为正虚邪恋，虚多实少的一种变证，多由婴幼儿平素体质虚弱，稚阴稚阳之体，无力抗邪外出所致。运用本方治疗小儿肺炎必须辨证清楚，方不致误。

我们体会必须掌握如下几个辨证要点：1. 年龄幼小，体质素弱，病程较长；2. 有汗而热不解，面色苍白，舌质淡嫩无华，脉细弱无力；3. 身热起伏不退，热势虽高，但无面赤、口渴、舌红、苔黄等化燥伤阴趋势；4. 全身有汗，汗出粘凉，汗后皮肤四肢欠温。我们体会，肺炎后期，若见发热起伏，有汗热不解，舌质淡嫩，面色苍白等，服用本方一般在三天左右发热渐退，诸症亦随之消失。若患儿神倦汗出，倍用龙骨、牡蛎，加黄芪、浮小麦以益气固表；兼咳嗽不爽加贝母、橘红、杏仁、紫菀以化痰止咳；肺虚喘促者加五味子、麦冬以补益肺气；痰多而稀食少者加苏子、白前、半夏、陈皮以化痰和胃。

【补述】：有学者认为，本方组方严谨，在治遗精等证中不宜加减，固守原方每获卓效，指出经方之加减与否，须视病情而定，非必加减而后效，故古方不治今病论，亦属无稽之谈。并举两遗精病案而阐述之。

424、【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗泄无梦阳痿不举医案】：

李某某，男，40岁，遗精半载，诸治不效，于82年4月13日来院就诊。证见：头晕神疲，面色萎黄，遗泄无梦，阳痿不举，舌存常薄苔，脉濡软如烂棉。证属肾元虚衰，相火不蛰，由精伤导致气馁。治宜引纳固下，益气调中，与桂枝加龙骨牡蛎汤再加黄芪、党参。进4剂，遗泄依然。筹思再三，以为病深药少，嘱其再进4剂，仍无寸效。于是以原方去参、芪与之。三剂知，六剂愈，至今未发。

425、【桂枝汤加龙骨牡蛎治遗精十余年医案】：

齐某某，男，53岁，黔阳县竹器厂篾工。遗精十余年，多方治疗而效不显。于82年7月14日来院就诊。证现头晕目眩，虚羸少气，腰酸肢冷，小便频数不禁，寝难成寐，遗泄无梦，近来几无虚夕。脉来弦细而弱。此亦精气神俱虚之候，亦与桂枝加龙骨牡蛎汤再加参、芪。并非故蹈复辙，以图再试耳！谁知进4剂后，不效依然。遂于原方去参、芪与之，进三剂，遗泄戛然而止。续进十余剂，诸证寻愈。随访至今，情况良好，间或一遗，不药而愈。（刘雪堂·经方加味而效不显·《江西中医药》1984；（6）：36）。

426、【桂枝加龙骨牡蛎汤治遗尿】宁飞：

大约是在2015年时候，我当时还在读书，当时学校搞了个医易协会，协会里有个学妹。她的妹妹，某女，13岁，正读初中。总遗尿，畏寒，面色很白。因为是转述，也就没有舌脉。2014年就有问我，我当时开了肾气丸，她父亲也略懂医术，考虑什么小儿纯阳之体，不适合用附子类，就没服药。2015年3月24日，又以遗尿问我。我处以桂枝加龙骨牡蛎汤，桂枝、芍药各6，生姜2片，红枣4枚，龙骨、牡蛎各15（先煎）。4月24日偶然提及，回我：5剂即不再遗尿。后再嘱服前方，调整剂量，桂枝12，芍药12，炙甘草6，生姜4片，大枣5枚，龙骨牡蛎各18。再后就没再提了。

思考：对于遗尿，一般不用辨证，基本都可以直接喝桂枝加龙骨牡蛎汤，其中中药基本都能药食同源，安全无毒。其实就今天看来，她这个用肾气丸很可能也能治愈，当然她最后没吃。对于桂枝加龙骨牡蛎汤治遗尿，我考虑的是桂枝白芍调气血，整方偏温，龙牡入少阴经，故而善治少阴病。但其实我还是低估了桂枝加龙骨牡蛎汤。在陆自量的经验中，他不只用来治小儿遗尿，还用来治“膀胱咳证”，也就是有些老年人（特别是妇女），咳嗽时候会遗尿。

其实桂枝加龙骨牡蛎汤还治疗虚劳、遗精、盗汗，但是我觉得并不神奇，唯有治疗遗尿上亲身经历有奇效。可能是遗尿属怪病，所以给人印象更深刻吧。

427、【桂枝龙骨牡蛎汤之夜必遗尿治验】陆自量：

中表某君有四岁女，患小便频数，日夜无度，然无其他症状。夜必遗尿数次，彼母深恶之，遂求治于余，以疗此恶疾。余沉思之，窃念遗尿之病，世多此疾，而无此方，在小儿则为司空见惯，在成人亦为秘密暗疾，故世少特效方，此亦破题儿之治证也。俄顷，悟得《金匱》桂枝加龙骨牡蛎汤为治男女失精梦交之良方，曾有人施治于膀胱咳证，且日人以此汤疗久年遗尿，每得特效。虽未亲历，实验所载，谅不我欺，乃处以整个的桂枝加龙骨牡蛎汤（桂枝、芍药各二钱，生姜二片，红枣四枚，龙牡各五钱），令试服之，竟二剂，遗尿已愈，洩数亦调。于服药时，彼母佯为枣子汤与之，故该孩颇为欢迎，益系纯属甘味，绝无苦口之药，虽有生姜之辛，尽为甘味所掩。服后亦无反射影响，故该孩屡索枣子汤不已也。

考遗尿证系肾脏泌尿作用兴奋，膀胱尿道括约肌麻痹而弛缓，致患尿意频数。投此汤，大枣、甘草正能缓和肾脏泌尿之兴奋，桂枝、生姜含有挥发油，能直达生理变常之所在地——病处——刺激括约肌之麻痹，使之兴奋，同时以龙骨、牡蛎含有石灰质，芍药含有单宁酸，能为之收敛，遗尿病遂由是而愈也。此汤之能愈失精者，亦从而知之矣”（录《苏州国医杂志》）。

余亦曾仿此用本汤治高年妇人遗尿，其结果大致甚佳。惜其报告系由人辗转传来，故不甚详明耳。读者如遇此证，大可一用此汤，盖以补治虚，以涩治遗，乃吾中医之大法，复何疑为？

注家按：思考：我怀疑上面陆自量所说的“日人以此汤疗久年遗尿”，这个日人要么指浅田宗伯，要么指丹波元简，都是日本名医。日本在民国时和中国曾有一段关系蜜月期，所以很多民国时的知识分子有留日学习经历或者参读日本书籍，在此影响下，近现代有很多老中医较崇拜日本中医。我没怎么读过日本的医书，就大致翻看过《皇汉医学》。但日医的特点大概能看个七八。和古中医对比，日本没有经历过后世宋明理学，受唐文化更深相对更深，更重视经验积累，而中国人更重辨证论治。相对于治病来说，经验肯定更重要一点。所以民国时期提出“废除中医”、“废医存药”口号的余云岫，就有留日求学的经历。中医理论中含有鲜明的阴阳五行等哲学思想，这是日医不重视的。台湾中医大多很崇拜日本中医，因为1949年去台湾的基本都是民国时有名的中医，传承下来自然和日医比较像。

比如我们流派代表方之一的“门氏护胃散”中有连翘，用来治疗癌症放化疗术后呕吐、食欲不振的。遍翻古今医书，除了“保和丸”中有连翘外，很少有见用连翘治脾胃病的。连翘止呕，就是经验用药，国人一般解释就是连翘用在此处清阳明胃热止呕，但无经验积累。而汤本求真的《皇汉医学》中有段记载：“《牛山治套》曰：“大人小儿呕吐不止，可用连翘加入任何药方之内，此家传之大秘密也。”可见日人对于经验积累确实是值得学习的。就像桂枝+龙牡治遗尿，也是日医用的多。

428、【桂枝加龙骨牡蛎治遗尿】浅田宗伯：

《橘窗书影》云：幕府集会酒井六三郎，年80。遗尿数年，百治罔效。余诊之，下元虚寒，小便清冷，且脐下有动，易惊，两足微冷。乃投以桂枝加龙骨牡蛎汤，兼服八味丸（即肾气丸），数日而渐减，服经半年而痊愈。桂枝加龙骨牡蛎，本为治失精之方，一老医用此治愈老宫女之屡小遗者；和田东郭用此治愈高槻老臣之溺闭；服诸药不效者，余用此治遗尿，屡屡得效。

429、【桂枝加龙骨牡蛎汤治小儿尿床8年】西湖虫二：

2020-4-10日，男10岁，反复尿床8年，近期1~2天尿床一次，夜间睡不安稳，听到动静则惊醒，纳差，舌质淡苔薄白，脉稍数偏弱。桂枝10，生白芍10，龙骨30，牡蛎30，炙甘草6，乌药12，益智仁30，柴胡10，枳壳10，大枣12，6剂，水煎分温两服。

一周后复诊，明显好转，上周尿床2次，予加强补肾固涩：桂枝10，生白芍10，龙骨

30, 牡蛎 30, 炙甘草 6, 乌药 12, 益智仁 30, 生麻黄 6, 金樱子 30, 淮小麦 30, 大枣 12, 6 剂, 水煎分温两服。尿床消失, 予上方 6 剂巩固, 一副药吃两天。

期间尿床一次, 随访一切尚好。停药。

虫二按: 此孩吃药后, 夜间睡觉踏实, 未有惊醒, 胃口大开, 体重增长不少。自从服药开始, 尿床仅有三次。为何, 典型的脾肾虚寒, 桂枝加龙骨牡蛎汤治疗遗精人所共知, 治疗尿床, 则来源于经方实验录。病机相同, 不论遗精遗尿均可用此方。乌药益智仁为缩泉丸, 治疗遗尿第一方。

又有麻黄, 为发汗利尿药, 为何能治遗尿? 因水道不通, 肺主通调水道, 前人有治疗遗尿常用药。我曾治一小孩尿床, 补肾健脾后大大减少, 但仍不断根, 予加麻黄 10g, 遗尿从此消失。可见此药之功。

430、【桂枝加龙骨牡蛎汤治遗尿医案】叶益丰:

李某, 男, 14 岁, 1980 年 4 月 13 日初诊, 从小至今, 每夜尿床, 虽多方求医, 遍服单方验方, 也未见效, 面色灰黯, 小腹拘急动悸, 头晕耳鸣, 舌质淡, 苔薄白, 脉迟缓。乃阴阳两虚, 气不固摄之证。治宜扶阳益阴, 固脬止遗; 桂枝, 白芍各 5 克, 甘草 3 克, 生姜 3 片, 大枣 10 枚, 龙骨, 牡蛎各 20 克, 猪脬一只 (另煮汤) 汤和药汁服, 猪脬也可同食, 嘱晚间禁服茶水, 1 剂后遗尿止, 服 10 剂而愈。 (《金匱名医验案精选》)

论: 桂枝龙牡汤, 能治小儿遗尿, 能治成人遗精。其时道理相同, 夜半一阳始生, 阳生而不能升, 则淫邪发梦, 木气疏泄, 梦中遗溺也。遗精与遗尿, 皆是木气疏泄而失藏也。桂枝龙牡汤, 升左路之清阳, 建中承气也, 清阳升则遗自止。小儿遗尿者, 只是中虚木陷, 虽不是劳, 也有五苓散证。用小建中汤, 黄芪建中汤, 或肾气丸, 也都能治遗尿。但龙骨牡蛎方者, 更像是特效药。另外, 就是所有医案中的剂量都那么小, 医生到底怕什么。其实开始没有考古结论, 临床就没有剂量依据。

431、【桂枝加龙骨牡蛎汤治梦交医案】廖仲颐:

张某, 女, 30 岁。小学教员。1970 年来, 患者悲哭不已, 似有隐情难言。自诉婚前多梦与人交, 婚后与夫性交时, 阴道干涩, 疼痛难忍。久之, 因畏痛拒绝与夫性交。但梦交时淫液自遗。去医院做妇查, 亦无异常发现, 夫疑为思变, 遂欲离婚。患者因此抑郁不乐, 形体渐见消瘦, 头晕目眩, 心悸健忘, 失眠多梦等症接踵而至。脉来革, 此阴阳失调, 心肾不交, 治宜调和阴阳, 潜镇固摄。处方: 桂枝 15 克, 白芍 18 克, 龙骨 18 克, 牡蛎 18 克, 炙甘草 6 克, 生姜 3 片, 大枣 3 枚, 5 剂。复诊: 梦交未发, 但与夫性交时, 仍无淫液, 此肾阴亏损。治宜补肾固精。处方: 党参 18 克, 熟地黄 24 克, 枸杞子 18 克, 当归 12 克, 山茱萸 10 克, 淮山药 15 克, 杜仲 15 克, 女贞子 18 克, 炙甘草 6 克, 服上方 10 剂后, 梦交未见复发, 与夫性交亦无痛苦。 (《湖南省老中医医案选》1980: 184)

按: 患者婚前罹病梦交, 婚后如故。此劳伤心气, 心肾不交所致。《难经》曰: “损其心者, 和其营卫。”故治用桂枝汤温养心气、调和阴阳, 加龙骨、牡蛎敛纳浮火, 心气复、心肾交则梦交不作。其后, 再以养阴补肾剂调理而痊。《经方临证集要》《孟景春选评疑难病案》

432、【桂枝加龙骨牡蛎汤治梦交医案】李光琰:

患者, 女, 22 岁, 1976 年 10 月 2 日初诊。婚前患梦交 2 年余, 婚后性交阴道干涩疼痛, 因痛而拒绝性交, 然其梦中仍与鬼怪之物交接, 致阴道分泌物增多, 醒后惊恐万分, 久久不能入眠。羞于求医, 致病情加重, 每周梦交 5~6 次, 拒绝性交月余, 其夫要求离婚, 不得已方来就诊。妇科检查未见异常, 转中医治疗。见病人消瘦, 精神不振, 面色翼黑, 倦怠无力, 少腹拘急, 腰膝酸软, 头晕目眩, 失眠多梦, 舌质淡红, 脉沉迟无力, 此属阴阳不调, 心肾不交。治以调补阴阳, 潜镇固涩, 拟桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味: 桂枝 12g, 龙骨、牡蛎、炒酸枣仁各 30g, 甘草、金樱子、芡实各 10g, 白芍 25g, 生姜 3 片, 大枣 5 枚。服 6 剂, 述此期梦交 1 次, 但立即能醒, 稍停片刻即能入睡。守方继服 6 剂, 梦交未作, 精神爽。连服 18

剂，诸症皆消，性生活正常。改服六味地黄丸善后，2年后随访未复发。按语：桂枝、甘草、龙骨、牡蛎调补阴阳、潜镇固涩，加金樱子、芡实增其固精之力，入炒酸枣仁养心安神。诸药相合，使阳能固涩，阴能内守，阴阳调和，神魄自宁，则病乃愈。（《当代名基经方应用赏析》）

433、【桂枝加龙骨牡蛎汤合五苓散治失眠下肢肿】

患者女性，49岁。患者失眠伴双下肢肿胀2个月于2012年1月就诊。患者两个月前开始失眠，头晕心烦，乏力，睡眠仅2~3h，双下肢肿胀沉重。每日昏沉不适，遂求中医调治。刻下症见：失眠，入睡后噩梦纷纭，甚则彻夜不睡，白天昏沉不适，双腿肿胀酸沉，面色暗滞，舌质暗红，脉沉缓。辨为心肾阴阳两虚，阳虚水泛，荣卫不合，治以益气温阳，调和营卫，固阳安神。以桂枝加龙骨牡蛎汤合五苓散加减：桂枝15g，赤芍15g，白芍15g，炒白术12g，云苓15g，泽泻15g，通草12g，黄芪20g，葛根40g，生龙牡各20g，丹参30g，夜交藤18g，酸枣仁20g，生姜三片，大枣5枚。三剂，日一剂。水煎早晚分服。二诊：睡眠明显改善，双腿肿胀减轻，调理9d后诸症俱除。随访无不适。

按：《灵枢·大惑论》所述：“卫气不得入于阴，常留于阳，留于阳则阳气满，阳气满则阳跷盛；不得入于阴则阴气虚，故目不瞑矣。”《灵枢》“营卫之行，不失其常，故昼精而夜瞑；……其营气衰少而卫气内伐，故昼不精，夜不瞑”之意，因此，营卫不和，运行失调为失眠的主要病机之一，此患者心胸阳虚，虚阳浮越，心神失养，阳虚水泛，故以桂枝加龙骨牡蛎汤益气安神，调和营卫，潜阳入阴；合五苓散温阳化气，渗利水湿；酸枣仁，夜交藤养血安神。

434、【桂枝加龙骨牡蛎汤癫狂医案】张季云：

孟某，女，53岁，农民，1993年12月2日初诊。患者半年前丧子悲伤过度，情志抑郁，默默不语，继则烦躁，精神错乱，喋喋不休，13服肌注镇静药物症状缓解，以后每因情志不舒即复发。3天前又复发此症。伴头晕，胀痛，双下肢肿胀，失眠，舌尖红，苔薄白，脉细弦。患者悲伤过度，致阴阳气血逆乱，治疗重在调整阴阳。处方：桂枝、白芍各15g，生龙骨、生牡蛎各20g，甘草10g，生姜10g，大枣10枚。

复诊：服6剂后，患者言语平稳，头痛明显减轻，舌淡红，苔薄白，脉沉细，上方加磁石15g，龟板10g，以加强重镇之功，7剂后症状消失，随访1年未再复发。（河南中医1995；（6）：343）

按语：对癫狂之证，叶天士主张应“察形证，诊脉候，以辨虚实”。但总由阴阳失调而发，故叶氏在治疗上指出：“医者惟调理其阴阳，不使有所偏胜，则郁逆自消，而神气得返其常焉矣。”本案即为调理阴阳治癫狂证的具体运用。

435、【桂枝加龙骨牡蛎汤昏厥(瘧病)医案】付美育：

吴某某，女，36岁，营业员，1986年6月24日就诊。5年前因与人口角而突然晕倒，不省人事，四肢僵硬，约数分钟后苏醒，但仍觉头晕乏力，后反复发作，每月2~3次，每逢情志不畅则发作频繁，多种检查未发现器质性病变。西医诊断为瘧病。5年来，服多种中西药罔效，遂求诊于余。

刻诊：发作后2天，表情抑郁，少语寡言，时时惊恐，伴头晕，时自汗出，舌淡、苔薄白，脉弦略浮。予桂枝加龙骨牡蛎汤治疗。处方：桂枝10克，白芍、炙甘草各20克，生龙骨、生牡蛎各30克，生姜5克，大枣30枚。每日1剂，水煎分2次服。服药5剂，自觉诸症消失，效不更方，守原方续进30余剂，5年沉痾遂愈，随访至今，未再复发。（新中医1992；（6）：44）

按语：本案辨证眼目是“时自汗出”，此为营卫阴阳失调之表现，故用桂枝龙骨牡蛎汤而取效。

436、【桂枝加龙骨牡蛎汤发热医案】叶益丰：

金某某，女，32岁，1978年3月4日诊。产后半月，发热十天，汗多，心悸纳呆，口淡

不渴，头晕耳鸣，面色苍白，两颧泛红，二便调和，舌淡苔白，脉浮大，按之芤，体温 39.5℃。此乃产后阴血内亏，阳气外浮之证，若误用表散，有漏汗亡阳之危。宜益阴扶阳，镇摄收敛。桂枝、白芍、甘草各 10 克，生姜 5 片，大枣 10 枚，龙骨、牡蛎各 30 克，黄芪 40 克，当归 10 克。2 剂热退汗止，继服 3 剂而愈。

按语：《素问·生气通天论》曰“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。产后阴血内亏，故心悸；阴不恋阳，虚阳外浮，则发热；卫外失固，见汗出怕风；虚阳上越，而头晕鸣，面白颧红。桂枝龙骨牡蛎汤合当归补血汤，有补阳气，益阴血，镇摄虚阳之功，故获捷效。

437、【桂枝加龙骨牡蛎汤奔豚医案】张德超：

陈姓妇女，42 岁。因受惊后，始感头昏，头痛，夜眠不宁，继则感气从少腹上冲，如奔豚之状，上至心胸则惊恐不安，甚则汗出，发则几乎欲死，移时冲气渐平，精神亦渐复。苔白而润，脉沉弦。如是者三年，时愈时发。证系心阳本虚，肾之阴气上逆。予本方重用桂枝加味。遂疏：桂枝 15 克，白芍 10 克，炙甘草 5 克，龙骨、牡蛎各 30 克(杵，先煎)，紫石英 15 克，生姜 4 片，红枣 7 枚。服至 20 余剂，冲气渐平。后以甘麦大枣汤调理善后，竟收全功。(《北京中医》1984；(3)：34~35)

按语：《灵枢》云：“心，怵惕思虑则伤神”。《金匱》云：“奔豚……从惊发得之。”患者因惊恐而伤心阳，肾中寒水之气，随冲脉上逆，而为奔豚之证，故用桂枝加龙牡汤，独加重桂枝用量，取桂枝加桂之法，以复心阳，温肾寒，降冲逆，龙牡、石英以收镇心安肾、平冲降逆之效。

438、【桂枝加龙骨牡蛎汤遗精半载】

李某某，男，40 岁，湘林汽车五中队工人，遗精半载，诸治不效，于 82 年 4 月 13 日来院就诊。证见：头晕神疲，面色萎黄，遗泄无梦，阳痿不举，舌存常薄苔，脉濡软如烂棉。证属肾元虚衰，相火不蛰，由精伤导致气馁。治宜引纳固下，益气调中，与桂枝加龙骨牡蛎汤再加黄芪、党参。进 4 剂，遗泄依然。筹思再三，以为病深药少，嘱其再进 4 剂，仍无寸效。于是以原方去参、芪与之。三剂知，六剂愈，至今未发。

439、【桂枝加龙骨牡蛎汤遗精十余年】

又齐某某，男，53 岁，黔阳县竹器厂篾工。遗精十余年，多方治疗而效不显。于 82 年 7 月 14 日来院就诊。证现头晕目眩，虚羸少气，腰酸肢冷，小便频数不禁，寝难成寐，遗泄无梦，近来几无虚夕。脉来弦细而弱。此亦精气神俱虚之候，亦与桂枝加龙骨牡蛎汤再加参、芪。并非故蹈复辙，以图再试耳！谁知进 4 剂后，不效依然。遂于原方去参、芪与之，进三剂，遗泄戛然而止。续进十余剂，诸证寻愈。随访至今，情况良好，间或一遗，不药而愈。

第二十七章 半夏厚朴汤方证

【原文】妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。（《金匱要略》第二十二篇）

半夏厚朴茯苓生姜汤方：

半夏一升（洗），厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，苏叶二两

上五味，以水一斗，煮取四升，去滓，分温四服，日三服，夜一服，苦痛者，去苏叶，加桔梗二两。

【组成】半夏 15g，厚朴 10g，茯苓 12g，苏叶 6g，生姜 15g，

【煎服】水浸 20 分，煎 30 分，约 600ml，分早晚 2 次服。

【主治】咽中如有炙脔。

【加减】

1. 兼胸痹者，加瓜蒌薤白半夏汤。

2. 无故悲伤者，加甘麦大枣汤。
3. 感冒见桂枝汤证者，加桂枝汤。

【禁忌】咽部焮红，口干思饮，舌红少苔者，忌之。

【类方】1.四逆散：同为理气之方。不同者，半夏厚朴汤复有化痰之功。2.小半夏加茯苓汤：同为痰饮治方。不同者，半夏厚朴汤复有理气之能。

【运用】

1. 治喜怒不节，忧思兼并，多生悲恐，或时震惊，致脏气不平，憎寒发热，心腹胀满，旁冲两胁，上塞咽喉，有如炙脔，吐咽不下。（《三因方》）

2. 声带息肉。（《汉方临床治验精粹》）

3. 诸气不调而作痛者非一，或手足疼痛，走注如痛风，或拘挛搐搦，或腹膈掣痛不可忍，或寒热交作，或小便短涩如淋者，能审其证，皆可用之。（《皇汉医学·医方口诀集》）

4. 精神病。善悲欲哭，蜷于暗处，流涎，舌淡苔白腻，脉弦缓。（《陕西中医》1981；5:12）

5、《医心方》云：医门方，疗咽中如肉脔，咽不入，吐不出，方（于本方去苏叶，加橘皮）。

6、《圣惠方》云：治咽喉中如有炙腐，半夏散方（于本方加枳壳、诃黎勒皮）。渊雷按：《金匱》本条“脔”字，《脉经》作“腐”，《圣惠》盖从《脉经》，然《脉经》“腐”字，实脔字之形讹。

又云：治膈气胸中烦闷，痰壅不下食，紫苏散方（于本方加枳壳、柴胡、槟榔、桂心）。

又云：治心腹胀满，痰饮不下食，厚朴散方（于本方加陈橘皮、前胡、槟榔）。

7、《三因方》云：大七气汤（即本方），治喜怒不节，忧思兼并，多生悲恐，或时震惊，致脏气不平，憎寒发热，心腹胀满，旁冲两胁，上塞咽喉，有如炙脔，吐咽不下，皆七气所生。渊雷按：七气之名，昉见《巢源》。云：七气者，寒气、热气、怒气、悲气、忧气、喜气、愁气，凡七气，积聚牢大，如杯若杵（即盘字），在心下腹中，疾痛欲死，饮食不能。时来时去，每发欲死，如有祸祟，此皆七气所生云云。“然《三因》论七气卷七与此稍异，云：“夫喜伤心者，自汗而不可疾行，不可久立，故经曰喜则气散；怒伤肝者，上气不可忍，时来荡心，短气欲绝，不得息，故经曰怒则气激；忧伤肺者，心系急，上焦闭，营卫不通，夜卧不安，故经曰忧则气聚；思伤脾者，气留而不行积聚在中脘，饮食腹胀满，四肢怠惰，故经曰思则气结；悲伤心胞者，善忘不识人，置物在处，还取不得，筋挛，四肢浮肿，故经曰悲则气急；恐伤肾者，上焦气闭不行，下焦回还不散，犹豫不决，呕逆恶心，故经曰恐则精却；惊伤胆者，神无所归，虑无所定，说物不竟而迫，故经曰惊则气乱。七者虽不同，本乎一气，脏气不行，郁而生涎，随气积聚，坚大如块，在心腹中，或塞咽喉，如粉絮，吐不出，咽不下，时去时来，每发欲死，状如神灵所作，逆害饮食，皆七气所生所成。”案《巢源》寒热二气，非关情志，故陈氏本《素问·阴阳应象大论》，专就情志立论，而沾出悲伤心胞，惊伤胆二者，所引经，当是《素问·举痛论》，惟文不尽合，所举七气证候，多非情志之病，其言原因，尤茫昧难信。惟半夏厚朴汤，为后世诸气剂之祖方，有多种官能性疾病，因情志郁塞而起者，本方速治之，故于此附详七气旧说。

8、《王氏易简方》云：四七汤（即本方），治喜怒悲恐惊之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，此七气之所为也。或中脘痞满，气不舒快，或痰涎壅盛，上气喘急，或因痰饮中节，呕吐恶心，并宜服之。

又云：妇人性情执著，不能宽解，多被七气所伤，遂致气填胸臆，或如梅核，上塞咽喉，甚者满闷欲绝，产妇尤多此证。服此剂，间以香附子药，久服取效，妇人恶阻，尤宜服之，间以红圆子，尤效。一名厚朴半夏汤，一名大七气汤。

9、《仁斋直指方》云：桂枝四七汤（于本方合桂枝汤，加枳壳人参），治风冷寒邪搏心腹

作痛。

又云：四七汤。(即本方)，治惊忧气遏上喘。

又云：加减七气汤(于本方去紫苏，加桂枝、人参、甘草、大枣)，治气郁呕吐。

又云：加味四七汤(于本方加茯神、远志、甘草、石菖、大枣)，治心气郁滞，豁痰散惊。

10、《瑞竹堂经验方》云：四七汤(于本方加香附子、甘草、琥珀末)，治妇人女子小便不顺，甚者阴户疼痛(四库本佚此方，今据丹波氏引)。

11、《证治大还》云：半夏厚朴汤，治积块坚硬如石，形大如盘，坐卧不安，中满腹胀。

12、《医方口诀集》云：三因七气汤，诸气不调而作痛者非一，或手足疼痛，走注如痛风，或拘挛搐搦，或腹膈掣痛不可忍，或寒热交作，或小便短滴如淋者，能审其证，皆可用之。

13、《方极》云：半夏厚朴汤，治咽中如有炙脔，或呕，或心下悸者。

14、雉间焕云：加桔梗、枳实益可也，又代苏叶以苏子尤可。

《方机》云：半夏厚朴汤，治咽中如有炙脔者，兼用南吕若感冒桂枝之证，而有痰饮者，桂枝汤合方主之，屡所经验也。《险症百问》云：平常患感冒，咳嗽声嘶者，师曰：“平常风邪声嘶者，桂枝汤合半夏厚朴汤投之则效。”凡咳嗽声嘶者，咳嗽治则数日自愈，虽不药亦可也，声嘶者，痰饮之变也。

15、《导水琐言》云：水气蓄滞心胸而难利，用吴茱萸橘皮汤等而不通利者，可用半夏厚朴汤加犀角。又小疮头疮内攻之肿，未至十分喘满，但腹胀而利水难者，用之尤妙。

16、《东郭医谈》云：疝气阴囊肿，后世家或用五积散加茴香，或用木香通气，或用三和散，古方家则用乌头煎，如是而不治者，诸医术尽矣，予尝以半夏厚朴汤加犀角治之。

17、《类聚方广义》云：此证，后世所谓梅核气也，加桔梗尤卷七佳，兼用南吕丸。又治妊娠恶阻极妙，大便不通者，兼用黄钟丸或太簇丸，且用苏子，其效胜苏叶。

18、《方函口诀》云：此方，《局方》名四七汤，气剂之权舆也，故不但治梅核气，尽可活用于诸气疾，《金匱》但用于妇人，非也，盖妇人气郁者多，故血病多自气生者。一妇人产后气不舒畅，少有头痛，前医以为血症，投川芎当归剂，不治。诊之脉沉，为气滞生痰之症，与此方，不日而愈，血病理气，亦一法也。东郭治水气，用此方加犀角，得奇效，又加浮石，治噎膈轻症，有效。雨森氏《治验》云：睾丸肿大如斗之人，诊其腹，必滞水阻隔，心腹之气不升降，因使服此方加上品犀角末，百日余，心下渐开，囊里蓄水亦消化而愈。又身体发巨瘤者有效。然不限此二症，凡腹形恶而水血之毒痼滞者，此方皆有奇效云。

19、孙氏《三吴医案》云：张溪亭乃眷，喉中梗梗有肉如炙脔，吞之不下，吐之不出，鼻塞头运，耳常啾啾不安，汗出如雨，心惊胆怯，不敢出门，稍见风即遍身疼，小腹时疼，小水淋漓而疼，脉两寸皆短，两关滑大，上关尤搏指，此梅核气症也。以半夏四钱，厚朴一钱，紫苏叶一钱五分，茯苓一钱三分，姜三分，水煎食后服，每用此汤调理，多效。

20、丛桂亭《医事小言》云：一士人妇，猝患积，饮食不入口。夜中，延予门人，脉平稳，惟滴水下咽，则烦躁欲死，腹满，不能进药食。门人归，问方于予，予以所言考之。得非喉痹欤？曰：“非也，咽不痛。”问之看护人，则云昨日食饼后发，初，一医官治之，谢去，门人谓得非食滞乎，欲与中正汤，任令与之。

次日，乞予往诊，即至其家，问之，则前夜饮医官之药，下咽难，吐之不出，大发汗而烦闷，饮门人药，则不如是之甚，苦痛似稍减，虽以一滴润喉，亦留滞难下云。诊之，无异状，仍与水试之，下喉如噎如呛，如欲从鼻孔出。问昔尝患此否，则病属猝起，见其暂时甚苦，旋即下去，问痛否，则不痛，但觉在咽中心口。看护者三四辈，抚胸按背，皆为之流汗，云心下有逆上之物，其呛势令腹气引张。因决为喉中之病，然窥其喉，又无他异。殆穷于处方，姑与半夏厚朴汤，得小快，更投之，经三四日，竟愈。渊雷按：此亦脏躁之一证，心下逆上之物，即西医书所谓癔病也。

闫氏云：炙脔者，炒肉也。形同炒肉，黏附于咽，吐之不出，吞之不下，有似梅核，故有梅核气之称，西医谓歇斯底里球，或癔病。为情怀抑郁，忧思气结，脾不化湿，则痰涎生之，痰气相结，凝阻于咽，系妇女常见之症。表现有胸膈满闷，饮食无味，善疑虑，易惊恐，甚者心情沉重，情绪低落。咽峡色淡红润，舌苔白腻，脉象弦滑。一般吞咽无阻，开心或忙碌之际其症竟忘，心情不快或闲静时其症尤显。反复空咽，愈咽梗物愈显，忧虑恐惧亦因之益甚。半夏厚朴汤下气化痰，开结散郁，痰消气畅，则炙脔自除。倘治不如法，或讳疾忌医，久而久之，顽痰死血结症，可成噎膈，故不可忽视。治疗同时，须解疑释惑，劝其怡情悦性，如是则如加催化剂，疗效必著。慢性咽炎，今之多发病也，因环境污染，有害气体刺激，以嗜烟酒者尤为多见。其咽中亦似有炙脔，多兼咽燥口干、口苦、口臭，痰如丝如豆，咯唾不爽，与情志无关，动静无别；每因辛辣刺激加重者为是。其咽峡深红，或明显红于周围巧不润少津，或有滤泡。舌边尖红，苔薄黄，为胃火熏灼，炼津成痰。若投半夏厚朴汤以治，其症必剧，以半夏、厚朴、生姜辛燥故也。痰火为患者，余喜用《顾氏医镜》之顺气开痰饮，顾松园谓治痰必以顺气为先，气顺则痰自降。是方清热润燥，顺气化痰，一方而诸法皆备也。慢性咽炎亦有痰气交阻者，余临床观察，多为胃、食管反流之剧者。盖胃气以下降为和，脾气以上升为顺，升降有序，始纳运衡常。若肝气郁结，木失条达，必横逆乘土，致胃气上逆，所谓肝胃不和也。反流物者，胆汁、胃酸也，本流于小肠，作腐熟水谷之用，反流则随胃气上逆，轻则溢于胃、食道，甚则咽，足以令其发炎。必有咽部不利，心下或胸骨后灼热，吞咽痛，噎逆，泛酸，餐后尤显，纳呆、脘胀，大便失调，舌苔白腻，脉象弦滑等症状，咽部症状以平卧、弯腰俯首加剧，坐立减轻为特点。其治疗，余常用大柴胡汤加三棱、莪术以降胃逆，除炙脔；反酸者，加吴茱萸黄连；心下痞者，则用半夏泻心汤加减。总之，相体论治，随证化裁。

刘渡舟曰：所以上一次我说梅核气。嗓子眼堵，吐之不出，咽之不下，如物哽于喉间，介介然而不能下者，就是用一些什么紫苏、厚朴、半夏、茯苓啊，吃了不行，不管用，后来加上桂枝，苓桂术甘，吃了它就下去了，为什么？桂枝能下气，还能开结气，治这个结气喉痹。临床上心脏病人，心律不齐，腾一下子嗓子眼堵了，桂枝是特效药。

曹颖甫曰：湿痰阻滞，咽中气机不利，如有物梗塞，吐之不出，咽之不下，仲师于无可形容中，名之曰有炙肉，即俗所称梅核气也。方用姜夏以去痰，厚朴以宽胸膈，苏叶以开肺，茯苓以泄湿，务令上膈气宽，湿浊下降，则咽中出纳无阻矣。

此方癸酉二月于四明刘姓男子为小异耳，又接近世效方，有用半青半黄梅子，以食盐淹一昼夜，取出晒干，再淹再晒，以盐水干为度，每用青铜钱二枚夹二梅子麻札入磁瓶封固，埋地下百日取出，每用梅子枚含口中半刻，咽中梗塞即消，当附存之。

曾记早年居乡时，见城隍庙道士宋左丞治咽喉痛胀闭塞，用青梅破开去核，中包明变烧灰研末，和皂角末少许吹入，吐出痰涎无算，咽喉即通，足见酸味之青梅当别具挥发性，不当如旧说之收敛矣。

446、【半夏厚朴汤合枳椇汤治精神病案】：

梅核气咽有炙脔，非妇人专病，丈夫亦有之。有班某者，31岁。其母大不幸，虽有小恙，然症情不重。令其痛苦者，乃忧恨迭生，惊气不断。稍有不适，便疑患大症，为120急诊科之常客也。虽精卫亦难填其愁恨之海，故日日与药壶为伴。某子承母性，杯弓蛇影之疑，风声鹤唳之惊，左右不离，真是有其母必有其子，西医谓神经官能症也，常找余诊询。一日咽中有物梗塞，吐之不出，咽之不下，疑食道有肿物，要求作仪器检查，云邻人即因食管癌而死。余以饮食不碍，大便通畅，谓其不须检查，枉花钱也。彼不之信，领餐后复悔恨不听余言。针对多噎逆一胸满闷，口干苦，脉沉弦，视为痰气交阻、肝火上炎，拟半夏厚朴汤合枳椇汤治之：半夏15g，厚朴10g，茯苓12g，苏叶6g，枳椇10g，豆豉15g，三剂。并宽言相告，再勿自吓自也。未几，其母复至，知药后症随失也。（《经方躬行录》）

447、【半夏厚朴汤治咳嗽喉痒不利病案】：

王某，女，50岁，夙有嗽疾，逢冬易发。近感冒，发热、头痛、喉痒咳嗽。经乡医输液五日，热退痛止，唯咳嗽不止。又令服止嗽青果丸、咳特灵日无毫效，遂进城求治。观其面色淡黄，容颜微肿，舌质淡，苔白滑，知痰湿为患。继询知寒热已解，一无表邪。痰涎甚多，喉痒不利，不黄不稠，无热象也。胸满闷，气上逆，胃纳无味，口干不欲饮，噎逆不畅，大便干秘，二三日一行，此肝郁气逆也。诊其脉，沉弦滑。触其腹，心下满，无压痛。肝气郁结，脾胃失运，则痰饮横逆，犯胃则纳呆、腕胀、咽喉不利；凌肺则咳嗽气逆；肺失制节则大便干秘。治当下气化痰，止嗽青果丸为肺热痰稠之药，本案用之，实相碍也。半夏15g，厚朴10g，茯苓15g，苏子15g，橘红10g，生姜5片，三剂。二诊：咳嗽、咽喉不利大减，胃纳增，大便通，诸症皆轻，此气行痰化故也。嘱守方五剂。（《经方躬行录》）

448、【半夏厚朴茯苓生姜汤治喉中梗梗有肉炙商】孙文垣：

治张溪亭乃眷，喉中梗梗有肉炙商，吞之不下，吐之不出，鼻塞头晕，耳常啾啾不安，汗出如雨，心惊胆怯，不敢出门，稍见风则遍身疼痛，小腹时痛，小水淋漓而疼，脉两尺皆短，两关滑大，右关尤搏指。孙曰：此梅核气也。以半夏四钱，厚朴一钱，苏叶一钱，茯苓一钱三钱，姜三片，水煎，食后服。每用此汤调理多效。（续名医类案）

449、【半夏厚朴茯苓生姜汤治滴水下咽则烦躁欲死】：

一士人妇，猝患积，饮食不入口。夜中，延予门人，脉平稳，唯滴水下咽，则烦躁欲死，腹满，不能进药食。门人归，问方于予，予以所言考之。得非喉痹欤？曰：“非也，咽不痛。”问之看护人，则云昨日食饼后发，初，一医官治之，谢去，门人谓得非食滞乎，欲与中正汤，任令与之。次日，邀予往诊，即至其家，问之，则前夜饮医官之药，下咽难，吐之不出，大发汗而烦闷，饮门人药，则不如是之甚，苦痛似稍减，虽以一滴润喉，亦留滞难下云。诊之，无异状，仍与水试之，下喉如噎如呛，如欲从鼻也出。问昔尝患此否，则病属猝起，见其暂时甚苦，旋即下去，问痛否，则不痛，但觉在咽中心口看护者三四辈，抚胸按背，皆为之流汗，云心下有逆上之物，其呛势令腹气引张。因决为喉中之病，然窥其喉，又无他异。殆穷于处方，姑与半夏厚朴汤，得小快更投之，经三四日，竟愈。（《医事小言》）

徐荣斋先生《读书教学与临证》一书载有曹炳章先生治梅核气的含化丸一方，据云效果颇佳，现录之备考。含化丸方：净硼砂20克，乌梅肉9克，柿霜9克，青盐15克，上四味共研细末，为丸如樱大，随时含化，日六至七丸。

450、【半夏厚朴汤食道癌术后食道糜烂（噎膈）】张磊昌：

李某，男，30岁，工人。主诉进行性吞咽困难10天，于1995年2月6日就诊。患者于半年前在当地医院做中下段食道癌根治术，术后情况良好，于10天前因生气后出现进食困难，继则水饮难下，食之呕吐，伴胸膈疼痛，痛连两胁，口干咽燥，舌红少津，脉弦细涩。胃镜检查提示：吻合处见黏膜充血水肿，糜烂，累及食道全段，蠕动较差，诊为“噎膈”。乃为情志所伤，气血瘀滞，胃津亏耗，痰、气、瘀阻经络所致。治宜理气行瘀，化痰润燥，投以半夏厚朴汤加味，处方：半夏15g，茯苓15g，厚朴15g，紫苏10g，沙参15g，麦冬15g，生地黄12g，桃仁12g，红花10g，丹参20g，昆布10g，贝母10g，生姜2片，甘草4g。4剂，每日1剂，每剂煎至约200ml，分3次少量频服。二诊：自觉胸膈疼痛减轻，已能进少量流质，原方加香附12g，10剂。三诊：上述症状均已明显减轻，已能进软质食物，守上方加黄芪30g，白术15g。1个月后诸症皆消，复查胃镜提示：食道黏膜轻度水肿，吻合口及周围水肿消退，糜烂修复，蠕动良好，给予香砂养胃丸以巩固疗效，半年后经随访未复发。（《上海中医药杂志》）

451、【半夏厚朴汤甲状腺腺瘤（瘰癧）】金国梁：

徐某，女45岁，干部。1992年12月2日初诊。患右甲状腺腺瘤3年余。初2cmx2cm大小，服西药多时未效，逐年增大，隐痛。1992年10月14日B超检查：右甲状腺腺瘤，4.8cmx4.2cm大小。建议手术而不从，要求中医治疗。诊时，右颈肿大明显，按之活动，质中。自谓腺瘤

每随情绪波动而增大、缩小，纳食、二便正常，苔薄、脉涩。此情志不畅，气滞痰凝，积而成疾。治法：行气开郁，化痰散结。半夏厚朴汤加味：姜半夏 9g，厚朴 9g，茯苓 15g，生姜 6g，苏梗 9g，黄药子 9g，夏枯草 15g，昆布 15g，桃仁 12g，上方连服 28 剂，隐痛除，腺瘤已缩小。续予原方服用 3 月余，腺瘤消失。B 超复查：右甲状腺腺体大小基本正常。（《北京中医杂志》）

452、【半夏厚朴汤颈淋巴结（核）肿（瘰癧）】金国梁：

陈某，女，24 岁，1993 年 2 月 4 日初诊。颈部两侧淋巴结肿 2 年，时大时小，以左侧为甚，经西医用消炎、抗菌药等治疗多时，未见显效。近 2 个月来淋巴结肿明显，按之活动，质硬。咽喉不利，面足浮肿，月经 3 个月未行，心情忧郁，少言语，苔白腻，脉沉。症属瘰癧。由情志抑郁，气滞痰凝所致。治法：疏郁化痰，软坚散结。半夏厚朴汤加味：姜半夏 9g，厚朴 9g，茯苓 15g，生姜 6g，苏梗 9g，苦丁茶 15g，夏枯草 15g，冬瓜皮 30g，瓜蒌 15g，服 14 剂后，两侧淋巴结肿缩小，面足浮肿消退，咽喉舒如。上方去冬瓜皮、地瓜蒌，加制香附 9g，益母草 20g，先后调治 3 月余，颈淋巴结肿消失，月事按期而行，以两症同愈而收功。（《北京中医杂志》）

453、【半夏厚朴汤治瘰癧】

一位妇女，数年来一直患瘰癧病，主诉每年发作 2~3 次，其欲发前神经兴奋，出现瘰癧之情绪，随之觉胃周围有硬块状物，突然上冲堵塞咽喉。此用半夏厚朴汤，奏大效。《临床应用汉方处方解说》

454、【半夏厚朴汤合金铃子散小儿郁滞腹痛】

荆北沙园张简斋女腹痛治略。二七幼女，伶俐非常，父母极其钟爱，自月前其母急病而亡，日夜啼哭，悲哀太过，不自知焉。近日忽尔腹中大痛，着于一处，手不停按，其痛虽甚幸有时而作，有时而止。其间医师朝张暮李，所见不同。有因面白唇红误认为虫积者，用扫虫煎加鹤虱、使君子者；有因身凉息微妄名寒痧者，用大顺散加降香、晚蚕砂者。药不对证，病乃转增。简斋彷徨无措，延余施治。甫入室，渠即告余曰：前此贱荆腹痛，治不得人，以至不起，今小女病势与贱荆仿佛，所以飞速请教，望先生赐一良方，使小女危而复安，不独生者感德，即亡荆亦相慰于地下矣。语毕就诊，脉左手沉伏，右手浮大，腹痛得此不宜。外证舌红唇燥，溺赤便闭，其为热痛显然矣。余谓简斋曰：书云女子二七而天癸至，令媛适当天癸将至之时，遭此失恃大故，以哭泣之哀，致气血之滞，而腹痛由是作焉。且一团郁火，挟木邪纵行于腹中，得热为伍，愈肆猖狂，而痛由是甚焉。宜四七汤合金铃子散，庶几近理。

简斋曰：病因固不出先生所论，但施治用方其义云何，敢还质之。余曰：四七汤即《金匱》半夏厚朴汤去生姜，陈灵石之注甚明。其云半夏降逆气，厚朴解结气，茯苓除痰气，苏叶散郁气，生姜去秽气，葱白通阳气。《金匱》主以治炙脔，借诸药行气以奏功也。余移之治腹痛，亦以气为血帅，气行则血行，通则不痛之义耳。而必佐以金铃子散者，方中诸药皆行气，独赖延胡索通血而活络，和一身上下诸痛；诸药皆辛温，妙在金铃子味苦而性寒，引心包相火下行。此相须之般，亦承制之理，非古法之可易，实活法之在人耳。简斋闻而称善。命速进药饵，谓夜间但得稍愈一二，至明日再诊处方，可图脱然。抑知药一下咽，旋即安卧，睡里痛除，遍身发热，醒而索茶，未几高声大呃，连续不绝。简斋失色，以为呃则多凶，复促诊视。余曰：病将退矣。两手脉象渐和，舌红已退，是邪气向衰，正气得复之候；其遍身发热者，郁热外出也；高声大呃者，胃火从肝火上升，即得上散也。再服原方一剂，无有不愈。药后果得立愈。《医案梦记》

455、【半夏厚朴汤治浮肿了一年】姜绍昆：

王某，女，53 岁。主诉浮肿，说自己浮肿了一年，脸上浮肿，脚上也有轻微浮肿，但是吃饭、睡觉、大便都好。吃饭、睡觉和大便这三件事是中医学里的生命指标，而血压、体温、脉搏、呼吸次数，这些都是西医的生命指标。在中医看来，如果一个患者吃饭、睡觉、大便都好的话，那大多倾向于一种所谓的功能性或者心理性的病证。

听到浮肿一年，往往会对医者的诊治起一种误导作用，认为一定是心、肾或者肝方面的一种疾病，如果这些都不是，可能还会往甲状腺或者特异性浮肿上想。其实这个病证后来证实就是一种心理性的。心理性也有浮肿，这是我以前所想不到的。不过她吃饭、睡觉、大便都好，我就感到可能是功能性疾病。她说月经闭止了以后，近一年来，身体都不舒服，心里无缘无故感到不安，就是古人说的“忐忑不安”，过去都不懂这个词的真正含义，这一年算是真的体会到了心里一下子上的感觉，心里想的东西多得不得了。还有容易疲劳，经常头晕，她说头晕和浮肿都非常难过，她看病的目的也主要是想解决这两个症状。因此，医生也大都围绕着这些进行诊治处方，如以苓桂术甘汤为核心加几味药，天麻钩藤饮也吃过，类似的半夏白术天麻汤等也吃过。显然，苓桂术甘汤是围绕水肿的，而半夏白术天麻汤、天麻钩藤饮这一类是围绕着头晕，效果也有，但都平平，她总觉得没有把病的“根”挖掉。

她来我这里看是2017年的3月，体质看上去衰老得并不怎么快，身材中等，体能也中等。早晨起来脸上浮肿，下午脚的部位浮肿不明显，但是有肿胀，穿了袜子以后感觉小腿上有痕迹。小便次数多，但尿量少，有尿等待与尿残留感这一类症状，西医检查也没有发现什么阳性指标。还有经常胸闷，说自己要深呼吸几次就舒服了，胸透、心电图等检查都是正常的。

她很喜欢说话，但是又似乎讲不到一个点子上，有的话好像想不起来一样。我看她这么讲，就经常打断她，问一些情况。我问了以后她还想讲，可总感觉她有一种想讲又讲不出来的样子，要咳嗽几声才能够讲出来，一旦讲出来又讲得很多。当停下来要重新讲的时候，又感到好像表达不出来，要停半天，咳嗽几声后才能讲出。这是一个非常重要的症状。

我问她咽喉里是不是有什么不舒服，她讲不清楚，好像有点又好像没有。我是想听她讲咽喉里好像有个东西堵住，有异物感。于是我再问她咽喉有异物感吗？她说没有。感觉有什么东西堵住吗？她也说没有。我说那咽喉是不是有点不舒服啊？她说是有点，但讲不清楚。

脉象沉弱，舌淡红，很正常，舌苔白厚。腹诊：腹肌软，偏虚的证，腹部充气，充气就有微满，可见腹腔中有气堵住的样子，但也不是很严重，摸上去有满满的样子。心下这个位置，她说不舒服，压下去有点紧的样子，但是也没有很硬。中脘这个位置有明显的悸动。压背部至阳穴很痛。在腿上重要的穴位进行按压，阳陵泉有压痛，按压之后胸闷稍有解除。我说目前暂时解除一下，你回去以后，这几个部位每天都要按压。浮肿的话，水分这个位置熏灸5分钟，脚上每个穴位按压2分钟，能坚持住就不错了。同时给她开了半夏厚朴汤，原方5味药不改。

7天以后她来复诊，说自己胸闷这些症状有所改善。按我说的，每天都按压，就压那两个穴位，没有熏灸。我说压了就很好，总比不压好。坚持用这个方子给她治疗了一段时间，2个月之后所有的症状基本消失了。1年以后问她，情况还挺好，没有复发。不过这种情志上的病证，免不了还会复发，以后如果有复发，再做治疗，当然也离不开这个方子。

我能比较顺利地把这个病治好，主要得益于对半夏厚朴汤这个方的使用进行了几十年的摸索。开始的时候，我觉得半夏厚朴汤证很简单，就是咽喉里面有个什么东西堵住了，因此，对于咳嗽、咽喉炎、下咽不舒服、咽喉里面有堵塞感、声带水肿等人，我总喜欢用这个方子。当然了，小半夏汤有时候我也用，但是假如咽喉有堵住感觉的，我就用这个方。

效果怎么样呢？并不理想，治好的少，治不好的多。什么原因呢？我开始也想不清楚，症状也对，方子也对，患者多数是妇女，书上讲是对男人、妇女都一样，但我看到的多数是妇女。她们来诊的时候我非常高兴，认为用这个方子一定会好，结果没好很多，当时真的感到很失望。当然也有说感觉好一点了，我也很高兴，我的喜怒哀乐就伴随着患者的有效和无效，很长一段时间都是这样。但我总想把它搞清楚。

后来看到一些书，首先是日本汉方家对咽喉出现异物感的一种疾病分类，他们说不要认为咽喉有异物感就是半夏厚朴汤证，半夏泻心汤证也有咽喉堵住的样子，有“梅核气”的症状。那区别是什么呢？区别是半夏泻心汤证有心下痞硬，这个痞不是一般的痞，而是痞硬，还

有肠鸣，还有时下利，这些半夏厚朴汤证一般都没有。所以，半夏厚朴汤证和半夏泻心汤证虽然有些症状相同，但是半夏泻心汤证的心下痞硬、肠鸣下利具有特异性，总是可以区别开来。

还有一个是丹栀逍遥散证，也有咽喉塞住、“梅核气”的感觉。我们想一想，逍遥散证心里面本身就不舒服，也可以涉及喜怒哀乐悲恐惊这样的情绪变化，当然就会造成气堵住一样的情况。丹栀逍遥散证有一个特别的证，日本人称为不定踌躇证，有时候也叫血道证，就是绝经以后出现的一种更年期综合征。总之，患者讲的很多这里那里的不舒服，从头到脚都不舒服，但检查都是正常的，西医认为是神经官能症中的一种。丹栀逍遥散证中这种情况出现得最多，而半夏厚朴汤证这方面的症状没有那么多。还有，丹栀逍遥散一般是治失眠的，而半夏厚朴汤证患者的失眠也不是最多的。丹栀逍遥散证还有整个肩部有坚硬不舒服的感觉，这个也是半夏厚朴汤证所没有的。丹栀逍遥散证还有一个症状，就是交叉寒热，一下子冷一下子热，不是往来寒热，而是总感觉对气候变化敏感，哪怕一天里边的气温变化也敏感。另外，腹壁也是软的，肚脐上面的跳动比较明显，而半夏厚朴汤证是心下的悸动，这里稍微有点区别。丹栀逍遥散证有一个非常重要的腹证，左边肚脐下有抵抗、有压痛，这个位置大概是肚脐和髂前上脊这个连线的中点以及离肚脐 1/3 位置。

有的人就在这一点压上去有抵抗、有压痛，这也是一个经常碰到的症状。可见，丹栀逍遥散证虽然也有咽喉中异物感，但它还有很多症状是半夏厚朴汤证所没有的，这样就可以区别开来。

还有甘麦大枣汤证也会出现咽喉里“梅核气”样异物感的，但是它还有自己特异性的症状，即一种急迫紧张感，这个人做事情总想一口气把它做好，哪怕一点小事，他也非常紧张，就像我们讲过的小建中汤证的那种紧张感一样。虽然腹壁也是虚的，一片虚的症状，但它是一种紧张性的虚。还有情绪容易波动且很厉害，有时候甚至悲伤想哭，所以有人把它归到癔症这个范围。还有一个非常典型的症状，即忧郁，有时候老想伸欠，就好像我们睡之前想睡的那种感觉。半夏厚朴汤证就不会像这样典型，虽也会有胸中闷，但有时候喜欢喘大气，但深呼吸几口就可以了，不会那么严重，这个也有区别。甘麦大枣汤证有一个非常重要的腹证就是右边腹直肌特别紧张，左边只是有一点紧张，肚脐上面有好多地地方在跳动，甚至有时候四肢会出现肌肉痉挛，那种急迫紧张感也会造成肌肉出现痉挛这样的现象，所以方里大枣、甘草的用量都比较大，而半夏厚朴汤证的跳动一般都是停留在中脘以上。

456、【栀子甘草豉汤合厚朴半夏汤治咽中贴贴】李振华：

本人李振华，男，44岁，这几天总觉嘴干要喝水，胸口容易出汗，坐车下车的时候就发现胸口的衣服是湿的，喉咙一侧痛，舌根一侧也痛，吞咽也总觉得喉咙有痰，甚至觉得胸骨有痛感，右寸脉微数，喉咙痛舌根痛的越来越来厉害，家里人都催我去医院做检查，看了您给的医案启发用栀子甘草豉汤合厚朴半夏汤，昨晚去药房抓了3服药，睡前吃了一碗，早上起来好了八成，早上再吃一碗上班，现在病去无踪影。

病的起因是早上吃混沌，感觉要迟到了，吃得比较快，感觉烫到了。

罗按：这是一篇网友的自治的治验医案。网友李振华加我好友问我，罗老师您好，有没有关于食道疾病方面的医案？我说有，就把《大芒山中医验案经验集之口咽喉疾病病篇》发给他，过了几天，他高兴的反馈以上医案。李振华并不是医生，是一个中医爱好者，用他本人的话说“食道疾病现在还不太会辨证用药，盲区”。这个医案给我的感觉是眼睛一亮，原来还能这样治。叫我也未必能想到。

457、【半夏厚朴汤治脖子上先天性水瘤】费维光：

1974年4月15日初诊，患者吕峰，男，13岁。其舅父吴在梅工程师为费维光之同事。在诊前吴言：其外甥生下时，脖子上就有一个先天性水瘤。8个月时做了切除手术，痊愈。不料，到了9岁时，此瘤又从脖子上长出，又去医院做了手术。谁知到了13岁，即今年，此瘤又从嗓子里长出。曾去医院做过检查，医生还是叫动手术。并说，此处的手术难度很大，

不能保证生命安全。又说纵然动了手术，也难说今后此瘤不再发生。当时瘤子发展的情况是，吃东西时，须把脖子一伸方能咽下，感觉越来越严重了，全家为此忧愁不安。吴向患者的全家说，我单位有个费某擅长中医，叫他给看看如何？全家同意他的意见，于是带来就诊。

患者的皮肤浅黑，瘦弱。诊之，脉、舌、二便皆无异常，惟有明显的胸胁苦满腹证，先与小柴胡汤 5 剂，令其一日一剂。方：柴胡 18g，半夏 15g，黄芩 10g，党参 10g，甘草 6g，大枣 3 枚（切）生姜 6 片。

再诊：1974 年 4 月 21 日。服上方 5 剂后，其胸胁苦满已无。余又与半夏厚朴汤，令其一日一剂，连服 10 剂以试之。方：半夏 15g，厚朴 10g，茯苓 12g，紫苏叶 10g，生姜 8 片。后知服 10 剂后，患者稍觉轻快。费维光令其舅父捎信不必再来，必须连续服药。后听其舅父言，连服 40 剂痊愈。

费氏按：在 1985 年费维光又遇其舅父，问其外甥如何？说是永未再犯，事隔已经 11 年了。他外甥愈后，全家人甚是喜悦。以后他的妻子、妹妹皆来治过妇科病。

我在只知经方的大致功能，在不会加减的情况下，谁知治愈了这一大难症。在不长的时间内，类此做法，我用人参汤即理中汤治愈了多人的胃寒病，而未用过宋代《和剂局方》的附子理中汤。后来知道我这种做法，是符合日本中医学家用方应该“简单”的要求的。如和田东郭氏说：“用方简者，其术日精；用方繁者，其术日粗。世人动辄以繁为精，以简为粗，哀哉！”

第一章 附方：李杲三圣散方证

三圣散：（《儒门事亲》）

防风三两（9g）（去芦），瓜蒂三两（9g）（剥尽，碾破，以纸卷定，连纸锉细，去纸，用粗筛子罗过，另放末，将滓炒微黄，次入末一处，同炒黄用），藜芦（去苗及心，加減用之）或一两，或半两，或一分（3g）。

上各为粗末，每服约半两（15g），以藿汁三茶盏，先用二盏，煎三五沸，去藿汁，次入一盏，煎至三沸，却将原二盏同一处熬二沸，去滓，澄清，放温，徐徐服之，不必尽剂，以吐为度。

功用：涌吐风痰。主治：中风闭证，口眼喎斜或不省人事，牙关紧闭，脉浮滑实；癫痫，浊痰壅塞胸中，上逆时发；误食毒物，停于上脘者。

【鉴别】瓜蒂散善于涌吐痰食，主要用于痰涎宿食壅塞胸脘，胸中痞硬，气上冲咽喉不得息者；三圣散的涌吐作用大于瓜蒂散，长于涌吐风痰，主要用于中风闭证和浊痰上壅之癫痫。【方论选录】此足太阳、阳明药也。胸中痰食与虚烦者不同，越以瓜蒂之苦，涌以赤小豆之酸，吐去上焦有形之物，则水得舒畅，天地交而万物通矣。（汪昂《医方集解·涌吐之剂》）

《生生堂医谈》曰：问曰：当世之医，行下剂者虽有人，然行吐剂者至稀也。虽有人偶用，平生亦不过二三度乃至十余度耳。然子于一年间，使用瓜蒂数斤，且无误治，愿闻其方法。答曰：治病之大纲，为汗、吐、下三法。汗者，逐毒之在表者；下者，驱毒之在里者；吐者，条达毒在胸膈者。此三法者，诚医术之宝筏，而无病不可能者也。

如前云，越前之奥村良筑为医中之豪杰，始兴吐法。其时有山胁东门、独啸庵、惠美三伯等，相和而行此法，其后遂绝。闻前所行之吐剂方法与余所行者不同，其药毒烈，故其弊终力病家所恐惧。以迨于后世，夫良筑辈之行此，先呼病人之亲属，问之：“若因药之瞑眩

而死，亦无怨乎？…‘否耶’。然后行之。其法，服吐药后，使人起病人而拥之，或抱其头，两手自下腹推上，咽中探以乌羽等。医者待其拥抱而吐毕，则卧之。若不止，则与麝香。如是用药，而病家恐惧，亦不再与他药。

其先病人上冲时，眩晕颇强，自然损人。世人勿论，即医者亦以为大恐。吐剂是杀人之利器，非至此法不行而不已。即有欲行此法者，亦遭病家阻止。虽有志欲医行之者，非至法穷术尽，将成废疾之候者，则不行之。余生于后世而业医，因他法不治之病甚多，依数年之专精，研究吐剂之服法，而终于不误。以瓜蒂为吐剂之第一，产于越前者为上品。宜精察病人之虚实，其分量从病人之病位及毒之多寡不可预定。

大概用瓜蒂末自二分至一钱，煎汤亦可用。又可自三分至一钱，或三圣散同汤，或一物瓜蒂散同汤，或瓜蒂、赤小豆，研末等分，或豆豉汁，或整汁，或萝卜叶煎汁等送下，当随宜用之。胸膈中之毒，他药难拔者，亦可尽拔之。其服法，通例，散剂与煎汤无异。服毕，须臾有催呕气者，或有催于一日半日之后者，其迟速因人而殊。若虽有呕气，而吐来迟者，则困绵如枣大，中央缚以系，吞之，既下咽，则倏然找出，乃忽呕甚，而得快吐矣。

如是行之，其眩晕至轻，乃有用紫圆十粒许者。余行吐法数百人，无有一人误事者，且未见以麝香止吐之眩晕者。如是用法，轻病一吐而愈，剧者数吐而治也。

回忆六七年前，余在大津时，近乡遍处缠喉风流行。自五六岁至三十岁者，卒然憎寒壮热，咽喉肿痛，不能饮食。四五日之内，咽喉腐烂而死，医术不能救。其内若用半夏苦酒汤者，亦仅延四五日而死。余初施治，亦与他医同法，而杀多人。此时始觉作三圣散与之，得快吐而顿愈，亦不用调理之药。自得此法后，千余手死者稀矣。后得此证者，皆请治于余。及移居京师，亦治此证极多，兹举一二例于下。

求真按：现今医家之对于急性中毒，每用洗胃，或用解毒剂，未尝见用吐法者，真怪事也。如洗胃法，虽颇合理，然以口径微小之消息子通于内，而欲排出胃内容之全部，难望其成为事实。用解毒剂者，于试验管内其化学的试验成绩虽佳，然人体非如试验管之单纯，不能如试验之发现完全解毒作用。故毒物犹有存于胃内，而未被吸收者，是以必当应用吐剂也，就中以盐酸阿朴吗啡之皮下注射为上乘之策。

458、【瓜蒂散治水积医案】

一妇从少年时，因大哭罢，饮冰困卧，水停心下，渐发痛闷，咸以为冷积，治以温热之剂，及禁食冷物，一闻茶气，病辄内作。如此数年，燎灸烧艾，疮孔数千。十余年后，小大便秘闷，两目如昏，积水转甚，流于两胁，世谓水癖，或谓支饮，泽、漆、棱、莪攻磨之药，竟施之矣。食日衰，积日茂，上至鸠尾，旁至两胁及脐下。但发之时，按之如水声，心腹结硬，手不可近者，月发五次，甚则欲死，已二十余年。张诊其脉，寸口独沉而迟，此胸中有痰。先以瓜蒂散涌痰五七升，不数日再越痰水及斗，又数日上涌数升。凡三涌三下，汗如水者亦三，其积皆去。以流湿饮调之，月余大瘥。（《续名医类案》）

【方歌】瓜蒂散用赤豆研，豆豉煎汁送下安，痰涎宿食填上脘，逐邪宣壅服之先。

459、【三圣散白虎加人参汤治男子狂病大便燥】

《漫游杂记》曰：一男子患气疾，两脉洪数，心下痞坚，大便燥，结，寐寤不安，语言失理，称王称帝。余以三圣散吐之，二回后，与参连白虎汤，三十余日，痊愈。

求真按：参连白虎汤者，本方（白虎加人参汤）加黄连也。

《方輿貌》曰：白虎加人参汤，此方之正证为汗大出，有微恶寒，身热，大渴引饮也。余按凡宜与白虎汤证，脉当洪长，但在喝，却多虚微状，是赐与伤寒所不同也。由是观之，《素问》云：脉虚身热者，得于伤暑。《甲乙经》云：热伤气而不伤形，所以脉虚也。《金匱》云：弦细克迟。其，即虚豁也。弦细处，即热伤气之应也。由诸古训，可征病暑之脉矣。

《病因备考》有言曰：消渴，未经年月者，虽五十以上，间有得治者，白虎加人参汤主之。世医多以此病为难治，畏石膏故也。

求真按：虽如此说，石膏剂善治糖尿病，但未必以本方为主治也。

460、【瓜蒂散治妇人发狂】

《生生堂治验》曰：一妇人发狂痛，发则欲拔刀自杀，或投井，终夜狂躁不眠，间有脱然谨厚，女事无一误者。先生以瓜蒂散一钱五分，其痰上涌二三升许。使再服白虎加人参汤，不再发。

461、【三圣散治全身麻木目不能视口不能言】

一男子年三十，全身麻木，目不能视，口不能言，其人肥大，性好酒。先生诊之，脉涩而不结，心下急喜呕。即使饮三圣散六分，不吐而暴泻五六次。越三日，又使服（分量同前），涌出三升许。由是目能视，口能言，两手亦渐渐能动矣。后与桃花汤百余帖，痊愈。《皇汉医学》）

462、【瓜蒂散治卒然腹痛入于阴囊】

一男子二十岁，晚饭后半时许，卒然腹痛，入于阴囊，阴囊挺胀，其痛如刺，身为之不能屈伸，辗转闷乱，叫喊振伏。遽迎先生诊之。其脉弦，三动一止，或五动一止，四肢微冷，腹热如燔，囊大如瓜，按之石硬也。病者昏愤中愀然告曰：“心下有物，如欲上冲咽喉者。”先生闻之，乃释然抚掌而谓之曰：“汝言极当。”以瓜蒂散一钱，涌出寒痰一升余。次与紫圆三分，泻五六行。及其夜半，熟睡达天明，前日之病顿如忘。

求真按：治此嵌顿小肠气，以内服药而奏此伟效，此乃中医学之可贵也。

求真按：吐法为治病之要术，应用颇广。如永富氏等（永富为独啸庵氏之姓也）之说，然因尊重过甚，以致下剂适应之病证，不无犹且行之之弊，故不可尽信之。例如，宜用大柴胡汤之呕不止，心下急，郁郁微烦者，与宜用瓜蒂散之胸中痞硬，心中温温欲吐者混同。是宜与大柴胡者，常处以瓜蒂散之例不少。《皇汉医学》）

463、【三圣散治缠喉风】

一妇人因缠喉风，绝食欲死，众治无效。余作三圣散，吹入咽中忽吐黏痰升余，病顿愈，即能饮食言语矣。

求真按：此证吹入桔梗白散为佳。此外，以吐剂治缠喉风证，不可胜数，必有百发百中之数。又用吐方，治难证，亦中。

罗按：三圣散，或许是《儒门事亲》卷十二之三圣散，防风、瓜蒂、藜芦（去苗及心），为粗末。治涌吐风痰。治中风闭证，失者闷乱，口眼喎斜或不省人事，牙关紧闭，脉浮滑实；癫痫，浊痰壅塞胸中，上逆时发；误食毒物，停于上脘者。用法：每服约 15 克，以韭汁 300 毫升，先用 200 毫升，煎三五沸，去韭汁，次入 100 毫升，煎至三沸，却将原煎韭汁，同一处熬二沸，去滓澄清，放温，徐徐服之。不必尽剂，以吐为度。

464、【瓜蒂治妇人状如癫痫】

一女子年二十许，状如癫痫，卒倒不省人事，暂自苏而愈，年发四五次。自幼即有此病，百疗无效。余用瓜蒂末五分，以藜汁送下，吐黏痰一升余，其臭莫名，病顿愈，不复发。（《皇汉医学》）

罗按：藜汁，可能是韭菜之汁。

465、【吐剂治患喘多年】汤本求真：

余妹尝患喘多年，与吐剂一回，顿愈，不复发。（《皇汉医学》）

466、【瓜蒂赤小豆末以藜汁使服之治痫证发则乱言】

一僧，痫证若发则乱言，或欲自缢，且足挛急，困于步。来请治。余知不以吐剂不能治，因被同道阻难，不肯治，而请他医治之。与四逆散加吴茱萸、牡蛎服半年，无寸效。于是再求余，用瓜蒂、赤小豆末，以藜汁使服之。吐黏痰许多，痫不复发，足挛急顿治。

如是之病，只一帖而治者，非他药所能及也。然世医不亲试之，谩恐何为哉？余以是欲为吐方之木铎，有志之士，用之勿疑。（《皇汉医学》）

467、【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤面有疣赘】

一老妇有奇疾，每见人，面有疣赘，屡经医治，无寸效。先生诊之，脉弦急，心下满。使服三圣散八分而吐之，后与柴胡加龙骨牡蛎汤，由是不复发，时年七十许矣。（《皇汉医学》）

学》)

468、【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤少腹有物】

一妇人五十余，恚怒时，则少腹有物，上冲心而绝倒，牙关紧急，半时许，自苏。月或一二发。先生诊之，胸腹动悸，与柴胡加龙骨牡蛎汤，数旬而愈。（《皇汉医学》）

469、【三圣散柴胡加龙骨牡蛎汤右半身不仁】

一妇人年五十，右半身不仁，常懒于饮食，月事不定，每行必倍于常人。先生以三圣散一钱，约吐冷黏痰二三升，由是饮食大进。切其腹，胸满，自心下至少腹，动悸如奔马。与柴胡加龙骨牡蛎汤，数月痊愈。（《皇汉医学》）

第一章 甘草泻心汤方证

【原文】：狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，起卧不安，蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白。蚀于上部则声喝（一作“嘎”，求真按：嘎字为是），甘草泻心汤主之。（《金匱要略》）

汤本求真注曰：就本条，古说虽多，未得正解。余亦不知其意。由南涯、琴溪二氏之治验（记于下）考之，则本条可能是迷胃肠性神经证之证治。

《伤寒六书》曰：动气在上，下之则腹满、心痞、头眩者，宜甘草泻心汤。

《张氏医通》曰：如痢不纳食，俗名噤口。因邪留胃中，胃气伏而不宣，脾气因而涩滞者，连、枳、朴、橘红、茯苓之属。头疼、心烦、呕而不食、手足温暖者，甘草泻心汤。

东洞翁本方定义曰：治半夏泻心汤证而心烦不得安者。

《方机》本方主治曰：下利不止，干呕心烦者。默默欲眠，目不得闭，起卧不安，不欲饮食，恶闻食臭者。

《类聚方广义》本方条曰：此方于半夏泻心汤内加甘草一两，其主治即大不同。曰下利日数十行，谷不化；曰干呕心烦不得安；曰默默欲眠，目不得闭，卧起不安。此皆有所急迫使然，所以用甘草为君药也。慢惊风，有宜此方者。

《勿误药室方函口诀》本方条曰：此方主胃中不和之下利，故以“谷不化，雷鸣下利”为目的。若谷不化，无雷鸣下利者，则处以四逆、理中辈。《外台》作水谷不化，与清谷异文，可'从之。又用于产后口糜泻，有奇效。此等苓、连，可谓反有健胃之效。

甘草泻心汤方：

甘草四两，黄芩三两，干姜三两，半夏半升（洗），大枣 12 枚（擘），黄连一两。

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓。再煮，取三升，温服一升，日三服。

赵刻本半夏“半升”误“半斤”，今据徐谔本及《伤寒论》改。煮服法中，水上当夺“以”字，再煎下当夺“取三升”三字，用法方解。甘草泻心汤方：半夏 11 克，甘草 7 克，黄芩、干姜、人参、大枣各 5.5 克，黄连 1，8 克。煎法用法同上。

470、【甘草泻心汤治疗常无故悲伤】

《成绩录》云：一妇人，证如前章所言，惟气不逆无为异，常无故悲伤。先生（谓吉益南涯也名猷，东洞之子，《成绩录》皆记其治验）与甘草泻心汤而痊愈。案《成绩录》前章云：一男子，平居郁郁不娱，喜端坐密室，不欲视人，逆气甚，动则直视，胸腹有动，失治六年所。先生诊之，与柴胡姜桂汤而愈。

471、【甘草泻心汤治疗梦游症】

《生生堂治验》云：近江大津人某，来见先生，屏人私语曰：小人有女，年甫十六，有奇疾。每夜至亥初，俟家人熟睡，窃起舞跃，其舞曼妙娴雅，虽才妓不能过，至寅末，始罢而就寝，如是以为常。余常窃窥之，每夜辄异其舞，从无雷同，而皆奇妙不可名状，明朝，动止食饮，不异于常，亦不自知其故。或告之，则愕然不信。不知是鬼所凭，抑狐所惑也，

闻先生门多奇疾，幸赐存视。先生曰：此证盖尝有之，即所谓狐惑病者也。往诊之，果然。与之甘草泻心汤，不数日，夜舞自止。**渊雷按**：以上两则，皆甘草泻心汤治狐惑之验案。特其人不发热，亦无蚀咽蚀阴之证耳。

472、【甘草泻心汤治疗精神病】

又闻天津一妇人，有奇疾。初，妇人不知猫在柜中，误盖之。二三日后，开之，猫饥甚，瞋目吓且走。妇人大惊，遂以成疾，号呼卧起，其状如猫。清水某者，师友也，乃效先生方，与甘草泻心汤以治之。

求真按：前者所谓梦游病，后者即凭依证也。

473、【甘草泻心汤治疗心下有痞满】

《青州治谈》曰：师曰，前泉州有一病男，初感风寒，发为痰喘，或以痰喘为急，用十枣汤下之，瞑眩甚而吐下。故四肢微冷，食饵不进，看者甚以为危笃。前医频用茯苓四逆汤，微冷不得复。乞余往诊之，心下有痞满之气味，但因吐而逆上故也。乃调合甘草泻心汤五帖，谓之曰：“自五更迄黎明饮尽之。”微冷渐复，逆上渐降，遂愈。

474、【甘草泻心汤治疗心下有痞满疹不能出】

《麻疹一哈》曰：一妇人年可二十，伤寒愈后十四五日，发热三四日，疹子欲出不出，心下痞硬，烦躁不得眠，下利日二三行。因作甘草泻心汤，使服之。明日，大发汗，疹子皆出，诸证自安，疹收，健食如常。

求真按：非汗剂，因发汗而愈者如此，此古方所以为原因疗法也。

475、【甘草泻心汤治疗心下有痞满下利不止】

《橘窗书影》曰：一妇人年二十五六，产后数月，下利不止，心下痞硬，饮食不进，口糜烂，两眼赤肿，脉虚数，羸瘦甚，乃与甘草泻心汤。服数十日，下利止，诸证痊愈。是《张氏医通》所谓口糜泻也。余每用甘草泻心汤，屡奏奇效。盖本于《金匱》狐惑条与《伤寒论》下利条也。世医用他方，多误治者。

476、【甘草泻心汤治疗心下有痞满口中糜烂】

一妇人年二十六七，妊娠有水气，至产后不去。心下痞硬，雷鸣下利，口中糜烂，不能食盐味，仅啜淡粥，噫气吐酸水。医多以为不治。余以为口糜泻，胃中不和之证，与甘草泻心汤。数日痞硬去，食少进，益使连服，口中和，酸水止，而水气下利依然。乃与大剂四苓汤加车前子，旬余，两证痊愈。

求真按：四苓汤，虽为五苓散去桂枝之煎剂，但失却仲景之本旨，不可采用。

477、【甘草泻心汤治夜间卒昏冒状如癫痫而吐沫】

山田业广曰：余好用甘草泻心汤。曾治一男子，四五日许，夜间卒昏冒，其状如癫痫而吐沫，或以为痫，或以为蛔，诸治无效。一年余，乞余治。投甘草泻心汤一次，不发。今有一酒 281

478、【甘草泻心汤治时健忘而骂詈】

店主，嗜酒无度，屡不食，数登厕，先类下利，气郁懒惰，心气失常，时健忘而骂詈，又有发大声者，用归脾汤等，无效。乞余治，严禁其酒，投以甘草泻心汤加茯苓，日渐爽快，得大效。

一人脾虚无食气，羸瘦，昼夜吐涎沫。待医虽用种种治疗，反日渐疲劳。招余治之，处以甘草泻心汤。二十日许，愈其大半。归京后，发微肿，处以香砂六君子汤，痊愈。

求真按：用香砂六君子汤，不如处以小柴胡汤加橘皮、茯苓、白术焉。

479、【甘草泻心汤治自言自语哭笑不休精神病】

贺 XX，女，38 岁。因孩子暴殁后，悲愤异常，不久即现精神失常。每日下午至晚上即自言自语，哭笑不休，夜间虽能勉强入睡，但一夜之间数次惊醒，心悸不宁，躁扰不安，精神恍惚，有时独自乱跑，早上至上午的时间则清醒如常人。如此二月之久，虽经断续治疗，时好时坏，不能巩固。

初诊时，患者正在清醒时候，故能将自觉症状反映清楚：心神或清醒如常，或模模糊糊，

烦冤，懊憹，脚下憋胀不舒，口干舌燥，但不欲饮水。善太息，易感动。脉数大无力，苔白腻。证属心肝血虚，血燥肝急，兼痰热壅聚，时扰心神所致。遂投服甘草泻心汤，连服三剂，证情大有好转。后宗此方加减服十余剂，诸证痊愈。

炙甘草 30 克，半夏 10 克，党参 15 克，干姜 6 克，黄连 5 克，黄芩 10 克

【癫痫】

癫痫，见《内经》大奇论等篇，是一种发作性神志异常的疾病，又名胎病，说明《内经》早已指出病因中的遗传因素，或因惊恐，情志失调，饮食不节，劳累过度，伤及肝、脾、肾三经，使风痰随气上逆所致。证见短暂的失神、面色苍白、双目凝视，但迅速恢复常态；或见突然昏倒，口吐涎沫，两目上视，牙关紧急，四肢抽搐或口中发出类似猪羊的叫声，醒后除感觉疲劳外，一切如常人，时有复作。在发作阶段，治宜豁痰开窍，熄风定痛。

癫痫发作的病理因素以痰为主。由于痰聚而气逆不顺，于是导致气郁化火，火升风动，挟痰上蒙清窍，横窜经络，内扰神明，以致痫证发作。若痰降气顺，则发作渐止，神志渐苏，醒后外观如常人。甘草泻心汤治疗此病，可以健运中焦，清化痰热，降痰顺气，可减少或消除痰浊气郁的病理因素。

以本方制成丸剂久服可治疗发作较轻，间歇时间较长的轻型癫痫，间或有治愈者。对病程长、病情严重的虽未必能根治，但对改善证状方面，有一定的意义。

480、【甘草泻心汤治癫痫半年余病】

李 xx，女，68 岁。患者平素精神抑郁，性格不开朗，患癫痫半年余，约 20 余日或一月发作一次。发作时突然昏倒，不省人事，口吐白沫，两目上视，四肢抽搐，约持续五分钟后，即进入昏睡，半小时左右清醒。醒后除感头痛、心悸、疲乏外，余无不适。曾服西药苯妥因钠及利眠宁等药治疗，证状未见多大改善。后改服甘草泻心汤，制成丸剂，连服半年，在服药期间又发作两次，以后一直未复发。

罗按：这个情况，甘草泻心汤证不显。

481、【甘草泻心汤重症神经衰弱严重失眠】朱木通：

中年主妇某某，年约四十余岁，久患神经衰弱，去年以来，全身神经衰弱病名就医于某精神科病院。据云稍有起色，适因该医师应征入营当军医而退院。然而退院后原病复起，乃于 1959 年 6 月 22 日嘱我为之医治。

体格瘦小，一见而知为一敏感性妇人。即：言语絮絮而反复，错乱不休。自云此数年来因关心夫婿事业以致常陷于不眠，初唯不眠倦怠而已，继则居恒头涨脑昏，心神恍惚，忧愁苦闷，悲喜无常。入本年来则恒通夜不能入眠，容易惊恐，动辄气喘如有物从脐上上冲胸部，因而呼：吸几至窒息（按此可推定为奔豚），发作时则身体及手足不随意振颤。此外则厌恶与人接触，寡言笑，头眩心悸，居恒胃部膨满、喜噫食臭、心下嘈杂、吞酸、腹中雷鸣、便秘。

以上症状最近更为显著，但这种复合症状已为甘草泻心汤证无疑。据其主诉的前部，属于《金匱要略》的狐惑病甘草泻心汤证，后部之胃肠症状，又属《伤寒论》的甘草泻心汤证，决意投以甘草泻心汤二剂。不期服药后胃症状与精神症状同时痊愈，连服四剂，睡眠大佳，各病俱除。

罗按：此疾病表面上看是精神病，实际上是有甘草泻心汤证的证候。精神疾病不是主证，主证是：“胃部膨满、喜噫食臭、心下嘈杂、吞酸、腹中雷鸣、便秘”，所以，主证治好，精神病也随之消失。